



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Sustainable
Development
Goals

아하

서울시립청소년성문화센터

2018 개정판

International technical guidance on sexuality education

국제 성교육 가이드

An evidence-informed approach



Education
2030

2018 개정판

International technical guidance on sexuality education

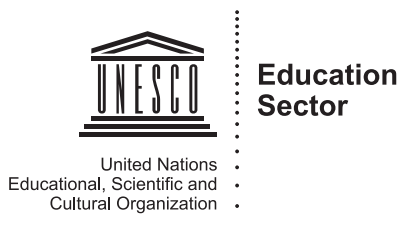
국제 성교육 가이드

본 지침서는 UNESCO 본부의 공식 허가를 받아
아하!서울시립청소년성문화센터에서 번역하였습니다.

본 문서는 네이버에서 제공한 나눔글꼴이 적용되어 있습니다.

유네스코 교육 분과

유네스코의 최우선 과제인 교육은 기본적인 인권이자 평화를 구축하고 지속 가능한 성장을 이끌어 낼 수 있는 기반입니다. 유네스코는 유엔의 교육 전문 기관이며 교육 분과는 오늘날 세계가 당면한 과제에 대응하기 위해 지구촌 사회에 적절한 리더십 모델을 제공하고 국가 교육 시스템을 강화하며, 성 평등 및 아프리카 교육을 강조하고 있습니다.



글로벌 교육 2030 의제

유네스코는 2030년까지 빈곤을 근절하기 위한 글로벌 운동의 일환인 <교육 2030 의제>를 주도하고 운영할 수 있는 권리를 유엔으로부터 위임받았습니다. 17개의 지속 가능한 개발 목표 중 유네스코는 “포괄적이고 공평한 양질의 교육을 보장하고 모두를 위한 평생학습 기회를 장려한다”는 내용의 네 가지 목표를 달성하기 위해 노력합니다. <행동하기 위한 교육 2030 프레임 워크>는 네 가지 목표 아래에서 사회적 약속을 수행하기 위한 방안을 제공합니다.



Published by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France, Aha Sexuality Education & Counseling Center for Youth, 200, Yeongsin-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea.

© UNESCO and AHA Center, 2018

UNESCO's ISBN 978-92-3-100259-5
AHA Center's ISBN 979-11-965179-1-5



This publication is available in Open Access under the Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 IGO (CC-BY-NC-ND 3.0 IGO) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/>). By using the content of this publication, the users accept to be bound by the terms of use of the UNESCO Open Access Repository (www.unesco.org/open-access/terms-use-ccbyncnd-en).

The present license applies exclusively to the text content of the publication. For the use of any material not clearly identified as belonging to UNESCO, prior permission shall be requested from: publication.copyright@unesco.org or UNESCO Publishing, 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP France.

Original title: International technical guidance on sexuality education: An evidence-informed approach, Revised edition
Published in 2018 by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

The designations employed and the presentation of material throughout this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of UNESCO concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

The ideas and opinions expressed in this publication are those of the authors; they are not necessarily those of UNESCO and do not commit the Organization.

발행처: 유네스코
한글번역: 아하서울시립청소년성문화센터

서문

지난 2009년 ‘국제 성교육 가이드’를 공개한 이후로 약 10년이 흘렀습니다. 그동안 국제 사회는 취약 계층의 요구를 충족하기 위해 정의, 평등, 관용, 개방에 초점을 맞추어 누구도 뒤쳐지지 않는 세상으로 발전하기 위한 의제를 채택했습니다. <지속 가능한 성장을 위한 2030 의제(SDGs)>는 양질의 교육, 건강과 복지, 성 평등과 인권이 본질적으로 하나라는 사실을 보여 줍니다.

10년 동안 청소년들은 함께 모여 성교육의 권리를 주장하고 지도자들에게 현재와 미래 세대를 위해 정치적 약속을 이행할 것을 촉구했습니다. 2012년 국제인구개발회의(ICPD)의 국제청소년포럼에서 청소년들은 정부에 ‘적절한 예산 할당을 통한 공식 및 비공식 적 공간에서 포괄적 성교육 접근성의 장벽을 낮추는 환경 만들기’와 정책 수립’을 요구했습니다.

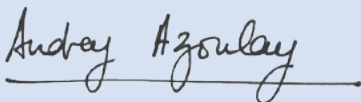
위와 같은 노력을 함에 있어 청소년들은 혼자가 아니었습니다. 질높은 포괄적 성교육에 찬성하는 지역 사회, 부모, 종교 지도자 및 이해 당사자들이 그들과 함께했습니다. 이들은 청소년들이 관계, 성, 재생산 건강에 대해 의식 있고 건강하며 타인을 존중하는 선택을 할 수 있도록 필요한 지식, 삶의 방식, 윤리적 가치 및 태도를 개발하는 일에 지원을 아끼지 않았습니다.

그러나 이러한 진보에도 불구하고, 아직도 많은 젊은이들은 여전히 신체적, 사회적, 정서적 발달에 부정적인 영향을 받아가며 유년기에서 성인기를 맞이합니다. 적절한 준비가 이루어지지 않은 상태에서 성인으로의 전환은 아동 및 청소년의 착취를 비롯하여 사회에 유해한 영향을 끼칩니다. 뿐만 아니라 사회의 의무 담지자들이 전 세대에 대한 책임을 이행하지 못했다는 현상을 나타내는 지표이기도 합니다.

본 개정판에서는 현장을 고려하여 국제성교육가이드를 전면 개편하고 인권과 성평등의 시각에서 성교육을 재정했습니다. 긍정적인 방식으로 청소년의 흥미를 끌어 성(Sexuality)과 관계에 대한 체계적 학습을 촉진하고 있습니다. 효과적인 성교육 프로그램의 필수 요소를 개괄함으로써 해당 가이드는 당국이 청소년들의 건강과 복지에 긍정적 영향을 미칠 포괄적인 커리큘럼을 설계할 수 있도록 돕고자합니다.

‘국제 성교육 가이드’ 초판과 마찬가지로, 이 개정판은 최신 과학적 증거를 기반으로 하고 있으며 각국이 문화적 맥락에 맞는 성교육 프로그램을 시행할 수 있도록 설계되었습니다.

질높은 포괄적 성교육을 요구하는 청소년들의 목소리에 응하지 않는다면, 2030년 완수 예정이었던 지속가능개발목표(SDGs)를 달성할 수 없을 것입니다. 또한 그 누구도 뒤쳐지게 하지 않겠다는 다짐을 이루지 못할 것입니다. 우리는 당국이 본 국제 성교육 가이드를 활용할 수 있도록 지원하는 데 전념하고 있습니다. 청소년들의 성장을 지원하는 각국의 교사, 청소년 육성 전문가, 성교육 전문가들이 자라나는 세대의 교육, 건강 및 복지에 대한 권리를 실현하고 포용적이고 성 평등한 사회를 이룩하는 과정에서 이 자료가 도움이 되기를 바랍니다.



유네스코 사무총장,
오드레 아줄레

감사의 말

‘국제 성교육 가이드’ 개정판은 유엔교육과학문화기구(UNESCO)가 주도했습니다. 본 개정은 유네스코 평화·지속가능발전국 국장 최수향(Soo-Hyang, Choi) 이사의 책임 하에 이루어졌습니다. 유네스코 HIV 및 에이즈 담당 글로벌 코디네이터인 크리스 캐슬이 전반적인 지침을 제공하였습니다. 건강 및 교육 분야 코디네이터인 조안나 헤렛의 도움이 있었습니다, 그리고 제넬레 밥, 카라 델마스, 리타 호우카엠, 카린 닐슨, 안나 에와 러스키위츠, 마린 토데스코의 지원을 받았습니다.

추가된 신규 내용들에 대한 개괄적인 지도는 자문위원 마르셀라 루에다 고메즈와 두티 브리켄이 맡았습니다. 핵심 개념과 주제에 대한 교육 분야에서의 개정은 니콜 치트햄, 데브라 하우저와 노라 겔페린으로 구성된 Advocates for Youth의 팀이 담당했습니다. 폴 몽고메리와 웬디 크너(옥스포드 대학교의 증거 기반 개입 센터)는 본 저작물의 2018년도 판본을 검토하였습니다. 원고의 편집 및 교정은 자문위원 제인 콤베스가 수행했습니다.

특히 자금을 지원한 스웨덴과 UN 에이즈 합동 계획, 그리고 정보, 검토, 피드백 및 기타 기술 지원을 제공하여 개발 과정에 귀중한 기여를 한 다음 성교육 자문 회의의 구성원들에게 감사드립니다. 루트거스 WPF의 콰디르 베이그, 국제 계획 부모 협회의 두티 브리켄, 미국 국제개발처의 산티 콘리, 세계 성 건강 협회(WAS)의 에스더 코로나, 멜버른 대학교의 헬렌 카힐, 스웨덴 국제 개발 협력 단체의 비아 앙스텐드, 아동 조혼 종결을 위한 아프리카 연합 선의 대사관과 로자리아 메모리얼 트러스트의 니아라드자이 굼본즈반다, 인구 자문위원회의 니콜 하버랜드, 베이징 사범대학교의 웬리 리우, 자메이카 교육부의 안나-케이 마그누스-왓슨, Y-Peer의 피터 블라덴 호브, 나미비아 교육부의 사넷 스티캠프, 손케 젠더 저스티스의 레미 샤와, 세네갈 교육부의 아미나타 트라오레 섹, 셀래맨더 트러스트의 앨리스 웰번, 연방 보건 교육 센터의 크리스틴 빈켈만, 그리고 UN 개발 계획의 디에고 안토니, 수키 비버스, 캐틀린 보이스, 맨딩 달리왈, 나탈리아 리노우, 노엘라 리차드, 그리고 킬리 셀러스, UN 개발 계획의 외부 검토 위원이자 아웃라잇 액션 인터내셔널의 시리 메이로부터 추가적인 조언이 있었습니다. 또한 절차에 따라 공동 작업 파트너로서 조언과 검토를 아끼지 않은 UN의 동료들에게도 감사드립니다. UN 에이즈 합동 계획 사무국, UN 인구 기금의 마리아 바카로우디스, 엘리자베스 베노마르, 일리아 주코브, 유니세프의 테드 차이반, 수잔 캐세데, 캐서린 랭게빈 팔콘, 비비안 로페즈, 체웨 루오, UN 여성 기구의 내즈닌 댄지, 엘레나 쿠드라브스테바, 세계 보건 기구의 이안 애스케우, 벤카스라만 찬드라-모울리, 특히 유네스코 본부와 보건 및 교육 분야 각 지부에서 일하고 있는 크리스토프 코르누, 마리 권 딜라니, 자비에 호스피탈, 홍안 리, 용 팡 리우, 패트리샤 매채위라, 앨리스 새일리, 저스틴 새스, 마리아나 스타머, 그리고 티그란 예포얀에게 감사의 인사 전합니다.

2016년 10월 25일부터 27일까지 파리 유네스코 본부에서 개최된 성교육 이해당사자 협의 및 자문단 회의에 참여하여 UN 국제 지침 개정 의견에 주신 모든 분들께도 깊은 감사를 포함합니다.

이 ‘국제 성교육 가이드’ 개정판에 참여한 모든 UN 파트너들은 다음 두 명이 주목받기를 바랍니다. 본 저작물 초판의 개발에 광범위한 연구를 진행한 교육과 연구 (ETR) 협회의 교육 분야 전 수석 과학자 더글라스 커비와 UN 인구 기금의 국장이었던 바바툰데 오소티 메힌 박사입니다. 이 두 사람은 청년들의 복지에 대한 전문적인 헌신과 봉사 정신으로 성교육과 성, 생식 건강 분야에 저명한 업적을 남겼습니다.

UNFPA 이사장
Ostimehin

목차

줄임말	9
1. 들어가며	11
1.1 국제 성교육 가이드의 목적과 대상	12
1.2 지침서는 어떻게 구성되어 있나?	13
1.3 개정판 지침서가 필요한 이유는 무엇인가?	13
1.4 지침서 개발 과정	14
2. 포괄적 성교육의 이해	15
2.1 포괄적 성교육(CSE)이란?	16
2.2 CSE 핵심 고려사항	18
3. 청소년 건강과 복지	21
3.1 아동청소년의 성과 재생산 건강 요구	22
3.2 CSE에서 다루는 아동청소년의 건강과 복지 핵심 이슈	24
3.3 특수 아동청소년 집단의 특정한 성과 생식 건강에 대한 요구와 이슈	25
4. 포괄적 성교육의 성과	27
4.1 도입	28
4.2 성과 연구의 주요 결과	28
4.3 성과 연구의 한계	30
4.4 어떤 연구가 더 필요한가?	31
5. 핵심 개념, 주제, 학습 목표	33
5.1 목적, 대상(연령집단), 내용구성	34
5.2 핵심 개념, 주제, 목표에 대한 개요	36
핵심개념 1 : 관계(Relationships)	37
핵심개념 2 : 가치(Values), 권리(Rights), 문화(Culture), 섹슈얼리티(Sexuality)	45
핵심개념 3 : 젠더(Gender) 이해	49
핵심개념 4 : 폭력과 안전	53

핵심개념 5: 건강과 복지를 위한 기술	58
핵심개념 6: 인간의 신체(body)와 발달(Development)	64
핵심개념 7: 섹슈얼리티(Sexuality)와 성적 행동(Sexual Behaviour)	69
핵심개념 8: 성과 재생산 건강(Sexual and Reproductive Health)	73
6. CSE 프로그램 실행 계획과 지원	81
6.1 CSE 실행력 강화	82
6.2 CSE 프로그램 계획과 실행 지원	86
7. 효과적인 CSE 프로그램 제공	89
7.1 도입	90
7.2 효과적 학습을 위한 커리큘럼의 특성	90
7.3 CSE 프로그램 기획과 실행	94
7.4 CSE 프로그램 모니터링과 평가	97
7.5 CSE 프로그램 확장하기	98
8. 참고자료	101
9. 용어설명	111
10. 부록	115
부록 1. 포괄적 성교육(CSE) 관련 국제협약, 도구 및 표준	116
부록 2. 2016-2017 포괄적 성교육 자문단 참가자 명단	123
부록 3. 유네스코 관계자 및 자문단 회의 참가자 명단	124
부록 4. 평가연구 및 평가방법의 선정 기준	127
부록 5. 성과 연구를 위해 참조한 연구자료	129
부록 6. 2017 지침서의 핵심 개념, 주제, 학습목표 갱신을 위해 만난 사람들과 세부 핵심 정보	133
부록 7. 2017 지침서의 핵심 개념, 주제, 학습목표에 사용된 참고자료와 출처 목록	134
부록 8. 라이프 스킬에 기반한 HIV 및 성교육을 위해 제안된 지표	138

표 및 박스 목차

표

표1 2008년과 2016년도 성과 연구의 핵심적 특성	30
표2 성과 연구의 한계	30
표3 CSE에 대한 일반적 우려	84
표4 효과적 CSE 커리큘럼의 특성	93
표5 독립형 또는 통합형 CSE의 핵심 고려사항	94
표6 CSE 프로그램 기획과 실행	97
표7 교육관리정보시스템(EMIS)국가의, 라이프 스킬 기반 HIV 및 섹슈얼리티 교육의 질, 포괄성 적용범위조사를 위한 지표	98

박스

박스1 CSE에서 섹슈얼리티에 대한 개념적 틀	17
박스2 CSE 관련 회원국간 국제 유엔 표준 및 협약의 예	82
박스3 CSE의 옹호와 실행에 참여하는 청소년	86
박스4 유네스코 섹슈얼리티 교육 확대를 위한 10가지 주요 원칙	99

줄임말

AIDS	Acquired immune deficiency syndrome 에이즈
CEFM	Child Early and Forced Marriage 조기 강제 결혼
CSE	Comprehensive sexuality education 포괄적 성 교육
FGM/C	Female Genital Mutilation/Cutting 여성 할례
EMIS	Education Management Information System 교육관리정보체계
GBV	Gender-based violence 젠더 기반 폭력
HIV	Human immunodeficiency virus 후천성 면역 결핍증
HPV	Human Papillomavirus 인유두종 바이러스
ICTS	Information and communication technologies 정보소통기술
ICPD	International Conference on Population and Development 세계인구개발회의
ITGSE	International technical guidance on sexuality education 국제 성교육 가이드
LAC	Latin America and the Caribbean 라틴 아메리카와 카리브해 지역
LGBTI	Lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex 레즈비언, 게이, 양성애자, 트랜스젠더, 인터섹스
NGO	Non-governmental organization 비영리조직
PoA	Programme of Action 결의문
PEP	Post-exposure prophylaxis 노출후 예방요법
PrEP	Pre-exposure prophylaxis 노출전 예방요법
RCT	Randomized controlled trials 무작위 비교연구
SDGs	Sustainable Development Goals 지속가능발전목표
SERAT	Sexuality Education Review and Assessment Tool 섹슈얼리티 교육 연구 및 평가 도구
SRH	Sexual and reproductive health 성과 재생산 건강
SRHR	Sexual and reproductive health and rights 성 및 재생산 건강과 권리
STIs	Sexually transmitted infections 성매개감염병
UNAIDS	United Nations Programme on HIV and AIDS 유엔에이즈계획
UNDP	United Nations Development Programme 유엔개발계획
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultral Organization 유네스코 (유엔교육과학문화기구)
UNFPA	United Nations Population Fund 유엔인구기금
UNICEF	United Nations Children's Fund 국제연합아동기금
UN Women	United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women 유엔여성기구 (성 평등과 여성의 권한을 위한 국제연합기구)
VMMC	Voluntary medical male circumcision 자발적 포경 수술
WHO	World Health Organization 세계보건기구
YPLHIV	Young people living with HIV 청소년HIV감염자





1

들어가며

1- 들어가며

포괄적 성교육(CSE)은, 청소년 복지에 심각한 위협을 초래하는 HIV 및 에이즈, 성병(STIs), 의도하지 않은 임신, 젠더 기반 폭력(GBV) 및 젠더 불평등이 여전히 존재하는 세상에서, 청소년들이 안전하고 생산적이며 충만한 삶을 준비할 수 있도록 하는데 핵심적 역할을 한다. 그러나 이와 같은 양질의 분명하고 강력한 커리큘럼 기반 CSE 프로그램이 있음에도 불구하고, 자신의 성적 지향과 관계를 자유롭게 책임감 있게 조절하고 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있는 아동 및 청소년은 많지 않다.

성인기에 접어드는 많은 청소년들이 섹슈얼리티에 대해 모순적, 부정적이며 혼란스러운 메시지를 직면하게 되며, 이는 부모나 교사를 포함한 성인들의 당황스러움과 침묵으로 인해 종종 악화되곤 한다. 많은 사회적인 규범이 섹슈얼리티 및 성 행동에 대한 공개적인 토론을 방해하며, 성 관계, 가족계획, 현대적 피임법 사용과 관련한 젠더 불평등과 같은 불리한 조건을 영속시킬 수 있다.

주요 연구 결과에 따르면 CSE는 아동 및 청소년의 발달에 도움을 준다; 올바르게 연령에 맞는 지식, 태도, 기술; 인권에 대한 존중, 젠더 평등, 다양성을 포함한 긍정적 가치; 그리고 안전, 건강, 긍정적 관계를 위한 태도와 기술(Section 4 - 성과 기반 포괄적 성 교육 참조) CSE는 또한 청소년들로 하여금 사회적 규범, 문화적 가치, 전통적 신념에 대해 다시 생각해보도록 함으로써, 또래, 부모, 교사, 다른 성인과 지역사회와의 관계를 더 잘 이해하고 다룰 수 있도록 돕기 때문에 중요하다.

국가는 특히 인터넷이나 다른 매체를 통해 성적으로 노골적인 자료에 더 많이 노출되는 상황에서, 청소년들이 자신의 삶에서 책임 있는 선택을 할 수 있는 지식과 기술을 갖추는 것의 중요성을 점점 더 인식하고 있다. 2030년 의제와 지속가능한 개발 목표¹(SDGs)에서는 단 한 사람도 소외되지 않는 실천과 모두의 인권과 성(Gender)평등의 실현을 촉구한다. 또한 교육, 성평등, 건강과 복지의 목표를 달성하기 위한 정치적 공약을 이끌어내는 것은, 기존 또는 여러 부문의 새로운 프로그램을 확장하여 아동과 청소년에게 제공할 수 있는 중요한 기회를 제공한다.

CSE 프로그램은 학교 프로그램으로 지원을 받는 환경에서 잘 훈련된 교사가 제공해야 한다. 이들 교사는 많은 청소년들이 성 행위 전에 성교육을 받을 수 있는 중요한 기회와 더불어 그렇게 할 수 있는 체계적인 학습 환경을 제공할 수 있다. CSE는 또한 잘못된 정보, 강압, 착취에 가장 취약한 학교 밖 아동과 청소년에게도 제공될 수 있어야 한다.

1.1 국제 성교육 지침서의 목적과 대상

국제 성교육 지침서는 학교 안팎에서 포괄적인 성 교육 프로그램과 교재를 개발하고 시행하는 교육, 건강 및 기타 관련 당국을 지원하기 위해 개발되었다. 이는 정부의 교육부 장관과 커리큘럼 개발자, 학교장 및 교사를 포함한 전문가와 직접적인 관련이 있다. 비영리단체, 청년 노동자 및 청소년 또한 이 자료를 지지 또는 책임의 도구로 활용할 수 있는데, 예를 들면, 모범 사례를 위한 지침서로 의사결정자에게 제공하고 SDGs와 같은 광범위한 의제로 통합되도록 하는데 활용할 수 있다. 이 지침서는 또한 양질의 교육, 성 및 재생산 건강(SRH), 청소년 건강 그리고/또는 성 평등을 위해 노력하는 관계자를 포함하여 학교 내, 학교 밖 성교육 프로그램을 기획, 제공하고 성교육 평가와 관련된 누구에게나 유용하다.

국가 정책 및 커리큘럼에서 CSE를 언급할 때는 다른 용어를 사용할 수 있다. 여기에서 사용하는 용어는 예방교육, 관계와 성교육, 가정생활교육, HIV교육, 평생기술교육, 건강한 생활방식 및 기본 생활안전교육이다. 사용한 용어와 무관하게 ‘포괄적인’은 긍정적인 섹슈얼리티와 성 및 재생산 건강에 대한 학습자의 지식, 기술, 태도의 개발을 의미한다. CSE 프로그램의 핵심 요소는 인권에 대한 확고함과 자연스러운 인간 발달의 한 부분으로서의 섹슈얼리티에 대한 광범위한 개념에 대한 인식의 어떤 유사성을 공유한다.

이 지침서는 근거에 따른 정보 제공, 지역 특성에 맞는 내용, 그리고 섹슈얼리티와 관련하여 건강과 복지에 영향을 미칠 수 있는 신념, 가치관, 태도, 기술과 같은 요인을 측정하고 설명하기 위해 논리적으로 설계된 프로그램의 필요성을 강조한다.

¹ <https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld>

양질의 영향력 있는 학교 기반 CSE를 위해서는 교사의 역량을 포함한 교육과정 뿐 아니라, 어떤 교육 접근법과 교수학습자료를 사용하는지와 관련된 학교 환경 전반에 달려있다. 이는 학교 규칙 및 학교 내 운영에도 다른 것과 함께 명시되어 있다. CSE는 보다 수준 높은 교육의 필수 요소이며 모든 학습자의 건강과 복지를 결정하는데 중요한 역할을 한다.

지침서의 목적은 다음과 같다.

- CSE 프로그램에 대한 명확한 이해와 바람직하고 긍정적인 결과를 분명하게 제시한다.
- 아동, 청소년에게 영향을 미치는 성 및 -재생산 건강(SRH)과 관련한 문제에 대한 인식을 재고함으로써 CSE 프로그램의 필요성에 대한 이해를 증진한다.
- 정책입안자, 교육자, 교육과정개발자에게 도움이 될 성과 및 연구에 기반한 지침을 공유한다.
- 교사 및 교육자의 준비를 높이고 양질의 CSE를 제공할 수 있는 제도적 역량을 강화한다.
- 지역 및 학교 단위에서 CSE를 위한 지원 체계를 구축하는 방법에 대한 지침을 교육당국에 제공한다.
- 성과 자료에 기반하고 연령 및 발달에 적합한 CSE 교육과정 및 교수학습자료, 그리고 문화적 감수성이 있는 프로그램을 개발할 것인지에 대한 지침을 제공한다.
- CSE가 월경 및 성평등과 같은 문화적 맥락에 따라 민감할 수 있는 문제에 대한 인식을 높이는 방법을 보여준다. 또한 아동 조기강제 결혼(CEFM)과 여성할례(FGM/C)와 같은 유해한 관행에 대한 인식을 높일 수 있다.

이 지침서는 최신 자료를 제공하는 것 외에, 모든 개인의 교육 받을 권리와 달성 가능한 가장 높은 건강과 복지의 기준을 강조하는 수많은 국제 인권 협약에 확고한 기초를 두고 있다. 이러한 인권 협약에는 세계인권선언, 아동권리협약, 경제·사회·문화적 권리에 대한 국제 협약, 여성에 대한 모든 형태의 차별 철폐에 관한 협약, 장애인 권리 협약이 있다. 국제 협약에 대한 자세한 내용은 부록 1. 포괄적인 성교육 관련 국제 협약, 결의, 선언 및 합의를 참조하기 바란다.

이 지침서는 교육과정이나 국가별 CSE 운영에 대한 세부 권장 사항도 제공하지 않는다. 오히려 이 지침서는 국제적인 모범사례에 기반한 틀로서 커리큘럼 개발자로 하여금 자신의 상황에 적합한 과정을 만들어 적용할 수 있도록 지원하고, 양질의 성교육 프로그램을 설계, 실행, 모니터링 할 수 있도록 안내한다.

이 지침서는 전 세계 여러 지역의 전문가 및 실무자의 의견을 바탕으로 국제수준에서의 품질, 수용 가능성, 소유권을 보장하는 기획과

정을 거쳐 개발되었다. 동시에 이 지침서는 섹슈얼리티 교육이 이루어지는 다양한 국가적 맥락의 다양성과 각국 정부의 교육 과정 내용 결정 권한을 인정함에 따라 자발적 특성을 가진다는 점에 유의해야 한다.

1.2 지침서는 어떻게 구성되어 있나?

지침서는 7장으로 구성되어 있다. 첫 4개 장은 최근 연구에 따른 성과 자료와 함께 CSE에 대한 정의와 원리를 제시한다. 5장은 연령에 따른 학습목표와 개념, 학습주제를 제시한다. 마지막 2개 장은 CSE 지원 구축과 효과적 프로그램 제공을 위한 권장사항과 지침을 제시한다.

종합 패키지로서 효과적인 CSE를 위한 권장 주제와 운영 지침을 제공한다. 이 같은 국제 기준은 지역 맥락에 맞게 조정함으로써 관련 성을 보장하고 학습내용 모니터링 아이디어를 제공하며 교수학습 목표에 따른 진행 과정을 평가할 수 있어야 한다.

1.3 개정판 지침서가 필요한 이유는 무엇인가?

이 지침서의 첫 번째 버전은 유엔에이즈계획(UNAIDS), 유엔인구기금(UNFPA), 유엔아동기금(UNICEF), 세계보건기구(WHO)와 공동으로 2009년 유네스코에 의해 발행되었다. 출판 이후 이 지침서는 전 세계적으로 적용 가능하고 현지 상황에 쉽게 적용할 수 있는 성과 기반 교육 자료로 활용되었다. 또한 인권과 관련하여 양질의 교육의 필수 요소인 아동, 청소년, 청년을 대상으로 한 CSE지지를 위한 도구로 사용되었다.

CSE 영역은 지침서가 처음 발간된 이후 빠르게 발전했다. 다양한 교육 환경에서의 성교육 프로그램의 실행으로 CSE에 대한 향상된 이해와 교환을 얻었으며, CSE를 위한 근거 자료가 통합되고 확장되었다. 지속가능발전목표(SDGs)는 성 교육 범위, 입지, 연관성에 대한 새로운 국제적 틀을 제공한다. 건강 증진에 대한 성인직접 관점과 사회적 맥락에 대한 인식의 확대를 포함하여 새로운 고려사항들 - HIV, 성병, 조기/의도하지 않은 임신, 젠더 기반 폭력과 관련된 것을 포함한 성 건강 문제에 대한 취약성을 줄이기 위한 교육의 보호적인 역할 ; 널리 퍼져있는 인터넷과 소셜미디어의 영향 - 이 등장했다. 더 나아가 CSE는 청소년 건강 개입의 중요한 요소로 인정받고 있다.(WHO, 2017b)

이러한 변화 인식과 함께, 성평등과 여성의 권한을 위한 국제연합기구(UN Women 유엔여성기구)와 협력하여, 최근 자료를 반영하고 젊은 학습자의 시대적 요구를 반영하고 교육 체계 및 실무자를 지원하기 위해 최신 자료를 담아 지침서의 내용을 개편하고 업데이트했다. 개편 지침서는 추가 자료 제공 뿐 아니라 지침서 이용자에게 효과적인 것으로 증명된 본래의 핵심적인 특성 및 내용을 유지하면서 동시에 업데이트 된 핵심 개념, 학습 주제, 학습목표를 제시하였다.

1.4 지침서 개발 과정

개정된 지침서는 2016년에 유네스코가 의뢰한 교육과정 및 교육 과정의 틀에 대한 검토와 함께 새로운 자료를 검토한 것을 토대로 한다. 새로운 자료는 옥스퍼드 대학교 폴 몽고메리 교수와 영국의 성과 기반 중재 센터(Centre for Evidence-Based Intervention, 유네스코 2016b) 웬디 크너가 검토하였다. 커리큘럼과 커리큘럼 틀은 미국의 ‘청소년 지지자(Advocates for Youth)’(UNESCO 2017c)가 검토하였다. 이 두 보고서는 www.unesco.org에서 참조할 수 있다.

개정 지침서는 유네스코가 개정을 감독하고 안내하는 자문 그룹을 소집하고 아울러 새로운 자료 조사에 기반을 두고 있다. 성교육 자문단은 교육, 보건, 청소년 발달, 인권과 젠더 평등 분야에서 일하는 전 세계의 전문가들로 구성되었다. 여기에는 연구자, 교육부장관, 청소년, NGO 프로그램 실행자 및 개발 협력자가 포함되어 있다. 여러 관계자로부터 의견을 수집하고 원래 지침서의 유용성을 평가하기 위해 개정 과정에서는 원래 지침서에 대한 온라인 설문조사가 실시되었다. 또한 국가별 포커스 그룹 토론을 하였으며, 국제 관계자 협의회를 실시하였다. 따라서 개정판은 청소년들의 목소리를 포함하여 전문가의 풍부한 의견과 모범 사례에 대한 이해를 바탕으로 작성되었다.

(부록II 포괄적 성교육 자문단 참가자 목록, 2016-2017,
부록III UNESCO 관계자 자문 및 자문단 회의 참가자 명단 참조)

2

포괄적

성교육의 이해

2 - 포괄적 성교육의 이해

이 장에서는 포괄적인 성교육에 대한 새로운 정의와 설명을 하고, 발전하고 있는 CSE 영역에 대한 이해를 돕는 주요한 고려 사항을 제시한다.

2.1 포괄적 성교육(CSE)이란?

포괄적 성교육(CSE)은 섹슈얼리티에 대한 인지적, 정서적, 신체적, 사회적 측면에 대해 배우는 커리큘럼을 기반으로 한 교육과정으로서, 아동과 청소년들로 하여금 자신의 능력·자신의 건강과 복지, 존엄성에 대한 인식 능력, 존중에 기반한 사회적, 성적(Sexual) 관계 형성 능력, 자신 및 타인의 복지에 미치는 영향을 고려한 선택 능력, 자신의 삶 속 권리에 대한 이해와 보호 능력·을 높일 수 있는 지식, 기술, 태도, 가치를 갖추도록 하는데 목적이 있다.

CSE 프로그램은 공식, 비공식 교육 환경에서 제공되는 교육이다.

과학적으로 정확하다 : CSE는 SRH(성 및 재생산 건강), 섹슈얼리티, 행동에 대한 사실과 성과에 기초한 내용으로 구성된다.

점증적이다 : CSE는 어린 나이에서부터 시작하는 지속적 교육과정이며, 이전에 학습한 것을 기반으로 새로운 정보를 구축하는 나선형 커리큘럼 접근법을 사용한다.

연령(발달)단계에 적합하다 : CSE는 아동 청소년이 성장함에 따라 변화하는 요구와 능력에 따라 내용을 구성한다. 학습자의 연령과 발달단계에 가장 밀접한 건강과 복지 관련 주제를 다룬다. 그리고 발달의 차이를 고려하여 인지 및 정서발달이 늦는 경우 내용을 수정한다. SRH(성 및 재생산 건강) 및 관련 메시지의 내재화 가능성이 가장 높게 제공된다.

교육과정이다 : CSE는 학생의 학습을 돕는 교육자를 위한 계획된 교육과정(written curriculum)이다. 교육과정에는 주요교육목표, 학습목표, 개념, 핵심 메시지를 구조화된 방식으로 명확하게 전달하는 내용이 포함되어 있으며, 학교 교육 또는 학교 밖 교육으로 제공할 수 있다.

포괄적이다 : CSE는 섹슈얼리티에 대한 포괄적이고 정확하며 풍부한 자료와 연령에 맞는 정보를 얻을 수 있는 기회를 제공한다. 성 및 재생산 건강 문제를 다루는데, 국한된 것은 아니지만, 성 및 생식 해부학, 생리학, 사춘기 및 월경, 현대적 피임, 임신 및 출산, HIV 및 에이즈를 포함한 성매개감염병(STIs)에 대한 내용을 포함한다. CSE는 일부 사회문화적 상황에서는 어려울 수 있는 주제를 포함하여 학습자가 알아야 할 모든 주제를 다룬다.

건강 및 복지와 관련한 분석, 의사소통 및 기타 생활 기술 능력을 향상시킴으로써 학습자의 역량을 높일 수 있도록 지원한다. 여기에는 섹슈얼리티, 인권, 건강하고 존중받는 가정 생활 및 대인관계, 개인 및 공동의 가치, 문화 및 사회 규범, 젠더 평등, 차별 금지, 성적 행동, 폭력과 젠더 기반 폭력(GBV), 동의 및 신체 통합성, 성적 학대, 아동

조기강제결혼(CEFM)과 여성할례(FGM/C)와 같은 유해한 관행을 포함한다.

‘포괄적’이란 말은 또한 일회성 수업이나 개입이 아닌 시간을 두고 일관되게 학습자에게 전달하는 주제와 내용의 폭과 깊이를 나타낸다.

인권 접근법에 기초해 있다 : CSE는 아동청소년의 권리를 포함하여 모든 개인의 건강권, 교육권, 동등한 정보 접근권 및 차별 금지와 같은 보편적 인권에 대한 이해를 증진하고 촉진한다. 청소년들에게 CSE에 대한 동등한 접근성을 제공하는 것은, 강압과 폭력이 없는 안전하고 책임있고 존중되는 성적인 선택과 아울러, 효과적인 자기 관리에 필요한 정보 접근권을 포함하여 달성 가능한 가장 높은 수준의 청소년 건강권을 존중하는 것이다.

부록 I 참조 : 성 교육 관련 국제 협약에 대한 더 많은 정보는 포괄적 성교육(CSE) 관련 국제협약, 도구 및 표준

성평등(Gender Equality)에 기초한다 : CSE는 젠더 규범이 불평등에 영향을 미치는 다양한 방식을 다루며, 이러한 불평등이 아동청소년의 건강과 복지 전반에 어떻게 영향을 미칠 수 있는지, 또한 HIV, STI, 조기 및 의도하지 않은 임신, 젠더 기반 폭력 등 문제를 예방하기 위한 노력에 대해 다룬다. CSE는 문화, 사회, 생물학적 차이와 유사성에 의해 형성된 젠더 규범에 대해 조사하고, 공감과 이해를 바탕으로 한 존중 및 평등한 관계를 만들 수 있도록 격려함으로써, 사람들의 삶 속에서의 젠더의 중요성과 다양성에 대한 인식을 구축함으로써 성평등에 기여한다. CSE 커리큘럼 전체에 걸쳐 젠더 관점을 통합하는 것은 효과적인 CSE 프로그램을 위해 필수적이다. 젠더 개념에 대한 자세한 내용은 9장 용어설명을 참조한다.

문화적 관련성과 맥락성을 고려한다 : CSE는 특정 환경에서의 문화 구조와 규범, 행동이 사람들의 선택과 관계에 영향을 미치는 방식을 조사하고 이해하고 문제를 제기하는 과정을 지원함으로써, 학습자가 존중과 책임있는 관계를 형성할 수 있도록 돕는다.

변화적이다 : CSE는 개인 및 지역사회의 역량을 강화하고, 청소년들의 시민의식과 비판적 사고능력을 높임으로써 공정하고 따뜻한 사회를 만드는데 기여한다. 학습자는 SRH에 대한 긍정적 가치와 태도에 대해 탐구하고 자존감과 인권 및 성평등에 대한 존중감을 키울 수 있는 기회를 갖게 된다. 또한 CSE는 청소년들이 자신의 결정과 행동이 다른 사람에게 영향을 미치는 방식에 대해 이해하고 책임을 질 수 있는 역량을 높인다. CSE는 청소년들이 민족, 인종, 사회경제적 또는 이민자로서의 신분, 종교, 장애, 성적 지향, 성 정체성 또는 성적 표현, 성적 특성과 무관하게 타인을 존중, 수용, 관용, 공감하는 마음으로 대할 수 있는 태도와 기술을 갖출 수 있도록 한다.

건강한 선택을 하는데 필요한 생활 기술을 개발 할 수 있다 : 여기에는 정보에 근거한 의사결정능력, 효과적인 의사소통과 협상 능력, 단호함을 보여주는 능력을 포함한다. 이러한 능력들은 아동, 청소년들이 가족, 또래집단, 친구 및 연인 또는 성적 파트너와 서로 존중하는 건강한 관계를 형성하도록 돕는다.

박스 1. CSE에서 섹슈얼리티에 대한 개념적 틀

섹슈얼리티의 개념을 정의하는 것은 간단하지 않다. 공중 보건 및 성 과학 분야의 많은 전문가들이 섹슈얼리티의 기본 개념을 논의한 결과 합의된 정의와 개념적 틀을 제시했다.(미주보건기구 Pan American Health Organization/세계보건기구 World Health Organization, 2000;WHO,2006a)

‘섹슈얼리티’는 인간의 핵심적인 차원으로 이해될 수 있는데, 여기에는 인간에 대한 이해와 관계, 감정적 애착과 사랑 ; 섹스, 젠더, 성 정체성, 성적 지향 ; 성적 친밀감, 쾌락, 재생산이 포함된다. 섹슈얼리티는 복합적이며 일생에 걸쳐 진화, 발전하는 생물학적, 사회적, 심리적, 영적, 종교적, 정치적, 법적, 역사적, 윤리적, 문화적 차원을 포함한다.

‘섹슈얼리티’라는 단어는 언어와 문화적 맥락에 따라 다른 의미를 가진다. 따라서 다양한 변수와 언어에 따른 의미의 다양성을 고려할 때 CSE는 섹슈얼리티에 대한 다음의 측면을 고려할 필요가 있다.

- 섹슈얼리티는 생물학적 측면 뿐 아니라 대인 관계 및 성 관계에 대한 개인적, 사회적 의미를 나타낸다. 이는 주관적 경험이며 친밀함과 사생활 둘 다를 위해 인간에게 필요한 부분이다.
- 이와 동시에 섹슈얼리티는 사회구조이며, 이는 신념, 관행, 행동, 정체성의 다양성 안에서 가장 쉽게 이해된다. ‘섹슈얼리티는 개별적 관행과 문화 가치와 규범의 차원에서 형성된다’(Weeks, 2011).
- 섹슈얼리티는 권력과 관련이 있다. 궁극적인 권력의 경계는 자신의 몸에 대한 성적 통제 가능성이다. CSE는 섹슈얼리티, 젠더, 권력, 그리고 그것의 정치사회적 차원의 관계를 다룰 수 있으며 이는 특히 나이가 많은 학습자에게 적합하다.
- 성적 행동을 통제하고자 하는 요구는 문화에 따라 광범위한 차이가 있다. 어떤 행동은 받아들일만하고 바람직한 것으로 보이지만 어떤 행동은 용납되지 않는 것으로 여겨진다. 이는 이러한 행동이 발생하지 않았다거나 성교육 토론에서 제외되어야 한다는 것을 의미하는 것은 아니다.
- 섹슈얼리티는 일생을 통해 다양한 방식으로 나타나며 신체적, 정서적, 인지적 성숙과 상호작용을 한다. 교육은 성적인 복지를 증진하고 아동청소년들이 삶의 여러 단계에서 건강하고 책임 있는 관계를 유지할 수 있도록 준비하는 주요 도구이다.

섹슈얼리티의 정의와 개념적 이해에 대한 자세한 내용은 PAHO(미주보건기구)와 WHO(세계보건기구) 2000. 성 건강 증진. 행동 권고. 워싱턴 DC. PAHO <http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2008/PromotionSexualHealth.pdf>, WHO. 2006a 참조. 성 건강에 대한 정의는, 성 건강에 대한 기술적 협의 보고서(2002. 1. 28-31 제네바 세계보건기구) 참조 http://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en/

2.2 CSE 핵심 고려사항

CSE는 재생산, 위험, 질병에 대한 교육을 넘어서나.

청소년의 삶 가운데 많은 경쟁적인 정보 자원을 고려해볼 때, 청소년들의 효과적인 학습과정 참여와 그들의 전반적인 요구에 대응하기 위해서는 균형적이고 포괄적인 접근이 요구된다. 아울러 CSE는 재생산, 성적 행동, 위험과 질병 예방에 대한 콘텐츠 뿐 아니라, 상호 존중과 평등에 기반한 사랑과 관계와 같은 긍정적인 방법으로 섹슈얼리티를 제시할 수 있는 기회를 제공한다.

또한 CSE는 젠더, 불평등한 권력, 사회경제적 요소, 인종, HIV, 장애, 성적 지향 및 성 정체성과 같은 광범위한 관계 및 취약성과 연관되어 있는 사회문화적 요소에 대한 지속적인 토론을 포함하고 있다.

CSE가 다루는 주제는 다양하며 일부는 문화적 맥락에 따라 민감한 것도 있다. 많은 경우, CSE 커리큘럼은 핵심주제를 생략하거나 회피하고 책임있는 성적 행동과 건강하고 평등한 관계의 중요성에 초점을 두지 않고 재생산의 ‘메커니즘’만을 너무 많이 강조한다.(UNESCO 2015a) 핵심주제를 생략하는 것은 CSE의 효과성을 떨어뜨리게 된다. 예를 들어, 월경을 언급하지 않으면 그것에 대한 부정적인 사회문화적 태도가 지속될 수 있다. 이는 여자아이들의 삶에 부정적으로 영향을 미쳐 평생 신체의 불편함을 초래할 수 있으며 문제가 발생했을 때 도움을 구하지 않고 침묵하게 될 수도 있다. 다른 예로는, 성관계, 임신에 대한 과학적 정보, 장애가 있는 청소년에 대한 성과 재생산권(SRH)에 대한 요구, 조혼(CEFM)과 여성할례(FGM/C)와 같은 불안정한 낙태와 유해한 관행 또는 성적 지향이나 성 정체성에 기반한 차별이 있다. 이러한 주제들에 대해 침묵하거나 생략하는 것은 낙인, 수치, 무지를 낳고 위험을 감수하고 취약하거나 소외된 사람들을 돕지 못하게 하는 장벽을 만들 수 있다.

이 지침서는 특정 사회에서 민감하거나 어려울 수 있는 몇 가지 측면을 포함하여 **청소년들의 삶에서 섹슈얼리티의 현실과 영향을 다루는 것의 중요성을 강조한다. 과학적 증거를 사용하고 성평등 및 인권 기준 및 체계 안에 내용을 담는 것은 민감한 문제를 다루는데 도움을 준다.**

양질의 CSE 커리큘럼이 있는 경우에도, 교사는 그들이 가르치기에 불편한 주제는 피하거나 축소하곤 한다. 민감하고 논쟁의 여지가 있는 주제를 가르칠 전문지식과 경험이 부족한 교사가 많으며 전문적인 CSE 훈련 기회가 제공되고 있지 않다. 양질의 전문 훈련 제공으로 교육 주제에 대한 교사의 숙련도와 편안함의 수준을 높이는 것은, 교사로서 하여금 질 높은 건강과 복지 교육 프로그램을 충실하게 제공할 수 있는 가능성을 높게 된다.(Stead et al., 2007).

연령과 발달에 적합한 섹슈얼리티 및 관계에 대한 교육의 부족은 아동청소년들이 유해한 성적 행동과 성적 착취에 취약해지게 할 수 있다. 또한 CSE에서 복잡한 이슈를 제외하고 교육하는 것은 청소년들의 성적 관행 및 관계의 취약성을 놓고 관련 서비스로부터의 제한을 유발할 수 있다.

CSE는 임신예방을 위해 접근가능한 모든 정보를 제공한다.

성매매 감염병(STIs)와 후천성면역결핍증(HIV), CSE는 언제 누구와 친밀하거나 성적인 형태의 관계를 가질 것인지 선택할 권리를 증진한다. 이는 자신의 선택에 대한 책임을 지고 다른 사람의 선택을 존중하는 것과 관련되어 있다. 이러한 선택에는 성적 관계를 자제하거나, 연기하거나 또는 성적 관계를 맺을 권리를 포함한다. 금욕은 임신, 성매매 감염병(STIs), HIV를 예방하는 중요한 방법이지만, CSE에서는 금욕은 청소년들의 삶 속에서 지속될 수 있는 조건이 아니라는 것과 청소년들이 다양한 연령대별로 자신의 성적 표현을 다양한 방식으로 관리하고 있음을 인식한다. 금욕 프로그램은 청소년의 성 및 재생산 건강과 권리에 효과적이지 않으며 잠재적으로 해로운 것으로 판명되었다(SRHR). (Kirby, 2007; Santeli et al., 2017; Underhill et al., 2007).

CSE는 보다 안전한 섹스에 대해 다루고, 신중한 의사 결정 후에 성교나 다른 성적 활동을 포함하는 친밀한 관계를 맺을 준비를 할 수 있도록 청소년들을 돕는다. 많은 연구 결과에 따르면 학습자들은 성과 관계없이 관계와 감정에 대해 더 많이 알고 싶어하며, 성적 친밀감이 있든 없든 존중과 소통에 기반한 건강한 대인관계를 형성하는 방법에 대해 더 알고 싶어하는 것으로 나타났다. 따라서 CSE는 청소년들이 자신의 가치관에 맞게 성적 감정을 표현하는 방법을 생각할 수 있도록 격려하는 데 중점을 둔다. 성관계를 계획 중이거나 이미 성관계를 하고 있는 청소년에게는 임신과 콘돔 사용에 의한 성매매 감염병(STIs)으로부터의 이중적인 보호를 포함하여 모든 형태의 피임법에 대한 정보를 알고 있는 것이 필수적이다.

청소년들은 남녀 모두 콘돔을 구하는 방법 및 정확하고 지속적으로 사용하는 방법, 중대한 HIV 감염위험에 처한 것으로 간주되는 사람들을 위한 노출 전 예방 요법(PrEP)의 가능성에 대한 정보를 필요로 한다. 청소년들은 또한 정신-사회적 지원, 노출 후 예방요법(PEP), 임신, 성매개감염병(STI) 및 HIV 서비스와 같은 성적 학대 또는 폭력과 관련된 서비스를 포함하여 청소년 맞춤 포괄적 정보를 제공받거나 추천 받아야 한다.

CSE는 학습자 중심 접근법을 사용한다.

전통적으로 교육에서 교사는 학습 과정의 '감독'으로 학생은 수용적인 역할을 해왔다. 지난 수십년 동안 학습은 학생이 이미 가지고 있는 지식을 기반으로 하여 이루어지며, 학습자는 환경과 제공된 학습내용과의 상호작용에 기초하여 자신의 지식을 구성한다는 학습에 대한 새로운 접근법이 개발되었다(Giroux, 1994). 이러한 관점에서 볼 때, 학습은 교사가 전달하는 정보를 수신하고 처리하는 과정 이상임을 알 수 있다. 학생들은 개인적인 경험과 정보에 비판적으로 참여함으로써 정보와 자료에 대한 자신의 이해를 구축할 수 있도록 허용할 때 가장 잘 배운다.

연구에 따르면, 일반적으로 학습자 중심 또는 협력학습 전략은 효율적인 보건교육 프로그램을 위해 필수적인 것으로 밝혀졌다. 핀란드의 섹슈얼리티 교육이 또래집단의 성 지식 및 태도에 미치는 영향에 대한 연구에 따르면, 동기부여, 교사의 태도와 기술, 참여수업 기술을 적용하는 능력이 교육 효과에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다(Kontula, 2010). 이 지침서는 학습자 중심 접근법과 협동학습 전략에 의한 CSE 프로그램을 장려한다. 학습자 중심 접근법은 학습자로 하여금 학습과정에 적극적으로 참여하도록 하고 학습자의 독특한 학습 스타일을 장려한다. 학습은 개인 성장의 한 형태로 볼 수 있기 때문에 학생들은 자신의 삶에 대해 비판적으로 생각하는 반성적 사고를 할 것을 권장한다.

학교는 CSE 제공에 있어 중심적인 역할을 담당한다.

다른 활동가와 기관이 아동청소년이 어른으로서의 역할과 책임을 다할 수 있도록 준비시키는데 중요한 역할을 하는 동안, 교육 현장에서는 CSE 제공에 있어 중요한 역할을 한다. 교수학습 및 개인 발달을 위한 곳으로서 학교는 숙련되고 신뢰할 수 있는 정보 제공자로서의 교사와 장기적인 프로그램을 제공하는 공식 교육과정을 포함한 기존 인프라를 제공한다. 교사는 아동청소년의 연령 및 발달에 적합한 학습 경험을 제공하는데 능숙하며 청소년은 학교와 교사를 신뢰할 수 있는 정보 제공자로 본다.

대부분의 국가에서 5-13세 사이의 어린이들은 학교에서 비교적 많은 시간을 보내고(UNESCO, 2008), 이는 반복 가능하고 지속 가능한 방식으로 다양한 배경의 청소년들을 만날 수 있는 실용적인 수단을 제공한다. 또한 학교는 해를 거듭하면서 새로운 내용을 추가하고 연령과 발달단계에 따라 CSE를 제공할 수 있다(Gordon, 2008).

많은 청소년들이 학교에서 사춘기 뿐 아니라 성 관계를 포함한 첫 관계를 경험하게 된다. 따라서 권리, 관계, SRH에 대한 연령별, 단계별 교육을 제공하고, 아동, 청소년에 대한 성인지 관점 교육을 제공하는 것이 더욱 중요하다.

학교에서의 CSE 교육의 장점은 다음과 같다.

- 학교는 여러 측면에서 학습 환경을 보호 지원하기 위한 규제 권한이 있다.
- 학교 기반 프로그램은 HIV 예방 및 SRH 교육 및 서비스에 대한 청소년의 권리를 보장하는데 대한 비용 효율성이 매우 높다(Kivela et al., 2013; UNESCO, 2011a; 2016c).
- 학교는 아동, 부모, 가족, 지역사회를 다른 서비스(예: 보건 서비스)와 연결하는 사회적 지원 센터 역할을 한다.

학교교육 이외에도 대학 이후의 교육기관에서도 중요한 역할을 할 수 있다. 많은 사람들이 어떤 섹슈얼리티 교육도 받지 않은 채 고등교육에 이른다. 많은 학생들이 처음으로 집을 떠나 관계를 발전시키고 성관계를 갖기 시작하는 시기일 수 있기 때문에 고등교육단계에서의 CSE 제공은 특히 중요하다.

지역사회 기반 교육 또한 CSE 과정을 제공하는 중요한 기회이다.

지역사회 기반 CSE 프로그램은 특히 학교 출석률이 낮은 또는 적절한 CSE 프로그램이 국가 교육과정의 하나로 포함되어 있지 않은 국가에서 학교 밖 청소년 및 가장 취약하고 소외된 청소년에게 제공될 가능성이 있다. 학교에 다니지 않거나 중퇴한 6-15세 사이의 2억 6천 3백만 명의 아동청소년에게, 커뮤니티 센터, 스포츠 클럽, 스카우트 클럽, 종교단체, 직업 시설, 보건기관, 온라인 플랫폼 등과 같은 지역사회 기관은 교육에서 필수적인 역할을 한다(IPPF, 2016).

학교에 다니는 청소년들 또한 주말, 야간, 방학 동안 지역사회 기반 CSE 프로그램에 참여하곤 한다. 지역사회 기반 CSE 프로그램을 할 경우 학교에서 제공하는 콘텐츠를 보완하고 확장하여 제공한다. 예를 들어, 세계 일부 지역에서는 교사가 교실에서 콘돔 사용법을 시연하는 것이 금지되어 있지만 대부분 지역사회 기반 교육에서는 그렇지 않다. 그리고 지역사회 기반 수업은 40분으로 제한되지 않으며, 지역사회 기반 교육에서 제공되는 CSE는 학부모와 지역사회 리더들을 감동시키고 SRH 서비스와 보다 긴밀한 관계를 구축할 기회를 제공하기도 한다.

지역사회 기반으로 CSE 프로그램을 제공하는 방법이 다를 수는 있지만, 교육내용은 반드시 입증되어야 하며 연령별 특성에 따라 권장되는 주제를 다루어야 하며, 효과적인 프로그램의 특성을 살려야 한다. (5장. 핵심 개념, 주제, 학습목표와, 7장. 효과적인 CSE 프로그램 제공 참조)

3

청소년

건강과 복지

3 - 청소년 건강과 복지

이 장에서는 성 및 재생산 건강(SRH)에 대한 개요 및 아동청소년의 건강과 복지에 영향을 미치는 핵심 문제와 요구에 대해 다룬다.

3.1 아동청소년의 성 및 재생산 건강(SRH)

성 및 재생산 건강(SRH)은 섹슈얼리티와 관련한 신체적, 정서적, 정신적, 사회적 복지 차원을 모두 포함한다. 이는 단지 질병, 기능 장애가 없거나 허약하지 않은 것만에 대한 것이 아니다(WHO, 2006a). 건강한 습관과 건강 유지 방법에 대한 이해는 어릴 때부터 시작된다. 사춘기는 신체적, 정서적, 사회적 변화가 지속되는 시기이면서 동시에 개별적인 섹슈얼리티에 대한 탐색이 시작되고 다른 사람들과의 관계를 발전시키기 시작하는 시기이기 때문에 SRH와 관련된 건강한 습관과 라이프스타일을 구축할 수 있는 적절한 시기이다.

청소년에게 영향을 미치는 핵심 성 및 재생산 건강(SRH) 이슈

사춘기 : 어린이에서 성인기로의 전환은 남녀모두에게 흥미로우며 중대한 변화를 가져올 수 있다. 그러나 남자아이들에게는 사춘기의 변화는 성적인 느낌에 긍정적인 방법으로 훨씬 더 분명해지도록 하지만, 반면에 여자아이들에게는 이 순간이 섹슈얼리티, 처녀성, 출산능력, 여성성에 대해 상충되는 메시지가 시작되는 시기이다.

여자아이들에게 사춘기는 월경을 하면서 시작된다. 월경을 문화적 금기와 수치로 여기는 곳에서는 월경을 하는 동안 여자아이들을 가족과 떨어져 잠을 자거나 먹게 하고 학교도 못 가게 강요하기도 한다. 많은 국가가 학교에 월경 관련 제품을 사적으로 청결하고 적절하게 처리하기 용이한 화장실이 없다. 월경은 일반적으로 도외시되어 온 이슈이며, 많은 국가의 상당수 여자아이들이 월경에 대한 지식의 부족과 오해로 인한 두려움과 불안을 갖게 되고 준비가 안 된 채로 월경을 시작하게 된다(Chandra-Mouli and Vipul Patel, 2017).

남자아이들의 사춘기는 종종 성적 욕구가 시작되고 즐길 수 있는 '힘'으로 간주된다. 발기와 몽정은 잠재적으로 당황스러운 일이지만, 여자아이들이 경험하는 것과 같은 수치스러운 이야기로 접근하지 않는 것이 일반적이다. 남성성이 일반적으로 문제가 있는 것으로 인식되지 않기 때문에 남성성에 대한 논의는 대부분의 성교육 프로그램에 빠져있지만, 남자아이들은 자신의 섹슈얼리티에 대해 다루고 있지 않은 것에 대해 의문을 가지며, 교육의 필요성을 느낀다(UNESCO, 2014b).

신체적, 심리적 변화와 관련된 사춘기는 간성(intersex)이거나 자신의 성 정체성이나 표현에 대해 의문을 갖고 있는 청소년에게 특히 어려운 시기가 될 수 있다.

임신 : 지난 수 십년 동안 세계적으로 출산율이 크게 떨어졌음에도 불구하고 지역에 따라 차이는 있지만 15-19세 사이의 많은 청소년들이 이미 아이를 낳기 시작했다. 2014년 세계 보건 통계에 따르면 15-19세 사이의 평균 출산율은 여자청소년 1000명 중 49명이며, 나라에 따라 여자청소년 1000명 중 1-299명의 출산율을 보였다(WHO, 2014b). 조기 결혼이 핵심 이슈인 개발도상국의 경우 10대 임산부의 출산율의 약 90%가 조기 결혼에서 비롯된다(Plan, 2017). 조기 임신과 출산은 건강과 사회에 심각한 결과를 초래할 수 있으며 19세 미만 청소년기 여자 사망의 두 번째 원인이며, 임신 출산 합병증은 청소년기 여성 사망의 가장 큰 원인 중 하나이다(WHO, 2011). 임신 중인 여자 청소년이 임신과 합병증에 대한 충분한 지식이 없기 때문에, 또는 의료 서비스 접근 및 사용에 대한 결정을 내리는 데 제약이 있기 때문에(예: 시부모 또는 성교에 대한 동의 연령 및 서비스 접근과 관련한 제한된 법과 정책) 나이 든 여성보다 산모 건강 진료가 더 늦어질 수 있다(WHO, 2008). 임신한 청소년들은 학교를 그만두고 학업을 중단함으로써 미래의 취업과 다른 삶의 기회로부터 제한될 가능성이 더 크다(UNESCO, 2017a).

현대적 피임 접근성 : 남녀 청소년 모두 피임약 사용에 대한 책임이 있으나 정작 피임에 대한 여성의 요구는 충족되지 않는 경우가 많다. 보수적인 사회에서 미혼여성이 성 행위를 하는 것을 인정하지 않으므로, 실제 결과보다 설문조사가 결과가 과소평가되었을 수는 있으나, 일반적으로 여성들의 피임에 대한 요구가 충족되지 않는 경우가 절반 이하를 차지한다(Sedgh et al., 2016). 여자 청소년은 피임약의 부작용에 대한 염려와 걱정 뿐 아니라 법적 장벽과 기타 접근성 관련 문제도 있는 것으로 보고된다(IPPF and Coram Children's Legal Centre, 2014; Guttmacher Institute, 2015b). 또한 아시아와 아프리카의 경우 콘돔 및 응급 피임을 포함한 다양한 현대 피임법을 배우고 얻을 수 있는 곳, 임신 또는 HIV 검사 서비스를 받을 수 있는 곳에 대한 지식의 중대한 차이가 있다. 이는 의도하지 않은 임신 및 HIV/성매개 감염병(STI)에 대한 이중적인 보호방법으로써 콘돔 사용에 대한 정보를 제공받는 것이 중요하다는 것을 보여준다.

안전하지 않은 임신 중단 : 전 세계적으로 매년 15-19세 사이의 300만 명의 여자 청소년들이 안전하지 않은 임신중단을 경험한다(WHO, 2014a). 전 세계의 많은 지역에 존재하는 안전한 낙태에 대한 법적 제한 때문에, 청소년들은 미숙한 사람이 집도하는 안전하지 않은 방법에 의존하게 된다. 여자 청소년은 20세 이상의 여성과 비교하여 안전하지 않은 임신 중단 관행으로 인한 사망과 장애의 고통을 겪는다(WHO, 2007b; WHO, 2015). 청소년의 경우 성인 여성에

비해 임신 사실을 깨닫는 데 시간이 오래 걸리고 임신을 중단하려는 청소년은 결국 임신 후반기에 임신 중단을 하는 경우가 많다. 어떤 경우에는, 낙인과 차별 또는 기타 요인으로 인해 여자 청소년은 나이 많은 여성보다 스스로 임신중단을 유도하거나 훈련 받지 않는 의료기관에서 임신중단을 하기 쉬우며, 일반적으로 임신중단 및 임신 중단 후 돌봄에 대한 자신의 권리에 대해 잘 알지 못한다.

젠더 기반 폭력을 포함한 폭력: 전 세계적으로 약 3명 중 1명(35%)의 여성들이 일생 동안 신체적 그리고/또는 성적으로 친밀한 파트너 또는 파트너가 아닌 사람으로부터 폭력을 경험한 것으로 나타났다. 폭력은 개인의 권리를 침해하는 것이며, 여성과 여자 아이들이라는 취약한 인구 집단을 건강과 사회 문제 중 'HIV 감염 및 의도하지 않은 임신 위험'에 빠뜨리는 것이기도 하다(UNAIDS, 2017). 친밀한 파트너에 의한 폭력이 가장 일반적이며(WHO, 2016b), 아동을 대상으로 한 젠더 기반 폭력(GBV)의 실태는 다음 자료들이 보여준다.

- 전 세계적으로 약 1억 2천만 명에 달하는 여자 아이들이 강제 성교 또는 강제 성행위 또는 기타 형태의 친밀한 파트너 폭력을 경험했다(UNICEF, 2014b).
- 아동 성적 학대는 남녀 아이들 모두에게 발생한다. 국제 연구(Barth et al., 2012)는 여성의 약 20%, 남성의 5-10%가 어릴 때 성폭력 피해를 입은 것으로 보고한다.
- 데이트 폭력을 포함하여 청소년들 사이의 폭력 또한 주요한 문제이다(WHO, 2016b).
- 30개국에서 최소 2억 명이 넘는 여성과 여자 아이들이 여성 할례(FGM/C)를 받았다. 이들 국가의 대부분에서 여자아이들 대부분은 5세 이전에 할례를 받았다(Plan, 2016).
- 아동 조기 강제 결혼/동거는 기본적인 권리를 침해하고 어린 신부와 남편 사이의 불균등한 권력 때문에 여자아이들을 취약한 상황에 처하게 한다. 전 세계 조기강제결혼(CEFM) 비율은 사하라 사막 이남 아프리카 지역에서 가장 높았으며, 10명 중 4명은 18세 이전에, 약 8명 중 1명은 15세 이전에 결혼하거나 동거하였다.
- 라틴아메리카와 카리브해 연안(LAC)의 조혼율은 20-24세 사이 여성의 24퍼센트인 사하라 사막 이남 지역을 뒤따랐으며 중동과 북아프리카에 서는 18퍼센트가 어릴 때 결혼을 했다(UNICEF, 2014a).
- 매년 2억 4천 6백만 명의 어린이가 학교에 가는 도중 또는 학교 안에서 학대, 괴롭힘, 심리적 학대 및 성적 괴롭힘을 포함한 젠더 기반 폭력(GBV)의 대상이 되었다. 25%의 아동이 신체적 폭력을 경험하고 36%는 정서적 폭력을 경험한다(WHO, 2016c).

• 레즈비언, 게이, 양성애자 또는 트랜스 젠더를 포함하여 일반적 인 젠더 규범에 맞지 않는 것으로 인식되는 학생들은 학교 내 폭력에 더 취약하다. 동성애 폭력이라고 불리는 성적 지향과 성적 체성/성적 표현에 기반한 폭력은 젠더 기반 폭력의 한 형태이다(UNESCO, 2016b).

• 조기 및 의도하지 않은 임신은 교사와 동료 학생의 성폭력의 결과일 수도 있다. 학교 내 임신 관련 젠더 기반 폭력(GBV)에는 임신한 여자아이와 청소년 엄마에 대한 학급 친구들과 교사들의 따돌림, 괴롭힘을 포함한다(UNESCO, 2017).

HIV와 에이즈: 15-24세 사이의 청소년들의 신HIV 감염 예방을 위한 진전이 세계적으로 이루어졌으나, 감염율은 너무 느리게 감소되고 있다. 2010-2016년 사이에 같은 기간 같은 연령대의 약 12%가 신HIV에 감염된 동유럽과 중앙아시아를 제외한 모든 지역에서 15-24세 연령대의 신HIV 감염이 감소했다(UNAIDS, 2017). 전 세계적으로 HIV와 에이즈는 2015년 10-19세 사이의 청소년 사망 원인 중 9위를 차지했다(WHO, 2017b). HIV와 에이즈는 사하라 사막 이남 아프리카에서 계속 큰 영향을 미치고 있다. 아프리카의 15-24세 사이의 여자 청소년과 젊은 여성들은 HIV에 대한 높은 취약성에 직면해 있다(UNAIDS, 2017). 여러 곳에서 청소년 게이 및 남성 및 트랜스 젠더 청소년과 섹스를 하는 남성을 포함하여 주요 젊은 층이 여전히 HIV의 과도한 부담을 안고 있다(Bekker et al., 2015). HIV에 대한 포괄적 지식이 높아졌다고는 하지만, 2011-2016년 기간 동안 유효한 데이터를 가진 37개국의 젊은 남성의 36%, 젊은 여성의 30%만이 (15-24세) HIV 예방법에 대한 포괄적이고 정확한 지식을 갖고 있는 것으로 나타났다(UNAIDS, 2017). 특정 위험 요소(예: 성적 네트워크를 통한 전염 또는 나이 차이가 큰 관계에서의 섹스와 항문 섹스와 관련된 위험), 더욱 새로운 생물학적, 의학적 예방법(예: 노출 전 예방요법(PrEP)), HIV와 젠더 기반 폭력(GBV)간의 연관성에 대한 지식이 낮을 수 있다(UNAIDS, 2016).

성매개 감염병(STIs): 매년 약 3억 3,300만 건의 치료 가능한 새로운 성매개 감염병이 발생하는데 20-24세 사이의 비율이 가장 높고 15-19세가 그 뒤를 잇는다. 청소년 20명 중 1명은 HIV 및 기타 바이러스 감염을 제외한 성매개감염병에 감염된 것으로 알려져 있다. 소수의 청소년들은 적당하고 저렴한 성매개감염병 관련 서비스를 이용할 수 있다(WHO, 2005). 그러나 성병에 대한 통계는 제한되어 있으며 지역 및 국가간, 지역 및 국가 내부에서도 일관성이 없다. 이는 특히 나이와 성별로 분리된 통계의 경우 더 그런데 이는 실제적인 책임을 불분명하게 하고 국제적인 대응을 어렵게 한다.

3.2 CSE에서 다루는 아동과 청소년의 건강과 복지 핵심 이슈

정보통신기술이 성적 행동에 미치는 영향 : 국가는 새로운 정보통신기술(ICT)과 소셜미디어가 삶에서 점점 더 중요한 역할을 하는 상황에서, 청소년들이 책임 있는 선택을 하는데 필요한 지식과 능력을 갖추는 것이 더욱 중요해지고 있다는 것을 인식하고 있다. 예를 들면 다음과 같다.

- **성 관련 정보와 이미지는** 인터넷에서 광범위하게 볼 수 있으며, 많은 아동·청소년에게 처음으로 접하는 섹슈얼리티 교육이 될 수 있다. 정보통신기술과 소셜 미디어는 섹슈얼리티와 관계에 대한 긍정적이고 정확하며, 비판적인 정보 접근성을 높일 수 있는 막대한 잠재력을 가지고 있다. 그러나 이러한 기술은 또한 부정확하고 부적절한 정보 접근성을 제공할 수 있으며 폭력적인 포르노물에 대한 접근성을 높여 유해한 젠더 규범을 강화할 수 있다 (Brown and L'Engle, 2009, Peter and Valkenburg, 2007).
- **사이버 괴롭힘** - 유럽연합(EU) 보고서에 따르면 15세 이상의 여성 10명 중 1명이 사이버 괴롭힘(원하지 않는, 불쾌감을 주는 그리고/또는 성적으로 노골적인 이메일 또는 SMS 메시지 또는 소셜 네트워킹 사이트에서의 불쾌하고 부적절하게 추근덕거리는 것을 경험한 것으로 나타났다. 사이버 괴롭힘을 경험 하면 정신적 장애가 발생할 수 있는데, 연구에 따르면 사이버 괴롭힘과 피해의 수준이 높을수록 우울감의 정도가 높아지고 피해자는 슬픈 감정, 우울감, 절망감, 무력감을 느끼는 것으로 나타났다(Nixon, 2014).
- **섹스팅(Sexting)** - 공개학술토론에서 자체 제작한 성적 이미지를 휴대폰이나 인터넷으로 사적으로 주고받는 것은 청소년들 사이의 새로운 고위험 행동으로, 교육의 개선과 확대를 통해 관행적으로 발생하는 심각한 여러 가지 위험에 대한 대처와 예방이 필요하다는 논의가 이루어졌다.

청소년들로 하여금 자신이 받은 성적인 메시지를 비판적으로 평가할 수 있도록 지원하는 것과 아울러, 현실적이며, 감정을 고려하며 함부로 판단하지 않는 새로운 유형의 디지털 성교육 환경에 대한 접근성을 필요로 한다. 정보통신기술을 안전하게 사용하는 방법을 토론할 때는 청소년의 취약성과 성적 주체로서의 청소년에 대한 관점간의 균형을 잘 유지하도록 하는 것이 중요하다 (Oosterhof 외, 2017).

취약한 정신적/정서적 건강 : 정신 건강 문제는 종종 학교 중퇴 증가와 관련이 있다(Kennedy et al., 2006). 정서적, 정신적 건강 문제는 또한 위험한 섹스, 성매개감염병 및 조기 성적 경험의 증가와 관련이 있다. 안전하지 않은 섹스를 포함하여 위험을 감수하는 것은 간접적인 분노의 표출이거나 자기 삶에 대한 통제하고자 하는 시도일 수 있다. 정신 건강 장애를 가진 청소년은 인지, 비인지 능력 개발의 어려움을 겪으며 자살을 시도할 가능성이 크다(Cash and Bridge, 2009). 정신 건강 문제와 성 및 재생산 건강의 연관성에 초점을 둔 연구는 거의 없지만 중요한 관계가 있다. 예를 들어, 적절한 지원 시스템이 없는 레즈비언, 게이, 양성애자, 트랜스젠더, 인터섹스(LGBT²) 청소년의 경우, 남들과 다르게 사회적 규범에 맞지 않는다는 느낌이 더 높은 수준의 폭력, 따돌림, 괴롭힘과 같은 위험에 노출된 것과 결합하여 분노, 우울, 슬픔, 스트레스 또는 걱정을 포함한 정신 건강 문제를 일으킬 수 있다(Baltag et al., 2017; Hiller et al., 2010).

알코올, 담배, 마약 : 알코올 등 물질은 현재와 미래의 건강 뿐 아니라 다른 차원에서 청소년들의 복지에 부정적 영향을 미칠 수 있다. 알코올 등 물질 사용자들은 중독이 빠르게 될 수 있고 나쁜 학업 성적, 학교 결석 및 조기 퇴학 등 그리고 자살 시도로 이어질 수도 있는 낮은 자존감과 정신 장애와 같은 인지적 문제와 교육의 어려움에 이르기까지 수많은 문제에 직면하게 된다(Hall et al., 2016). 알코올 등 물질 남용은 의사결정을 방해하고 흥분하게 하며, 억제력을 감소 시키므로 위험한 성적 행동의 증가를 가져온다는 연구 결과가 많다. (WHO, 2010). 학교 기반 프로그램은 대부분의 학생들이 항정신성 물질에 초기에 노출되었을 때 가장 효과적이다(UNESCO, 2017b).

2 LGBTI 용어를 사용할 때는 실제 또는 인식된 성적 지향, 성 정체성 및 성적 표현, 성별 특성을 이유로 폭력 및 차별을 당하는 사람들을 포함하는 것이 중요하다. (레즈비언, 게이, 양성애자, 트랜스젠더 및 인터섹스(LGBTI) 성인, 청소년, 아동에 대한 폭력 및 차별 철폐에 관한 기구간 성명서, 2015)

3.3 취약 아동청소년 집단의 특정한 성 및 재생산 건강 요구와 이슈

청소년들은 동질적인 집단이 아니다. 청소년들의 가족 상황, 사회 경제적 상황, 성별, 인종, 민족, HIV 상태, 지리적 위치, 종교, 문화적 신념, 성적 지향 및 성 정체성 등 많은 다른 요인들이 청소년들의 SRH, 교육 및 삶의 기회, 일반적인 복지에 영향을 미친다. 구치소에 있거나 보호시설에 있는 청소년, 원주민 청소년을 포함하여 필수적인 CSE 및 성 과 재생산 건강 및 다른 건강 서비스에 대한 접근할 수 없는 청소년들을 포함하여 많은 청소년들이 소외받고 있으며, 취약한 상황에 놓이고 낙인과 차별을 당하고 있다. 난민, 망명 신청자 및 이주 아동은 조혼, 폭력 및 인신매매와 같은 여러 가지 문제에 취약하다. 이들 각각에 대한 다른 CSE가 필요하며, 지침서는 현실에 적합한 CSE 교육과정을 구성하는데 도움을 줄 것이다. 예를 들면 다음과 같다.

- **HIV(YPLHIV) 청소년** : 현재의 섹슈얼리티 교육 프로그램은 HIV 예방에 초점을 두고 있으며 종종 청소년 HIV 감염자의 요구를 충족하지 못한다. 청소년HIV(UNAIDS, 2017) 감염자의 치료 지속성이 낮은 가운데, 학교는 재발 방지, HIV 전염 방지, 긍정적이고 건강한 삶을 살기, 낙인과 차별 줄이기 교육을 포함하여 서비스 접근에 대한 지원 및 지속적인 치료를 하도록 지원하는 중요한 역할을 한다(UNESCO와 GNP+, 2012).
- **빈곤 청소년** : 빈곤은 청소년 발달과 복지를 제약하는 주요 요인이다. 가난한 시골 가정에 살고 있는 청소년은 물질적 불이익을 당하고, 사회적으로 배제되며, 건강에 즉각적이고 미래에 부정적 결과를 초래하는 영양 부족과 주거환경으로 고통받고 있다. 빈곤 아동청소년은 폭력에 노출 되어 스스로 폭력을 할 가능성이 다른 사람에 비해 높다. 또한 학교 이탈, 알코올 등 약물 남용, 조기 성적 행동 시작, 거래 또는 상업적인 섹스, 보호받지 못하는 섹스와 같은 위험한 행동을 할 가능성이 높다(Okonofua, 2007; USAID, 2013). 또한 빈곤 가정의 여자 청소년과 여성은 부유한 가정의 여자 청소년 및 여성에 비해 18세 이전에 임신 또는 출산을 경험하게 될 확률이 높다(UNFPA, 2013).
- **장애 청소년** : 역사적으로 장애가 있는 사람들은 성적으로 무관심하거나 자유분방한 것으로 인식되곤 했으며, 일반적으로 장애인을 대상으로 한 성교육은 불필요하거나 심지어 해로운 것으로 간주되었다. 몇몇 국가만이 장애인 권리 협약에 규정된 장애 청소년의 인권 구현을 위해 나아갔다. 연구에 따르면 장애인은 성 폭력으로 인해 균형을 잃고 HIV 감염에 더욱 취약해질 수 있다(Hughes et al., 2012).

장애가 있는 청소년에 대한 기존의 교육은 성을 위험한 것으로 묘사 하고 과거 장애인의 섹슈얼리티를 문제가 있는 것으로 보았던 것을 되풀이한다(Rohleder와 Swartz, 2012). 정신적, 심리적 또는 정서적 장애를 갖고 살아가는 청소년은 모두 성적 존재이며 강압 및 폭력 없는 쾌적하고 안전한 성적 경험을 포함하여 도달 가능한 최고 수준의 섹슈얼리티를 즐기고, 양질의 섹슈얼리티 교육 및 SRH 서비스를 받을 동일한 권리가 있다.

- **레즈비언, 게이, 양성애자, 트랜스젠더, 인터섹스(간성) 청소년 (LGBTI)** : 전 세계적으로 LGBTI 사람들에 대한 엄중한 규제와 처벌을 하는 나라가 많다. 규제는 다음과 같은 직간접적인 박해의 형태를 취한다. 개개인에 대한 적극적인 기소(IPPF 및 Coram 아동법률센터, 2014)를 한다거나, 성적 지향, 성 정체성 및 성적 표현에 따른 괴롭힘, 낙인, 차별, 피해로부터 개인을 보호하지 못한다거나, 또는 인터섹스(간성) 아동·청소년의 경우 영구 불임, 통증, 요실금, 성 감각 상실 및 평생 정신적 고통을 유발할 수 있는 불필요한 수술 및 기타 절차로부터 보호하지 못하고(OHCHR, 2016), 구제 수단에 대한 접근성이 부족한 것을 예로 들 수 있다. LGBTI 청소년의 성 및 재생산 건강 관련 삶과 요구에 대한 연구는 충분하지 않다. CSE 프로그램은 섹스의 특성 또는 인터섹스 아동·청소년에게 영향을 주는 생물학적 변이에 대한 정보를 포함하여 LGBTI 집단과 관련한 교육내용을 생략하는 경우가 많다. 학교에 다니는 LGBTI 청소년은 특히 피해와 차별의 영향을 받는다. 예를 들어 학교에서의 동성애 혐오와 트랜스젠더 혐오는 학습을 방해하고 폭력적인 괴롭힘과 보복에 놓이는 토대가 된다(UNESCO, 2015b).
- **인도적 위기에 처한 아동청소년** : 분쟁 국가 또는 교육을 받을 수 없는 인도적 위기 환경에 거주하는 초등학생은 총 2천 850만 명으로 전 세계 학교 밖 아이들의 절반을 차지한다(Save the Children, 2015). 또한 국제적 연구에 따르면, 인도적 환경에서의 청소년에 대한 성과 재생산 건강 프로그램의 필요성에 대한 인식은 커지고 있으나 성 및 재생산 건강서비스에 대한 접근성을 포함한 프로그램의 격차가 상당히 크다는 것이 발견되었다(Women's Refugee Commission et al., 2012).





4

포괄적

성교육의 성과

4- 포괄적 성교육의 성과

이 장에서는 아동·청소년의 건강 요구와 관련하여 CSE가 어떤 역할을 했는지에 대해 소개한다.

4.1 도입

이 장에서는 섹슈얼리티 교육을 통한 일차적(성적 행동 및 건강)인 성과와 이차적(지식, 태도, 기타 건강 및 행동의 변화 이외의 것) 성과가 무엇인지에 대해 소개한다. 이를 위해 주로 UNESCO에 위탁한 2008년과 2016년 과정의 성과 연구를 참고하였다. 2008년 성과 연구는 전 세계적으로 실시된 87건의 연구결과를 기반으로 교육훈련연구연맹(Education, Training and Research Associates)의 더글라스 커비(Douglas Kirby)에 의해 수행되었다. 2016년 성과 검토 중 22개는 엄격한 체계적 연구를 하였으며, 77개는 절반 이상이 저소득 국가 또는 중간 소득 국가로 광범위한 국가 및 맥락 속에서 무작위 비교 연구를 하였다. 연구는 옥스퍼드 대학 성과 기반 중재 센터(Evidence-Based Intervention) 폴 몽고메리(Paul Montgomery)와 웬디 크너(Wendy Knerr)에 의해 수행되었으며, 본 지침서에는 유네스코 2016c로 소개되었다.

4.2 성과 연구의 주요 결과

전반적으로, 학교 기반 섹슈얼리티 교육의 효과성은 교육성과에 대한 많은 긍정적 결과 연구 보고와 함께 지속적으로 발전 강화되고 있다.

2016년 연구 결과에 따르면 CSE 성과는 2008년 이후로 확대되었지만, 초기 지침서의 결론과 권고 사항의 상당 부분이 여전히 타당하고 적용 가능한 것으로 유지되고 있다. 연구를 통해 재확인한 교육과정을 기반으로 한 섹슈얼리티 교육 프로그램의 성과는 다음과 같다.

- 성행위 시작 시기 지연
- 성행위 빈도 감소
- 성 파트너 수 감소
- 위험한 행동의 감소
- 콘돔 사용 증가
- 피임 증가

2016년 성과 연구에 따르면 섹슈얼리티 교육은 섹슈얼리티의 다양한 양상과 임신, HIV, 기타 성매개감염병 관련 행동 및 위험성에 대한 지식의 증가를 포함하여 긍정적인 영향을 미친다. 또한 섹슈얼리티 교육은 성 및 재생산 건강 관련 태도를 향상시킨다는 강력한 연구 결과도 있다(UNESCO, 2016c).

개정 지침서는 학교 안팎에서의 섹슈얼리티 교육이 성적 행동 및 성적으로 위험한 행동, 또는 성매개감염병/HIV 감염비율을 낮춘다는 것을 강조하는 초기 지침서와 광범위한 과학적 실천적 문헌에서의 연구결과를 반영한다.

여전히 고품질의 임상 시험이 거의 실시되지 않고 있고, 특히 종단적 연구가 거의 없어, 성매개 감염병 또는 HIV 비율과 같은 생물학적 성과에 대한 CSE의 영향이 무엇인지 강력한 결론을 내리기는 어렵다.

연구결과에 따르면 교육과정이 의도한대로 포괄적 범주로 제공되고, 청소년들이 CSE의 목표(표 4. 참조) 달성에 '효과적'인 것으로 자신을 특징지을 때 결과적으로 청소년 건강에 바람직하고 긍정적인 효과가 있다고 한다. 또한 학교 기반 섹슈얼리티 교육은 학교, 지역사회, 건강 서비스, 가정/가족을 포함한 복합적인 환경을 둘러싼 자신의 성 및 재생산의 미래를 학습하고 실현하는데 청소년들이 참여하는 것을 목표로 하는 총체적 전략의 일부가 되어야 한다고 결론짓는다.

양질의 높은 성과는 다중적 개입, 특히 학교 기반 섹슈얼리티 교육과 콘돔 배포를 비롯한 비학교 기반 청소년 친화적 서비스 연계를 지원한다. 학교 기반 CSE는 HIV 예방과 청소년 스스로 자신의 건강과 권리를 지키도록 하는데 충분하지는 않지만 여전히 중요하고 비용 효율적인 전략으로 남아있다(UNESCO, 2011a).

대부분 연구의 초점은 건강과 관련한 성과에 대한 것이지만, 이 지침서에서 제시된 수정된 정의에 따르면, CSE에 대한 발전적인 이해를 통해 교육이 성평등한 태도, 자신감 또는 자아 정체성과 같은 더 폭넓은 성과를 가져올 수 있음을 인식한다. 체계적 연구의 분석 결과에 더하여, 2016년 연구에서는 저소득 및 중간 소득 국가 포함 기준(즉, 무작위, 비교, 또는 질적 연구)을 특히 충족시키지 못했던 2008년 연구에 반해 CSE 프로그램 평가를 위해 사용된 실질적인 수많은 연구가 있다고 말한다. 섹슈얼리티 교육 개발, 실행, 평가에 대한 전문가의 권고와 함께 이러한 연구 결과는 건강에 대한 성과를 넘어서는 변화 - 젠더 기반, 친밀한 파트너사이의 폭력과 차별을 방지하고 감소, 성평등 규범의 증가, 자아 효능감과 자신감, 더욱 강하고 건강한 관계 구축에 기여하는 CSE 프로그램의 잠재적 효과를 나타낸다.

현재까지 건강에 대한 성과가 아닌, 이러한 효과를 평가하는 철저한 연구는 제한적이다.

건강 외의 성과에 대한 연구 분야와 관련하여, 바람직한 CSE 성과 범주에서의 효과성 평가를 위해 성 규범 및 폭력에 대한 인식을 파악해야한다는 생각이 증가하고 있다. 일부 연구는 젠더 및 권력 규범이 특히 여자 어린이 및 청소년의 성적 위험에 대한 새로운 지식 기반 행동 능력을 포함한 CSE 프로그램 효과에 영향을 미치는 방법에 대한 분석의 필요성을 강조한다. 또한 지식과 태도 뿐 아니라 제한적인 젠더 규범을 확인하고 분석하는 것의 중요성을 강조한다. CSE 효과성에 영향을 미칠 수 있는 폭력의 역할을 고려한 평가도 마찬가지로 중요하다.

평가 연구, 연구 방법, 2016년 성과 연구를 위해 참조한 연구 자료 전체 목록 관련 기준에 대한 자세한 정보는 부록 IV(평가 연구 및 연구 방법의 선정 기준)과 부록 V(2016년 성과 검토 참고 연구 자료)를 참조하기 바란다.

핵심 성과 요약

- **섹슈얼리티 교육** : 학교 안 밖에서의 섹슈얼리티 교육이 성적 행동, 성적 위험 또는 성매개 감염병/HIV 감염률을 증가시키지 않는다(UNESCO, 2009; Fonner et al., 2014; Shepherd et al., 2010).
- **섹슈얼리티 교육은 성과 재생산 건강 및 행동에 대한 지식의 향상과 태도 개선을 포함하여 청소년에게 긍정적인 효과가 있다** (UNESCO, 2016b). 연구에 따르면 거의 모든 섹슈얼리티 교육 프로그램이 섹슈얼리티의 다른 측면 과 임신 또는 HIV 및 다른 성매개감염병에 대한 지식을 향상시킨다.
- **금욕을 조장하는 프로그램은 성행위 시작 시기를 늦추거나 섹스 회수 및 섹스 파트너 수를 줄이는데 효과가 없는 것으로 나타났다.** 성행위 시작 시기를 늦추는 데 초점을 두고 콘돔 또는 피임약 사용에 대한 내용을 결합한 프로그램이 효과적인 것으로 나타났다(UNESCO, 2009; Fonner et al., 2014).
- **효과적인 피임과 콘돔사용에 대한 프로그램이나 성행위 감소와 같이 하나 만에 초점을 두는 프로그램보다, 임신 예방과 성매개 감염병/HIV 예방 등 모두를 함께 다루는 프로그램이 더욱 효과적이다**(Lopez et al., 2016; UNESCO, 2016c).
- **명시적 권리에 기반한 접근법을 사용한 CSE 프로그램은 성적 관계에서 자신의 권리에 대한 지식 향상, 섹스 및 관계에 대한 파트너와의 의사소통의 증가, 위험한 상황을 다루는 자기 효능감의 증가를 포함하여 지식 및 태도에 단 기적으로 긍정적인 효과를 나타낸다.** 또한 심리사회적, 행동에 있어 장기적으로 유의미하고 긍정적인 효과가 있는 것으로 밝혀졌다(Constantine et al., 2015b; Rohrbach et al., 2015; UNESCO, 2016c).

- **젠더에 초점을 둔 프로그램은 의도하지 않은 임신이나 성병 비율 감소와 같은 건강 목표 달성에 있어 ‘젠더를 고려하지 않은’ 프로그램 보다 훨씬 더 효과적이다.** 이는 학생들로 하여금 젠더를 둘러싼 사회문화적 규범에 의문을 제기하고 성평등한 태도를 개발하도록 지원하는 전환적 콘텐츠와 교수법을 포함한 결과이다 (Haberland and Rogow, 2015).
- **실행 가능성이 높은 프로그램, 즉 효과적인 커리큘럼을 원래 의도한대로 전달할 때, 원래의 기획, 내용 또는 전달 방법에 충실하지 않은 것보다 청소년 건강에 바람직하고 긍정적인 영향을 줄 가능성이 훨씬 높다**(Michielsen et al., 2010; Shepherd et al., 2010; Wight, 2011). 연구 결과 프로그램 횟수나 시간을 줄이는 것, 참가자의 참여를 줄이는 것, 이론적 접근 방식을 변경하는 것, 적절한 훈련이나 자격이 없는 직원 또는 자원봉사자를 활용하는 것과 같이, 프로그램을 수정(예를 들어, 프로그램 적용 과정에서)하는 것은 효과성을 감소시킬 위험이 있는 것으로 나타났다(O'Connor et al., 2007). 그러나 언어, 이미지 또는 문화적인 자료를 변경하여 일부 적용하는 것은 효과에 큰 영향을 미치지 않는다.
- **효과적으로 잘 설계된 교육은 교육환경이 바뀌어 다른 방식으로 실행된다 하더라도 지식, 태도 또는 행동에 긍정적인 영향을 미친다**(Fonner et al., 2014; Kirby et al., 2006). 이는 투입되는 자원이 적어진다 하더라도 한 국가 또는 문화적 환경에서 효과적인 것으로 판단되는 잘 설계된 심리사회적, 행동적 개입은 다른 맥락에서도 똑같이 성공적일 수 있다는 것을 보여주는 연구 결과와 일치한다(Gardner et al., 2015; Leijten et al., 2016).

- 섹슈얼리티 프로그램은 위험한 성적 행동(의도하지 않은 섹스와 같은)을 피하 고자 하는 의지와 지식, 기술의 향상, 의료서비스 이용 의향을 높이는 것으로 나타났지만, 사회 및 젠더 규범, 폭력의 경험, 서비스 이용 장벽과 같은 요인 과 더욱 안전한 성적 행동을 위한 청소년들이 어떤 행동을 취하는 것은 매우 어려운 과제 일 수 있다(UNESCO, 2009).
- 가장 영향력 있는 섹슈얼리티 교육은 콘돔 배포, 청소년 친화적인 서비스를 제공하도록 훈련된 건강관리 제공, 부모와 교사의 참여를 포함한 지역사회 자원과 연계된 학교 기반 프로그램이다. 특히 학교 기반 섹슈얼리티 교육과 비학교 기반 청소년 친화적 건강 서비스가 연계된 다층적인 프로그램은 특히 학교 밖 청소년을 비롯한 소외 계층 청소년에게 접근하기 위해 중요하다(UNESCO, 2016c).

표 1. 2008년과 2016년도 성과 연구의 핵심적 특성

2008년 성과 검토	2016년 성과 검토
▶ HIV를 포함한 원치 않는 임신 또는 성매개 감염병 감소를 위해 설계된 프로그램에 초점. 연구에 포함된 프로그램은 청소년의 다양한 요구 또는 청소년의 정보에 대한 권리를 다루기 위해 설계되지 않음. ▶ 커리큘럼 기반 프로그램 검토에 초점. 프로그램 대부분은 지역사회, 병원에서 실행되었고 학교에서 실행된 것은 7%임. ▶ 87개의 연구 결과 중 29개는 개발 도상국에서, 47개는 미국에서, 11개는 다른 선진국에서 실시됨. ▶ 5세-24세 사이의 아동·청소년에게 초점.	▶ 10세-24세 청소년들의 성 및 재생산 건강 향상을 목표로 한 연구에 대한 체계적인 검토와, 5세-18세 청소년 대상 학교 및 커리큘럼 기반 섹슈얼리티 교육 프로그램에 대한 무작위 비교 연구를 통해 성과를 도출함. ▶ 총 22개의 관련 체계적 연구를 포함하여, 잠재적으로 관련 있는 70개의 무작위 비교연구 및 65개의 간행물과 온라인 자료를 비롯한 많은 의미있는 비실험적 정보를 활용함. ▶ 최근 발표된 지리적으로 광범위한 연구를 포함함. 이 연구에 포함된 것으로 확인된 70개의 무작위 비교연구 중 절반 이상이 저 - 중간 소득국가에서 실행된 연구이며, 22개의 체계적 분석 연구의 대부분은 저 - 중간소득국가 특히 사하라 사막 이남 아프리카에서 시행된 것임. ▶ 5세-24세 사이의 아동청소년에게 초점을 두고, 학교 기반 프로그램 외에 체계적으로 분석 연구된 학교 밖 프로그램을 포함하는 것으로 범위를 확장함.

4.3 성과 연구의 한계

유네스코가 위탁받아 수행한 본 성과 연구는 CSE 프로그램의 영향이 어느 정도의 규모인지에 대해 일반적으로 말하기 어려운 몇 가지 한계가 있다(UNESCO, 2016c).

표 2. 성과 연구의 한계

2008년 성과 연구의 한계	2016년 성과 연구의 한계
▶ 개발도상국에서 실시된 연구의 부족 ▶ 일부 연구의 존중되어야 할 각 프로그램에 대한 부적절한 묘사	▶ CSE 프로그램의 다양한 면에 대한 평가와, 특히 저소득-중간 소득국가 환경에서 의 건강에 반하는 성과에 대한 결과를 보여주는 질적 연구의 부재

- ▶ 게이, 레즈비언 등 동성애 청소년 프로그램을 조사한 연구의 부재.
- ▶ 몇몇 연구들이 최소한으로만 적용가능하게 평가 설계되어 있음. 대부분의 연구들이 통계적으로 부족한 점이 있으며, 다중적 검사에 유의미하도록 조정되어 있지 않음.
- ▶ 마지막으로, 연구의 출판에 영향을 미친 내재적 편향성. 논문 출판을 위해 주장하는 이론에 긍정적 결과를 도출하려는 경향이 있을 수 있음. 또한 프로그램과 저널도 긍정적 결과가 나와야 기사화되는 것을 수락할 가능성이 커짐.

- ▶ CSE에 대한 전 생애에 걸친 유용한 지식 및 기술 구축 기대와 달리, 대 부분의 연구는 단기간의 후속 평가 (예: 개입 후 1년) 에 그침(Hindin et al., 2016; Shepherd et al., 2010). 그러나 단기간의 효과를 나타내는 프로그램을 기대하는 것이 타당하지 않을 수 있음. 또한 CSE의 장기적인 영향에 대한 종단적 연구가 부족함.
- ▶ 연구 방법의 질은 다른 환경과 인구 집 단에 어떻게 일반화 할 수 있는지를 포 함하여 연구 결과의 신뢰성에 영향을 미침.
- ▶ 사실상, 고품질의 출판 논문에서의 정보 제공의 부족으로 다른 구성요소의 효과성에 대한 평가는 복잡함.
- ▶ 2008년 성과 연구와 마찬가지로 내재적 편향이 연구 발표에 영향을 미침.

4.4 어떤 연구가 더 필요한가?

지난 10년간 CSE의 주요한 성과가 유의미하게 증가한 반면, 더 많은 관심이 요구되는 연구 분야가 있는데 그것은 다음과 같다 (UNESCO, 2016c; UNESCO, 2009).

- 섹슈얼리티 교육 참가자 및 전문가들은 CSE 프로그램이 성적 행동의 변화 이상의 훨씬 강력한 잠재력이 있다고 믿는다. 예를 들어, CSE는 장기간의 건강 개선에 기여할 수 있으며, 친밀한 파트너에 의한 폭력을 줄일 수 있고, 성평등한 규범을 높일 수 있다. 더욱이, CSE 프로그램은 청소년들이 자신의 권리를 주장할 수 있는 세계 시민으로서의 권한을 부여한다. 전 세계적으로 특히 저-중간 소득 국가에서의 영향 평가 CSE 프로그램에 대한 요구가 많았으나, 매우 제한된 몇 지역에서만 이러한 연구 평가가 실시 되었다.
- 성과 연구에는 맥락적 요소 및 함축된 의미를 밝히기 위한 공식적, 참여적, 양적, 질적 평가를 포함하는 총괄적 평가가 이루어져야 한다.
- 또한 저-중간 소득 국가에서의 복합적 CSE 프로그램(학교 및 지역사회 연계) 평가를 위해서는 더욱 높은 품질의 무작위 비교 평가가 필요하다.
- 종합적으로, 교사 효율성 및 학생들의 학습 성과를 포함하여 커리큘럼 설계 및 실행의 효과성에 대한 더 많은 연구가 필요하다.
- 신체적 그리고/또는 인지적 장애, 청소년 HIV 감염자 및 LGBTI를 포함한 청소년 소외 집단에 대한 CSE 커리큘럼의 영향에 대해서는 제한된 정보만 있을 뿐이다.
- 폭력 예방을 위한 구성 요소 또는 주요한 특성에 대한 체계적인 연구가 거의 없는데, 이는 친밀한 파트너에 의한 폭력과 진단 전후의 HIV의 높은 상관관계와 평생에 걸친 아동 폭력의 부정적 영향을 고려할 때 시급히 해결되어야 할 과제이다.
- 성 및 재생산 건강의 성과와 관련하여 CSE 프로그램이 갖는 장기적 효과성에 대한 종단 연구가 필요하다.
- 청소년 친화적인 성 및 재생산 건강권 서비스 및 필수품 제공과 잠재적인 CSE 수요 창출 사이의 연관성을 입증하는 연구가 필요하다.



A photograph of three people in a library setting. A woman with long brown hair, a man with short dark hair, and a woman with dark hair are gathered around a table, looking at a laptop screen. They are all smiling and appear to be engaged in a collaborative activity. The background shows bookshelves filled with books and a white desk lamp.

5

핵심 개념, 주제, 학습목표

5 - 핵심 개념, 주제, 학습 목표

이 단원에서는 5세~18세 이상 연령과 지역별 상황에 맞게 적용할 수 있도록 핵심 개념, 주제, 예시 학습목표를 포괄적으로 제시한다. 유네스코 최초 지침서(2009)를 근거로, 최근 새롭게 떠오르는 전문가의 조언과 국가적, 지역적 성교육 구성 체계 및 청소년의 행동과 실제 경험에 있어 변화가 입증된 교과과정에 대한 연구들을 토대로 한다.

5.1 목적, 대상(연령집단), 내용구성

개발목적

초기 및 개정된 핵심 개념, 주제, 학습 목표의 개발은 12개국³의 기존 교과과정에 대한 특별 위탁 연구로 이루어졌다(UNESCO, 2017c). 성과 연구(UNESCO, 2009; UNESCO, 2016c), 지역 및 국가별 섹슈얼리티 교육 지침 및 기준(부록 VII 참조), 관련 데이터 및 웹사이트 검색, 전문가, 학생, 교사와의 심층 면접(부록 VI 참조), 2009년과 2016년에 개최한 전 세계 각국의 유네스코 이해관계자 상담 및 전문가 그룹 회의(부록 III 참조)가 이에 해당한다. UNAIDS, UNDP, UNESCO, UNFPA, UNICEF, UN Women, WHO에게 핵심 개념, 주제 및 예시 학습 목표에 대한 의견을 제공받았으며, 이는 포괄적 섹슈얼리티 교육 자문 위원으로부터 철저한 검토를 받았다.

이 장에서는 지침서가 보편적 인권과 불가분의 관계가 있는 것으로서 포용, 존중, 평등, 공감, 책임, 호혜성과 같은 가치를 강조하는 권리에 기초한 접근법을 채택하고 있음을 보여준다. 또한 성평등이 청소년의 섹슈얼리티 건강과 복지에 결정적으로 중요하다는 것을 이해하는데 기반을 두고 있다. 마지막으로 교육의 초점을 학습자 중심 접근 방식을 지향한다.

핵심 개념, 주제, 학습 목표는 아동청소년들이 자신의 건강, 복지, 존엄성을 실현할 수 있는 지식, 태도, 기술을 갖추도록 하는데 목적이 있다. 즉, 자신의 선택이 다른 사람의 복지에 미치는 영향을 고려하고, 자신의 권리에 대한 이해를 기반으로 행동하고, 아래와 같이 ‘~함으로써’ 다른 사람의 권리를 존중하도록 한다.

- 인지적, 정서적, 신체적, 사회적 섹슈얼리티에 대해 과학적으로 정확하고, 연령과 발달단계에 따라 성인지적인 방향으로 점진적이고, 적절하며, 문화적 맥락을 반영하여 전환적인 변화를 가져오는 정보를 제공함으로써

- 청소년들로 하여금 그들의 성적, 사회적 관계에 영향을 미치는 가치관, 태도, 사회문화적 규범을 탐구할 수 있는 기회를 제공함으로써
- 사회생활을 하는데에 효능을 발휘하는 여러가지 기술과 능력에 습득을 촉진함으로써

연령집단

이 장은 아래 나열된 8가지 주요 핵심 개념을, 학습자를 수준별 4개의 연령집단(5-8세, 9-12세, 12-15세, 15-18세 이상)으로 구분하여 제시한다. 학습목표는 더 기본적이고, 덜 인지적이며, 덜 복잡한 활동을 포함하여 청소년들을 위한 개념을 논리적 단계에 따라 제공한다. 다양한 연령대로 구성되어 있는 학급에도 적용할 수 있도록 두 번째 연령집단(9-12세)과 세 번째 연령집단(12-15세)간에 의도적으로 중복되는 부분이 있다. 마지막 연령집단인 15-18세 이상 연령은, 중등 교육 수준의 일부 학습자가 18세 이상 연령일 수 있고, 학습 주제 및 목표가 고등 교육 기관의 보다 성숙한 학습자에게도 적용될 수 있음을 말한다. 많은 청소년들이 초, 중등학교에서 그 어떤 섹슈얼리티 교육도 받지 않았기 때문에, 고등교육 수준의 학습자도 나이가 들었지만 여전히 이 지침서로부터 도움을 받을 것이 있을 수 있다. 이 지침서는 또한 학교 기반 섹슈얼리티 교육을 받지 못하는 학교 밖 아동청소년에게도 적용할 수 있다. 위에서 언급한 연령 집단별 학습자 구분은 학습자의 인지능력을 고려하고 여기에는 지적 장애 및 학습 장애 아동청소년도 포함되어야 한다. 일부 사회에서는 한 학급에 여러 연령대가 혼합되어 있는 경우가 많다. 일부 학습자들은 학교에 늦게 들어갈 수도 있으므로 발달 단계와 지식, 태도, 기술 수준이 다양할 수 있다는 것을 고려해야 한다.

또한 아동·청소년의 성 및 재생산 건강에 대한 요구와 관심은 성행위 시작시기 뿐 아니라 지역별, 국가와 지역사회에 따라 매우 다양하다. 이는 커리큘럼, 자료, 프로그램을 개발을 할 때 연령에 적합한 학습 목표와 교사가 한 학급 내에 성적 경험이 다양한 학생들이 있을 수 있음을 인식하도록 한다.

3 보츠와나, 이디오피아, 인도네시아, 자메이카, 케냐, 나미비아, 나이지리아, 남아프리카공화국, 탄자니아, 태국, 미국, 잠비아

따라서 학습목표는 학습자의 현실에 맞추어야 하며, 개인적 불편이나 어린이 또는 청소년과의 섹슈얼리티에 대한 반대되는 의견보다는 이용 가능한 통계와 연구에 근거해야 한다. 섹슈얼리티 교육에 대한 문헌과 연구는 이러한 도전에도 불구하고 민감한 이슈를 다룰 필요성을 강조한다. 섹슈얼리티와 관련한 주제는 학교에서 다루는 다른 과목과 다르게 아동·청소년의 강한 감정적인 측면을 불러일으킬 수 있기 때문에(UNESCO, 2016), 아동청소년 시기 때부터 자신의 신체, 감정 및 관계에 대해 말하고 이해할 수 있는 언어와 능력을 개발하는 것이 중요하다.

내용구성

8개의 핵심 개념은 동일하게 중요하며, 상호보완적이고, 연령 집단에 따라 수준별 학습이 가능하다.

나선형 교육과정 방식을 사용하여 이전 학습을 바탕으로 복잡성이 증가하면서 주제 관련 내용이 여러 번 반복된다.

1. 관계(Relationships)
2. 가치(Values), 권리(Rights), 문화(Culture), 섹슈얼리티(Sexuality)
3. 젠더(Gender) 이해
4. 폭력과 안전
5. 건강과 복지를 위한 기술
6. 인간의 신체(body)와 발달(Development)
7. 섹슈얼리티(Sexuality)와 성적 행동(Sexual Behaviour)
8. 성과 재생산 건강(Sexual and Reproductive Health)

핵심개념은 2-5가지 주제로 더 자세히 설명되며, 주제별, 연령대별 핵심 내용과 지식, 태도, 기술 기반에 학습 목표가 제시된다. 지식은 학습자에게 중요한 정보를 제공하며 태도는 청소년들이 자신의 섹슈얼리티에 대한 이해를 할 수 있도록 한다. 동시에 학습자로 하여금 의사소통, 경청, 거절, 의사결정, 협상, 대인관계, 비판적 사고, 자기 인식 재고, 감정이입 연습, 신뢰할 수 있는 정보 및 서비스 접근성, 낙인과 차별에 대한 저항, 권리 주장과 같은 기술을 사용할 수 있도록 한다.

지식, 태도, 기술 형성과 같이 학습 목표에 제시된 세 가지 학습 영역은 반복적이고, 상호보완적인 과정을 거쳐 학습자로 하여금 핵심 내용을 익히고 더욱 강화할 수 있는 반복적인 기회를 제공한다. 학습 목표는 고정적이지 않으며 예시를 위한 의도적 목표이고, 목표가 주제 또는 학습 영역 전반을 포괄하지는 않는다. 세 가지 학습 영역의 조합은 청소년들의 역량을 강화하고 효과적인 CSE 프로그램을 제공하기 위해 중요하다. 따라서 지침은 모든 주제에 대해 각각의 학습목표를 체계적으로 설명하고 있지 않기 때문에, 세 가지 영역에 걸쳐서 학습 목표의 균형을 유지하면서 교육과정을 개발하는 것이 좋다.

예시된 학습목표는 교육과정 개발자에 의해 지역 수준에 맞게 해석될 수 있으며, 지역적 맥락 혹은 국가나 지역의 기준을 바탕으로 적절히 조정할 수 있다. 본 지침서는 보편적인 연구와 실천에 기초한 것으로 의무 사용이 아니며, 섹슈얼리티 교육이 이루어져야 할 여러 국가의 맥락에 따른 다양성을 인정한다. 따라서 일부 국가에서는 적용 가능하지만 어떤 국가에서는 적용이 어려울 수도 있으므로, 각각의 나라가 인권, 포용, 차별 금지에 대한 존중을 기반으로 적절히 결정을 내릴 수 있는 권한을 갖는다.

사회문화적 규범과 역학적 맥락과 같은 나라 또는 지역적인 특성 및 집단의 요구에 따라, 학습목표에 기초한 수업은 연령 조건에 충족되지 않더라도 다양한 집단에게 적용하고 조정할 수 있다. 그러나 대부분 전문가는 발달심리학에서 인정하고 유럽 섹슈얼리티 교육 기준에 반영 되었던 것과 같이 아동청소년이 가능한 어린 나이에 포괄적으로 섹슈얼리티 및 재생산 건강에 대한 정보를 원하며, 필요로 한다고 믿는다(WHO Regional Office for Europe and BZgA, 2010). 또한, 학습목표는 연령과 지속적인 인지 발달에 따라 단계적으로 제시된다. 연령이 높은 학습자와 프로그램을 시작하는 경우라도 기술과 태도를 구축할 수 있는 기초지식을 충분히 습득하도록 하기 위해 연령이 낮은 단계에 학습 주제와 학습목표가 필요하다면 충분히 다룰 수 있다.

5.2 핵심 개념, 주제, 목표에 대한 개요

핵심 개념 1 : 관계	핵심 개념 2 : 가치, 권리, 문화, 섹슈얼리티	핵심 개념 3 : 젠더 이해
주제 : 1.1 가족 1.2 친구, 사랑, 연인관계 1.3 관용, 포용, 존중 1.4 결혼과 육아	주제: 2.1 가치와 섹슈얼리티 2.2 인권과 섹슈얼리티 2.3 문화, 사회와 섹슈얼리티	주제: 3.1 사회적으로 구성된 젠더와 젠더규범 3.2 성 평등, 고정관념과 편견 3.3 젠더 기반 폭력
핵심 개념 4 : 폭력과 안전	핵심 개념 5 : 건강과 복지를 위한 기술	핵심 개념 6 : 인간의 신체와 발달
주제 : 4.1 폭력 4.2 동의, 온전한 사생활과 신체 4.3 정보통신기술의 안전한 사용	주제 : 5.1 성적 행동에 대한 규범 및 또래의 영향 5.2 의사결정 5.3 대화, 거절 및 협상의 기술 5.4 미디어 정보해독력과 섹슈얼리티 5.5 도움과 지원 찾기	주제 : 6.1 성, 생식기, 생리 6.2 임신 6.3 사춘기 6.4 신체 이미지
핵심 개념 7 : 섹슈얼리티와 성적 행동	핵심 개념 8 : 성 및 재생산 건강	
주제 : 7.1 성(Sex), 섹슈얼리티(Sexuality), 생애주기별 성 생활 7.2 성적 행동 및 반응	주제 : 8.1 임신, 임신예방 8.2 HIV와 AIDS 낙인, 돌봄, 치료, 지원 8.3 HIV를 포함한 성매개감염병 위험 감소에 대한 이해와 인식	

핵심 개념 1:

관계(Relationships)

주제 :

- 1.1 가족
- 1.2 친구, 사랑, 연인관계
- 1.3 관용, 포용, 존중
- 1.4 결혼과 육아

핵심 개념 1: 관계(Relationships)

1.1 가족

학습목표(5-8세)

핵심내용: 가족의 형태는 매우 다양하다.

- ▶ 다양한 형태의 가족(보호자-후견인 가족, 확대가족, 핵가족, 비전통적 가족)을 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 다른 형태의 가족에 대한 존중을 표현할 수 있다. (태도)
- ▶ 다른 형태의 가족을 존중하는 방법을 보여줄 수 있다. (기술)

핵심내용: 가족 구성원들 각각 다른 요구와 역할이 있다.

- ▶ 가족 구성원들 각각 다른 요구와 역할이 있음을 안다. (지식)
- ▶ 때로 원하지 않을 수도 있고, 할 수 없다고 하더라도 가족 구성원들이 서로를 많은 방면에서 신경쓰고 있음을 이해한다. (태도)
- ▶ 가족 내 요구와 역할에 대해 소통할 수 있다. (기술)

핵심내용: 젠더 불평등은 종종 가족 구성원의 역할과 책임에 나타난다.

- ▶ 가족 내 여성과 남성의 역할과 책임의 차이가 무엇인지에 대해 열거할 수 있다. (지식)
- ▶ 차이로 인해 할 수 있고, 할 수 없는 것이 서로 어떤 영향을 미치는지에 대해 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 젠더 불평등이 가족 내 역할과 책임에 영향을 미친다는 것을 인식한다. (태도)
- ▶ 가족 내 남성과 여성에게 주어진 역할과 책임에 대한 자신의 느낌, 역할에 대해 다시 생각해 볼 수 있다. (기술)

핵심내용: 가족 구성원은 아이들에게 가치를 교육하는 데 중요하다.

- ▶ 가치가 무엇인지 정의할 수 있다. (지식)
- ▶ 자신과 자신의 가족에 중요한 가치가 무엇인지 기술할 수 있다. (지식)
- ▶ 가족 구성원들의 가치가 아동의 가치 형성에 미치는 영향을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 개인의 가치를 표현할 수 있다. (기술)

학습목표(9-12세)

핵심내용: 부모/보호자, 다른 가족구성원들은 아동의 가치 형성을 도우며, 그들의 의사결정을 인도하고 지원한다.

- ▶ 부모/보호자, 다른 가족구성원들이 아동의 의사결정을 돕는 방법을 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 부모/보호자, 다른 가족구성원들이 아동의 의사결정에 미치는 영향이 무엇인지 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 가족의 가치가 가족들의 의사결정에 어떤 영향을 미쳤는지를 떠올려 볼 수 있다. (기술)

핵심내용: 가족의 역할과 책임을 통해 성평등을 촉진할 수 있다.

- ▶ 가족 구성원들 간의 서로 다른 역할, 권리, 책임을 구분할 줄 안다. (지식)
- ▶ 가족 구성원의 역할과 책임을 통해 젠더 평등을 지원하는 방법을 열거할 수 있다. (지식)
- ▶ 가족 구성원 모두 가족 내 젠더 평등을 높일 수 있음을 인식한다. (태도)
- ▶ 가족 내 평등한 역할과 책임을 위해 무엇을 할 지 보여줄 수 있다. (기술)

핵심내용: 건강과 질병은 가족의 구조, 역량, 책임의 측면에서 가족에게 영향을 미칠 수 있다.

- ▶ 건강과 질병이 가족 구성원의 역할과 책임에 어떤 영향을 미치는지 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 건강과 질병이 가족의 기능에 어떤 영향을 미치는지 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 질병으로 인해 어려움에 처한 가족에게 공감을 표현할 수 있다. (기술)

핵심 개념 1 : 관계(Relationships)

1.1 가족

학습목표(12-15세)

핵심내용 : 성장한다는 것은 자신과 타인에 대해 책임을 지는 것을 의미한다.

- ▶ 자신과 다른 사람들이 성장함에 따라 생기는 새로운 책임이 무엇인지 알아보고 조사할 수 있다. (지식)
- ▶ 성장함에 따라 자신의 세계와 애착이 가족을 넘어 친구들과 또래 집단으로 확대되는 것이 특히 중요하다는 것을 인식한다. (태도)
- ▶ 새로운 책임과 관계를 헤아려 받아들일 수 있다. (기술)

핵심내용 : 부모/보호자와 아이들, 특히 청소년기의 갈등과 오해는 흔하며 보통 해결 가능하다.

- ▶ 부모/보호자와 아이들 사이에 통상적으로 발생하는 갈등과 오해를 열거할 수 있다. (지식)
- ▶ 부모/보호자와의 갈등과 오해를 해결하는 방법을 기술할 수 있다. (지식)
- ▶ 부모/보호자와의 갈등과 오해는 청소년기에 흔하게 발생하며 보통은 해결될 수 있음을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 부모/보호자와의 갈등과 오해를 풀기 위한 전략을 적용할 수 있다. (기술)

핵심내용 : 건강한 가족의 기능과 관계를 위해서는 사랑, 협력, 성 평등, 상호 돌봄, 상호 존중이 중요하다.

- ▶ 건강한 가족 기능의 특징에 알아볼 수 있다. (지식)
- ▶ 이러한 특징이 건강한 가족 기능을 위해 중요한 이유를 주장할 수 있다. (태도)
- ▶ 건강한 가족으로서 기능하는데 자신이 기여한 것을 평가할 수 있다. (기술)

학습목표(15-18세 이상)

핵심내용 : 성적인 관계와 건강 문제는 가족관계에 영향을 미칠 수 있다.

- ▶ 가족 구성원이 민감한 문제를 드러낼 때 가족의 역할과 관계가 어떻게 변화하는지 알아볼 수 있다(예를 들어 HIV 양성반응, 임신, 결혼, 파혼, 성착취대 경험 등). (지식)
- ▶ 성적 관계를 공개하거나 관련된 정보를 공유한 가족구성원의 역할과 책임이 어떻게 달라질 것인지 생각해볼 수 있다. (기술)

핵심내용 : 청소년과 가족 구성원이 성적 관계나 건강 문제 관련한 정보를 공개하거나 공유할 때 직면하게 되는 어려움을 돕는 지원 시스템이 있다.

- ▶ 형제, 부모/보호자 또는 가족 구성원이 성적 관계 또는 건강 문제를 공개 또는 공유한 청소년을 어떻게 지원할 수 있는지 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 가족 구성원은 상호존중하면서 서로를 도우면서 어려움을 극복할 수 있음을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 도움이 필요한 자신이나 가족 구성원을 지원할 효과적이고 신뢰할 수 있는 지역사회 자원에 접근할 수 있다. (기술)

핵심 개념 1: 관계(Relationships)

1.2 우정, 사랑, 연인관계

학습목표(5-8세)

핵심내용: 우정의 종류는 다양하다.

- ▶ 우정에 대한 정의를 할 수 있다. (지식)
- ▶ 우정을 중요시 할 수 있다. (태도)
- ▶ 젠더, 장애 또는 건강이 친구가 되는데 방해가 되지 않음을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 다양한 친구를 만들 수 있다. (기술)

핵심내용: 우정은 신뢰, 나눔, 존중, 공감, 유대에 기초를 둔다.

- ▶ 우정의 핵심요소를 설명할 수 있다(예를 들어, 신뢰, 나눔, 존중, 지원, 공감, 유대 등). (지식)
- ▶ 우정의 핵심요소에 기초한 우정관계를 형성하고자 제안할 수 있다. (태도)
- ▶ 친구에게 신뢰, 존중, 공감을 보이며 나누는 방법을 표현할 수 있다. (기술)

핵심내용: 사랑에도 여러 가지 종류(예, 친구간의 사랑, 부모간의 사랑, 연인간의 사랑)가 있으며 사랑이 표현되는 방법도 다양하다.

- ▶ 여러 종류의 사랑과 사랑이 표현되는 방법을 파악할 수 있다. (지식)
- ▶ 사랑은 다르게 표현될 수 있음을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 친구에 대한 사랑을 표현할 수 있다. (기술)

핵심내용: 건강하고 건강하지 않은 관계가 있다.

- ▶ 건강하고 건강하지 않은 관계의 특성을 나열할 수 있다.(지식)
- ▶ 좋은 접촉과 나쁜 접촉을 구분할 수 있다.(지식)
- ▶ 건강하고, 건강하지 않은 우정이 있음을 이해할 수 있다. (태도)
- ▶ 건강한 우정관계를 형성하고 유지할 수 있다.(기술)

학습목표(9-12세)

핵심내용: 우정과 사랑은 사람들에게 자신을 긍정적으로 느끼도록 돕는다.

- ▶ 우정과 사랑의 장점을 나열할 수 있다.(지식)
- ▶ 우정과 사랑은 사람들이 자신을 긍정적으로 느끼도록 돕는 것을 인식할 수 있다.(태도)
- ▶ 누군가가 자신을 긍정적으로 느낄 수 있도록 우정과 사랑을 표현 할 수 있다.(기술)

핵심내용: 아동들이 성장하면서 우정과 사랑은 다르게 표현될 수 있다.

- ▶ 성장함에 따라 다른 사람에 대한 우정과 사랑이 어떻게 다르게 표현되는 지 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 다른 사람에 대한 우정과 사랑을 표현하는 방법은 다양하다는 것을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 성장함에 따라 다른 사람에 대한 우정과 사랑을 표현하는 방법이 어떻게 변화되어 왔는지 되돌아 볼 수 있다. (기술)

핵심내용: 불평등한 관계는 사람들의 관계에 부정적인 영향을 미친다.

- ▶ 불평등한 관계가 개인의 관계에 미치는 부정적 영향을 탐색할 수 있다(예: 성, 연령, 경제적 지위 또는 권력 등). (지식)
- ▶ 평등한 관계일수록 건강함을 분석할 수 있다. (지식)
- ▶ 평등한 관계는 건강한 관계의 한 요소임을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 관계에서의 평등한 역할을 적용할 수 있다. (기술)

핵심 개념 1 : 관계(Relationships)

1.2 우정, 사랑, 연인관계

학습목표(12-15세)

핵심내용 : 친구는 서로에게 긍정적, 부정적 영향을 미칠 수 있다.

- ▶ 친구가 서로에게 어떻게 긍정적, 부정적 영향을 미치는지 비교할 수 있다. (지식)
- ▶ 친구들은 친구들의 행동에 긍정적 부정적 영향을 미칠 수 있음을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 친구로 인한 부정적인 영향을 피하는 방법을 발표할 수 있다. (기술)

핵심내용 : 관계의 종류는 다양하다.

- ▶ 다양한 관계를 파악할 수 있다. (지식)
- ▶ 사랑, 우정, (사랑의) 열병, 성적매력과 관련된 감정을 구분할 수 있다. (지식)
- ▶ 어떻게 가까운 관계가 성적인 관계가 되는지 토론할 수 있다. (기술)
- ▶ 다양한 종류의 관계와 관련된 감정을 다루는 방법을 발표할 수 있다. (기술)

핵심내용 : 연인관계는 불평등한 권력관계에 의해 강한 영향을 미칠 수 있다.

- ▶ 불평등한 권력관계가 어떻게 연인관계에 부정적인 영향을 미치는지 분석할 수 있다. (지식)
- ▶ 젠더규범과 젠더고정관념이 어떻게 연인관계에 영향을 미치는지 떠올려 볼 수 있다. (지식)
- ▶ 불평등한 권력관계는 유해함을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 평등하고 형평성 있는 권력 관계에 대한 질문을 할 수 있다. (기술)

학습목표(15-18세 이상)

핵심내용 : 건강하고 건강하지 못한 성적 관계가 있다.

- ▶ 건강하고 건강하지 못한 성적인 관계의 특성을 비교할 수 있다. (지식)
- ▶ 건강하고 건강하지 않은 성적인 관계를 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 건강하지 못한 성적인 관계를 피하는 방법을 발표할 수 있다. (기술)
- ▶ 신뢰할 수 있는 어른을 구분하고 만약 누군가가 건강하지 않은 관계 속에 있다면 어떻게 도움을 구할 것인지 발표할 수 있다. (기술)

핵심내용 : 한 사람의 성인으로서 애정과 사랑을 표현하는 방법은 다양하다.

- ▶ 건강한 성적관계에서 애정을 표현하는 다양한 방법을 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 사랑을 표현하는데 성적 행동이 필요한 것은 아님을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 애정과 사랑을 적절히 표현할 수 있다. (기술)

핵심 개념 1: 관계(Relationships)

1.3 관용, 포용, 존중

학습목표(5-8세)

핵심내용 : 모든 사람은 특별하며 사회에 기여하고 존중 받을 권리가 있다.

- ▶ 타인을 공정하게, 평등하게, 존엄하게, 존중하며 대한다는 것이 무엇인지 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 모든 사람들은 차이가 있음에도 불구하고 사회에 공헌할 수 있는 방법의 예를 찾을 수 있다. (지식)
- ▶ 사람들을 놀리는 것이 해롭다는 것을 열거할 수 있다. (지식)
- ▶ 모든 사람은 특별하고 가치가 있으며 존엄과 존중을 받을 권리가 있음을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 타인에 대한 관용, 포용, 존중을 나타내는 방법을 발표할 수 있다. (기술)

학습목표(9-12세)

핵심내용 : 낙인과 차별은 해롭다.

- ▶ 낙인과 차별을 정의하고 그것이 해롭다는 것을 알 수 있다. (지식)
- ▶ 스스로 자초한 낙인과 그것의 귀결을 설명할 수 있다(예: 침묵, 부정, 비밀). (지식)
- ▶ 낙인과 차별을 경험한 사람들을 돕기 위해 있는 전형적인 지원 매커니즘이 있음을 떠올려 볼 수 있다. (지식)
- ▶ 타인에 대한 관용, 포용, 존중을 보여주는 것이 중요함을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 낙인 또는 차별에 대항하는 사람들을 지원할 수 있다. (기술)

핵심내용 : 사회적, 경제적, 또는 건강 상태, 민족성, 인종, 출신, 성적 지향, 성 정체성 또는 기타 차이를 이유로 누군가를 괴롭히는 것은 무례하며 상대를 상처 입히는 것이다.

- ▶ 왕따(bullying)와 괴롭힘(harassing)의 의미를 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 타인을 그룹에서 배제시키거나 괴롭히는 것이 왜 해롭고 무례한 행동인지 그 이유를 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 모든 사람들은 괴롭힘에 대해 “잘못됐다”고 말할 책임이 있음을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 왕따나 괴롭힘에 저항하는 방법을 표현할 수 있다. (기술)

학습목표(12-15세)

핵심내용 : 차이에 근거하여 낙인과 차별(예: HIV, 임신, 인종, 출신, 성별, 성적 지향, 성별 정체성 등)을 하는 것은 무례하며 안녕과 인권을 침해하는 것이다.

- ▶ 낙인, 차별, 편견, 편협, 배제의 개념을 떠올려 볼 수 있다. (지식)
- ▶ 사람의 성적 그리고 재생산을 위한 건강권에 대한 낙인과 차별의 결과를 조사해 볼 수 있다. (지식)
- ▶ 모든 사람은 낙인이나 차별받는 사람들을 보호할 책임이 있음을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 포용, 비차별, 다양성의 중요성을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 낙인과 차별을 당할 경우 지원을 요청할 수 있다. (기술)
- ▶ 다양성에 대한 포용, 비차별, 존중을 나타내는 연습을 할 수 있다. (기술)

학습목표(15-18세 이상)

핵심내용 : 낙인과 차별에 도전하고 포용, 비차별, 다양성을 증진하는 것이 중요하다.

- ▶ 낙인과 차별이 어떻게 개인과 지역, 사회에 부정적인 영향을 미치는가를 분석할 수 있다. (지식)
- ▶ 낙인과 차별에 대한 관련법을 요약할 수 있다. (지식)
- ▶ 차이가 차별에 도전하는 것이 중요함을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 배제된 누군가를 위한 지원을 표현할 수 있다. (기술)
- ▶ 낙인과 차별에 반대하고, 포용, 차별금지, 다양성을 존중할 수 있다. (기술)

1.4 결혼과 육아

학습목표(5-8세)

핵심내용 : 다른 가족 구조와 결혼의 개념이 있다.

- ▶ '가족'과 '결혼'의 개념을 설명할 수 있다.(지식)
- ▶ 다양한 결혼 방법을 열거할 수 있다(예: 결혼 상대자 선택 또는 중매결혼 등). (지식)
- ▶ 별거, 이혼 또는 사별로 끝나는 결혼도 있음을 생각할 수 있다. (지식)
- ▶ 가족의 형태와 사람들의 결혼하는 방법이 다를지라도 모두 가치있는 것임을 인식할 수 있다. (태도)

학습목표(9-12세)

핵심내용 : 대부분의 나라에서 조혼, 조기강제결혼(CEFM)은 유해하며 불법이다.

- ▶ 조기강제결혼(CEFM)을 정의할 수 있다. (지식)
- ▶ 조기강제결혼(CEFM)이 아동과 가족, 사회에 미치는 부정적인 결과를 열거할 수 있다. (지식)
- ▶ 조기강제결혼(CEFM)이 유해함을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 조기강제결혼(CEFM)의 위험에 처한 경우 부모/보호자 또는 신뢰할 수 있는 성인에게 신고할 수 있다. (기술)

핵심내용 : 다양한 (지속적이고 진지한)연애, 결혼, 양육이 있으며, 이는 사회, 종교, 문화, 법률에 의해 형성된다.

- ▶ 연애, 결혼, 양육의 특성에 대해 열거할 수 있다. (지식)
- ▶ 문화, 종교, 사회, 법률이 연애, 결혼, 양육에 영향을 미치는 방법을 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 모든 사람들은 언제, 누구와 결혼을 할 것인지를 결정할 수 있어야 함을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 연애, 결혼, 양육에 대한 자신의 생각을 발표할 수 있다. (기술)

핵심내용 : 문화와 성역할은 육아에 영향을 미친다.

- ▶ 문화와 젠더역할이 양육에 어떻게 영향을 미치는지 토론할 수 있다. (지식)
- ▶ 좋은 부모/보호자가 된다는 것의 의미가 무엇인지를 자신의 가치와 신념에 비추어 볼 수 있다. (기술)

핵심 개념 1: 관계(Relationships)

1.4 결혼과 육아

학습목표(12-15세)

핵심내용: 결혼과 연애에는 많은 책임이 따른다.

- ▶ 결혼과 연애의 핵심적인 책임을 요약할 수 있다. (지식)
- ▶ 안정적인 결혼과 연애의 핵심적인 특성을 생각해 낼 수 있다. (지식)
- ▶ 결혼과 연애에서 사랑, 포용, 평등, 존중의 중요성을 인식할 수 있다. (태도)

핵심내용: 사람들은 다양한 방법으로 양육자가 되며, 양육자의 역할에는 여러 가지 다른 책임을 포함한다.

- ▶ 양육자의 책임을 열거할 수 있다. (지식)
- ▶ 성인이 양육자가 되는 다양한 방법을 비교할 수 있다(예: 의도적 또는 비의도적 임신, 입양, 위탁양육, 의료적 도움 및 대리출산). (지식)
- ▶ 양육자가 될 것인지 말 것인지 또 언제 될 것인지는 장애를 가진 사람들과 HIV에 감염된 사람들을 포함하여 누구나 스스로 결정할 수 있어야 함을 주장할 수 있다. (태도)

핵심내용: 조혼과 조기강제결혼(CEFM), 의도하지 않은 임신은 부정적인 사회적 및 건강의 결과를 가져올 수 있다.

- ▶ 조기강제결혼(CEFM)과 의도하지 않은 양육으로 인한 사회적, 건강의 결과를 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 조기강제결혼(CEFM)과 의도하지 않은 양육은 해롭다는 것을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 조기강제결혼(CEFM) 또는 의도하지 양육이 염려될 경우 지원을 요청할 수 있다. (기술)

학습목표(15-18세 이상)

핵심내용: 결혼에는 보상과 도전이 있을 수 있다.

- ▶ 결혼으로 인한 보상과 도전에 대해 평가해볼 수 있다. (지식)
- ▶ 부모/보호자는 자녀에게 지속적인 교육을 할 책임과 권리가 있음을 인식할 수 있다. (태도)

핵심내용: 사람들이 임신을 결정하는 이유와 시기에 영향을 주는 많은 요소들이 있다.

- ▶ 사람들이 아이를 갖거나 갖지 않기로 결정하는 여러 가지 이유를 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 누구나 젠더, HIV, 성적 지향 또는 성 정체성과 무관하게 부모/보호자가 될 수 있음을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 사람에 따라 양육자가 되기를 원하는 사람이 있는가 하면 그렇지 않은 사람도 있다. 모든 사람이 양육자가 될 수 있는 것은 아니며, 누군가는 원치않은 시기에 부모/보호자가 될 수도 있다는 것을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 아이를 갖는 시기와 이유에 대한 자신의 생각에 영향을 미치는 요소를 비판적으로 평가할 수 있다. (기술)

핵심내용: 부모/보호자가 자녀의 다양한 요구를 이행해야 할 책임을 가지고 있다.

- ▶ 아동의 중요한 신체적, 정서적, 경제적, 건강 및 교육적 요구 사항과 관련한 부모/보호자의 책임을 범주화할 수 있다. (지식)
- ▶ 부모/보호자의 관계에 어려움이 아동의 복지에 어떻게 영향을 주는지 보여줄 수 있다. (지식)
- ▶ 양육에서 건강한 관계의 중요성을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 부모/보호자와 아동은 자신의 신체적, 정서적, 경제적, 교육적 요구와 관련한 소통을 할 수 있다. (기술)

핵심 개념 2:

가치(Values), 권리(Rights),

문화(Culture), 성(Sexuality)

주제 :

2.1 가치와 섹슈얼리티

2.2 인권과 섹슈얼리티

2.3 문화, 사회와 섹슈얼리티

핵심 개념 2: 가치, 권리, 문화, 성

2.1 가치와 섹슈얼리티

학습목표(5-8세)

핵심내용 : 가치는 개인, 가족 및 지역사회가 중요 사안에 대해 갖는 강한 신념이다.

- ▶ 가치에 대해 정의할 수 있다. (지식)
- ▶ 평등, 존중, 수용, 관용과 같은 중요한 개인적 가치를 알아볼 수 있다. (지식)
- ▶ 가치와 신념에 따라 자신의 삶과 자신이 맺는 관계가 결정되는 방식을 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 개인, 동료, 가족 및 지역사회가 서로 다른 가치를 가질 수 있음을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 자신이 갖고 있는 가치를 공유할 수 있다. (기술)

학습목표(9-12세)

핵심내용 : 가족과 지역공동체로부터 전수된 가치와 태도는 성(sex)과 섹슈얼리티를 배우는 원천이며 우리의 개인행동과 의사 결정에 영향을 미친다.

- ▶ 성(sex)과 섹슈얼리티에 대해 무엇을 어떻게 배우는지 알려주는 가치와 태도가 어떻게 형성되었는지 원천을 알아볼 수 있다 (예: 부모/보호자, 가족 구성원, 지역사회 등). (지식)
- ▶ 어떤 부모/보호자는 그들의 가치를 자녀들에게 가르치고 귀감이 되기도 한다는 것을 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 가족 구성원과 지역공동체의 가치, 태도는 그들의 행동과 의사 결정에 영향을 미친다는 것을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 자신이 가족으로부터 학습한 가치를 되돌아볼 수 있다. (기술)

학습목표(12-15세)

핵심내용 : 자신의 가치와 신념, 태도를 알고, 그것이 다른 사람의 권리에 어떻게 영향을 미치는지, 그것에 어떻게 대응해야 하는 지를 아는 것이 중요하다.

- ▶ 섹슈얼리티와 재생산 건강 이슈에 대한 자신의 개인적 가치를 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 개인적인 가치가 자신의 결정에 어떻게 영향을 미치는지 보여줄 수 있다. (지식)
- ▶ 개인적 가치가 타인의 권리에 영향을 미칠 수 있음을 알 수 있다. (지식)
- ▶ 자신과 다른 가치, 신념, 태도에 대한 포용과 존중의 중요성을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 자신의 개인적 가치를 지킬 수 있다. (기술)

학습목표(15-18세 이상)

핵심내용 : 자신과 일치하는 성적 행동을 취하기 위해서는 자신의 가치와 신념, 태도에 대해 아는 것이 중요하다.

- ▶ 섹슈얼리티, 재생산 건강과 관련하여 자신의 가치와 일치하거나 일치하지 않는 행동을 비교하고 대조할 수 있다. (지식)
- ▶ 자신의 가치가 어떻게 성적 행동을 이끌어내는지 평가해볼 수 있다. (태도)
- ▶ 자신의 가치에 따라 성적 행동을 선택할 수 있다. (기술)

핵심내용 : 아동이 성장함에 따라 부모/보호자와 다른 자신만의 가치를 개발한다.

- ▶ 섹슈얼리티에 대해 자신과 부모/보호자가 갖고 있는 가치를 구별할 수 있다. (지식)
- ▶ 자신이 갖고 있는 어떤 가치는 부모/보호자와 다르다는 것을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 자신과 다른 가치로 인한 가족구성원과의 갈등을 해결하는 방법을 발표할 수 있다. (기술)

2.2 인권과 섹슈얼리티

학습목표(5-8세)

핵심내용: 인권은 모두에게 있다.

- ▶ 인권에 대해 정의할 수 있다. (지식)
- ▶ 모두에게 인권이 있으며 이러한 인권은 존중되어야 함을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 사람들의 인권에 대한 지지를 표현할 수 있다. (기술)

학습목표(9-12세)

핵심내용: 자신의 권리와 인권은 국내법 및 국제협약에 명시되어 있다는 것을 아는 것이 중요하다.

- ▶ 인권이 정의된 내용과 모든 사람에게 어떻게 적용되는지 생각할 수 있다. (지식)
- ▶ 보편적 인권과 아동의 권리를 확인 할 수 있는 국내법 및 국제협약에 대해 말할 수 있다. (지식)
- ▶ 국내법 및 국제협약(예: 세계인권선언 및 아동권리협약)에 명시된 아동의 권리를 인식할 수 있다. (지식)
- ▶ 인권과 인권은 모두에게 적용된다는 것을 인식한다. (태도)
- ▶ 자신이 누리고 있는 권리에 대해 생각해볼 수 있다. (기술)

학습목표(12-15세)

핵심내용: 인권에는 성 및 재생산 건강에 영향을 미치는 권리가 포함된다.

- ▶ 성 및 재생산 건강에 영향을 미치는 권리에 대해 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 인권에 영향을 미치는 관련법에 대해 토론할 수 있다. (지식)
- ▶ 인권이 침해받는 상황을 인식할 수 있다. (지식)
- ▶ 사회에는 인권 침해에 특히 취약한 사람들이 있다는 것을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 성 및 재생산 건강과 관련된 권리를 포함하여 모든 사람들에게 대한 인권 존중에 대해 예를 들어 보여줄 수 있다. (기술)

학습목표(15세-18세 이상)

핵심내용: 성 및 재생산 건강에 영향을 미치는 인권을 다루는 지역과 국내법 및 국제협약이 있다.

- ▶ CEFM(조기강제결혼), FGM/C(여성생식기절단), 간성(Intersex) 아동에 대한 동의없는 외과적 개입, 강제 불임, 합법적 성관계 연령, 성적 지향, 성별 정체성, 임신중단 강간, 성적 학대, 성매매, 성 및 재생산 건강 서비스 및 재생산권에 대한 접근권에 관한 지역과 국내법 및 국제협약을 분석할 수 있다. (지식)
- ▶ 성 및 재생산 건강에 영향을 미치는 인권 침해 사례를 보여줄 수 있다. (지식)
- ▶ 성 및 재생산 건강에 영향을 미치는 인권에 대해 알아볼 수 있다. (태도)
- ▶ 성 및 재생산 건강에 영향을 미치는 인권 관련 지역 그리고/또는 국내법을 지지할 수 있다. (기술)

핵심내용: 성 및 재생산 건강에 영향을 주는 인권에 대해 알고 증진하는 것이 중요하다.

- ▶ 친구, 가족, 학교 및 지역사회에서 인권을 증진하는 방법을 조사할 수 있다. (지식)
- ▶ 성 및 재생산 건강에 영향을 미치는 인권을 증진하고, 차별, 강제, 폭력으로부터 자유로운 생식에 대한 결정권 증진이 중요하다는 것을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 성 및 재생산 건강에 영향을 주는 인권을 증진하기 위한 행동을 할 수 있다. (기술)

핵심 개념 2: 가치, 권리, 문화, 성

2.3 문화, 사회와 섹슈얼리티

학습목표(5-8세)

핵심내용: 자신의 감정과 몸에 대해 스스로 배울 수 있는 것이 많다.

- ▶ 자신의 감정과 몸을 이해하는데 도움이 되는 정보를 열거할 수 있다(예: 가족, 개인, 동료, 지역사회, 소셜미디어를 포함한 매체).(지식)
- ▶ 가족, 지역사회로부터 배운 우리의 감정과 몸에 대한 가치와 신념을 인식할 수 있다.(태도)
- ▶ 신뢰할 수 있는 어른을 찾아서 자신의 감정과 몸에 대한 질문을 하는 방법을 발표할 수 있다.(기술)

학습목표(9-12세)

핵심내용: 문화, 종교 및 사회는 성에 대한 우리의 이해에 영향을 미친다.

- ▶ 문화, 종교, 사회가 섹슈얼리티에 대한 우리의 이해에 어떻게 영향을 미치는지 예를 찾을 수 있다.(지식)
- ▶ 지역과 여러 문화권에 걸쳐있는 다양한 성년 의식을 설명할 수 있다.(지식)
- ▶ 시간이 지남에 따라 변한 섹슈얼리티 관련 문화적, 종교적, 사회적 신념과 관행을 식별할 수 있다.(지식)
- ▶ 섹슈얼리티와 관련해 다양한 신념이 있음을 인식할 수 있다.(태도)
- ▶ 섹슈얼리티와 모든 사람들의 인권과 관련된 다양한 관행에 대한 존중을 표현할 수 있다.(기술)

학습목표(12-15세)

핵심내용: 사회적, 문화적, 종교적 요인은 사회에서 수용 가능하고 수용 불가능한 성적 행동으로 간주되는 것에 영향을 미치며, 이러한 요인은 시간이 흐르면서 변화/발전한다.

- ▶ 사회문화적 규범에 대해 설명할 수 있다.(지식)
- ▶ 사회에서 성적 행동에 영향을 미치는 사회문화적 규범과 시간이 지나며 어떻게 변화하는 방식을 조사할 수 있다.(지식)
- ▶ 사회문화적 규범이 시간 흐름에 따라 변화한다는 것을 인식할 수 있다.(태도)
- ▶ 사회에서 성적 행동에 영향을 미치는 사회문화적 규범에 대해 의문을 제기할 수 있다.(기술)

학습목표(15-18세 이상)

핵심내용: 사회문화적 규범이 어떻게 성적 행동에 영향을 미치는지 인식하면서 자신의 관점을 발전시키는 것이 중요하다.

- ▶ 성적 행동과 성 건강을 포함한 섹슈얼리티에 긍정적 혹은 부정적인 영향을 주는 사회문화적 규범을 비교하고 대조할 수 있다.(지식)
- ▶ 성적 행동과 성건강을 포함한 섹슈얼리티에 대한 자신의 관점을 확장시키는 것이 중요함을 인식할 수 있다.(태도)
- ▶ 자신이 가치를 두고 있는 사회문화적 규범이 섹슈얼리티와 성적 행동에 대한 신념과 감정에 어떻게 영향을 미치는지 돌이켜 생각해 볼 수 있다.(기술)

핵심 개념 3:

젠더(Gender) 이해

주제 :

- 3.1 사회적으로 구성된 젠더와 젠더규범
- 3.2 젠더 평등, 고정관념과 편견
- 3.3 젠더기반폭력

핵심 개념 3: 젠더 이해

3.1 사회적으로 구성된 젠더와 젠더규범

학습목표(5-8세)

핵심내용: 생물학적 성과 젠더의 차이를 이해하는 것이 중요하다.

- ▶ 젠더와 생물학적 성을 정의하고 어떤 차이가 있는지 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 자신의 생물학적 성과 젠더에 대해 어떻게 느끼는지 생각해볼 수 있다. (기술)

핵심내용: 가족, 개인, 지역사회는 성과 젠더에 대한 정보의 원천이다.

- ▶ 성(sex)과 젠더에 대한 정보의 원천을 찾을 수 있다. (지식)
- ▶ 성과 젠더에 대한 관점은 매우 다양한 영향을 받아 형성된다는 것을 인식한다. (태도)

학습목표(12-15세)

핵심내용: 젠더 역할과 젠더 규범은 사람들의 삶에 영향을 미친다.

- ▶ 젠더 규범이 어떻게 정체성과 관행, 행동을 규정하고 요구하는지 파악할 수 있다. (지식)
- ▶ 젠더 규범이 유해하며 사람들의 선택과 행동에 부정적으로 영향을 줄 수 있음을 조사할 수 있다. (지식)
- ▶ 젠더 규범에 대한 신념은 사회문화적으로 형성된다는 것을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 젠더 역할과 경험은 변화될 수 있음을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 가족, 학교, 지역사회에서 더욱 긍정적인 젠더 역할을 위한 일상적인 실천을 할 수 있다. (기술)

핵심내용: 연인관계는 젠더 역할과 젠더 고정관념에 의해 부정적인 영향을 받을 수 있다.

- ▶ 연인관계에서의 젠더 규범과 젠더 고정관념의 영향을 분석할 수 있다. (남성적, 여성적 규범). (지식)
- ▶ 학대와 폭력적 관계는 젠더 역할과 젠더 고정관념과 깊게 연결되어 있다는 것을 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 젠더 역할과 젠더 고정관념에 기반한 관계의 유해성을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 젠더 역할과 젠더 고정관념에 기반한 관계에 대해 의문을 제기할 수 있다. (기술)

학습목표(9-12세)

핵심내용: 사회문화적 규범과 종교적 신념은 젠더 역할에 영향을 주는 요소이다.

- ▶ 젠더 역할을 정의할 수 있다. (지식)
- ▶ 사회적 규범, 문화적 규범, 종교적 신념이 어떻게 젠더 역할에 영향을 주는지 예를 들 수 있다. (지식)
- ▶ 젠더 역할에 영향을 주는 요소를 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 젠더 역할에 대한 자신의 관점에 영향을 준 사회문화적 규범과 종교적 신념을 돌이켜 생각해 볼 수 있다. (기술)

핵심내용: 자기 자신에 대한 생각이나 젠더 측면에서 다른 사람에게 자신을 설명하는 방식은 고유하며 존중받아야 한다.

- ▶ 젠더 정체성을 정의할 수 있다. (지식)
- ▶ 누군가의 젠더 정체성이 생물학적 성과 일치하지 않을 수도 있음을 설명할 수 있다. (태도)
- ▶ 자신의 젠더 정체성을 인식하고 다른 사람의 젠더 정체성에 대한 존중을 표현할 수 있다. (기술)

학습목표(15-18세 이상)

핵심내용: 자신과 타인의 젠더 편견에 대해 도전하는 것이 중요하다.

- ▶ 남자, 여자, 다양한 성적 지향과 성 정체성을 가진 사람에 대한 젠더 편견의 예를 들 수 있다. (지식)
- ▶ 자신과 타인의 젠더 편견은 유해하다는 것을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 자신의 젠더 편견 정도를 비판적으로 평가하고 지역사회에서의 젠더 편견을 분석할 수 있다. (기술)
- ▶ 자신과 타인의 젠더 편견을 비판하는 전략을 연습할 수 있다. (기술)

핵심내용: 동성애와 성전환에 대한 적대감은 다양한 성적 지향과 젠더 정체성을 가진 사람에게 해롭다.

- ▶ 동성애와 성전환에 대한 적대감을 정의할 수 있다. (지식)
- ▶ 동성애와 성전환에 대한 적대감 형성에 기여하는 사회적 규범과 그 결과를 분석할 수 있다. (지식)
- ▶ 누구나 폭력, 강제 또는 차별 없이 원하는 사랑을 할 수 있어야 함을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 동성애 또는 성전환에 대한 적대감을 경험한 사람들을 지원하는 방법을 발표할 수 있다. (기술)

3.2 젠더 평등, 고정관념과 편견

학습목표(5-8세)

핵심내용 : 누구나 성별과 무관하게 동등한 가치가 있다.

- ▶ 성별을 이유로 어떻게 사람들이 불공정하고 불평등하게 대하는지 파악할 수 있다. (지식)
- ▶ 가정, 학교, 지역사회에서 더욱 공정하고 평등한 젠더 관계를 형성하는 방법을 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 성별로 불공정하고 불평등한 처우를 하는 것은 올바르지 못하며 반인권적임을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 젠더와 무관하게 타인에 대한 인권을 존중하는 것이 중요함을 인식할 수 있다. (태도)

학습목표(12-15세)

핵심내용 : 성별 고정관념과 편견은 남자, 여자, 다양한 성적 지향과 성 정체성을 가진 사람들에게 대한 대우와 그들의 선택에 영향을 미친다.

- ▶ 남녀, 그리고 다양한 성적 지향과 성 정체성을 가진 사람들을 형상화하는 사회적 규범을 돌이켜볼 수 있다. (지식)
- ▶ 모든 형태의 젠더 편견에 대한 예를 들 수 있다. (지식)
- ▶ 사람들을 평등하게 대하는 것의 중요성을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 젠더 규범을 정당화 하는 사람들에게 대한 편견은 그들의 선택에 있어 건강을 포함한 상당부분에 부정적 영향을 줄 수 있다는 것을 알 수 있다. (태도)
- ▶ 젠더 편견 없이 사람들을 대하는 방법을 보여줄 수 있다. (기술)
- ▶ 젠더 고정관념에 기반한 자신의 가치관과 신념이 젠더 편견에 어떻게 영향을 미치는지 돌이켜 생각해볼 수 있다. (기술)

핵심내용 : 젠더 평등은 성적 행동과 인생계획에 대한 동등한 의사 결정을 촉진 할 수 있다.

- ▶ 성적 관계 내에서 젠더 평등의 특성을 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 젠더 역할이 성적 행동과 피임도구 사용 및 생활계획에 관한 결정에 영향을 미치는 방법을 열거할 수 있다. (지식)
- ▶ 젠더 역할이 공평할 수록 성적 관계도 더욱 건강할 수 있음을 분석할 수 있다. (지식)
- ▶ 왜 젠더 평등이 더욱 건강한 성적 관계의 일부분인지 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 젠더 평등한 관계를 형성할 수 있다. (기술)

학습목표(9-12세)

핵심내용 : 가정, 친구, 관계, 사회에 존재하는 젠더 불평등과 권력의 차이

- ▶ 젠더 불평등을 정의할 수 있다. (지식)
- ▶ 젠더 불평등은 가정, 친구, 사회 내 권력의 차이와 연계되어 있음을 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 젠더 불평등과 관계에서의 권력의 차이로 인한 부정적인 결과를 회상해 볼 수 있다(예: GBV 젠더 기반폭력). (지식)
- ▶ 모든 사람이 젠더 불평등을 극복해야 할 의무와 책임이 있다는 신념을 조성할 수 있다. (태도)
- ▶ 집, 학교, 지역사회에서 젠더 평등한 관계를 증진하는 방법을 발표할 수 있다. (기술)

핵심내용 : 젠더에 대한 고정관념은 편견과 불평등을 낳는다.

- ▶ 젠더 관련 고정관념과 편견을 정의할 수 있다. (지식)
- ▶ 젠더 고정관념과 기대는 사람들이 살아가는 삶에 긍정적, 부정적으로 강한 영향을 미친다는 것을 인식한다. (지식)
- ▶ 젠더로 인한 차이는 특히 사람들이 사회적 규범에 어긋난 행동을 할 경우 착취 또는 불평등한 대우로 이어질 수 있음을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 젠더 역할의 공정성에 의문을 제기하고 부당하고 해로운 결과를 낳는 관행에 도전하는 방법을 표현할 수 있다. (기술)

학습목표(15-18세 이상)

핵심내용 : 젠더 불평등, 사회적 규범, 권력의 차이는 성적 행동에 영향을 미치고, 성적 강압, 학대, GBV(젠더 기반 폭력)의 위험을 높인다.

- ▶ 젠더 불평등과 권력에서의 차이가 성적 행동과 성적 강압, 학대, GBV의 위험에 영향을 미치는 방법을 파악할 수 있다. (지식)
- ▶ 젠더 불평등과 권력의 차이는 성적 행동과 콘돔 사용, SRH(성과 재생산 건강) 서비스 이용에 대한 의사결정, 행동, 안전한 선택 능력에 영향을 미칠 수 있음을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 자신 또는 다른 사람이 성적 강압, 학대, 또는 GBV(젠더 기반 폭력)에 노출되었을 경우 도움을 요청할 수 있다. (기술)

핵심 개념 3: 젠더 이해

3.3 젠더 기반 폭력

학습목표(5-8세)

핵심내용 : GBV(젠더 기반 폭력)이 무엇이며 어디에서 도움을 얻을 수 있는지는 아는 것이 중요하다.

- ▶ GBV를 정의할 수 있으며 다른 장소(예: 학교, 집 또는 공공장소)에서 발생할 수 있음을 인식할 수 있다. (지식)
- ▶ 젠더와 젠더 고정관념에 대한 우리의 생각이 차별과 폭력을 포함하여 타인을 대하는 우리의 태도에 영향을 미친다는 것을 이해할 수 있다. (지식)
- ▶ 젠더에 기반한 모든 형태의 폭력은 잘못된 것임을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 자신이나 타인이 학교 주변의 폭력을 포함하여 GBV를 경험하고 있는 것을 알고 있을 경우, 그것을 말하기 위해 신뢰할 수 있는 성인을 확인하고 접근하는 방법을 설명할 수 있다. (기술)

학습목표(12-15세)

핵심내용 : 성인, 청소년, 권력을 가진 사람에 의한 모든 형태의 GBV(젠더 기반 폭력)는 인권을 침해한다.

- ▶ 친근한 파트너 폭력 및 강간을 포함한 성적 학대와 GBV는 권력과 지배력에 대한 범죄이며 성적 욕망에 대한 통제력의 문제가 아님을 상기할 수 있다. (지식)
- ▶ GBV(젠더기반폭력)를 인식하고 줄이기 위한 구체적인 전략을 세울 수 있다. (지식)
- ▶ 폭력에 대한 주변인과 목격자가 개입하기 위해 몇 가지 안전한 조치를 취할 수 있으며, 또는 폭력의 영향을 받을 수도 있다는 것을 인식할 수 있다. (지식)
- ▶ GBV는 성인, 권력을 가진 사람, 청소년에 의해 일어날 수 있으며, 언제나 옳지 않다는 것을 인식한다. (태도)
- ▶ GBV 예방 및 GBV 생존자를 지원하는 신뢰할 수 있는 성인 및 서비스에 접근하는 방법을 설명할 수 있다. (기술)

학습목표(9-12세)

핵심내용 : 모든 형태의 GBV(젠더 기반 폭력)는 잘못되었으며 인권을 침해한다.

- ▶ GBV(예: 왕따, 성희롱, 심리적 폭력, 가정폭력, 강간, FGM/C(여성성기절단) CEFM(아동조기강제결혼), 동성애 혐오 폭력) 사례를 열거하고, 학교, 집, 공공장소 또는 온라인 등 GBV가 발생할 수 있는 공간을 확인할 수 있다. (지식)
- ▶ 모든 형태의 젠더기반폭력은 인권이 침해됨을 인식한다. (태도)
- ▶ 누군가 젠더기반폭력에 노출되거나 젠더기반폭력에 관여할 우려가 있는 경우 신뢰할 수 있는 성인에게 말할 수 있다. (기술)

핵심내용 : 젠더 고정관념은 폭력과 차별의 원인이 될 수 있다.

- ▶ 젠더 고정관념이 어떻게 괴롭힘, 차별, 학대, 성폭력을 일으킬 수 있는지 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 성적 학대와 GBV(젠더 기반 폭력)는 성적 욕망을 통제할 능력의 문제가 아니라 권력과 지배력에 관한 범죄임을 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 젠더 불평등과 성역할 고정관념은 젠더기반폭력을 유발한다는 것을 인식한다. (태도)
- ▶ 젠더 평등을 주장하고 젠더 차별 또는 GBV에 맞설 수 있는 방법을 보여줄 수 있다. (기술)

학습목표(15-18세 이상)

핵심내용 : 친밀한 파트너 폭력은 해로우며 이를 경험하는 사람들을 위한 지원이 있다.

- ▶ 친밀한 파트너 폭력은 매우 다양한 형태로 나타날 수 있음을 인식한다(예: 심리적, 신체적, 성적). (지식)
- ▶ 친밀한 파트너 폭력은 옳지 않으며 폭력적인 관계로부터 떠날 수 있음을 인식한다. (태도)
- ▶ 친밀한 파트너 폭력을 경험한 경우 신뢰할 수 있는 성인에게 접근하는 방법을 보여줄 수 있다. (기술)

핵심내용 : 모든 사람이 젠더 평등을 지지하고 성적 학대, 해로운 관행 및 GBV(젠더 기반 폭력)와 같은 인권을 침해하는 행위에 대해 대항할 책임이 있다.

- ▶ 젠더 평등을 증진하고 GBV를 줄이기 위한 성공적인 노력의 예를 분석할 수 있다. (지식)
- ▶ 온라인을 비롯한 공공 및 민간 부문에서의 인권 침해와 성 차별에 대항하여 공개적으로 말하는 것의 중요성을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 젠더 평등과 GBV의 근절을 위한 지지를 할 수 있다. (기술)

핵심 개념 4:

폭력과 안전

주제 :

- 4.1 폭력
- 4.2 동의, 온전한 사생활과 신체
- 4.3 정보통신기술의 안전한 사용

핵심 개념 4: 폭력과 안전

4.1 폭력

학습목표(5-8세)

핵심내용: 괴롭힘, 폭력을 인식하고 잘못된 것임을 이해하는 것이 중요하다.

- ▶ 놀림, 괴롭힘, 폭력에 대한 정의를 할 수 있다. (지식)
- ▶ 가족구성원 또는 다른 성인에 의한 폭력을 포함하여 괴롭힘과 폭력은 잘못된 것이며, 피해자의 잘못이 아님을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 또래들 안에서의 괴롭힘이나 폭력에 대응하기 위해 취할 수 있는 안전한 행동이 무엇인지 발표할 수 있다. (기술)

핵심내용: 아동학대를 인식하고 잘못된 것임을 이해하는 것이 중요하다.

- ▶ 성적 학대 및 온라인 성 착취를 포함한 아동 학대를 정의할 수 있다. (지식)
- ▶ 알고 있고 신뢰할 수 있는 어른이나 가족 구성원에 의해 발생한 아동 성 학대를 포함한 아동학대는 아동의 권리를 침해하는 것이며 결코 피해자의 잘못이 아님을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 성인이 자신에게 성적 학대를 하려고 할 경우 취할 수 있는 행동을 보여줄 수 있다(예: '안 돼' 또는 '저리 가'라고 말하고 믿을 수 있는 어른에게 말한다). (기술)
- ▶ 학대를 당하는 경우 부모/보호자 또는 믿을 수 있는 어른을 찾아서 학대당하고 있음을 알리는 방법을 보여줄 수 있다. (기술)

핵심내용: 부모 또는 연인 관계에서의 폭력은 잘못된 것임을 이해하는 것이 중요하다.

- ▶ 부모 또는 연인관계에서 발생하는 폭력의 형태에 대해 인식할 수 있다(예: 신체적, 언어적 폭력 또는 파트너에게 무언가를 하도록 강요하는 것). (지식)
- ▶ 부모 또는 연인관계에서의 폭력은 옳지 않음을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 가족 내에서 이런 유형의 폭력이 발생했을 때 믿을 수 있는 성인을 찾아서 도움을 요청하는 방법을 설명할 수 있다. (기술)

학습목표(9-12세)

핵심내용: 성적 학대, 성희롱, 괴롭힘(사이버 포함)은 해로우며 이를 경험할 경우 지원을 요청하는 것이 중요하다.

- ▶ 성적 학대(강간, 근친강간 및 온라인 성 착취 포함), 성희롱 및 괴롭힘(사이버 포함)의 예를 들 수 있다. (지식)
- ▶ 아동 성 학대는 불법이며 이를 경험한 사람들을 돕는 기관 및 서비스가 있음을 알 수 있다. (지식)
- ▶ 성적 학대, 성희롱, 근친강간 또는 괴롭힘을 경험할 경우 도움을 요청하는 것의 중요성을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 누군가 괴롭힘을 당하거나 성적 학대 또는 희롱을 당하는 것을 알았을 때 대처하는 효과적인 방법을 보여줄 수 있다. (기술)
- ▶ 자신이 성적 학대, 성희롱, 근친강간, 괴롭힘을 당할 경우 스스로 또는 누군가에게 도움을 요청하는 방법을 보여줄 수 있다. (기술)

핵심내용: 친밀한 파트너 사이에서의 폭력은 잘못된 것이며, 이를 목격할 경우 지원을 요청하는 것이 중요하다.

- ▶ 친밀한 파트너간 폭력을 정의할 수 있다. (지식)
- ▶ 친밀한 파트너간 폭력의 예를 들 수 있다. (지식)
- ▶ 친밀한 파트너간 폭력은 잘못된 것이며 폭력을 목격한 어린이들은 도움을 받을 수 있음을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 이와 같은 폭력을 가족 내에서 경험할 경우 믿을 수 있는 성인에게 도움을 요청할 수 있다. (기술)

핵심 개념 4 : 폭력과 안전

4.1 폭력

학습목표(12-15세)

핵심내용 : 성적 학대, 성폭행, 친밀한 파트너 간 폭력 및 괴롭힘은 인권을 침해하는 행위이다.

- ▶ 괴롭힘, 정신적 폭력, 신체적 폭력, 성적 학대, 성희롱, 친밀한 파트너간 폭력을 비교 및 대조할 수 있다. (지식)
- ▶ 성인, 청소년, 권력을 가진 사람에 의한 성적 학대, 성폭행, 친밀한 파트너간 폭력, 괴롭힘은 결코 피해자의 잘못이 아니며 항상 인권을 침해한다는 것을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 성적 학대, 성폭행, 친밀한 파트너 폭력 및 괴롭힘에 대한 신고 방법을 보여줄 수 있다. (기술)
- ▶ 성적 학대, 성폭행, 친밀한 파트너 폭력 및 괴롭힘을 방지하고 피해자를 지원하는 서비스와 신뢰할 수 있는 성인에게 도움을 요청하는 방법을 보여줄 수 있다. (기술)

학습목표(15-18세 이상)

핵심내용 : 폭력 없는 건강하고 행복한 삶을 옹호할 책임은 모두에게 있다.

- ▶ 다양한 형태의 신체적, 정신적, 성적 폭력을 줄이기 위해 노력한 사례를 분석할 수 있다. (지식)
- ▶ 학교, 가정, 지역사회, 온라인을 포함한 모든 공간에서의 폭력 및 인권침해에 대해 공개적으로 말하는 것의 중요성을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 우리 모두의 존엄성을 높이는 안전한 환경을 요구할 수 있다. (기술)

핵심 개념 4 : 폭력과 안전

4.2 동의(합의), 프라이버시, 온전한 신체(Bodily Integrity)

학습목표(5-8세)

핵심내용 : 자신의 몸을 누가 어디에서 어떤 방법으로 만질 수 있는지 결정할 권리가 모두에게 있다.

- ▶ ‘신체의 권리’의 의미를 묘사할 수 있다. (지식)
- ▶ 나만 볼 수 있는 몸의 부분이 어디인지 알 수 있다. (지식)
- ▶ 누구나 ‘신체의 권리’가 있음을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 누군가 불편한 느낌을 갖게 하는 방식으로 내 몸을 만질 경우 대응하는 방법을 발표할 수 있다(예: ‘안 돼’ ‘저리 가’라고 말하고 믿을 수 있는 어른에게 얘기한다). (기술)
- ▶ 만지는 것에 대해 불편함을 느낄 경우 부모/보호자 또는 믿을 수 있는 어른에 도움을 요청하는 방법을 찾고 이를 설명할 수 있다. (기술)

학습목표(9-12세)

핵심내용 : 원치 않는 성적 관심(unwanted sexual attention)이 무엇인지 그리고 성장함에 따라 프라이버시가 필요하게 됨을 이해하는 것이 중요하다.

- ▶ 사춘기 동안 나의 신체와 사적인 공간에 대한 프라이버시가 남자, 여자아이 모두에게, 특히 여자아이의 경우 화장실과 물에 대한 접근성이 중요하게 된다는 것을 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 원치 않는 성적 관심에 대해 정의할 수 있다. (지식)
- ▶ 남자 아이와 여자 아이를 향한 원치 않는 성적 관심은 프라이버시와 자기 자신의 몸에 대한 결정권을 침해하는 것임을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 프라이버시를 지키고 원치 않는 성적 관심을 피하기 위해 적극적으로 대화를 할 수 있다. (기술)

4

학습목표(12-15세)

핵심내용 : 누구나 프라이버시와 온전한 신체에 대한 권리를 가진다.

- ▶ 프라이버시와 신체적으로 온전함이 무엇을 의미하는지 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 누구나 프라이버시와 온전한 신체에 대한 권리가 있음을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 프라이버시와 온전한 신체에 대한 권리에 대해 어떻게 느끼는지 설명할 수 있다. (기술)

핵심내용 : 성적 지향에 상관없이 누구나 자신이 성적으로 할 일과 하지 말아야 할 일을 스스로 통제할 권리가 있으며, 파트너와 적극적으로 소통하고 동의를 구해야 한다.

- ▶ 동이에 대해 정의하고 성적 자기 결정권의 중요성에 대해 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 성적 동의를 표현하는 것과 알아차림의 중요성을 인식한다. (태도)
- ▶ 성적 행동에 대한 개인적인 경계와 관련하여 동의하거나 동의하지 않는 것에 대해 설명할 수 있다. (기술)

학습목표(15-18세 이상)

핵심내용 : 동의는 파트너와의 건강하고 즐거운, 합의된 성적 행동을 위해 중요하다.

- ▶ 성적인 동의와 동의를 거부하는 것 그리고 다른 사람의 성적인 동의 또는 동의가 부족함을 인식하는 것의 장점을 분석할 수 있다. (지식)
- ▶ 남녀의 신체가 다르게 취급되는 방식과 합의된 성행위에 영향을 줄 수 있는 성행위의 이중 규범을 비교하고 대조할 수 있다. (지식)
- ▶ 합의된 성 행위는 건강한 성 관계를 위한 중요한 부분임을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 동의를 하고 동의를 거부하는 방법과 동의 또는 동의 부족을 인식하는 방법을 발표할 수 있다. (스킬)

핵심내용 : 동의하거나 동의하는 능력에 영향을 줄 수 있는 요인을 아는 것이 중요하다.

- ▶ 성적 동이에 귀 기울이고, 인식하고, 행동 또는 행동하지 않는 것의 의미에 대해 토론할 수 있다. (지식)
- ▶ 동의하거나 동의하지 않은 또는 동의를 인식하거나 인식하지 못한 상황의 예를 비교 대조할 수 있다. (지식)
- ▶ 동의하거나 동의를 인식하는 능력에 영향을 줄 수 있는 요소(예: 알코올 외, GBV, 빈곤, 권력 관계)를 분석할 수 있다. (지식)
- ▶ 성적 동의를 훼손할 수 있는 요인을 피하는 것이 중요하다는 것을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 성적 동의를 하거나 거부할 수 있는 능력을 보여줄 수 있다. (기술)
- ▶ 다른 사람의 동의 또는 동의 부족을 인식할 수 있는 능력을 보여줄 수 있다. (기술)

4.3 정보통신기술의 안전한 사용

학습목표(5-8세)

핵심내용 : 인터넷과 소셜미디어는 정보를 제공하고 사람들을 안전하게 연결해주기도 하지만 반면에 아동을 포함한 사람들을 위험에 처하게 할 수도 있다.

- ▶ 인터넷과 소셜미디어가 무엇인지 묘사할 수 있다. (지식)
- ▶ 인터넷과 소셜미디어의 장점과 잠재적인 위험을 열거할 수 있다. (지식)
- ▶ 인터넷과 소셜미디어가 안전하지 않을 수 있다는 것을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 인터넷 또는 소셜미디어가 자신을 불편하게 하거나 두려운 마음을 갖게 할 경우 믿을 수 있는 어른에게 도움을 요청하는 방법을 찾아서 보여줄 수 있다. (기술)

학습목표(12-15세)

핵심내용 : 인터넷, 휴대폰, 소셜미디어는 원치 않는 성적 관심의 원인이 될 수 있다.

- ▶ 인터넷, 휴대폰, 소셜미디어가 원치 않는 성적 관심의 원인이 될 수 있는 방법을 보여줄 수 있다. (지식)
- ▶ 인터넷, 휴대폰, 소셜미디어를 통한 원치 않는 성적 관심에 대응하는 방법을 알 수 있다. (태도)
- ▶ 인터넷, 휴대폰, 소셜미디어를 안전하게 사용하는 계획을 세우고 실행할 수 있다. (기술)

핵심내용 : 노골적인 성적 매체와 이미지는 성적 자극을 줄 수 있으며 잠정적으로 유해하다.

- ▶ 노골적인 성적 매체(포르노그래피)가 보편적인 이유를 분석할 수 있다. (지식)
- ▶ 노골적인 성적 매체는 유해할 수 있으며, 어디에 알리고 도움을 받을 수 있는지 요약할 수 있다. (지식)
- ▶ 미성년자가 노골적인 성적 이미지를 보내거나, 받거나, 구매하거나 소유하는 것이 언제 불법일 수 있는지 구분할 수 있다. (지식)
- ▶ 노골적인 성적 이미지를 공유하거나 획득하는 것과 관련한 법을 아는 것이 중요함을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 노골적인 성적 매체를 사용하는 것에 대한 느낌을 표현할 수 있다. (기술)

학습목표(9-12세)

핵심내용 : 인터넷과 소셜미디어 사용에는 특별한 주의와 배려가 필요하다.

- ▶ 인터넷과 소셜미디어의 장점과 가능한 위험성을 예를 들어 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 인터넷과 소셜미디어를 사용하는 방법에 주의를 하는 것의 중요성을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 소셜미디어에서 누구와 정보를 공유할 것인지 정하는 방법을 보여줄 수 있다. (기술)

핵심내용 : 성적으로 노골적인 이미지와 매체는 소셜 미디어를 통해 쉽게 접근할 수 있으며, 유해한 젠더 고정관념을 갖게 할 수 있다.

- ▶ 성적으로 노골적인 매체(포르노그래피)와 섹스팅(sexting)이 무엇인지 묘사할 수 있다. (지식)
- ▶ 성적으로 노골적인 매체는 종종 남성, 여성, 성적 관계를 비현실적으로 묘사한다는 것을 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 성적으로 노골적인 매체는 부정확한 묘사를 통해 남성, 여성, 성적 관계를 오도할 수 있음을 알아차릴 수 있다. (태도)
- ▶ 성적으로 노골적인 매체에 대해 믿을 수 있는 어른에게 말하는 방법을 찾아서 보여줄 수 있다. (기술)

학습목표(15-18세 이상)

핵심내용 : 소셜미디어 사용은 많은 장점을 가져올 수도 있지만, 신중한 조사가 필요한 도덕적, 윤리적, 법적 상황이 발생할 수도 있다.

- ▶ 소셜미디어를 안전하고, 합법적으로 사용하기 위한 전략을 분석할 수 있다. (지식)
- ▶ 소셜미디어 사용이 많은 장점을 가지고 있는 반면 불편하거나 법을 위반하는 상황을 초래할 수 있음을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 책임있는 소셜미디어 사용 계획을 세우고 실행할 수 있다. (기술)

핵심내용 : 노골적인 성적 미디어가 성적 행동, 성적 반응 및 신체 모습에 대한 비현실적인 기대를 초래할 수 있다.

- ▶ 노골적인 성적 매체가 남성, 여성, 성적 행동, 성적 반응, 신체 모습에 대한 비현실적인 기대를 가져오는 방법을 인식할 수 있다. (지식)
- ▶ 노골적인 성적 매체는 젠더 고정관념을 강화할 수 있고, 폭력적이거나 합의를 하지 않은 행동을 일반화할 수 있음을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 노골적인 성적 매체가 남성, 여성, 성 행위에 대한 비현실적인 묘사를 한 결과 자기 이미지, 자신감, 자존감, 타인에 대한 인식에 어떻게 영향을 미칠 수 있는지를 돌아볼 수 있다. (기술)

핵심 개념 5:

건강과 복지를 위한 기술

주제:

- 5.1 성적 행동에 대한 규범 및 또래의 영향
- 5.2 의사결정
- 5.3 대화, 거절 및 협상의 기술
- 5.4 미디어 정보 해독력과 섹슈얼리티
- 5.5 도움과 지원 찾기

핵심 개념 5: 건강과 복지를 위한 기술

5.1 성적 행동에 대한 규범 및 또래의 영향

학습목표(5-8세)

핵심내용: 또래집단의 영향은 다양한 방식으로 존재할 수 있으며 좋을 수도 나쁠 수도 있다.

- ▶ 또래집단 영향력을 정의할 수 있다. (지식)
- ▶ 또래집단의 좋고 나쁜 영향을 사례를 들어 묘사할 수 있다. (지식)
- ▶ 또래집단의 영향은 좋을 수도 나쁠 수도 있음을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 또래집단의 압력에 대응하는 방법을 보여줄 수 있다. (기술)
- ▶ 또래집단에게 긍정적인 영향을 줄 수 있는 행동 모델이 될 수 있다. (기술)

학습목표(12-15세)

핵심내용: 사회 및 젠더 규범과 또래집단의 영향력은 성적 의사 결정과 행동에 영향을 미칠 수 있다.

- ▶ 젠더와 사회적 규범을 정의할 수 있다. (지식)
- ▶ 젠더와 사회적 규범, 또래집단의 영향력이 성적 의사결정과 행동에 영향을 미치는 방법을 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 자신의 성적 의사결정과 행동이 젠더와 사회적 규범, 또래집단에 의해 영향을 받는 것을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 종합적으로 포괄할 것을 주장하고 서로를 존중하고 지지하는 방법을 보여줄 수 있다. (기술)

핵심내용: 또래집단은 성적 의사결정과 행동에 영향을 줄 수 있다.

- ▶ 또래집단이 성적 의사결정과 행동에 미치는 긍정적, 부정적인 영향을 비교 대조할 수 있다. (지식)

핵심내용: 성적 의사결정과 행동에 대한 또래집단의 부정적인 영향력에 도전하는 전략이 있다.

- ▶ 성적 의사결정과 행동에 부정적인 영향을 미치는 또래집단의 압력에 적극적으로 직면한다는 의미가 무엇인지 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 성적 의사결정과 행동에 부정적인 또래집단의 영향력에 도전하고 싶을 수 있다. (태도)
- ▶ 누군가 원하지 않는 성적 의사결정을 하도록 괴롭히거나 압력을 행사할 때 반대대사를 밝힘으로써 단호함을 보여줄 수 있다. (기술)

학습목표(9-12세)

핵심내용: 또래집단은 청소년기 섹슈얼리티와 관련된 의사 결정과 행동에 영향을 줄 수 있다.

- ▶ 또래집단은 청소년기 섹슈얼리티와 관련된 의사결정과 행동에 긍정적, 부정적인 영향을 줄 수 있음을 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 또래집단은 사춘기 섹슈얼리티와 관련된 의사결정과 행동에 영향을 줄 수 있음을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 또래집단의 영향력에 대해 의문을 제기할 수 있다. (기술)

핵심내용: 또래집단의 부정적인 압력에 저항하고 섹슈얼리티와 관련하여 긍정적인 영향력을 높이는 방법이 있다.

- ▶ 또래집단의 부정적인 압력에 저항하고, 섹슈얼리티와 관련하여 긍정적인 영향력을 높일 수 있는 방법을 말할 수 있다. (지식)
- ▶ 청소년기 섹슈얼리티와 관련한 부정적인 또래집단의 압력에 저항하는 것이 중요함을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 또래집단의 긍정적인 영향력을 수용하고 증진하는 방법을 보여줄 수 있다. (기술)

학습목표(9-12세)

핵심내용: 성적 행동에 대한 합리적인 결정을 하는 것은 가능하다.

- ▶ 젠더 및 사회적 규범 또는 또래집단의 압력에 의해 영향을 받거나, 영향 받지 않은 성적 행동에 대한 시나리오를 비교하고 대조할 수 있다. (지식)
- ▶ 성적 행동에 대한 합리적인 의사결정을 더 쉽게 또는 어렵게 만드는 요인을 평가할 수 있다. (지식)
- ▶ 성적 행동에 대한 합리적인 의사결정을 하고 싶은 것이다. (태도)
- ▶ 성적 의사결정에 대한 젠더 및 사회 규범과 또래집단의 부정적인 영향력에 대응하는 방법을 보여줄 수 있다. (기술)

핵심 개념 5: 건강과 복지를 위한 기술

5.2 의사결정

학습목표(5-8세)

핵심내용 : 모든 사람에 스스로 결정을 내릴 권리가 있으며 모든 결정에는 결과가 따른다.

- ▶ 자신이 내렸던 결정 중 자랑스러웠던 것에 대해 말할 수 있다. (지식)
- ▶ 자신 또는 타인이 내린 결정 중 좋거나 나빴던 결과가 있었던 예를 찾아볼 수 있다. (지식)
- ▶ 아동이 어떤 결정을 할 때 부모/보호자 또는 믿을 수 있는 어른의 도움이 필요할 수도 있음을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 좋은 결정을 내리는 데 도움을 줄 수 있는 상황에 대해 설명할 수 있다. (기술)
- ▶ 좋은 결정을 내리는데 도움을 줄 부모/보호자 또는 믿을 수 있는 어른을 찾을 수 있다. (기술)

학습목표(12-15세)

핵심내용 : 성적 행동에 대한 의사결정 과정은 긍정적, 부정적인 모든 잠재적 결과를 고려해야 한다.

- ▶ 성적 행동과 관련한 의사결정에 따른 긍정적, 부정적 결과를 평가할 수 있다. (지식)
- ▶ 성적 행동에 대한 의사결정이 사람들의 건강, 미래, 인생계획에 어떻게 영향을 미치는지 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 성적 행동과 재생산 건강 문제를 해결하기 위해 의사결정 과정을 적용할 수 있다. (기술)

핵심내용 : 성적 행동에 대한 합리적인 의사결정을 어렵게 하는 요인이 있다.

- ▶ 성적 행동에 대한 의사결정에 영향을 미칠 수 있는 다양한 감정을 파악할 수 있다. (지식)
- ▶ 알코올과 마약이 성적 행동에 대한 합리적인 의사결정에 어떤 영향을 미치는지 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 빈곤, 젠더 불평등, 폭력이 성적 행동에 대한 의사결정에 어떻게 영향을 미치는지 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 성적 행동에 대한 사람들의 의사결정에 영향을 미치는 요소가 많으며 어떤 것은 통제할 수 없다는 것을 이해할 수 있다. (태도)
- ▶ 성적 의사결정에 영향을 미칠 수 있는 감정을 평가하고 다루는 방법을 보여줄 수 있다. (기술)

학습목표(9-12세)

핵심내용 : 의사결정 기술은 학습하고 연습하는 것이다.

- ▶ 의사결정의 주요 과정을 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 의사결정은 학습되는 것임을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 문제를 해결하기 위해 합리적인 의사결정 과정을 적용할 수 있다. (기술)
- ▶ 의사결정에 도움이 될 수 있는 부모/보호자 또는 믿을 수 있는 어른이 누구인지 말할 수 있다. (기술)

핵심내용 : 친구, 문화, 성 역할 고정관념, 또래집단, 미디어를 포함하여 의사결정에 영향을 미치는 것은 다양하다.

- ▶ 나의 의사결정에 영향을 미치는 것을 말할 수 있다. (지식)
- ▶ 의사결정에 영향을 미치는 여러 가지 요인이 있음을 인식할 수 있다. (지식)
- ▶ 의사결정에 영향을 미치는 여러 가지 사항에 대해 어떻게 느끼는지 표현할 수 있다. (기술)

학습목표(15-18세 이상)

핵심내용 : 성적 의사결정은 자신과 타인, 사회의 건강에 영향을 미친다.

- ▶ 자신의 성적 행동과 관련한 의사결정이 개인, 가족, 사회의 건강에 미치는 잠재적인 영향을 분석할 수 있다. (지식)
- ▶ 성적 의사결정이 자신과 가족, 사회에 영향을 미치는 것을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 자신의 성적 의사결정으로 인해 영향을 받은 타인에게 공감을 표현할 수 있다. (기술)
- ▶ 성적 행동에 대한 책임 있는 의사결정을 할 수 있다. (기술)

핵심내용 : 성적 의사결정은 법적 결과를 초래할 가능성이 있다.

- ▶ 성적 행동과 관련하여 청소년이 할 수 있거나 할 수 없는 것에 대한 국내법을 찾아볼 수 있다(예: 성적 동의 연령, 피임을 포함한 의료서비스 이용, 성매개감염병(STI)/HIV). (지식)
- ▶ 성적 행동에 대한 의사결정 평가에 대한 자신의 권리를 아는 것이 중요함을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 성적 행동과 관련하여 내린 의사결정과 행동의 법적 결과를 평가할 수 있다. (기술)

핵심 개념 5: 건강과 복지를 위한 기술

5.3 대화, 거절 및 협상의 기술

학습목표(5-8세)

핵심내용: 부모/보호자 또는 신뢰할 수 있는 성인과 아동, 친구와 타인을 포함한 모든 관계에서 대화가 중요하다.

- ▶ 대화(언어적, 비언어적 대화 포함)에는 다양한 형태가 있음을 알 수 있다. (지식)
- ▶ 건강한 대화와 건강하지 못한 대화의 차이를 알 수 있다. (지식)
- ▶ 부모/보호자 또는 신뢰할 수 있는 성인과 아동, 친구와 타인들 간의 건강한 대화의 장점을 열거할 수 있다. (지식)
- ▶ '예'와 '아니오'로 분명히 대화하는 것은 자신의 프라이버시와 신체의 온전함(Bodily Integrity), 행복한 관계 형성을 위한 핵심적인 부분임을 상기할 수 있다. (지식)
- ▶ 모든 사람은 자기 자신을 표현할 권리가 있음을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 언어적, 비언어적 대화와 '예' '아니오'라고 말하는 방법을 보여줄 수 있다. (기술)

핵심내용: 성(Gender) 역할은 사람들의 대화에 영향을 미칠 수 있다.

- ▶ 성 역할을 예를 들어 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 성 역할은 사람들의 대화에 영향을 미칠 수 있음을 인식할 수 있다. (태도)

학습목표(12-15세)

핵심내용: 바람직한 대화는 개인, 가족, 학교, 직장, 연인관계에서 필수적이다.

- ▶ 개인, 가족, 학교, 직장, 연인관계에서의 효과적인 대화의 장점을 열거할 수 있다. (지식)
- ▶ 서로 모순되는 언어적, 비언어적 대화가 담고 있는 잠재적 의미를 분석할 수 있다. (지식)
- ▶ 연인관계에서의 협상에서 있을 수 있는 장애(젠더 역할과 기대 포함)를 파악할 수 있다. (지식)
- ▶ 연인관계에서 자신감 있게 협상과 거절을 하는 것을 보여줄 수 있다. (기술)

학습목표(9-12세)

핵심내용: 효과적인 대화는 다양한 방식과 화법을 사용하며, 바람, 욕구, 개인적인 경계가 무엇인지 표현하고 이해하는 것이 중요하다.

- ▶ 효과적/비효과적, 언어적/비언어적 대화의 특징을 설명할 수 있다(예: 적극적 경청, 감정 표현하기, 이해 표현하기, 직접적인 눈 맞춤, 듣지 않기, 감정 표현하지 않기, 이해 표현하지 않기, 바라보기, 외면하기). (지식)
- ▶ 바람, 욕구, 개인적 경계선 및 다른 사람에 대한 이해를 표현하는 것의 중요성을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 협상은 상호존중, 협력 및 모든 당사자와의 타협이 필요하다는 것을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 다른 사람의 바람, 욕구, 개인적 경계에 대해 경청하고 존중하며 효과적으로 소통하는 방법을 보여줄 수 있다. (기술)

학습목표(15-18세 이상)

핵심내용: 개인의 성적 요구와 성적 한계를 표현하는 핵심적인 방법은 효과적인 대화이다.

- ▶ 개인의 성적 요구와 성적 한계를 표현하기 위한 효과적인 대화 사례를 분석할 수 있다. (지식)
- ▶ 성적 동의를 하는 것과 듣는 것의 예를 보여줄 수 있다. (지식)
- ▶ 동의와 안전한 섹스를 위해 효과적인 대화가 필요한 이유를 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 자기주장과 협상 능력은 원치 않는 성적 압력에 대항하고 더욱 안전한 섹스를 실천할 의지를 강화할 수 있음을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 개인적 요구와 성적 한계에 대한 효과적인 대화 방법을 보여줄 수 있다. (기술)

핵심 개념 5: 건강과 복지를 위한 기술

5.4 미디어 정보 해독력과 섹슈얼리티

학습목표(5-8세)

핵심내용 : 정확 또는 부정확할 수 있는 다양한 형태의 미디어가 있다.

- ▶ 자신여러 가지 형태의 미디어를 열거할 수 있다(예: 라디오, 텔레비전, 책, 신문, 인터넷, 소셜미디어). (지식)
- ▶ 매체를 통해 제공되는 진실이거나 거짓된 정보 사례를 토론할 수 있다. (지식)
- ▶ 매체를 통해 제공되는 모든 정보가 진실이 아니라는 것을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 다양한 형태의 매체를 통해 제공되는 정보를 어떻게 볼 것인지에 대해 발표할 수 있다. (기술)

학습목표(9-12세)

핵심내용 : 미디어는 섹슈얼리티와 젠더에 대한 가치, 태도, 규범에 긍정적, 부정적 영향을 미칠 수 있다.

- ▶ 다른 형태의 매체에 대해 정의할 수 있다(예: 소셜미디어, 전통적인 매체). (지식)
- ▶ 미디어에서 남성, 여성 및 남녀관계가 어떻게 묘사되는지 보여주는 사례를 말할 수 있다. (지식)
- ▶ 섹슈얼리티와 젠더에 대한 개인적 가치, 태도, 행동에 대한 미디어의 영향을 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 섹슈얼리티와 젠더에 대한 가치, 태도, 행동에 영향을 주는 미디어의 힘을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 미디어에서 여성과 남성을 묘사하는 방법에 대해 의문을 제기할 수 있다. (기술)

학습목표(12-15세)

핵심내용 : 일부 매체는 섹슈얼리티와 성적 관계를 비현실적인 이미지로 묘사하고 있으며, 젠더와 자존감에 대한 우리의 인식에 영향을 줄 수 있다.

- ▶ 섹슈얼리티와 성적 관계 관련하여 미디어에서 볼 수 있는 비현실적인 이미지를 파악하고 비판할 수 있다. (지식)
- ▶ 성별 고정관념에 대한 이미지의 영향에 대해 조사할 수 있다. (지식)
- ▶ 미디어가 아름다움과 성별 고정관념에 영향을 준다는 것을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 섹슈얼리티와 성적 관계에 대한 비현실적인 이미지는 젠더와 자존감에 영향을 미칠 수 있음을 상기할 수 있다. (기술)

학습목표(15-18세 이상)

핵심내용 : 부정적이고 부정확한 남성과 여성에 대한 묘사는 긍정적인 행동과 젠더 평등을 촉진하는데 장애가 된다.

- ▶ 섹슈얼리티와 성적 관계에 대한 미디어 메시지가 갖고 있는 긍정적, 부정적 영향을 평가할 수 있다. (기술)
- ▶ 미디어가 더욱 안전한 성적 행동과 젠더 평등을 증진하는데 기여할 수 있는 방법을 제안할 수 있다. (지식)
- ▶ 섹슈얼리티, 성적 관계 및 젠더 인식에 긍정적으로 영향을 줄 수 있는 미디어의 잠재적인 힘을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 미디어에서의 성별 고정관념, 섹슈얼리티, 성적 관계에 대한 부정확한 묘사에 저항하는 방법을 보여줄 수 있다. (기술)

핵심 개념 5: 건강과 복지를 위한 기술

5.5 도움과 지원 찾기

학습목표(5-8세)

핵심내용: 친구, 가족, 선생님, 종교지도자, 지역사회 구성원은 서로 도울 수 있고 도와야 한다.

- ▶ 믿을 수 있는 어른이 무엇을 의미하는지 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 사람들이 서로 도울 수 있는 특정한 방법을 묘사할 수 있다. (지식)
- ▶ 모든 사람들은 보호받고 지지 받을 권리가 있음을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 믿을 수 있는 어른을 찾고 도움을 요청하는 방법을 보여줄 수 있다. (기술)

학습목표(9-12세)

핵심내용: 학교와 지역사회에는 다양한 도움을 주고 지원을 하는 자원이 있다.

- ▶ 도움을 필요로 하는 아동의 문제를 인식하고(예: 학대, 희롱, 괴롭힘, 질병) 도움을 줄 수 있는 관련 자원을 파악할 수 있다. (지식)
- ▶ 신뢰할 수 있는 성인에게 학대, 희롱, 괴롭힘에 대해 신고할 필요가 있음을 상기할 수 있다. (지식)
- ▶ 일부 문제의 경우 학교 밖 또는 지역사회의 도움을 필요로 함을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 광범위하게 도와줄 곳을 찾고 도움을 요청하는 방법을 보여줄 수 있다. (기술)

5

학습목표(12-15세)

핵심내용: 양질의 정보와 서비스를 위해서는 서비스 및 미디어 자원을 포함하여 도움을 주는 자원에 대한 평가가 중요하다.

- ▶ 성 및 재생산 건강(SRH)과 권리를 위한 도움과 지원을 받을 수 있는 곳을 열거할 수 있다. (지식)
- ▶ 바람직한 도움과 지원(기밀 유지와 프라이버시 보호)의 특성을 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 성 및 재생산 건강(SRH)을 지원하는 곳이 있다는 것을 이해할 수 있다(예: 상담, 성매개 감염병/에이즈 검사와 치료, 현대적인 피임, 성적 학대, 강간, 가족과 젠더에 기반한 폭력, 임신중단, 임신중단 후 돌봄, 낙인과 차별). (지식)
- ▶ 도움과 지원을 제공하는 합리적인 미디어 매체(예: 웹사이트)의 특성을 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 건강과 관련하여 도움을 주는 자원을 비판적으로 평가하는 것이 중요함을 인식할 수 있다. (기술)

학습목표(15-18세 이상)

핵심내용: 누구나 비밀을 유지하고 개인 정보를 보호할 합리적이고 실질적인 지원을 받을 권리가 있다.

- ▶ 성 및 재생산 건강(SRH) 서비스 또는 도움을 받을 수 있는 곳을 파악할 수 있다. (지식)
- ▶ 비밀을 유지하고 개인 정보를 보호하며, 적절한 가격, 진실되고, 단정적이지 않은 서비스에 청소년들이 쉽게 접근할 수 있어야 함을 인식할 수 있다. (지식)
- ▶ 적절한 도움을 요청하는 행동을 보여줄 수 있다. (기술)
- ▶ 죄책감이나 수치심 없이 도움 또는 지원을 요청하는 연습을 할 수 있다. (기술)

핵심 개념 6:

인간의 신체(body)와 발달(Development)

주제 :

- 6.1 성, 생식기, 생리
- 6.2 임신
- 6.3 사춘기
- 6.4 신체 이미지

핵심 개념 6: 인간의 신체와 발달

6.1 성, 생식기, 생리

학습목표(5-8세)

핵심내용 : 자신의 신체 이름과 기능에 대해 아는 것이 중요하며, 성 및 임신 기관을 포함하여 몸에 대해 호기심을 갖는 것은 당연하다.

- ▶ 내부 및 외부 생식기의 중요한 부분 및 기본 기능을 확인할 수 있다.(지식)
- ▶ 생식기를 포함하여 자신의 몸에 호기심을 갖게 되는 것은 지극히 정상적이라는 것을 인식할 수 있다.(태도)
- ▶ 호기심이 생기는 신체 부위에 대해 궁금한 것을 질문하고 대답하는 연습을 할 수 있다.(기술)

핵심내용 : 모든 사람들은 장애인을 포함하여 자신의 신체에 대해 존중 받을 가치가 있다.

- ▶ 남성, 여성, 남자아이, 여자아이의 신체가 시간이 지나면서 어떻게 변화하는지 알 수 있다. (지식)
- ▶ 사람들의 신체를 보는 방법은 문화에 따라 다르다는 것을 설명할 수 있다.(지식)
- ▶ 장애인을 포함한 모든 사람들은 자신의 신체에 대해 존중 받을 가치가 있음을 인식할 수 있다.(태도)
- ▶ 자신의 몸에 대해 좋은 것을 표현할 수 있다.(기술)

학습목표(12-15세)

핵심내용 : 호르몬은 사춘기 및 임신 기간 동안 성숙과 재생산 과정에 많은 영향을 미친다.

- ▶ 태아의 성별은 임신초기에 염색체에 의해 결정된다는 것을 설명할 수 있다.(지식)
- ▶ 성장, 발달 및 생식 기관과 성 기능에 대한 호르몬의 역할을 설명할 수 있다.(지식)
- ▶ 호르몬이 사춘기와 임신에 미치는 역할을 인식할 수 있다.(태도)

핵심내용 : 문화에 따라 성(Sex), 젠더, 재생산에 대한 이해 방식과 적절한 성적 활동 시기에 대한 생각은 다양하다.

- ▶ 성(Sex), 젠더, 재생산에 대한 생물학적, 사회적 측면의 차이를 구별할 수 있다.(지식)
- ▶ 성, 젠더, 재생산에 대한 사회적 관점이 문화와 종교에 의해 어떻게 영향을 받는지 비교 및 대조할 수 있다.(지식)
- ▶ 성, 젠더, 재생산에 대한 문화적, 종교적, 사회적, 개인적 관점이 다양할 수 있음을 인식할 수 있다.(태도)
- ▶ 성, 젠더, 재생산에 대한 자신의 관점을 분명히 말하고 돌이켜볼 수 있다.(기술)

학습목표(9-12세)

핵심내용 : 모든 사람의 몸에는 성 및 재생산 건강과 관련되어 있는 부분이 있으며, 아이들이 그것에 대해 질문하는 것은 일반적이다.

- ▶ 성 및 재생산 건강과 관련한 몸의 부분을 묘사할 수 있다.(지식)
- ▶ 자신의 몸과 성적 기능에 대해 질문을 하고 호기심을 갖는 것은 정상적인 것임을 인식할 수 있다.(태도)
- ▶ 모든 사람들의 몸은 독특하며 크기, 모양, 기능, 특성이 다양하다는 것을 인식할 수 있다.(태도)
- ▶ 신뢰할 수 있는 어른을 식별하여 성 및 재생산과 월경현상에 대해 질문하는 방법을 보여줄 수 있다.(기술)

핵심내용 : 여성의 몸은 월경 주기 중에 난자를 배출하고, 남자의 몸은 정자를 만들고 사정할 수 있는데, 이 둘은 재생산을 위해 필요하다.

- ▶ 임신을 위한 신체의 주요 기능에 대해 설명할 수 있다(예: 월경 주기, 정액 생산 및 정액 사정). (지식)
- ▶ 여성과 남성의 신체 모두 임신에 중요한 역할을 함을 설명할 수 있다.(태도)
- ▶ 월경 주기와 정자의 사정이 어떻게 발생하는지 이해한 것을 자신 있게 표현할 수 있다.(기술)

학습목표(15-18세 이상)

핵심내용 : 재생산 능력과 성 기능을 포함하여 남녀의 신체는 시간이 지나면서 변화한다.

- ▶ 인생 주기별 남녀의 성 및 재생산 능력을 요약할 수 있다.(지식)
- ▶ 사람은 전생애적인 성적 존재임을 인식할 수 있다.(태도)
- ▶ 인생 주기별 재생산 능력의 변화를 어떻게 느끼는지 표현할 수 있다.(기술)

핵심 개념 6: 인간의 신체와 발달

6.2 임신

6

학습목표(5-8세)

핵심내용: 임신은 난자와 정자가 자궁에서 결합하여 착상할 때 시작한다.

- ▶ 임신 과정 - 특히 임신은 정자와 난자가 만난 후 자궁에 착상하면서 시작된다는 것에 대해 묘사할 수 있다. (지식)

핵심내용: 임신은 일반적으로 40주 동안 지속되며 임신 기간 중 여성의 신체는 많은 변화를 겪는다.

- ▶ 임신 기간 중 여성의 신체가 겪는 변화를 기술할 수 있다. (지식)
- ▶ 임신 중 여성의 신체가 겪는 변화에 대한 느낌을 표현할 수 있다. (기술)

학습목표(9-12세)

핵심내용: 임신을 위해서는 정자와 난자가 결합하여 자궁에 정상적으로 착상해야 한다.

- ▶ 임신을 위해 필요한 단계를 열거할 수 있다. (지식)
- ▶ 성기가 질 속에 사정하는 성관계의 결과로 임신을 할 수 있음을 알 수 있다. (지식)
- ▶ 성관계를 한다고 해서 항상 임신을 하는 것을 아님을 알 수 있다. (지식)

핵심내용: 월경 주기에는 다양한 단계가 있다.

- ▶ 임신 가능성이 가장 높은 특정 단계를 포함한 생리주기에 대해 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 호르몬의 변화에 따라 월경이 조절된다는 것과 임신 가능성이 가장 높은 시기를 알 수 있다. (지식)
- ▶ 월경 주기가 어떻게 작동하는지 알 수 있다. (태도)
- ▶ 월경에 대한 자신의 느낌을 나타낼 수 있다. (기술)

핵심내용: 일반적인 임신 징후가 있는데, 월경을 하지 않거나 늦어지면 바로 임신 테스트를 해야 한다.

- ▶ 임신의 징후와 태아의 발달 단계에 대해 기술할 수 있다. (지식)
- ▶ 건강한 임신, 출산의 단계를 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 임신 확인을 위해 가능한 검사가 무엇이 있는지 설명할 수 있다. (지식)

학습목표(12-15세)

핵심내용: 재생산 기능과 성적 감정은 서로 다르며, 이들은 시간이 지남에 따라 바뀔 수 있다.

- ▶ 임신을 계획하고 예방할 수 있음을 상기할 수 있다. (지식)
- ▶ 재생산 기능과 성적 감정은 다른 것임을 이해할 수 있다. (지식)
- ▶ 성과 재생산 기능, 욕구에 대한 남녀의 경험은 일생에 걸쳐 변화한다는 것을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 앞으로 의도하지 않은 임신을 예방하는 방법에 대한 계획을 세울 수 있다. (기술)

학습목표(15-18세 이상)

핵심내용: 임신을 원하는 사람들을 위한 불임치료법이 있다.

- ▶ 임신을 원하지만 불임인 사람들을 위한 대안을 열거할 수 있다. (지식)
- ▶ 불임 문제를 해결하기 위한 대안이 있음을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 임신하기를 원하지만 불임을 경험하고 있는 사람들에게 공감 을 나타낼 수 있다. (기술)

6.3 사춘기

학습목표(5-8세)

핵심내용: 사춘기는 아이들이 성장하고 성숙함에 따라 신체와 감정이 변화하는 시기이다.

- ▶ 사춘기를 정의할 수 있다. (지식)
- ▶ 성장은 육체적, 정신적 변화를 포함한다는 것을 이해할 수 있다. (지식)
- ▶ 사춘기는 정상적이고 건강한 청소년기의 한 부분임을 이해할 수 있다. (태도)

학습목표(12-15세)

핵심내용: 사춘기는 성적 성숙의 시기로 신체적, 정서적, 사회적, 인지적 변화를 가져온다.

- ▶ 사춘기와 청소년기를 구별할 수 있다. (지식)
- ▶ 사춘기가 오는 시기는 사람마다 다르며 남자와 여자에게도 다른 영향을 미친다는 것을 안다. (지식)
- ▶ 청소년기에 일어나는 다양한 변화를 파악하여 분류할 수 있다 (예: 신체적, 정서적, 사회적, 인지적). (지식)
- ▶ 청소년기의 다양한 변화와 관련하여 여자아이와 남자아이의 유사점과 차이점을 비교할 수 있다. (지식)
- ▶ 사춘기는 젠더 쿼어(gender-non-conforming 자신을 남성이나 여성으로 정의하지 않는), 트랜스 젠더(transgender) 또는 간성(intersex 생물학적으로 성별 구분이 모호한)에게 특히 어려울 수 있음을 인식할 수 있다. (지식)
- ▶ 청소년기의 이러한 신체적, 정서적, 사회적, 인지적 변화는 정상적인 것임을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 사춘기 시기의 변화를 놀림거리로 삼거나, 비난하는 것은 심리적인 트라우마로 남을 수 있음을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 청소년 시기의 신체적, 정서적, 사회적, 인지적 변화를 잘 소화하는 방법을 보여줄 수 있다. (기술)

학습목표(15-18세 이상)

핵심내용: 호르몬은 평생 사람의 정서적, 신체적 변화에 중요한 역할을 한다.

- ▶ 일생에 걸쳐 감정과 신체의 변화를 다루는 호르몬의 역할을 분석할 수 있다. (지식)

학습목표(9-12세)

핵심내용: 사춘기는 한 사람의 재생산 능력의 변화 신호이다.

- ▶ 사춘기의 과정과 성 및 재생산 기관의 성숙에 대해 기술할 수 있다. (지식)
- ▶ 사춘기 동안 일어나는 주요한 신체적, 감정적 변화를 열거할 수 있다. (지식)
- ▶ 사춘기에 대한 신뢰할 수 있는 정보를 찾는 방법을 보여줄 수 있다. (기술)

핵심내용: 사춘기 동안 건강하고 청결한 성 및 재생산 기관 유지를 위해 위생이 중요하다.

- ▶ 개인위생과 위생관리에 대해 기술할 수 있다. (지식)
- ▶ 개인위생의 중요성을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 위생에 대한 이해를 개인적인 건강 유지 계획에 적용할 수 있다. (기술)

핵심내용: 월경은 신체발달의 일부로 정상적이며 자연스러운 것이며, 비밀스럽거나 수치스러운 것으로 다루어서는 안 된다.

- ▶ 월경을 하는 사람이 느끼는 다양한 신체적 증상과 감정을 파악할 수 있다. (지식)
- ▶ 월경 용품을 구하는 방법, 사용하는 방법, 버리는 방법을 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 월경 중인 사람에게 수치심과 두려움을 갖게 하는 젠더 불평등의 구조를 인식할 수 있다. (지식)
- ▶ 월경 중인 모든 사람이 월경용품, 깨끗한 물, 개인 화장실 시설에 쉽게 접근할 수 있어야 한다는 점을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 월경 중인 사람이 편안함을 느끼도록 긍정적이고 협력적인 태도를 보여줄 수 있다. (기술)

핵심내용: 사춘기 동안 청소년들은 다양한 신체 반응을 경험할 수 있다. (예: 발기 및 몽정)

- ▶ 청소년들은 자극 또는 특별한 이유 없이 발기를 경험할 수 있다는 것을 이해할 수 있다. (지식)
- ▶ 일부 청소년은 밤에 발기와 몽정이라 불리는 체액의 방출을 경험할 수 있는데 이는 정상적이라는 것을 이해할 수 있다. (지식)
- ▶ 발기와 몽정 또는 기타 성적 반응은 사춘기의 정상적인 한 부분임을 인식할 수 있다. (태도)

핵심 개념 6: 인간의 신체와 발달

6.4 신체 이미지

학습목표(5-8세)

핵심내용 : 모든 신체는 특별하고 독특하며, 자신의 몸에 대해 긍정적인 인식을 갖는다.

- ▶ 모든 신체는 특별하고 독특하다는 점을 알고 있다. (지식)
- ▶ 자신의 몸에 대해 자부심을 갖는 것이 무엇을 의미하는지 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 자신의 몸에 감사할 줄 알다. (태도)
- ▶ 자신의 몸에 대해 어떻게 느끼는지 표현할 수 있다. (기술)

학습목표(9-12세)

핵심내용 : 사람의 겉모습으로 인간의 가치가 결정되지 않는다.

- ▶ 신체적 외모는 유전, 환경, 건강 습관에 의해 결정됨을 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 신체적 외모가 인간으로서의 가치를 결정하지 않음을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 다양한 신체, 외모를 수용하는 태도를 지닐 수 있다. (태도)

핵심내용 : 사람들이 매력적으로 느끼는 신체적 외모는 문화마다, 사람마다 다양하고, 시간에 따라 변화할 수 있다.

- ▶ 사람들이 매력적이라고 생각하는 신체적 외모는 사람마다 차이가 있음을 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 사람들이 신체적으로 매력적이라고 생각하는 것은 시간이 지나면서 변화하고 문화에 따라 다양할 수 있음을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 자신과 다른 사람이 생각하는 매력이 다를 수도 있음을 생각해 볼 수 있다. (기술)

학습목표(12-15세)

핵심내용 : 자신의 신체에 대한 자기존중감은 그들의 건강, 이미지 및 행동에 영향을 미친다.

- ▶ 자신의 신체에 대해 느끼는 좋은 감정이 갖는 장점에 대해 토론할 수 있다. (지식)
- ▶ 신체적 외모가 다른 사람들의 생각과 행동에 어떻게 영향을 미치는지, 신체적 외모가 남자아이와 여자아이에게 어떻게 다르게 영향을 미치는지 비교하여 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 사람들이 어떠한 방법으로 자신의 외모에 변화를 주고자 하는지 분석하고(예: 다이어트 약, 스테로이드, 표백 크림), 그 위험을 평가할 수 있다. (지식)
- ▶ 아름다움에 대한 젠더화된 기준은 사람들로 하여금 자신의 외모를 바꾸고 싶어하도록 유도할 수 있음을 비판적으로 평가할 수 있다. (지식)
- ▶ 자신의 신체 이미지와 관련하여 어려움을 겪을 수 있는 다양한 장애(예: 불안감, 거식증과 폭식증과 같은 섭식장애)에 대해 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 자신의 신체 이미지를 바꾸기 위해 마약을 사용하는 것은 해로울 수 있음을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 자신의 신체 이미지와 관련하여 고통을 겪고 있는 사람들을 지원하는 서비스에 접근하는 방법을 보여줄 수 있다. (기술)

학습목표(15-18세 이상)

핵심내용 : 외모에 대한 비현실적인 기준을 비판적으로 바라볼 수 있다.

- ▶ 특정 문화 및 성별 고정관념이 사람들의 신체 이미지와 관계에 미치는 영향을 분석할 수 있다. (지식)
- ▶ 신체적 외모에 대한 비현실적인 기준은 유해할 수 있음을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 자신의 신체 이미지에 대해 생각해보고 그것이 자존감, 성적 의사 결정 및 성적 행동에 어떻게 영향을 미칠 수 있는지 생각해 볼 수 있다. (기술)
- ▶ 신체적 외모에 대한 비현실적인 기준에 이의를 제기하는 방법을 보여줄 수 있다. (기술)

핵심 개념 7:

섹슈얼리티(Sexuality)와

성적 행동(Sexual Behaviour)

주제 :

- 7.1 성(Sex), 섹슈얼리티(Sexuality),
생애 주기 별 성생활
- 7.2 성적 행동 및 반응

핵심 개념 7: 섹슈얼리티와 성적 행동

7.1 성(Sex), 섹슈얼리티(Sexuality), 생애 주기 별 성생활

학습목표(5-8세)

핵심내용 : 인간이 자신의 몸을 즐기고 일생에 걸쳐 다른 사람들과 가까워지는 것은 자연스러운 일이다.

- ▶ 육체적 즐거움과 흥분은 인간이 가지는 자연스러운 감정이며, 다른 사람과의 신체적 친근감도 포함될 수 있음을 이해할 수 있다. (지식)
- ▶ 육체적인 감정 표현은 다른 사람과 교감할 수 있는 방법 중 하나임을 이해할 수 있다. (지식)
- ▶ 다른 사람에게 감정과 친밀감을 표현하는 방식에는 적절하거나 부적절한 언어와 행동이 있음을 인식할 수 있다. (태도)

학습목표(9-12세)

핵심내용 : 인간은 일평생 자신의 섹슈얼리티를 즐길 수 있는 능력을 갖고 태어난다.

- ▶ 섹슈얼리티는 다른 사람에 대한 감정적, 신체적 매력을 포함한다는 것을 이해할 수 있다. (지식)
- ▶ 인간이 신체적 접촉(예: 키스, 만지기, 애무, 성적 접촉)을 통해 쾌락을 느끼는 방식을 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 섹슈얼리티는 인간의 건강한 한 부분임을 인식한다. (태도)
- ▶ 성소수자에 대한 차별은 잘못된 것이며 이들에게 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 인식한다. (태도)
- ▶ 사람마다 다르게 느끼는 성적인 감정에 대해 소통하고 이해할 수 있으며, 적절한 방법으로 섹슈얼리티를 말할 수 있다. (기술)

핵심내용 : 섹슈얼리티에 호기심을 갖는 것은 자연스러운 것이며 믿을 수 있는 어른에게 물어보는 것이 중요하다.

- ▶ 섹슈얼리티에 호기심을 갖고 질문을 하는 것은 자연스러운 것임을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 편안하고 신뢰할 수 있는 어른을 찾아서 섹슈얼리티에 대해 물어볼 수 있다. (기술)

학습목표(12-15세)

핵심내용 : 성적 감정, 환상, 욕구는 일상에서 자연스럽게 일어날 수 있지만 사람들이 항상 그러한 감정에 따라 행동하지는 않는다.

- ▶ 사람들이 자신의 섹슈얼리티를 표현하는 방법을 열거할 수 있다. (지식)
- ▶ 성적, 감정, 환상, 욕구는 일상생활을 통해 일어나며, 자연스럽게 수치스러운 것이 아님을 말할 수 있다. (지식)
- ▶ 사람들이 자신의 성적 감정, 환상, 욕구에 따라 행동을 선택하지 않는 이유를 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 섹스에 대한 관심은 나이에 따라 변할 수 있으며 삶 전체에 걸쳐 표현될 수 있음을 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 사람들이 섹슈얼리티를 표현하는 방법은 문화와 환경에 따라 다양하고 이를 존중하는 것이 중요함을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 성적 감정, 환상, 욕구와 관련된 감정을 다루는 방법을 보여줄 수 있다. (기술)

학습목표(15-18세 이상)

핵심내용 : 섹슈얼리티는 복합적이며 생물학적, 사회적, 심리적, 영적, 윤리적, 문화적 차원을 포괄한다.

- ▶ 생물학적, 사회적, 심리적, 영적, 윤리적, 문화적 요소를 포괄하는 섹슈얼리티의 복합성을 설명하고 분석할 수 있다. (지식)
- ▶ 섹슈얼리티는 인간의 자연스러운 한 부분이며 삶의 질을 높일 수 있음을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 자신의 섹슈얼리티, 그리고 섹슈얼리티에 영향을 주는 요소를 생각해 볼 수 있다. (기술)

7.2 성적 행동 및 반응

학습목표(5-8세)

핵심내용: 사람들은 신체접촉이나 성행위를 통해 사랑을 표현할 수 있다.

- ▶ 사람들은 키스, 포옹, 신체접촉, 성 행위 등 다양한 방법으로 사랑과 관심을 표현한다는 것을 알 수 있다. (지식)

핵심내용: 적절하고 적절하지 않은 신체접촉이 무엇인지 이해할 수 있다.

- ▶ ‘좋은 신체접촉’과 ‘나쁜 신체접촉’에 대해 정의할 수 있다. (지식)
- ▶ 누군가 아이들에게 부적절한 방법으로 신체를 접촉할 수 있음을 알 수 있다. (태도)
- ▶ 누군가 자신에게 나쁜 방법으로 신체접촉을 할 경우 어떻게 할 것인지 보여줄 수 있다. (기술)

학습목표(12-15세)

핵심내용: 성적 자극에 따라 신체가 어떻게 반응하는지 안다.

- ▶ 성적 자극에는 신체적, 심리적 자극이 있으며 사람마다 반응하는 방법과 시간이 다르다는 것을 이해할 수 있다. (지식)
- ▶ 성적 반응은 질병, 스트레스, 성적 학대, 약물치료, 약물사용, 트라우마와 같은 문제의 영향을 받을 수 있음을 인식할 수 있다. (태도)

핵심내용: 사회, 문화, 세대에 따라 성적 행동에 대한 통념이 있다는 사실을 아는 것이 중요하다.

- ▶ 성적 행동에 대한 통념과 사실을 구분할 수 있다. (지식)
- ▶ 섹슈얼리티와 관련된 정보의 사실을 아는 것이 중요하다는 점을 안다. (태도)
- ▶ 성적 행동 통념에 대해 의문을 제기할 수 있다. (기술)

핵심내용: 정보에 근거하여 성적 행동에 대한 의사결정을 하는 것이 중요하다.

- ▶ 정보에 근거한 성적 의사결정(풍부한 지식과 자신감을 갖고 언제 누구와 성 행위를 할 것인지 말 것인지를 결정하는)이 자신의 건강과 복지를 위해 중요함을 인식할 수 있다. (태도)

학습목표(9-12세)

핵심내용: 사람들은 성적 자극(신체적 또는 정신적)에 의해 신체 반응이 나타날 수 있다.

- ▶ 성적 자극에 대한 신체 반응을 기술할 수 있다. (지식)
- ▶ 사춘기 동안에 성적 끌림과 자극에 대한 그들의 반응을 더 잘 인식할 수 있게 됨을 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 많은 아이들이 유아·아동·청소년기에 자위를 시작함을 알 수 있다. (지식)
- ▶ 자위행위는 신체적 또는 정서적으로 해롭지 않으나 개인적으로 해야 함을 인식할 수 있다. (지식)

핵심내용: 성행위의 시기, 방법, 파트너, 피임법 등 성행위와 관련한 다양한 선택지에 대해 정보에 기반해서 결정을 내릴 수 있어야 한다.

- ▶ 섹스를 늦추거나 섹스를 하는 것에 대한 선택의 장단점을 비교하고 대조할 수 있다. (지식)
- ▶ 절제란 섹스를 하지 않기로 하거나 언제 누구와 섹스를 시작할 것인지 결정하는 것임을 이해하고, 이것이 임신과 HIV를 포함한 성병을 예방하는 가장 안전한 방법임을 이해할 수 있다. (지식)
- ▶ 섹스 및 관계와 관련하여 선택한 결정이 자신의 미래 계획에 어떻게 영향을 미칠 수 있는지 생각해볼 수 있다. (태도)

핵심 개념 7: 섹슈얼리티와 성적 행동

7.2 성적 행동 및 반응

- ▶ 성적 행동에 대한 의사결정은 사람마다 다르며, 시간이 지나면서 변할 수 있고 항상 존중되어야 함을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 자신의 성적 행동에 대해 책임 있는 의사결정을 할 수 있다. (기술)

핵심내용 : 자신의 건강과 복지에 부정적인 영향을 줄 수 있는 성 행위의 위험을 피하거나 줄일 수 있는 방법이 있다.

- ▶ 성 행위와 관련한 위험을 줄이고 생활 계획을 지원하는 선택이 가능함을 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 콘돔 및 기타 피임약이 의도하지 않은 성 행위 결과의 위험(임신, 성매개 감염병 등)을 줄인다는 것을 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 질과 음경이 결합하지 않는 성 행위는 의도하지 않은 임신에 대한 위험이 없으며, HIV와 성매개 감염병(STIs) 위험을 줄이면서 즐길 수 있음을 알 수 있다. (지식)
- ▶ 성 행위와 관련된 위험을 최소화하고 인생 계획을 실현할 수 있는 선택지가 있음을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 정보에 근거하여 성적인 행동을 취할 수 있다. (기술)

핵심내용 : 성매매, 성 접대 등의 성착취는 건강과 복지의 위험을 초래할 수 있다.

- ▶ 성 행위 거래에 대한 정의를 할 수 있다. (지식)
- ▶ 돈이나 재화의 거래를 수반하는 친밀한 관계는 불평등한 권력 관계와 취약성을 증가시키고 보다 안전한 섹스를 위한 협상력을 제한할 수 있음을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 성 행위 거래를 줄이기 위한 단호한 대화와 거부의 기술을 보여 줄 수 있다. (기술)

학습목표(15-18세 이상)

핵심내용 : 성 행위를 하는 것이 즐거워야 하며 자신의 건강 및 복지와 관련한 책임이 따른다.

- ▶ 성적 즐거움과 책임의 핵심 요소를 알 수 있다. (지식)
- ▶ 많은 사람들이 다른 사람과의 성적 접촉 없이 살아가는 시기가 있음을 상기할 수 있다. (지식)
- ▶ 좋은 대화가 성적 관계 향상에 미치는 영향을 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 젠더 규범과 고정관념이 사람들의 성적 즐거움에 어떤 영향을 미치는지 깊이 생각해 볼 수 있다. (지식)
- ▶ 성적 자극에 따른 신체 반응을 이해하는 것이 자신의 몸을 이해하는데 도움을 주고, 상황이 좋지 않을 때 도움을 요청할 수 있음을 인식할 수 있다. (지식)
- ▶ 성적 파트너와 자신이 원치 않는 임신과 성매개 감염병을 예방하기 위해 책임을 다 해야 함을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 성적 욕구와 제한에 대한 대화를 할 수 있다. (기술)

핵심내용 : 성적 의사결정을 위해서는 원치 않는 임신과 성병/HIV를 감염시키는 위험을 예방하기 위한 방법을 알고 실천할 수 있다.

- ▶ 출산, 성적 학대, 준비되지 않거나 원치 않는 섹스를 했을 경우, 성매개 감염병 및 원치 않는 임신을 예방하기 위한 방법이 무엇인지 알 수 있다. (지식)
- ▶ 돈이나 재화를 이용한 관계는 안전한 섹스를 위한 의사소통 능력을 제한할 수 있음을 상기할 수 있다. (지식)
- ▶ 원치 않는 임신과 성매개 감염병/HIV를 다른 사람에게 감염시키는 위험을 줄일 수 있음을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 원치 않는 임신, 성매개 감염병/HIV를 다른 사람에게 감염시키는 위험을 줄이는 방법을 실천할 수 있다. (기술)

핵심 개념 8:

성과 재생산 건강

(Sexual and Reproductive Health)

주제 :

- 8.1 임신, 임신예방
- 8.2 HIV와 AIDS 낙인, 돌봄, 치료, 지원
- 8.3 성매개 감염병/HIV 위험 감소에 대한 이해와 인식

핵심 개념 8 : 성과 생식 건강

8.1 임신, 임신예방

학습목표(5-8세)

핵심내용 : 임신은 자연스러운 생물학적 과정이며 계획할 수 있다.

- ▶ 임신은 난자와 정자가 만나 자궁에 착상할 때 시작된다는 것을 상기할 수 있다. (지식)
- ▶ 임신과 생식은 자연스러운 생물학적 과정이며 언제 임신할 것인지 계획할 수 있음을 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 원하는 임신을 해야 하며 임신한 아이는 돌봄과 사랑이 필요함을 설명할 수 있다. (태도)
- ▶ 모든 커플이 아이를 가지는 것은 아님을 인식할 수 있다. (지식)

학습목표(9-12세)

핵심내용 : 주요한 임신 특성을 이해하는 것이 중요하다.

- ▶ 일반적인 임신의 징후를 열거할 수 있다. (지식)
- ▶ 임신을 확인하기 위한 방법을 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 조기 결혼(자발적, 강제적) 및 조기 임신 및 출산과 관련한 건강 위험에 대해 안다. (지식)
- ▶ 이른 나이에 원치 않는 임신을 하는 것은 건강과 사회에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 임신의 징후가 있을 경우 부모/보호자 또는 신뢰할 수 있는 성인에게 도움을 요청할 수 있다. (기술)

핵심내용 : 피임은 임신 예방과 계획에 도움을 줄 수 있다.

- ▶ 피임, 콘돔, 원치 않는 임신 예방법에 대한 잘못된 통념을 바로잡을 수 있다. (지식)
- ▶ 질과 음경을 결합 하지 않는 것이 원치 않는 임신을 피하는 효과적인 방법임을 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 원치 않는 임신의 위험을 줄이기 위해 남녀 모두 콘돔을 바르게 사용하는 단계를 설명할 수 있다. (지식)

핵심내용 : 성 역할 및 또래집단의 규범은 피임을 위한 의사결정에 영향을 미칠 수 있다.

- ▶ 성 역할과 또래집단의 규범이 피임 방법에 어떻게 영향을 미칠 수 있는지에 대해 토론할 수 있다. (지식)
- ▶ 콘돔 또는 기타 피임 방법을 결정하는 것은 남녀 파트너 모두의 책임이라는 것을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 임신 예방은 남녀 모두의 책임이라는 것을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 피임에 대해 어떻게 느끼는지 그리고 이러한 느낌에 영향을 미치는 성 역할 및 또래집단의 규범에 대해 깊이 생각해 볼 수 있다. (기술)

8.1 임신, 임신예방

학습목표(12-15세)

핵심내용 : 피임법마다 다른 효과, 효능, 장점, 부작용을 가지고 있다.

- ▶ 원치 않는 임신을 예방하는 효과적인 방법(예: 남녀 콘돔, 피임약, 피임주사, 임플란트, 응급피임법)과 관련된 효능을 분석할 수 있다. (지식)
- ▶ 원치 않는 임신에 취약한 개인의 개념을 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 질과 음경의 접촉을 완벽하게 차단하는 것은 원치 않는 임신을 예방하는 한 가지 방법임을 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 콘돔과 현대 피임약을 올바른 방법으로 사용한다면 의도하지 않는 임신을 예방할 가능성이 높음을 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 콘돔을 올바르게 사용하는 방법을 보여줄 수 있다. (기술)
- ▶ 부족한 피임, 잘못된 피임, 피임 실패 또는 성폭력으로 인한 임신을 포함한 원치 않는 임신을 예방할 수 있는 응급 피임법(합법적이고 유효한)을 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 자연 피임법은 올바른 피임법만큼 신뢰할 수는 없지만, 올바른 피임을 할 수 없을 경우, 자연적 피임을 하는 것이 아무 것도 하지 않는 것보다 나으며, 보건 전문가의 도움을 받을 수도 있다. (지식)
- ▶ 불임은 영구적인 피임법임을 설명할 수 있다. (지식)

핵심내용 : 성적으로 활발하고 피임이 필요한 많은 청소년들은 자신의 능력, 혼인 유무, 성별, 성 정체성 또는 성적 지향과 무관하게 큰 장벽 없이 피임을 할 수 있어야 한다.

- ▶ 청소년들이 콘돔이나 피임 도구를 구하는데 방해나 제한이 있다 할지라도 피임도구를 일반적으로 어디서 구할 수 있는지 찾아볼 수 있다. (지식)
- ▶ 청소년들이 결혼 상태, 성별 또는 젠더와 관계 없이 피임법 및 콘돔을 쉽게 구할 수 있어야 함을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 피임을 위한 자원(정보, 서비스, 도구 등)에 접근하는 방법을 보여줄 수 있다. (기술)

학습목표(15-18세 이상)

핵심내용 : 피임은 성 행위를 하는 사람들의 임신 예방 또는 임신 시기를 계획하는데 도움이 될 수 있으며 이는 개인 및 사회적 이익과 관련하여 중요하다.

- ▶ 피임법(예: 남녀 콘돔, 피임약, 피임주사, 임플란트, 응급 피임법)이 개인에게 주는 이익과 가능한 부작용이나 위험을 평가할 수 있다. (지식)
- ▶ 가장 적절한 또는 혼합된 피임 방법을 결정하는데 도움을 주는 요소(예: 위험 인식, 비용, 접근성)를 파악할 수 있다. (지식)
- ▶ 콘돔 및 응급 피임법을 포함한 올바른 피임 도구 사용의 중요성을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 다양한 피임법을 사용하고 토론하는데 대한 자신감을 가질 수 있다. (태도)
- ▶ 필요할 때 원하는 피임법을 선택하고 피임을 위한 계획을 세울 수 있다. (기술)

핵심내용 : 원치 않는 임신을 했을 때 모든 청소년은 건강과 복지를 위해 필요한 서비스와 보호 장치에 접근할 수 있어야 한다.

- ▶ 10대 비혼모가 학업을 지속하고 마칠 권리와 차별 없이 재생산 건강 서비스를 받을 권리를 보호하기 위한 관련법 및 정책을 조사할 수 있다. (지식)
- ▶ 학교 재학 중 임신한 청소년을 배제하거나 퇴학시키는 것은 인권에 위배된다는 것을 인식할 수 있다. (지식)
- ▶ 의도하거나 의도하지 않는 임신의 경우, 임신한 여성 또는 청소년이 이용할 수 있는 건강 및 지원 서비스의 범위를 확인할 수 있다. (지식)
- ▶ 불안정한 인공임신중단은 여성과 청소년에게 심각한 건강 위험을 초래 한다는 것을 이해할 수 있다. (지식)
- ▶ 조기 또는 원치 않는 임신이 되었을 경우일지라도 임신한 여성 또는 청소년은 양질의 안전하고 포괄적인 건강 관리 및 지원 서비스에 접근할 수 있어야 함을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 의도하거나 의도하지 않 임신을 하거나, 아이가 있는 사람에게 건강, 교육, 복지와 관련한 도움을 줄 수 있다. (기술)

핵심 개념 8 : 성과 생식 건강

8.1 임신, 임신예방

학습목표(12-15세)

핵심내용 : 조기 분만과 짧은 임신 간격은 건강에 위험하다.

- ▶ 조기 분만의 정의와 조기 분만이 건강에 미칠 수 있는 위험을 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 짧은 임신 간격이 신체에 미치는 영향을 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 임신을 지연하고 간격을 두는 것의 중요성을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 임신을 원하는지 원치 않는지, 원한다면 언제하고 싶은지 의사를 표현할 수 있다. (기술)

학습목표(15-18세 이상)

핵심내용 : 입양은 누군가 임신할 될 준비가 되어 있지 않거나 될 수 없는 경우 선택할 수 있다.

- ▶ 입양의 장점과 위험에 대해 평가할 수 있다. (지식)
- ▶ 입양은 임신할 준비가 되어 있지 않거나 될 수 없는 사람들을 위한 중요한 선택임을 인식할 수 있다. (태도)

핵심내용 : 건강한 임신에 도움이 되거나 위협이 되는 관행이 있다.

- ▶ 건강한 임신에 도움이 되거나 위협이 되는 관행이 무엇인지 평가할 수 있다. (지식)
- ▶ 건강한 임신을 위해 노력하는 것은 단지 엄마의 책임만이 아님을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 건강한 임신을 위한 지원 계획을 세울 수 있다. (기술)

8.2 HIV와 AIDS 낙인, 돌봄, 치료, 지원

학습목표(5-8세)

핵심내용 : HIV 감염자도 동등하고 생산적인 삶을 살 권리가 있다.

- ▶ HIV 감염자도 올바른 돌봄, 치료, 지원이 있으면 충분히 생산적인 삶을 살 수 있고 자신의 자녀를 가질 수도 있음을 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ HIV 감염자도 다른 모든 사람처럼 동등한 사랑, 존중, 돌봄, 지원을 받을 권리가 있음을 인식할 수 있다. (태도)

핵심내용 : HIV 감염자를 도울 수 있는 효과적인 치료법이 있다.

- ▶ 돌봄, 존중, 지원을 받음으로써 HIV 감염자가 자신의 현재 상태를 관리할 수 있는 효과적인 치료법이 있음을 설명할 수 있다. (지식)

학습목표(9-12세)

핵심내용 : HIV 감염자는 안전하고 지지 받는 환경 속에서 자신의 HIV 상태에 대해 말할 수 있어야 한다.

- ▶ HIV 감염자가 자신의 상태에 대해 이야기 할 때 직면하게 되는 이점과 도전에 대해 말할 수 있다. (지식)
- ▶ HIV 감염자는 태어날 때부터 HIV를 가지고 태어난 경우도 있으며, 어떤 사람들은 삶 속에서 감염된 경우도 있음을 상기할 수 있다. (지식)
- ▶ HIV 감염자를 위한 안전하고 지원받는 환경을 보장할 책임이 모든 사람에게 있음을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 안전하고 지원받는 환경을 조성하는 방법을 제시할 수 있다. (기술)

핵심내용 : HIV 감염자는 부작용 증상을 포함한 치료 및 돌봄을 받고자 하는 욕구가 있다.

- ▶ HIV 감염자는 부작용 증상을 포함한 HIV 치료 및 돌봄을 받고자 하는 욕구가 있음을 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ HIV 치료는 평생에 걸친 과제이며 종종 부작용 및 기타 문제가 발생할 수도 있어 영양에 특별한 주의를 기울일 필요가 있음을 상기할 수 있다. (지식)
- ▶ HIV에 감염된 아동과 청소년은 치료 혜택을 받을 수 있고, 사춘기에는 특히 적절한 복용량 및 순응도 및 부작용(예: 뼈 밀도, ARV 약물 내성) 확인하기 위한 세심한 주의가 필요함을 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 사람들이 HIV 돌봄 및 치료 서비스에 어떻게 접근할 수 있는지 설명할 수 있다. (기술)

핵심내용 : HIV 및 에이즈는 가족 구조, 가족의 역할 및 책임에 영향을 미칠 수 있다.

- ▶ 서로 다른 HIV 상태인 사람들은 함께 살면서 HIV에 감염될 위험없이 성적 파트너가 될 수도 있고, HIV가 없는 아이를 가질 수도 있기 때문에 가족과 관계를 만들거나 성 생활을 하는데 HIV가 장애물이 되지 않는다는 것을 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ HIV가 가족의 구조, 역할, 책임에 어떻게 영향을 줄 수 있는지 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 가족과 지역사회에서의 돌봄, 치료, 서비스를 통해 HIV 감염 여성도 건강할 수 있으며 HIV가 없는 아이를 낳고 모유 수유를 할 수 있음을 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 모든 사람이 HIV 감염자를 지원할 책임이 있음을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ HIV 감염자를 지원하는 방법을 보여줄 수 있다. (기술)

핵심 개념 8: 성과생식 건강

8.2 HIV와 AIDS 낙인, 돌봄, 치료, 지원

8

학습목표(12-15세)

핵심내용 : 올바른 치료, 존중 및 지원을 통해 HIV 감염자도 차별 없는 충분히 생산적인 삶을 살 수 있다.

- ▶ HIV 때문에 사람을 차별하는 것은 불법임을 인식할 수 있다. (지식)
- ▶ 출생하면서부터 HIV에 감염되어 있는 사람들도 치료와 지원으로 충분히 건강하고 생산적인 삶을 살 수 있음을 인식할 수 있다. (태도)

핵심내용 : HIV 감염자를 비롯한 모든 사람들은 결혼과 장기 계약을 함으로써 타인에 대한 성적 감정과 사랑을 표현할 동등한 권리를 가진다.

- ▶ 왜 HIV 감염자를 포함한 모든 사람에게 타인에 대한 성적 감정과 사랑을 표현할 권리가 정당한지 보여줄 수 있다. (지식)
- ▶ HIV 감염자를 포함하여 타인에 대한 성적 감정과 사랑을 표현할 권리를 지지할 수 있다. (태도)

핵심내용 : HIV 감염자가 운영하거나 감염자와 함께 운영하는 단체 혹은 프로그램을 지지하라.

- ▶ HIV 감염자가 운영하거나 감염자와 함께 운영하는 단체, 프로그램을 어떻게 지원하는 것이 도움이 될 수 있을지 설명하고, 그들이 제공하는 서비스에 대해 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ HIV 감염자가 운영하거나 감염자와 함께 운영하는 단체, 프로그램이 제공하는 도움에 감사할 줄 안다. (태도)
- ▶ 지역의 지원 단체와 프로그램에 접근하는 방법을 보여줄 수 있다. (기술)

학습목표(15-18세 이상)

핵심내용 : 올바른 관심과 존중, 지원으로 HIV 감염자가 생애 전반에 걸쳐 충분히 생산적인 삶을 살도록 이끌 수 있다.

- ▶ HIV 감염자 또는 HIV와 에이즈에 걸린 사람들에 대한 낙인과 차별의 원인과 영향을 분석할 수 있다. (지식)
- ▶ 자신의 나라에서 HIV(남성, 여성, 트랜스젠더) 감염자로서 활동하는 활동가를 찾아보고, 그들이 HIV에 대한 사람들의 생각을 바꾸고 HIV 감염자를 지원 및 보호한 것과 관련된 성과를 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ HIV와 함께 살아가는 사람들이 이룬 것에 감사할 줄 안다. (태도)
- ▶ HIV 감염자를 포함하여 모든 사람들이 낙인과 차별로부터 자유로울 수 있는 권리를 옹호할 수 있다. (기술)

8.3 HIV를 포함한 성병 위험 감소에 대한 이해와 인식

학습목표(5-8세)

핵심내용 : 질병으로부터 신체를 보호하고 건강을 유지하도록 돕는 면역체계가 있음을 안다.

- ▶ ‘건강’과 ‘질병’의 개념에 대해 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 사람들은 질병으로부터 자신을 보호하는 면역체계를 가지고 있음을 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 사람들이 자신의 건강을 보호하는 방법을 열거할 수 있다. (지식)

핵심내용 : 사람들은 병에 걸려도 건강해 보일 수 있다.

- ▶ 누군가 병에 걸렸다 해도 여전히 건강해 보일 수 있음을 상기할 수 있다. (지식)

핵심내용 : 사람은 누구나 질병이 있든, 없든 사랑, 돌봄, 지지를 필요로 한다.

- ▶ 사람들은 자신의 건강 상태와 무관하게 사랑, 돌봄, 지지를 필요로 한다는 것을 설명할 수 있다. (지식)

학습목표(9-12세)

핵심내용 : 성매개감염병을 가지고 있는 사람과 섹스를 하면 HIV를 포함한 성매개감염병에 걸릴 수 있는 가능성이 있으나, 감염에 대한 취약성을 낮출 수 있는 방법이 있다.

- ▶ 청소년들 사이에서 일반적인 성매개감염병(예: HIV, HPV, 헤르페스, 클라미디아, 임질)의 종류와 가장 일반적인 성매개감염병 전염 경로를 열거할 수 있다. (지식)
- ▶ HIV는 평상시의 접촉(예: 악수, 포옹, 같은 잔으로 술 마시기)으로는 전염되지 않는다는 것을 설명할 수 있다. (지식)

핵심내용 : HIV는 HIV에 감염된 누군가와 무방비적인 섹스를 포함한 다양한 방식으로 전염될 수 있는 바이러스이다.

- ▶ HIV가 전염될 수 있는 다양한 방법(예: HIV 양성인 사람과의 무방비적인 성관계, 전염된 사람의 혈액 수혈, 주사기 공유, 바늘 또는 다른 예리한 도구, 임신 중, 출생 중 또는 모유 수유 중)을 열거할 수 있다. (지식)
- ▶ 대부분의 사람들은 HIV 감염자와의 무방비 상태의 성적인 접촉을 통해 HIV에 감염된다는 것을 설명할 수 있다. (지식)

핵심내용 : HIV를 포함한 성매개감염병에 걸릴 위험을 줄일 수 있는 방법이 있다.

- ▶ HIV 감염 전(예: 콘돔 사용이 가능할 경우 콘돔 사용과 함께 자발적 포경수술(VMMC), 노출 전 감염 위험 감소요법(PrEP)과 감염 후(예: 가능하다면 바이러스 노출 후 예방 요법(PEP) HIV 감염 위험을 줄이는 방법을 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 콘돔을 단계별로 올바르게 사용하는 방법을 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 생식기 인유두종 바이러스(HPV)에 대한 백신 접종이 가능한 나이와 장소를 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 올바르게 지속적인 콘돔 사용과 피임을 포함하여 더욱 안전한 섹스를 하고자 하는 의도를 강하게 표명하고, 원치 않는 성적 압박에 대항하는 소통, 협상, 거절 기술을 보여줄 수 있다. (기술)

핵심내용 : HIV를 포함한 성매개감염병이 있는 사람이 누구인지, HIV 및 대부분의 성매개감염병 치료가 끝났는지를 확실히 알 수 있는 유일한 방법은 검사뿐이다.

- ▶ 자신의 지역사회에서 성매개 감염병 검사 및 HIV를 포함 가장 일반적인 성매개감염병 치료법에 대해 설명할 수 있다. (지식)

핵심 개념 8: 성과 생식 건강

8.3 HIV를 포함한 성병 위험 감소에 대한 이해와 인식

학습목표(12-15세)

핵심내용 : 성 보건 서비스는 HIV 검사, 치료, 콘돔을 제공할 수 있으며, 일부는 HIV에 대한 취약성을 평가하고 필요에 따라 검사 및 치료에 도움을 줄 수 있는 노출 전 감염 위험 감소 요법 (PrEP), 노출 후 예방 요법(PEP) 또는 자발적 포경수술 (VMMC) 서비스를 제공할 수 있다.

- ▶ HIV 검사를 받기 위한 건강 시스템과 HIV 감염자에 대한 지원을 제공하는 프로그램에 접근하는 방법을 조사할 수 있다. (지식)
- ▶ 이용 가능한 HIV 검사 유형과 검사가 어떻게 진행되는지 알 수 있다. (지식)
- ▶ 자발적 포경수술(VMMC) 서비스를 설명하고 사람들 간의 HIV 취약성을 어떻게 줄일 수 있는지에 대해 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 잠재적으로 HIV에 노출될 가능성을 줄이기 위한 방법인, 노출 전 감염 위험 감소 요법 (PrEP)과 노출 후 예방 요법(PEP)을 정의하고, 지역에서 이용이 가능한지 알아볼 수 있다. (지식)
- ▶ 누구나 자발적이고 사전에 통지된 비밀 검사를 받을 권리가 있으며 HIV 상태가 공개될 필요는 없다는 것을 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ HIV에 대한 취약성을 평가하기 위한 검사와 필요에 따라 치료를 받는 것의 중요성을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 검사를 받기 원하는 친구를 지지하는 방법을 보여줄 수 있다. (기술)

- ▶ 검사를 받기를 원하는 사람을 지지하는 방법을 설명할 수 있다. (지식)
- ▶ 검사를 받는 사람의 안전 및 지원의 중요성을 인식할 수 있다. (태도)
- ▶ 지역사회에서 검사를 받을 수 있는 곳이 어디인지 보여줄 수 있다. (지식)

학습목표(15-18세 이상)

핵심내용 : 소통, 협상, 거절 능력은 청소년들이 원치 않는 성적 압력에 대항하거나 안전한 섹스를 하도록 유도할 수 있다. (예: 지속적인 콘돔 사용과 피임)

- ▶ 사람들의 협상 기술은 사회적 규범, 불평등한 권력, 개인의 신념, 자신의 결정력에 대한 자신감에 의해 영향을 받을 수 있음을 상기할 수 있다. (지식)
- ▶ 원치 않는 성적 압력에 대항하고 더욱 안전한 섹스를 위해 자신이 사용할 수 있는 효과적인 의사소통, 협상 및 거절 기술을 적용할 수 있다. (기술)

핵심내용 : 자기 효능감, 인지적 취약성, 젠더 역할, 또래집단 규범은 성적 취약성을 줄이기 위한 전략 결정에 영향을 준다.

- ▶ 성적 취약성을 줄이기 위한 개인의 결정에 잠재적인 영향을 주는 모든 것에 대해 비평할 수 있다. (지식)
- ▶ 사회의 특정 그룹에 대한 배제와 차별이 HIV 및 기타 성매개감염병에 대한 약성을 증가시킨다는 것을 인식할 수 있다. (지식)
- ▶ 건강과 복지를 위한 개인 계획을 세우고 실천할 수 있다. (기술)
- ▶ 콘돔 사용법을 보여줄 수 있다. (기술)

핵심내용 : 성 건강 서비스는 콘돔, HIV 검사, 치료를 제공할 수 있으며, 일부는 성매개 감염병 검사와 치료, 피임, 젠더에 기반한 폭력 대응과 같은 서비스 중 노출 전 감염 위험 감소 요법 (PrEP), 바이러스 감염 직후 예방 요법 (PEP) 또는 자발적 포경수술 (VMMC)을 제공함으로써, 사람들이 HIV에 대한 취약성을 평가하고 필요 시 검사 및 치료에 도움을 줄 수 있다.

- ▶ HIV 취약성을 줄이고 예방하기 위해 사람들이 이용할 수 있는 성 건강 서비스를 평가할 수 있다. (지식)
- ▶ PrEP와 PEP를 포함한 안전하고 비밀이 보장되는 HIV 검사 및 기타 서비스를 받을 수 있는 곳을 찾을 수 있다. (지식)

6

CSE 프로그램

실행계획과 지원

6 - CSE 프로그램 실행 계획과 지원

이 장에서는 서로 다른 이해관계자에 의한 CSE 프로그램 사례가 어떻게 만들어지는지에 대해 설명한다. 또, 학교 안 밖에서의 CSE 프로그램을 계획 실행하는 활동가를 지원하는 방안, 참여가 필요한 이해관계자와 그들의 역할 및 기여에 대해 개괄적으로 설명한다.

6.1 CSE 실행력 강화

효과적인 CSE 프로그램에 대한 분명하고, 긴급한 요구에도 불구하고 전 세계 여러 국가가 아직 실행하고 있지 않다. 이유로는 섹슈얼리티 교육의 본질, 목적, 효과에 대한 오해에서 비롯된 CSE 프로그램에 대한 인식과 저항 등이 있다. CSE를 의제에 포함하기 위해서는 이와 같은 실제적 또는 인식적 저항에 대응하는 것이 중요하다.

다음 사항은 CSE의 도입 및 국가적 실시를 위한 명확한 근거를 설정하는데 도움이 될 수 있다.

청소년들의 국가 지역적 맥락에 따른 요구를 보여주는 자료를 활용하라. 자료에는 가장 취약한 청소년들을 포함한 청소년들의 HIV, 기타 성매개감염병(STIs), 십대 임신, 성적 행동 패턴, HIV와 기타 성매개감염병(STI)위험 및 취약성 관련 특정 요인에 대한 연구가 포함되

어야 한다. 이상적으로는 성 활동 개시 연령 및 경험에 대한 성별, 젠더관점 통계, 파트너십 역학관계, 강간, 강압 또는 착취를 포함한 젠더기반폭력(GBV)에 대한 통계, 파트너십 기간과 동시성, 콘돔 사용과 현대 피임법, 이용 가능한 건강 서비스 이용에 대한 공식적, 참여 관찰, 양적, 질적 정보를 모두 포함한다. 가능한 자료를 활용하는 것이 CSE 수업이 학습자 삶의 향상을 위해 반드시 필요하다는 것을 보여주는 데 유용하다.

CSE 지원을 위한 국제적 지역적 프레임워크와 국제협약을 활용하라. 여러 나라가 높아진 정치적 의지를 보여주는 것부터 CSE 프로그램 개발과 투자에 이르기까지 CSE 프로그램 개발과 실행에 주도적 역할을 해왔다.

박스 2. CSE 관련 회원국간 국제 유엔 표준 및 협약의 예

세계인구개발회의(ICPD) 행동계획과 베이징행동강령(Beijing Platform for Action)과 검토 회의 결과 문서에서 다음과 같이 정부에 요구한다. ‘사생활 및 비밀보장에 대한 존중, 차별로부터의 자유와 함께 청소년의 성 및 재생산 건강 서비스에 대한 정보와 교육 요구를 충족하는 것에 모든 관심을 기울이고, 섹슈얼리티, 성 및 재생산 건강, 인권, 성평등에 관한 포괄적인 교육을 성과 자료에 기초하여 제공함으로써 청소년들로 하여금 자신의 섹슈얼리티에 대해 긍정적이고, 책임감 있게 대처할 수 있도록 지원한다.’

지속 가능한 개발목표(SDGs)를 포함한 2030년 지속 가능발전 의제에서 설정된 내용은 다음과 같다. 건강한 삶의 보장과 모든 단계에서 모두를 위한 웰빙 증진(SDG3), 포괄적이고, 평등한 양질의 교육 보장과 모두를 위한 평생학습의 기회 증진(SDG4), 성평등 달성 및 모든 여성과 여자 어린이의 역량 강화(SDG5)

인권 이사회는 국가에 다음과 같이 요구한다. ‘완전하고 정확한 정보를 토대로 모든 사춘기 및 청소년에게 포괄적 섹슈얼리티를 포함한 교육 프로그램과 자료를 발달 역량에 맞게 개발하여 실행한다.’

아동권리위원회는 다음과 같은 내용을 국가에 촉구한다. ‘과학적 증거와 인권 기준에 기초하여 청소년과 함께 성 및 재생산 건강 교육을 포괄하는 연령별 포괄적 교육은 학교 의무 교육과정 중 하나가 되어야 하며 학교 밖 청소년에게도 적용될 수 있어야 한다.’

경제, 사회, 문화 권리위원회는 다음과 같이 권고한다. ‘성 및 재생산 건강권(SRH) 실현을 위해, 포괄적, 비차별적, 증거기반, 과학적으로 정확하고, 연령에 맞는 섹슈얼리티 및 재생산에 대한 교육권과 같은 국가적 의무를 이행할 것을 요구한다.’

부록 I. 포괄적 섹슈얼리티 교육(CSE) 관련 국제협약, 도구, 표준 참조

- **서유럽**은 50년 전에 학교 기반 CSE 프로그램을 선도적으로 도입했다. 스웨덴, 노르웨이, 네덜란드와 같은 국가는 학교에서 CSE 프로그램을 오랫동안 실시해 오고 있으며, 학교에서의 섹슈얼리티 및 성 및 재생산건강과 권리(SRHR) 문제에 대해 공개적인 토론이 더 민감한 지역인 동유럽 및 중앙아시아(ECCA) 국가에 비해 청소년 출산율이 현저히 낮다. 예를 들어 에스토니아에서의 여러 연구 결과, CSE 개발과 청소년들의 사이의 성 건강 지표의 꾸준한 증가 간의 상관관계가 시간이 지남에 따라 더욱 강해지고 있음을 보여 준다. 최근 의도하지 임신, 임신중단, HIV 감염 비율의 감소를 포함하여 지표가 개선된 것은 청소년 친화적인 성 건강 서비스 전달의 발전과 함께 학교에서의 의무적인 CSE프로그램의 개발에 기인한다(UNESCO, 2011a).
- **라틴 아메리카와 카리브 지역(LAC)**의 보건부 장관과 교육부 장관은 2008년 에 체결된 교육부 장관의 선언문을 통해 CSE 실행을 약속했다. 정부는 부서 간 협조를 보장하고 포괄적인 CSE와 인간 면역결핍바이러스(HIV)/성매개감염병(STI) 예방을 포함한 성 건강 증진에 대한 다중 전략을 이행하고, 강화하기로 합의했다. 필수적인 보건과 교육영역 간의 협력에 초점을 둔 선언문은 CSE 정책 및 내용, 청소년 및 청소년과의 연결을 위한 보다 접근 가능성이 높은 성 및 재생산건강(SRH) 서비스에 대한 국가 차원의 작업에 전환점이 되었다.
- 마찬가지로 **동아프리카와 남아프리카** 의사결정자들은 사춘기 및 청소년을 대상으로 한 포괄적 섹슈얼리티 교육과 성 및 재생산건강 서비스에 관한 동남 아프리카 공약에서 입증한 바와 같이, CSE 접근성 보장을 위한 정치적 의지를 분명히 했다. 핵심 공약은 문화적 접근법을 채택하고, 모든 사춘기 및 청소년을 위한 양질의 포괄적이며 생활기술에 초점을 맞춘 CSE와 청소년 친화적인 HIV와 성 및 재생산건강(SRH) 서비스에 대한 접근성 보장을 최우선으로 할 것을 명백히 한다(UNESCO, 2013b).

- **아시아 태평양 지역**은 대다수 국가가 CSE에 대한 국가의 HIV 전략에 초점을 맞추고 있는 것과 함께 HIV 교육 실시를 위한 매우 유리한 정책 환경을 가지고 있다(UNESCO, 2012). 아시아 태평양 인구개발회의는 2013년 모든 사람들 특히, 가장 가난하고, 가장 소외된 사람들을 위한 성 및 재생산건강과 권리(SRHR)보장에 중점을 둔 공약을 발표했다.

아동 청소년의 사회 정서적 웰빙의 중요성에 대한 논점을 공유하라. 사회 정서적 학습은 학습의 필수적인 부분이며 학생들의 웰빙과 인지적 결과에 영향을 미친다. 또한 친절, 공유, 공감과 같은 사회적 행동을 증가를 가져오며, 학교에 대한 학생의 태도를 개선하고, 학생들 사이의 우울감과 스트레스를 감소시킨다.(Durlak et al., 2011; OECD, 2017). CSE 프로그램은 자기인식, 자기 관리, 사회인식, 관계 기술 및 책임 있는 의사결정 등 효과적인 사회 정서적 학습과 밀접한 관련이 있는 기술 개발에 도움을 준다.

CSE에 대한 질문 및 우려 사항에 대한 대응

표 3은 CSE 프로그램이 처음 제공되었을 때 자주 제기된 일반적인 오해와 우려에 대한 정보와 대응 방안을 제안한다. 이러한 질문과 대응에 대한 명확한 이해가 중요한 이유는 교육 및 보건 부문이 CSE를 제공하는 것의 필요성에 대해 교육 및 보건부 직원, 학교장 및 교사가 확신하지 못하거나 자신감과 기술 부족으로 CSE 프로그램을 제공하는 것을 꺼릴 수도 있기 때문이다. 또한 교사의 개인적 직업적 가치가 그들이 제기한 문제들과 충돌할 수도 있으며, 교육 전문가에게는 무엇을 가르칠 것인지, 어떻게 가르칠 것인지에 대한 명확한 지침이 필요할 수 있다.

표 3. CSE에 대한 일반적 우려

우려	대응
▶ CSE는 성행동 시작 시기를 앞당긴다.	▶ 세계 각국의 연구는 섹슈얼리티 교육이 성행동 시작 시기를 앞당기는 일은 거의 없다고 분명하게 말한다. 연구들은 CSE가 성관계 시작 시기와는 직결되는 영향이 없으며, 오히려 시작 시기를 늦추거나 성적 행동에 더 책임있는 태도를 갖게 한다고 말한다. 더 많은 정보를 위해서는, 4장 참고.
▶ CSE는 아동의 순수성을 빼앗는다	▶ 성과 연구에서는, 어린이 청소년에게 공식교육을 시작하는 시기부터 신중하게 계획된 과정으로, 과학적으로 정확하고, 함부로 판단하지 않으며, 연령 및 발달에 적합한 정보를 제공하는 것이 좋다고 설명한다. CSE가 없는 경우, 아동 청소년은 또래집단, 미디어 등 여러 메세지들 사이에서 갈등하고 취약한 위치에 놓일 수 있다. 양질의 섹슈얼리티 교육은 긍정적 가치와 관계를 강조하며 완성도 있고, 정확한 정보를 제공한다. 섹슈얼리티 교육은 섹스 이상에 대한 교육으로 신체, 사춘기, 관계, 라이프 스킬 등에 대한 정보를 포함한다.
▶ CSE는 우리의 문화 또는 지역과 상반된다.	▶ 이 지침서는 지역의 문화적 맥락에 맞게 콘텐츠를 적용 할 수 있도록 지역의 문화보존자들의 참여와 지원을 구축할 필요가 있음을 강조한다. 종교지도자를 포함한 주요 이해관계자들은 사람들의 종교적 신념에 따른 행동을 알려줌으로써, CSE 프로그램이 해당 지역의 종교 및 문화의 핵심 가치와 맞물릴 수 있도록 프로그램 개발자 및 제공자를 도울 수 있다. 또한 지침서는 비인권적이며 특히, 여자어린이와 여성 또는 소외계층에 대한 취약성과 위험의 증가를 가져오는 부정적 사회 규범 및 유해한 관행을 돌아보고 다루어야 할 필요성을 강조한다.
▶ 청소년 섹슈얼리티 교육은 부모와 가족의 역할이다.	▶ 부모와 가족은 건강한 섹슈얼리티와 관계를 형성하도록 지원하고, 보살피는 주요한 정보의 원천으로서 근본적인 역할을 한다. 그러나 교육부, 학교 및 교사를 통해 정부는 양질의 CSE 프로그램에 필요한 도구와 자료 제공 뿐 아니라 안전하고, 협조적인 학습 환경에서 모든 아동 청소년에 대한 전인교육을 제공함으로써 부모 및 가족이 수행하는 역할을 지원하고, 보완해야 한다.
▶ 부모는 학교에서의 섹슈얼리티 교육에 반대할 것이다.	▶ 부모는 자녀가 성 정체성과 주요한 성적 사회적 관계를 형성하는데 중요한 역할을 한다. 학교 내 CSE프로그램에 대한 학부모의 반대 의견은 섹슈얼리티와 성 및 재생산건강(SRH)에 관한 메시지가 가족의 가치체계에 뿌리를 두고 있는지 확인하고 싶어 하는 학부모의 경우 CSE의 영향에 대한 두려움과 정보의 부족에 기초해 있는 경우가 많다. CSE 프로그램은 부모의 역할을 대신하기 위한 것이 아니라 부모의 협력과 참여로 이루어지며, 부모를 지원하기 위한 것이다. ▶ 학부모는 학교 내 양질의 섹슈얼리티 교육 프로그램을 위한 가장 강력한 조력자 중 하나이다. 많은 학부모들이 자녀의 '섹스 이슈'에 대한 접근과 토론에 도움이 되는 외적 지원과 어려운 상황(예: 아동이 인터넷에서 포르노를 보거나 소셜미디어에서 괴롭힘을 당할 때)에 대처하는 방법과 정확한 정보를 제공하는 방법을 중요하게 생각한다.
▶ CSE는 청소년에게는 유용할 수 있으나 어린이들에게는 부적합하다.	▶ 어린이들 또한 연령에 맞는 정보가 필요하다. 이 지침서는 5장에서 연령별로 학습목표를 제시한 것처럼 연령과 발달의 적합성 원리에 기초한다. 또한 지역적 맥락을 고려한 유연성을 갖도록 하며 성적 관계만이 아닌 다양한 관계를 포괄하고 있다. 어린이들은 자신의 섹슈얼리티에 따라 행동하기 오래 전부터 이러한 관계를 알아차리기 때문에 어릴 때부터 자신의 신체, 관계, 감정을 이해하는 기술과 지식이 필요하다. ▶ 이 지침서는 어린이들이 신체 부분에 대한 정확한 명칭, 인간 생식의 원리와 사실 이해, 가족 및 대인 관계 탐구, 안전 학습, 성적 학대 예방 및 신고에 대해 배울 수 있는 안전한 환경을 제공함으로써 건강한 어린 시절을 보낼 수 있는 토대를 마련한다. CSE는 아이들이 자신의 감정, 자기관리(예: 위생, 감정, 행동에 대한), 사회적 인식(예: 공감), 관계 기술(예: 긍정적 관계, 갈등해결), 책임 있는 결정(건설적이고 윤리적인 선택)에 대해 배움으로써 자신감을 개발할 기회를 제공한다. 이러한 주제는 어린이의 연령과 발달에 따라 단계별로 소개된다.

우려	대응
▶ 교사가 CSE를 불편해하거나 수업기술이 부족할 수 있다.	▶ 훈련, 지원, 동기 부여가 잘 된 교사는 양질의 CSE 전달에 핵심적 역할을 한다. 교사는 학습자로부터 성장, 관계, 또는 섹스에 대한 질문을 받는 경우가 많으며, 이러한 질문에 답할 수 있는 적절하고, 안전한 방법을 알고 있는 것이 중요하다. ▶ 명확한 부문별 학교 정책과 커리큘럼은 교사를 지원하는데 도움이 되며, 학교로부터의 제도화된 예비 현직 교사 훈련과 지원도 마찬가지이다. CSE를 학교 교육과정으로 구성하는데 중점을 두는 것은 물론이고, 보다 강력한 전문성 개발과 지원을 통해 교사가 수업기술과 자신감을 가질 수 있도록 지지해야 한다.
▶ 교사에게 CSE 수업은 너무 어렵다	▶ 섹스, 젠더, 섹슈얼리티에 대한 부정적이고, 모순적인 메시지를 갖는 사회 문화적 맥락에서 볼 때 학교에서의 섹슈얼리티 수업은 도전이 될 수 있다. 동시에 대부분의 교사와 교육자는 라포를 형성하는 능력, 적극적으로 경청하는 능력, 학생들의 요구와 우려를 파악하는 능력, 정보를 제공하는 능력을 가지고 있다. 교사는 참여적 방법론을 통한 CSE 교육 내용에 대한 훈련을 받을 수 있는 것이지만, 섹슈얼리티의 전문가가 되어야 하는 것은 아니다. 이 훈련은 교사훈련기관 커리큘럼의 일부로서(CSE 수업 전) 또는 수업 중 교사훈련으로 제공될 수 있다.
▶ CSE는 이미 다른 과목(생물, 생활기술, 또는 시민교육)에서 다루어지고 있다.	▶ 가이드는 역동적이고 급변하는 CSE 영역에 기초하여 커리큘럼, 교수법, 자료에 대해 평가하고 강화할 수 있는 기회를 제공하며, 다양한 학교 교과목으로 학습이 분산되어 있다 하더라도 포괄적인 주제와 학습목표를 완전히 포괄할 수 있도록 돕는다. 또한 효과적인 CSE는 다른 과목에 포함되어 있지 않을 수도 있는 태도, 기술 기반 학습 성과가 많이 포함되어 있다.
▶ 섹슈얼리티 교육은 긍정적 가치와 관계를 증진해야 한다.	▶ 가이드는 존중, 수용, 평등, 공감, 책임, 상호주의와 같은 가치를 보편적 인권과 불가분의 관계로 강조하는 권리 기반 접근법을 지지한다. 섹슈얼리티 교육에 대한 포괄적인 접근법 안에서 가치와 책임에 중점을 두는 것이 중요하다. CSE는 학습자로 하여금 다양한 주제에 대한 자신의 가치와 태도를 평가하고 명확히 할 수 있는 기회를 제공한다.
▶ 청소년들은 인터넷과 소셜미디어를 통해 이미 섹스, 섹슈얼리티에 대한 모든 것을 알고 있다.	▶ 인터넷과 소셜미디어는 청소년들이 섹슈얼리티에 대한 질문에 대한 정보와 답을 얻을 수 있는 훌륭한 방법일 수 있다. 청소년들은 다른 곳의 정보에 빠르고, 편하게 접근할 수 있기 때문에 온라인 매체(소셜미디어 포함)를 사용하고 있다. 그러나 온라인매체는 연령 적합성, 증거에 기반한 사실을 제공할 필요가 없기 때문에 편향되고, 왜곡된 메시지를 제공할 수 있다. 청소년들은 무엇이 정확하고 부정확한지 구별하는 것이 어렵다. 온라인 매체는 많은 정보를 제공할 수는 있지만 청소년들이 이슈에 대해 토론, 생각, 논쟁할 공간을 제공하지 않으며, 관련한 기술을 개발할 기회를 주지 않는다. CSE는 청소년들이 소셜미디어와 포르노로 본 이미지, 관행, 규범, 성적인 각본을 파악할 수 있는 논의를 제공한다. 또한 정서적 친밀감, 동의 협상, 현대 피임법 등 포르노가 아닌 섹슈얼리티의 측면에 대해 학습할 기회를 제공한다. CSE는 청소년들이 인터넷과 소셜미디어를 안전하게 탐색하고, 정확한 사실에 근거한 정보를 식별할 수 있도록 돕는다.
▶ 종교지도자들은 섹슈얼리티 교육을 지지하지 않을 수 있다.	▶ 종교지도자들은 학교 CSE 지원에 있어 특별한 역할을 한다. 종교단체는 성 건강 및 섹슈얼리티 교육 토론을 위해 종교지도자에게 접근하는 방법에 대한 지침을 프로그램 개발자와 제공자에게 제공할 수 있다. 모델, 멘토, 옹호자로서 종교지도자는 청소년 복지를 소중히 여기는 신앙공동체를 위한 특사이다. 청소년들은 자신의 삶과 관련된 도덕적 지침을 추구하며 모든 청소년들은 정서적, 육체적으로 건강한 관계를 맺고 섹슈얼리티에 대한 신뢰할 수 있는 정보와 배려를 받을 자격이 있다. 사실 부정확하고, 정보를 주지 않는 섹슈얼리티 교육은 청소년 삶의 현실을 무시하고, 불필요한 질병이나 의도하지 않은 임신의 위험에 놓이게 하며 특히, 무엇보다 청소년의 삶과 인간의 존엄성을 위협한다. 많은 신앙공동체는 경험과 많은 연구 결과를 통해 청소년들이 관계에서 책임 있는 의사 결정과 상호 존중에 초점을 둔 섹슈얼리티 교육을 받을 때 성숙한 성적 행동을 지니는 경향이 있음을 보여준다(UNESCO, 2009).
▶ CSE는 청소년들을 대안적인 라이프스타일로 이끄는 수단이다	▶ 이 가이드의 주요 원칙은 성적 행동, 성적 지향, 성 정체성, 건강 상태에 대한 판단 없이 모든 사람이 최상의 건강 및 복지 수준에 도달하기 위한 정확한 정보 및 서비스를 받을 권리가 있다는 것이다. 또한 이 가이드는 젠더에 초점을 맞추고 있으며 성적 행동, 성적 지향, 성 정체성을 비롯하여 젠더 또는 사회적 규범에 순응하지 않는 사람에 대해 모든 사회가 다르게 표현한다는 것을 인식하는 권리 기반 접근법을 사용한다. 모두를 위한 건강과 복지 증진 이외에 특정 라이프스타일을 지지하거나 선전하지 않는다.

CSE 리더십과 책무가 있는 핵심 이해관계자의 역할

국가 차원에서 교육 및 보건부는 젠더 부서와 마찬가지로 CSE 강화를 위한 지원 및 지원 환경을 제공하고, 정책 및 도덕적 리더십을 발휘하는 중요한 역할을 한다. 또한 섹슈얼리티 교육의 개발과 제공에 참여해야 하는 정부와 시민사회의 다양한 영역들과 공감대를 형성하는 핵심적인 역할을 한다.

리더십과 책무가 있는 주요한 이해관계자는 학부모와 학부모-교사 연합, 교사, 교장, 장학사 및 연수기관 등 교육전문기관, 종교지도자 및 종교단체, 교사노조, 연구원, 지역사회와 전통적 지도자, LGBTI 그룹, 비영리조직, 특히 청소년과 함께 성 및 재생산건강 및 권리를 위해 일하는 사람들, HIV 감염자, 미디어(지역 및 국가), 관련 기부자 또는 외부 기부자이다.

챔피언의 역할

‘챔피언’의 참여는 섹슈얼리티 교육에 대한 인식을 제고하고 긍정적 접근할 수 있도록 도울 수 있다. 챔피언은 CSE의 중요성을 정치인, 유명인, 청소년, 종교지도자 및 교육 분야 안팎의 영향력 있는 사상가들이다. 이들은 지역적 맥락을 이해하고, 지역사회로부터 가치를 인정받는다. 이들은 국가 및 지역, 의회, 학교, 지역사회 등에서 자신의 네트워크 및 언론과 소셜미디어를 활용하여 CSE가 청소년의 건강 및 정서적 웰빙에 미치는 긍정적 영향에 대한 인식을 재고하도록 할 수 있다.

박스 3. CSE 옹호와 실행에 참여하는 청소년

유엔아동권리협약은 참여할 권리를 인정한다 : ‘(자신에게) 영향을 미치는 모든 문제에 있어... 자유롭게 표현할... (자신의) 연령과 성숙도에 따라 정당한 비중이 부여되어야..’(12조) 또한 세계인구개발회의(ICPD) 1994 결의문(POA)은, 2012년 인구 및 발달 위원회 결과 문서와 청소년 국제 결의문(2007년에 유엔에 의해 채택)과 마찬가지로, 특별히 청소년들이 재생산건강프로그램에 참여할 권리를 인정했다. 청소년들은 CSE 프로그램을 지지, 개발, 실행, 평가하는 다양한 역할을 수행할 수 있다(Kirby, 2009). 프로그램 개입에 관한 운영연구결과에 따르면, 프로그래밍 작업 청소년들의 아이디어, 연계성, 독특한 지식을 활용하면 개입의 도달 범위, 매력, 관련성, 효율성이 증가하는 것으로 나타났다(Jennings, et al., 2006; SRHR Alliance, 2016; Villa-Torres and Svanemyr, 2015; IPPE, 2016).

6.2 CSE 프로그램 계획과 실행 지원

학교 기반 CSE, 학교 밖 CSE의 계획과 실행에는 여러 수준의 다양한 이해관계자가 참여해야 한다. 커리큘럼 개정, 새로운 커리큘럼 실행 체계 및 계획 수립 등 국가 및 지역 당국, 학교, 지역사회가 각각 다른 단계와 범주에서 국가정책 개발에 참여해야 한다. 다음은 다양한 수준에서의 다양한 참여자가 학교 안팎에서의 CSE 계획과 실행을 어떻게 지원할 수 있는 지에 대해 살펴본 것이다.

국가 및 지역수준

일부 국가는 지방 교육부처가 국가 자문위원회 및 테스크포스 위원회를 설립하여 국가교육과정 개선, CSE프로그램 개발 및 시행을 지원하였다.

의회와 위원회 위원들은 국가교육과정 및 정책을 위한 초안 자료 및 개선 사항 검토, 모니터링 및 평가를 포함하여 학급에서 CSE 프로그램을 수행하기 위한 포괄적인 업무 계획 수립과 같이 사안을 민감하게 들여다보고, 지지하는 활동에 참여할 수 있다. 정책적 수준에서 CSE 정책이 잘 되어 있는 국가에서는 교육 부문 계획 뿐 아니라 HIV 및 성 및 재생산건강(SRH)에 대한 국가의 전략적 계획 및 정책의 틀과도 CSE 프로그램의 명시적 연계가 가능하다.

학교 수준

학교 당국 및 경영진의 역할 : 전반적으로 긍정적인 학교 환경은 프로그램의 완전한 실행을 촉진함으로써 효과성을 높이는 것으로 나타났다.(Picot et al., 2012 in UNESCO, 2016c). 학교 당국과 경영진의 역할은 다음과 같다.

▶ **리더십과 경영 :** 학교 경영진은 CSE에 대한 동기부여 및 지원 뿐 아니라, CSE 실행을 위한 적절한 분위기를 조성하고, 청소년의 요구에 부응하며 앞장설 수 있다. 교실에서는 교사가 아동 청소년들이 발견, 학습, 성장하면서 섹슈얼리티에 대한 더 나은 이해를 하도록 안내하는 역할을 한다. 확신이 없거나 갈등이 있는 상황에서는 학교 경영진과 교사 간의 리더십 능력에 따라 프로그램의 성공과 실패를 좌우할 수 있다.

▶ **CSE 제공을 위한 정책의 수립 또는 강화**: 민감하고, 때로는 논쟁의 여지가 있는 CSE 특성상 CSE 실행은 개별적 선택이라기보다는 제도적인 정책의 문제로 인식하고, CSE 프로그램 시행과 관련 CSE를 지지하는 포괄적인 법률 및 정책을 수립하는 것이 중요하다. 관련 국가 및 학교 전체 정책 또는 지침이라는 명확한 체계 안에서의 CSE를 실행하는 것은 CSE 프로그램 실행과 관련된 민감한 사항에 대한 예상 및 처리, 비밀유지 및 적절한 행동 기준 설정, CSE 제공 교사 보호 및 지원, 학교 및 지역사회에서의 CSE 입지 보호 및 증대와 같은 CSE 프로그램 실행을 위한 제도적 기반 제공을 포함하여 다양한 이점이 있다.

앞서 언급한 문제 중 일부 기존 학교 정책에 명시되어 있는 것을 제외하고 지침이 없는 경우, CSE는 다음과 같은 정책을 분명히 강조할 것이다.

- 훈련된 교사에 의한 커리큘럼 제공
- 부모의 참여
- 생물학적 성, 젠더, 성적 지향, 성 정체성과 관계없이 성 평등 및 차별 금지 촉진과 모든 학습자의 권리 존중
- CSE 실행 지원을 위한 재정 및 인적 자원 배분
- 부모의 염려에 부응하는 절차 수립
- 임신한 학습자가 계속 교육을 받을 수 있도록 지원
- CSE를 제공하기 위한 안전한 학교 환경 만들기. 예를 들어, 성희롱과 성적 지향, 성 정체성을 근거로 한 낙인과 차별을 포함한 괴롭힘에 대한 무관용 정책 취하기
- 학교를 건강 증진을 위한 환경으로 만들기. 예를 들어, 흐르는 물이 있는 깨끗하고, 개인적이며 분리되어 있는 남녀 어린이 화장실 제공
- 기밀 유지 위반, 낙인과 차별, 성희롱 또는 괴롭힘과 같은 정책 위반에 대한 조치
- 지역 법률에 따라 지역 성 및 재생산건강(SRH) 서비스 및 기타 서비스 접근 및 연계 촉진
- 교사-학습자의 성적 관계 금지 및 행동 규범을 위반한 교사에 대한 일관된 행동을 취하는 직업윤리강령 준수 (및 엄격한 시행)

교사의 역할: 교사는 CSE 구현의 핵심이다. 교사에게는 더욱 복잡한 섹슈얼리티와 성 및 재생산건강(SRH) 문제를 가르칠 수 있는 자신감, 책무, 자원이 필요하다. CSE 커리큘럼을 효과적으로 실행하기 위해서는 법, 학교, 지방 당국의 지원을 받고 있음을 감지할 수 있어야 하며 관련된 훈련 및 자원에 대한 접근성이 있어야 한다.

CSE는 어떤 특정 교사의 노력 또는 책임이 아니며 교육자들이 서로 지원하고 CSE 프로그램 실행 경험을 공유하는 공동의 노력이어야 한다. 또한, CSE 제공 책임이 있는 교사는 섹슈얼리티를 정확하고, 명확하게 다루는 것 뿐 아니라 능동적 참여적 학습 방법에 대한 기술 훈련이 필요하다.

교사 외 학교 내 의료 제공자 및 기타 행정 직원의 역할: CSE 관련 서비스의 결합은 청소년들의 성 및 재생산건강(SRH) 지원에 효과적인 것으로 나타났다(UNESCO, 2015a, Hadley et al., 2016). 예를 들어, 학교 간호사는 추가 정보와 상담을 제공하고, 교실활동을 지원하며 외부 성 및 재생산건강(SRH) 또는 기타 서비스와 연계할 수 있다. 행정 직원 예를 들어, 건물 관리인과 청소년부는 CSE 정책 및 원칙, HIV, LGBTI 청소년 관련 지침을 알고 있어야 한다.

학교에서의 학생의 역할: 학생들은 CSE를 위한 지원을 구축하는데 적극적으로 참여할 필요가 있다. 학생회 및 기타 학생 그룹 및 개별 청소년 리더들은 CSE 프로그램의 설계, 모니터링, 평가에 적극적으로 의견을 개진하도록 권장해야 하며 학생들의 요구를 수렴하여 CSE가 필요성을 계발하고, 자신의 삶에서 CSE의 중요성에 대해 부모 및 다른 지역사회 구성원과 대화를 시작한다.

지역사회 수준

종교단체 및 비영리단체를 포함한 다양한 지역사회 이해관계집단:

- ▶ 지역사회 리더는 공식 비공식 환경에서 CSE 프로그램을 수용하고, 지원할 수 있는 길을 열어줄 수 있다. 지역사회 이해관계자들과 협력하여 부정확한 정보에 대응하고, CSE를 둘러싼 지역의 통념 및 오해를 없애는 것이 중요하다. 또한 지역사회 리더는 프로그램 내용을 맥락화하는 노력을 지원할 수도 있다.
- ▶ 종교단체는 공동체의 삶에서 중요한 역할을 한다. 종교지도자들이 지역사회에서 갖는 영향력과 권위는 종교지도자들이 신학적 기반에서 인간의 존엄성과 온전함에 말하는 것을 가능하게 한다(Religious Institute, 2002). 종교단체와 마찬가지로 서로 다른 종교를 가진 청소년들과의 지속적인 대화도 중요하다. CSE 내용에 대한 복잡한 문제를 해결할 수 있는 것은 오직 토론을 통해서이다. 대부분 종교는 강요와 학대로부터 자유롭고, 건강하며 사랑하는 관계를 형성하는 것을 장려한다. 모든 종교는 청소년들이 건강하고 행복하게 되기를 바란다. 대화는 지역청소년들이 종교의 가르침, 과학적 증거, 현실적인 삶 사이의 균형을 찾을 수 있도록 도움을 줄 수 있다.

- ▶ 지역 NGO 단체들은 학교와 교사에게 더 많은 정보를 제공하고, CSE 커리큘럼 보완 및 강화를 위한 주제 토론을 위해 외부 인사를 초청하는 등 지역사회의 소중한 자원이다. 일부 NGO 단체들은 지역사회 기반의 CSE 프로그램을 시행하기도 한다.

학부모 : 청소년들의 인식과 행동은 가족 및 지역사회의 가치, 사회적 규범과 조건의 영향이 크다. 따라서 부모, 가족, 지역사회 활동가와의 협력과 지원방안을 초기부터 찾고 정기적으로 강화해야 한다.

아동 청소년 안전과 복지 증진에 대한 교사와 학부모 보호자의 공통 관심사를 강조하는 것이 중요하다. 학부모 보호자의 CSE 지원과 참여 보장은 장기적인 성과를 위해 필수적이다. 연구에 따르면 섹슈얼리티에 대한 부모-자녀의 대화를 증진하는 가장 효과적인 방법 중 하나는 아동 청소년들이 학부모 또는 다른 신뢰할 수 있는 성인과 선택한 주제에 대한 토론 과제를 제시하는 것으로 나타났다(UNESCO, 2009). 만약 교사와 학부모가 지침에 따른 체계적인 교수학습 수행 과정에서 서로를 지원하면 아동 청소년의 개별적 성장 가능성이 훨씬 더 높아질 것이다.

미디어 및 기타 게이트키퍼(gatekeepers) : TV, 신문, 잡지, 인터넷 등 대중매체는 CSE에 대한 사람들의 생각과 오해에 중요한 영향을 미친다. 이들 매체는 메시지의 결과에는 관심이 없으며, 건강한 섹슈얼리티 증진보다는 잠재 고객을 유치하는데 더 중점을 둔다. 미디어는 정확한 메시지 전달을 위해 증거에 기반한 정보를 제공하는 것이 중요하다.

의료서비스 제공자 : 의료서비스 제공자는 성 및 재생산건강(SRH) 관련 청소년들의 일반적 요구에 대한 정보 제공, 교육 결과에 대한 정보공유, CSE와 건강 서비스 연계 강화를 위한 노력에 적극 참여함으로써 CSE를 지원할 수 있는 좋은 위치에 있다.

7

효과적인

CSE 프로그램 제공

7 - 효과적인 CSE 프로그램 제공

이 장에서는 지식의 증가, 가치와 태도의 명확화, 기술 향상, 행동에 영향을 미치는 효과적인 프로그램으로 밝혀진 CSE의 공통적인 특성을 설명한다. 또, 기획, 실행 모니터링, 평가 및 확대를 포함한 CSE 개발 및 제공의 모든 단계에서의 권장 사항도 포함한다.

7.1 도입

아래와 같은 효과적인 커리큘럼 개발과 실행, 모니터링에 대한 특성은 CSE 관련 다양한 연구 및 검토 결과를 기반으로 한다(UNESCO, 2009; WHO Europe and BZgA, 2010; UNEPA, 2014; UNESCO, 2016c; Pound et al., 2017). CSE를 개발하여 제공할 때에는 기존의 표준 및 지침을 기반으로 구축하고, 실행과 평가를 위한 명확한 단계를 설계하는 것이 중요하다.

CSE 제공이 콘텐츠만큼 중요하다는 연구 결과가 점점 많아지고 있다. 효과적인 섹슈얼리티 교육은 청소년들이 편안한 마음으로 참여할 수 있고, 프라이버시를 존중받고, 괴롭힘으로부터 보호받으며, 학교의 관행 속에서 콘텐츠의 원리를 볼 수 있는 안전한 환경에서 이루어져야 한다(Pound et al., 2017).

이러한 권장 사항은 세계 각지의 CSE 주제별 전문가와 실무자가 개발한 매뉴얼, 지침서, 툴킷, 행동 체계에 의해 보완될 수 있다.

7.2 효과적 학습을 위한 커리큘럼의 특성

준비단계에서 :

1. 섹슈얼리티, 행동 변화 및 관련한 교육이론 전문가의 참여 : 수학, 과학, 기타 분야와 마찬가지로 섹슈얼리티는 광범위한 연구 및 지식을 기반으로 확립된 영역이다. 이러한 연구와 지식에 익숙한 전문가가 커리큘럼 개발, 선정, 적용 과정에 참여해야 한다. 또한 CSE 커리큘럼 개발자는 연령대별 청소년 위험 행동 뿐 아니라, 젠더, 인권, 건강과 같은 이슈에 대해 잘 알고 있어야 한다. 즉, 환경 및 인지적 요인이 청소년 행동에 어떤 영향을 미치는지, 참여 수업으로 학습의 세 요소들을 가장 잘 다루는 방법은 무엇인지에 대해 알고 있어야 한다. CSE 커리큘럼 개발자는 유사한 지역에서 청소년을 대상으로 하여 긍정적인 결과를 가져온 다른 CSE 프로그램에 대한 지식도 필요하다. 개발자가 이와 같은 경험이 부족할 경우, 아동 청소년 발달과 섹슈얼리티 전문가는 적절한 콘텐츠와 맥락 보장을 위한 노력을 해야 한다.

2. 청소년, 부모 가족 구성원, 기타 지역사회 이해관계자 참여 : 체계적인 청소년의 참여는 섹슈얼리티 교육의 질을 향상시킨다. 학습자는 섹슈얼리티 교육을 수동적으로 받는 것이 아니라 섹슈얼리티 교육의 내용을 조직, 조정, 실행, 개선하는데 적극적인 역할을 해야 한다. 이는 섹슈얼리티 교육이 단순히 교육자가 미리 결정한 의제를 따르는 것이 아니라 자신의 섹슈얼리티를 탐색하고자 하는 청소년들의 요구와 현대적 삶에 기반을 두도록 한다(WHO Europe and BZgA, 2010). 청소년들의 참여는 또래 교육자를 포함한 다양한 유형의 교육자가 커리큘럼을 활용하는 방법과 형식, 비형식 교육을 포함한 다양한 맥락에 따라 활동을 어떻게 조정할 것인지를 결정하는데 도움이 될 수 있다. 부모와 지역사회 리더들 또한 중요한 역할을 한다. 부모와 지역사회의 참여도가 높을수록 예를 들어 숙제, 부모와 자녀들을 위한 방과후 프로그램, 부모로 하여금 프로그램을 배우도록 격려하는 것은 자녀의 성 건강의 향상에 가장 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다(Wight and Fullerton, 2013 in UNESCO, 2016c).

3. 프로그램 대상인 아동 청소년의 발달단계에 따른 사회적, 성 및 재생산건강(SRH) 요구와 행동 평가 : 커리큘럼 계획 과정에서는 원치 않고, 의도하지 않은 보호받지 못하는 성 행위로 이어지도록 하는 기존의 장벽을 포함하여, 청소년의 성적 요구와 행동에 대한 증거 기반의 정보를 고려해야 한다. 또한 CSE 커리큘럼 개발 과정에서는 아동 청소년의 발달단계 뿐 아니라 각자의 독특한 상황, 환경, 문화적 가치 등에 따른 서로 다른 요구를 고려해야 한다. 또한 아동 청소년이 갖고 있는 지식과 긍정적인 태도 및 기술을 바탕으로 교육과정이 설계되어야 함을 인식하는 것도 중요하다. 청소년들의 요구와 자산(기존의 지식, 태도, 기술)은 포커스 그룹 및 청소년 전문가와의 인터뷰를 통해 파악하고, 대상 집단 또는 유사 집단 관련 연구 통계에 대한 검토로 보완할 수 있다.

4. **커리큘럼 개발 및 실행을 위해 사용 가능한 자원(인적, 시간, 재정적) 평가** : 이는 모든 프로그램에서 중요한 단계이다. 직원의 시간, 직원의 기술, 시설 공간, 공급을 포함하여 사용 가능한 자원의 불일치로 인해 커리큘럼을 충분히 구현하지 못하거나 조기에 종료하는 사례가 많이 있다.

커리큘럼 내용 개발 단계에서 :

5. **분명한 목표, 결과, 주요한 학습에 초점을 두고 내용, 접근방법, 활동을 결정** : 효과적인 커리큘럼에는 목표와 직접적 관련이 있는 명확한 건강 관련 목표와 행동 결과가 있다. 행동 결과 이외에도 커리큘럼은 안전하고, 건강하며 긍정적인 관계 뿐 아니라 인권, 성평등, 다양성에 대한 존중을 포함한 긍정적 가치를 형성하는 태도와 기술을 개발하는데 초점을 두어야 한다. 아동 청소년의 서로 다른 연령, 성별, 특징(예 : HIV, GBV 또는 원치 않는 임신)에 영향을 미치는 핵심 이슈에 중점을 두어야 한다. 자세한 내용은 5장, 개념, 주제, 학습목표 참조.
6. **논리적인 순서로 주제 다루기** : 대부분의 효과적 커리큘럼은 안전, 건강, 긍정적인 라이프스타일 개발에 필요한 특정 지식, 태도, 기술을 다루기 전에 섹슈얼리티에 대한 가치, 태도, 규범을 탐구하고, HIV, 성병(STIs), 의도하지 않은 임신 예방 및 학습자 자신과 타인의 권리를 보호하도록 학습자의 동기를 부여하고 강화하는데 초점을 둔다.
7. **맥락 중심, 비판적 사고를 증진하는 활동 기획** : 학습자는 다양한 사회 경제적 배경을 가지고 있으며, 나이, 성별, 성적 지향, 성 정체성, 가족과 지역사회, 가치, 종교 및 기타 특성이 다를 수 있다. 따라서 학습자의 환경에 적절한지 주의를 기울이고 개인 및 지역사회의 가치에 대한 이해와 비판적 사고, 섹슈얼리티 및 관계에 대한 가족, 지역사회, 또래집단의 인식 촉진에 도움이 되는 커리큘럼을 구현하는 것이 중요하다.
8. **동의와 라이프 스킬 다루기** : 동의에 대한 교육은 건강하고 존중하는 관계 구축과 성적인 건강을 장려하고, 잠재적으로 취약한 사람들을 피해를 입지 않도록 보호하는데 필수적이다. 청소년들에게 다른 사람들의 개인적인 경계를 인정하고, 존중하도록 가르치는 것은 누구나 부끄럽게 여기지 않고, 기꺼이 성적인 행동에 참여 또는 거절하거나 동의를 철회할 수 있는 사회를 만드는 데 도움이 될 수 있다(IPPF, 2015b). 동의에 대한 양질의 교육은 청소년들이 위험을 판단하고, 원치 않는 성 행위로 이어질 수 있는 상황으로부터 자신을 보호하도록 지원하고, 다른 사람들과의 긍정적 관계를 추구할 수 있는 지식과 자신감을 개발하도록 돕는다.

아동·청소년에게 위험 판단, 협상 능력과 같은 라이프 스킬은 필수적이다. 위험 판단 기술은 학습자가 부정적 또는 원치 않는 성 및 재생산건강(SRH) 결과에 대해 얼마나 민감한지를 파악하고, HIV의 영향, 기타 성매개감염병(STIs)와 원치 않는 임신의 문제를 이해할 수 있도록 돕는다. 증언, 시뮬레이션, 역할 연기는 모두 통계와 기타 사실적인 정보의 보완책으로 사용되어 학습자로 하여금 위험, 민감성, 심각성의 개념을 탐색할 수 있도록 돕는다. 협상 기술은 아동·청소년들이 성행위 참여에 대한 또래집단의 압력, 성행위 결정과 함께 증가하는 콘돔과 현대적 피임법 사용 등과 같은 성적 활동 시작 연령을 늦추는 보호 행동을 실천하도록 하는데 필수적이다. 협상 기술은 아동·청소년들에게 섹슈얼리티에 대한 대화와 합의에 도달하고 다른 사람들과의 차이를 해결할 수 있는 도구를 제공한다. 여러 일반적 상황에 대한 역할활동은 점차 복잡해지는 시나리오를 통해 파악된 기술적인 요소를 활용하여 가르치는데 일반적으로 사용된다. 콘돔 사용 방법을 보여주고, 콘돔을 구할 수 있는 장소에 가보는 것 또한 협상 기술 수업 방법으로 사용된다.

9. **HIV 및 기타 성매개감염병(STIs), 임신 예방, 조기 및 의도하지 않은 임신, 다양한 보호방법의 효과 및 이용가능성에 대한 과학적으로 정확한 정보 제공** : 커리큘럼 안에서 제공되는 정보는 증거에 기반한 과학적으로 정확하고 균형 잡힌 정보여야 하며, 콘돔과 다른 피임법(전통 및 현대)의 위험 또는 효과에 대해 과장도 과소평가도 하지 않는다. 대부분의 커리큘럼이 현대적 피임법, 특히 응급 피임 및 여성 콘돔 또는 노출 전 예방요법(PrEP)와 노출 후 예방요법(PEP)에 대한 적절한 정보를 제공하지 않는다. 금욕만을 강조하는 것은 효과적인 접근법이 아니라는 확실한 증거에도 불구하고 여러 나라에서 여전히 제공되고 있다. 또한 금욕에 대한 프로그램은 성교, 동성애, 자위, 낙태, 성역할 및 기대, 콘돔 및 HIV와 같은 주제에 대해 불충분하거나 부정확한 정보를 포함할 가능성이 크다(UNFPA, 2014).

10. 생물학적 경험, 젠더 및 문화적 규범이 아동청소년들이 자신의 섹슈얼리티와 성 및 재생산건강(SRH)을 경험하고, 탐색하는 방법에 미치는 일반적인 영향 다루기 : 생물학적 경험, 젠더와 기타 문화규범은 일반적으로 섹슈얼리티와 성 및 재생산건강(SRH) 관련한 아동 청소년들의 삶에 영향을 미친다. 예를 들어 월경은 많은 여자청소년에게 중요한 생물학적 경험이다. 그러나 일부 가난한 지역 여자청소년의 경우, 월경과 관련하여 성 차별을 강화하는 고유한 문제에 직면해 있다(Secor-Turner 외, 2016). 성 차별은 일반적이며 관계 속에서 여자 청소년들이 갖는 권력이나 통제력이 낮아 남자청소년, 성인남자, 특히 나이든 남자들에 의한 강요, 학대, 착취에 더욱 취약해지도록 만든다. 성인남성과 남자청소년은 남성에 대한 성적 고정관념(예 : 신체적 힘, 공격적 행동, 성적 경험)을 충족하고 유해한 행동에 참여하도록 또래들로부터의 압력을 느낄 수도 있다.

평등한 관계의 효과적 증진과 위험한 성 행위의 감소를 위해 커리큘럼은 이와 같은 생물학적 경험, 성불평등, 고정관념을 다루고, 비판적으로 검토할 필요가 있다. 프로그램은 여자청소년과 남자청소년들이 직면한 구체적 상황에 대해 논의하고, 원치 않거나 의도하지 않는 성행위를 피하는 효과적인 기술과 방법 제공해야 한다. 이와 같은 활동은 성불평등, 사회적 규범, 고정관념을 변화시키는데 중점을 두고, 유해한 성별 고정관념을 조장하지 않아야 한다.

11. 특정 성 행위에 영향을 미치는 특정 위험 및 보호 요소 다루기 : 효과적인 프로그램의 가장 중요한 특징 중 하나는 위험 및 보호 행동에 대한 분명한 메시지를 제공하는 것이다. 가장 효과적인 CSE 프로그램은 다양한 형태의 보호 행동에 대해 명확하고 일관된 메시지를 반복적으로 강화하는 것이다. 이에 대한 몇 가지 예를 들면 다음과 같다.

- **HIV 및 기타 성매개감염병(STIs) 예방 :** 청소년들은 성기 결합을 하지 않거나, 모든 파트너와 성기 결합을 할 때마다 올바른 콘돔 사용을 해야 한다. 특정 효과적 프로그램은 동시다발적인 성관계를 피하고, 한 사람과의 성관계를 가질 것을 강조한다. 또한 일부 국가는 ‘돈 많은 중년남자들(sugar daddies, 성관계를 대가로 자기보다 훨씬 젊은 여자에게 많은 선물과 돈을 안겨주는)’에 대한 위험성과 콘돔을 일관되게 사용하지 않는 동시다발적인 파트너와 관련된 위험의 증가와 같은 문화적 메시지를 강조한다. HIV를 포함한 성매개 감염병(STIs)에 대한 검사와 치료를 권장하는 프로그램도 있다. 커리큘럼과 내용과 교사는 청소년들이 콘돔, HIV 검사, 노출 전 예방요법(PrEP)과 노출 후 예방요법(PEP)을 포함한 HIV 예방 통합 서비스에 접근하는 방법 및 노출 전 예방요법(PrEP)과 같은 가장 최근의 생물학적 예방 기술을 포함한 HIV 예방에 대한 최신 과학 및 연구를 따라야 한다(UNAIDS, 2016).

- **임신 예방 :** 청소년들은 성적 관계를 피하거나 섹스를 할 때마다 다 매번 현대적 피임법을 사용해야 한다. 또한 성 및 재생산건강(SRH)서비스를 받을 수 있는 곳이 어디인지를 알아두어야 한다.

- **젠더 기반 폭력 및 차별 방지 :** CSE 프로그램에는 불평등을 강화하는 행동의 변화 방법과 여성에 대한 유해한 관행의 변화 요구에 대한 명확한 메시지를 포함해야 한다.

위험과 보호 요소들은 성행위에 대한 청소년들의 의사결정에 중요한 역할을 한다. 여기에는 청소년 친화적인 건강 및 사회적 지원 서비스 접근과 같은 외부적인 것 뿐 아니라 인지적, 심리사회적 요소가 포함된다. 커리큘럼 기반 프로그램 특히, 학교 기반 프로그램은 재생산 건강 서비스 접근방법에 대한 정보를 포함하고는 있지만 일반적으로 내적 인지적 요소에 집중한다. 섹슈얼리티 교육에서 강조되는 지식, 가치관, 규범 등은 사회적 규범에 의해 뒷받침될 필요가 있으며, 이와 같은 사회적 규범의 모델이자 강화하는 신뢰할 수 있는 성인에 의해 추진되어야 한다.

12. HIV 감염 및 기타 성매개감염병(STIs), 원치 않는/의도하지 않은 성적 삽입/폭력을 유발할 수 있는 특정 상황 다루기 : 이상적으로는 청소년 자신의 참여와 함께 원치 않는 성행위 압박을 받을 위험이 있는 특정한 상황을 파악하고, 이를 피하거나 협상하기 위한 전략을 연습하는 것이 중요하다. 또한 청소년들이 동의 및 원치 않는 상황에서 행동을 하도록 다른 사람들을 압박하지 않는 방법을 이해하는 것도 중요하다. 보호되지 않는 성행위가 약물 또는 음주와 관련된 지역사회에서는 약물 및 음주가 성행위에 미치는 영향을 해결하는 것도 중요하다.

13. 콘돔 및 전체적인 피임에 대한 개인의 태도와 또래 규범 다루기 : 개인의 태도와 또래 규범은 콘돔 사용과 피임 방법에 영향을 미친다. 효과적인 CSE 커리큘럼은 콘돔 및 현대 피임법에 대한 명확한 메시지와 그것의 효과에 대한 정확한 정보를 제공한다. CSE는 학생들이 콘돔과 현대 피임법에 대한 자신의 태도를 탐구하고, 사용에 대한 인식의 장벽을 파악하는데 도움을 준다. CSE 프로그램은 이와 같은 장벽을 극복하는 방법에 대해 토론할 기회를 제공한다. 예를 들어, 콘돔을 획득과 소지의 어려움, 파트너에게 콘돔 사용을 요구할 때 있을 수 있는 당혹스러움, 또는 실제 콘돔 사용 관련 어려움이 있을 수 있다.

14. 아동청소년의 건강 요구, 특히 성 및 재생산건강(SRH) 요구 관련 가능한 서비스에 대한 정보 제공 : 효과적인 CSE 커리큘럼에는 섹슈얼리티와 관계에 대한 상담을 포함하되 이에 국한하지 않는 청소년 친화적인 건강 서비스 이용 방법에 대한 정보를 포함한다. 여기에는 월경 건강관리, 현대 피임법과 임신 테스트, 인공임신중절(법적), 성매개감염병(STI) 및 HIV 예방, 상담, 검사 및 치료, 인유두종 바이러스(HPV) 예방 접종, 자발적 포경수술(VMMC) 및 여성 할레(FGM/C) 예방과 결과 관리 등을 포함한다.

커리큘럼에 포함되어 있는 활동에서는 정보에 기초한 동의와 개인 정보 보호 및 기밀 유지의 중요성에 대해 설명하고, 청소년 스스로 의사결정을 할 수 있도록 지원 또는 방해하는 기존의 법률 체계에 대해 학습하도록 함으로써 청소년들이 자신의 보호와 관련된 의사결정과정에서 적극적인 역할을 해야 한다는 것과 그 방법에 대한 이해를 하도록 장려해야 한다. 마지막으로 커리큘럼을 통해 학습자는 일부 청소년이 자신의 성별, 성적 지향, 성 정체성, 지리적 위치, 혼인 상태, 장애로 인해 직면할 수 있는 성 및 재생산건강(SRH) 서비스 장벽을 생각해보고, 보호 제공을 위한 법적 요건에 대해 배움으로써 또래집단 또는 파트너가 성 및 재생산건강(SRH) 서비스에 접근할 수 있도록 지원하는 적극적인 역할을 하는 방법을 배워야 한다.

표 4. 효과적 CSE 커리큘럼의 특성

준비 단계

1. 섹슈얼리티, 행동 변화 및 관련 교육이론에 대한 전문가의 참여
2. 청소년, 부모/가족 구성원 및 지역사회 이해관계자의 참여
3. 프로그램 대상자인 아동 청소년의 발달단계에 따른 사회적, 성 및 재생산건강(SRH) 요구 및 행동 평가
4. 커리큘럼 개발 및 실행에 필요한 자원(인적, 시간적, 재정적) 평가

내용 개발

5. 내용, 접근방법, 활동 결정을 위해 명확한 목표, 결과, 주요 학습에 집중
6. 논리적 순서에 따라 주제 다루기
7. 맥락적, 비판적 사고를 증진하는 활동 기획
8. 동의 및 라이프 스킬 다루기
9. HIV 및 AIDS, 기타 성매개감염병(STIs), 임신 예방, 조기 및 의도하지 않은 임신, 다양한 보호 방법 및 이용 가능성에 대한 과학적으로 정확한 정보 제공
10. 생물학적 경험, 성별, 문화적 규범이 아동청소년 자신의 성 행위와 성 및 재생산건강(SRH) 경험 및 처리 방식에 미치는 일반적인 영향 다루기
11. 특정 성행위에 영향을 미치는 특정 위험 및 보호 요소 다루기
12. HIV 감염, 기타 성매개감염병(STIs), 원치 않는 또는 비보호적인 성적 삽입 및 폭력으로 이어질 수 있는 특정 상황을 관리하는 방법 다루기
13. 콘돔 및 피임 전반에 대한 개인의 태도와 또래 규범 다루기
14. 아동청소년의 건강에 대한 요구, 특히 성 및 재생산건강(SRH) 요구에 부응하는 사용 가능한 서비스에 대한 정보 제공하기

7.3 CSE 프로그램 기획과 실행

1. 독립형 또는 통합형 프로그램 중 무엇으로 할지 결정 : 섹슈얼리티 교육을 하나의 독립된 주제로 할 것인지, 건강 또는 생물과 같이 기존의 주요 교과목과 통합할 것인지, 커리큘럼 전반에 걸쳐 또는 라이프 스킬 프로그램에 포함하여 독립형과 통합형 두 가지 방법으로 할 것인지에 대한 결정이 필요하다. 이러한 결정은 일반적인 교육정책, 자원의 이용가능성, 학교 커리큘럼의 우선순위 선정, 학습자의 요구, CSE 프로그램을 위한 지역사회 자원 및 시간적 문제와 관련이 있다. 실용적으로는 이상적일 수는 있으나 섹슈얼리티 교육을 별도의 단일 주제로 하거나 기존 라이프 스킬과 같은 주제 중 하나로 배치하는 것이 좋다.

교사가 이미 가르치고 있는 것을 토대로 해서 내용을 개선하고, 사회과학, 생물 또는 상담과 같은 기존 과목에 CSE를 통합하는 것이 더 실용적일 수 있다.

이러한 상황에서는 CSE 콘텐츠가 약화되지 않도록 보호하고, 교사 훈련 및 다양한 과목과 연계하여 CSE 콘텐츠를 제공하기 위해 필요한 교수학습자료를 늘리는 것이 중요하다.

기타 중요한 고려사항에는 전달 방식(독립형 대 통합형)에 따라 필수적으로 CSE 콘텐츠에 대한 고려를 하는지 그리고 CSE 관련 콘텐츠를 공식적으로 검토할 것인지 여부 등이 포함된다. 교사와 학습자 모두 시험 또는 다른 평가 접근법이 도입될 때 이를 심각하게 받아들이는 경향이 있으며, 또한 시험은 교사의 효율성과 학습의 결과를 측정할 수 있는 더 많은 기회를 제공한다.

표 5. 독립형 또는 통합형 CSE의 핵심 고려사항

독립형	통합형
고유의 독립적인 주제의 중요성을 생각한다.	기존 커리큘럼 주제의 보완 및 특정 기술이나 지식 영역을 다른 과목(예: 사회연구, 라이프스킬)과 연계
독립된 주제를 모두 다루기에는 커리큘럼 시간이나 공간이 충분하지 않을 수 있다.	시험 준비를 하려고 하는 교사에게 심층학습 또는 도전적인 주제가 시험을 위해 더 중요한 것으로 간주되는 과목에 밀릴 수 있다.
단 한 명의 훈련받은 교사만 있어도 되지만, 교육 주제는 한 개인의 책무와 역량에 달려있다.	모든 과목에 걸쳐 충분한 ‘커리큘럼’이 되도록, 교사에 대한 훈련, 지원, 조정 체계가 필요하다.
평가와 시험은 보다 직관적일 수 있다.	커리큘럼 틀에 따라 여러 과목에 걸친 평가를 진행하는 것은 전체 커리큘럼 진도 검토 및 평가를 더욱 복잡하게 만들 수 있다.
훈련받은 교사의 수와 교수학습자원의 개발의 수를 기준에서 잠재적으로 비용 효율적이다.	특정하고 관련된 CSE 구성요소를 추가함으로써 훈련, 교육자료, 평가 비용을 기존의 다른 영역에 분산시킬 수 있다.
교사는 소외감 또는 민감한 주제에 대한 지지가 부족하다고 느낄 수 있다.	참여하는 직원의 수가 많아지고, CSE에 대한 이해가 ‘학교 전체’적인 더욱 총체적인 접근 방식으로 이어질 수 있다.

2. 여러 해에 걸쳐 순차적으로 진행 : 학습 효과를 극대화하기 위해서는 섹슈얼리티에 대한 다양한 주제를 연령에 맞추어 나선형 커리큘럼 접근법으로 다룰 필요가 있다. 청소년들에게 행동에 대한 명확한 메시지를 제공하는 것과 중요한 개념은 여러 해에 걸쳐 강화하는 것이 중요하다. 또한 청소년들이 성적으로 위험한 의사결정을 하지 않도록 위험 및 보호 요소 둘 다 다루어야 한다. 이러한 접근은 시간이 필요하다. 사하라 사막 이남의 아프리카 (Michielsen et al., 2010 in UNESCO, 2016c)의 연구 검토 결과 개입을 많이 받은 청소년들에게 더 큰 영향을 미친 것으로 보고되었다.

CSE 기간과 강도가 효과적 측면에서 중요한 요소이므로, 특별활동, 프로젝트, 이벤트로 보완할 수 있도록 시간표가 짜여져 있는 학급에서 수업이 이루어져야 한다(Pound et al., 2017). 12회 또는 12회 이상, 30회 또는 30회 이상, 각 회 별 50분의 프로그램을 했을 경우 긍정적인 결과가 나타났다. CSE 프로그램의 효과성을 높이기 위해서는 이 지침에 따라 학년별 커리큘럼 및 수업 계획 시 CSE 프로그램을 위한 적절한 시간과 장소를 신중하게 확보해야 한다 (UNESCO, 2009).

3. **CSE 커리큘럼 시범운영** : CSE 커리큘럼 시범운영을 통해 조정
이 필요한 것은 조정할 수 있다. 프로그램 개발자는 시범운영을
통해 교육내용을 세부적으로 조정하고, 변경이 필요한 중요한 사
항을 발견할 수도 있다. 시범운영은 전체 커리큘럼을 다 해야 하
며 시범운영 참여자는 어떤 것이 효과적이고 효과적이지 않았는
지, 교육 관련성과 효과를 높이기 위해서는 어떤 것을 강화해야
하는 지 필요한 피드백을 주어야 한다.
4. **아동 청소년의 적극적 참여와 청소년들로 하여금 정보를 내면화
하고 통합하도록 돕는 참여 학습법 활용** : 교수자는 학습의 주요
영역(지식, 태도, 기술)을 학습할 수 있도록 다양한 상호작용, 참
여 및 학습자 중심적 접근법을 광범위하게 활용하는 것이 좋다.
양질의 임상시험 결과는 가장 효과적인 학교 기반 수업은 상호
작용적이며, 실제적인 기술에 대한 지식 기반 학습과 가치와 태
도를 생각해보는 기회를 주는 다양한 활동(Lopez et al., 2016 in
UNESCO 2016c)의 제공이라고 말한다. 역할게임, 정보통신기
술을 활용한 과제수행, 익명의 질문상자, 강의 및 전달식 수업, 그
룹토론과 같은 수업방법은 학습목표와 일치해야 한다(Amaugo
et al., 2014; Fonner et al., 2014; Tolli, 2012).
5. **커리큘럼을 실행할 수 있는 유능하고 동기부여가 된 교사 선택**
: 섹슈얼리티 교육 프로그램은 교사, 또래집단, 보건전문가 또는
이 셋의 조합에 의해 이루어지는 것이 가장 일반적이다(Fonner
et al., 2014). Pound et al.(2016)에 따르면, 좋은 교사에 대한
청소년의 관점은 다음과 같다. 1) 아는 것이 많다. ; 2)성 건강에
대한 전문 지식이 있다. ; 3)전문적이어야 한다. ; 4)(성 및 관계 교
육)에 대한 특별 교육을 받았다. ; 5)섹스에 대해 말하고 일상적
인 언어로 사용하는데 대해 자신감 있고, 당황스러워 하지 않고,
직설적이며, 친근하고, 흔들리지 않고, 경험이 풍부하다. ; 6)신뢰
할 수 있으며 비밀 유지를 잘한다. ; 7)경험적 지식을 갖고 있으
며, 자기자신의 섹슈얼리티에 편안함을 느낀다. ; 8) 청소년과 함
께 하는 것을 좋아한다. ; 9)청소년들의 성적 행동에 대해 공감하
고 수용하는 능력이 있다. ; 10) 청소년과 자신의 자율성을 존중
하고 평등하게 대우한다. ; 11)청소년과 비슷한 가치를 가지고
균형적이고 판단 없는 관점을 제시한다.
6. **교사에게 감수성, 가치명료화, 양질의 사전 직무연수 등 지속적
인 전문역량개발 기회 제공** : 섹슈얼리티에 대한 교사연수를 위
해서는 새로운 개념과 교수법이 필요하며 교사로서의 감수성, 가
치명료화 등 훈련 기회 제공이 중요하다. 교사연수 내용에는 참
여학습법 및 실습, 내용과 기술의 균형, 커리큘럼 수업 연습 기회
제공, 분명한 목적과 목표에 대한 교육, 교사 개인의 수업 효과
에 대한 건설적인 피드백이 포함되어야 한다. 교사로 하여금 자
신 및 학습자의 개인적 가치 및 건강 요구를 구분할 수 있으며 교
사로서의 자신감과 능력을 향상시키고, 커리큘럼 중 일부를 선
택하는 것이 아닌 전체를 가르치도록 장려해야 한다. 교육 중 일
부 지역사회(대규모 학급)에서 발생할 수 있는 도전적인 문제
를 다루고, 가장 중요한 지식 내용과 기술을 다루기에 충분한 시
간을 확보해야 한다. 교사가 교육을 개인의 필요에 맞추고 질문
과 문제를 제기하도록 허용해야 한다. 가능하다면 성 및 재생산건
강(SRH) 및 섹슈얼리티에 대한 교사 자신의 일반적인 우려에 대
해 다루는 것도 좋다. 마지막으로 경험과 지식이 풍부한 강사가
교육을 실시해야 하며 교육 종료 후에는 참가자들의 피드백을 받
는다.

학교 경영자는 교사가 교육연수 내용을 실천할 수 있도록 격려하
고, 지도 및 지원을 해야 한다. 학교 감독관은 커리큘럼이 계획대
로 실행되고, 모든 부분이 완벽하게 실행되고 있는지(시험을 위
한 생물학적 내용 뿐 아니라), 수업과정 중 발생할 수 있는 새롭
고, 도전적인 상황 대응을 위한 지원을 받을 수 있는지를 확인해
야 한다. 장학사는 학교 프로그램 적용을 위해 필요한 것을 만들
기 위한 섹슈얼리티 교육 분야에서의 중요한 진전 상황에 대한
정보를 지속적으로 얻는 것이 필요하다. 이 정보에는 학교 감독
관 및 장학사로 하여금 교사가 진행하는 동일 수정된 교사연수
모듈에 참여할 기회 뿐 아니라, CSE(학급)에 대한 모니터링 및 평
가를 체계적으로 할 수 있는 전국적으로 승인된 관찰 도구가 포
함될 수 있다.

교사는 학급 또는 과목담당(특히 보건교육 또는 라이프스킬 교
육)교사,또는 학급과 학급을 다니며 전 학년의 성교육만을 담당
하는 성교육 전문 강사일 수도 있다. 연구결과에 따르면 두 가지
유형의 교사가 프로그램을 효과적으로 제공할 수 있는 것으로 나
타났다(Kirby et al., 2006). 프로그램의 효과는 성인 대상 교육의
수준과 질, 프로그램의 질, 프로그램이 의도한대로 제공되는지의
여부, 학교 및 학교 외 사회환경 등과 같이 여러 요인의 영향을 받
을 수 있다(UNESCO, 2016c).

7. 모든 아동청소년을 위한 비밀, 사생활, 안전한 환경의 보장 : 섹슈얼리티가 불안감, 당혹감, 취약감에 대한 강한 감정, 반응, 행동을 불러일으킬 수 있음을 감안할 때(Pound et al., 2016, p.4), 모든 아동 청소년들이 자유롭게 질문하고, 배우고 참여하기 위해서는 비밀유지가 되고, 개인적이고 안전한 환경이 제공되는 것이 중요하다. 이러한 안정감은 어려운 질문 및 사례를 잘 다룰 줄 아는 훈련된 교사와 소규모 수업이나 소그룹 토론을 통해 획득될 수 있다. 교육자는 성적 학대를 경험한 학습자가 자신의 권리에 대해 더 많이 배우게 되면 이런 정보를 공개하기로 결정할 수도 있음을 인식해야 한다. 학교는 지역 법률 및 정책에 따라 절차를 마련하여 도움이 필요함을 알리거나 요청하고 추가 서비스가 필요한 사람들을 지원할 준비를 해야 한다.
8. 복합적 프로그램 계획 수행 : 가장 유망한 청소년 성 및 재생산 건강(SRH) 프로그램 개발 중 하나는 학교 내 섹슈얼리티 교육을 과외활동, 지역사회 또는 보건시설 기반 서비스와 함께 복합적으로 제공하는 것이다. 일부 보고에 따르면 학교 내 프로그램에 청소년 친화적인 서비스를 할 수 있도록 보건의료제공자 훈련, 콘돔 배포 및 부모와 교사의 참여를 포함한 지역사회 요소가 보완될 때 가장 큰 영향이 나타난다고 한다(Chandra-Mouli et al., 2015; Fonner et al., 2014; UNESCO, 2015a; 2016C).
9. 디지털 매체를 수업도구로 사용하는 것의 적절성 평가 : 디지털 매체를 활용한 섹슈얼리티 교육은 특히, 학교 수업에서 정적인 커리큘럼으로 제공하는 프로그램이 적절하지 않을 수 있는 청소년 취약집단을 포함하여 사용자의 특수한 요구에 맞게 디지털 사용을 조정함으로써 풍부한 기회를 제공하는 것으로 나타났다(UNESCO, 2016c). 디지털 매체를 통한 섹슈얼리티 교육에 대한 최근의 연구는 섹스 시작 지연과 아울러 콘돔, 자기효능감, 절제, HIV/성매개감염병(STIs), 임신에 대한 지식, 태도의 변화를 포함한 행동의 변화가 있음을 발견했다(Guse et al., 2012 in UNESCO 2016c).

디지털 매체 활용 CSE 실행을 위해서는 적절한 프로그램 실행에 필요한 기술 지원 및 장비와 같은 광범위한 요소를 고려해야 한다. 대부분의 경우, 널리 보급 하거나 저렴한 휴대폰을 활용하는 것이 청소년들에게 정보를 전달하는데 효과적일 수 있다. 청소년들의 온라인 행동 또는 개인 프로파일은 프로그램을 위해 직원, 교사 또는 연구자에게 공개되어야 하는지를 포함하여, 더 큰 커리큘럼 기반 프로그램 중 하나로 할 것인지 독립형으로 할 것인지, 디지털 매체를 통해 섹슈얼리티 교육을 제공하는 것에 대한 윤리적 함의가 있다(Guse et al., 2012 in UNESCO, 2016c). 디지털 매체로 섹슈얼리티 교육을 제공하는 것의 기회와 위험은 교사, 부모 또는 다른 연장자보다 이런 매체 사용에 훨씬 더 전문적 사용자인 청소년을 수업 계획 과정에 참여시킴으로써 가장 잘 이해할 수 있다.

10. CSE 복제 프로그램의 품질 유지 : 한 나라 또는 문화에서 효과가 있는 것으로 밝혀진 프로그램은 프로그램을 위한 자원이 낮아졌다 하더라도 다른 맥락에서도 성공적으로 복제될 수 있다(Gardner et al., 2015; Leijten et al., 2016). 그러나 사회, 지역 사회, 프로그램, 종사자 및 조직의 영향, 심지어 실행 과정 자체가 복제된 프로그램의 실행의 질에 영향을 줄 수 있다(Durlak, 2013 in UNESCO 2016c). 여기에는 환경, 학교, 학생, 교직원 또는 지역사회의 특정 요구 충족을 위한 적용이 포함된다. 적용은 프로그램의 또는 커리큘럼의 핵심 구성요소에 대한 신중한 고려와 이해로 이루어져야 한다. 일부 적용은 신뢰도에 제한적인 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어 언어 바꾸기(어휘 번역, 수정), 청소년, 가족 또는 대상 또는 상황적 맥락에 맞게 이미지 바꾸기, 문화적인 참고자료 바꾸기가 있을 수 있다. 회수 및 시간 줄이기, 참여자수 줄이기, 학습할 핵심 메시지 또는 기술, 주제를 완전히 없애기, 이론적 접근 방법 바꾸기, 적절한 훈련을 받지 않거나 자격이 없는 직원 또는 자원봉사자 활용하기, 추천하는 직원 수보다 적은 직원 배치하기도 위험한 적용의 예로 포함된다. 보다 적절한 내용으로 만들기 위해 일부 언어나 이미지 또는 문화적 참고자료를 바꾸는 것은 효과에 영향을 미치지 않는다.

표 6. CSE 프로그램 기획과 실행

1. 독립형 또는 통합형 프로그램 중 무엇으로 할 것인지 정한다.
2. 여러 해에 걸쳐 복합적, 순차적으로 진행한다.
3. CSE 커리큘럼을 시범운영 한다.
4. 아동 청소년의 적극적 참여와 청소년들로 하여금 정보를 내면화하고 통합하도록 돕는 참여 학습법을 활용한다.
5. 학교 및 비형식 환경에서 커리큘럼을 실행할 수 있는 유능하고, 동기부여가 된 교사를 선택한다.
6. 교사에게 감수성, 가치명료화, 양질의 사전/직무연수 등 지속적인 전문역량개발 기회를 제공한다.
7. 모든 아동 청소년을 위한 비밀, 사생활, 안전한 환경을 보장한다.
8. 복합적 프로그램 계획을 수행한다.
9. 디지털 매체를 수업도구로 사용하는 것의 적절성을 평가한다.
10. CSE 복제 프로그램의 품질을 유지한다.

7.4 CSE 프로그램 모니터링과 평가

1. 학교, 지역사회, 교사, 학습자로부터 프로그램 결과 성과에 대한 평가 및 피드백을 받는다 : 프로그램에 대한 정기적인 모니터링과 평가에는 참가자 수, 학습자 수, 교사교육, 메시지, 중재에 관한 통계 검토가 빈번하게 이루어져 한다. 또한 모니터링 및 평가에는 사용되는 교수법, 커리큘럼의 충실성, 학습 경험에 대한 학생들의 인식, 학습 환경의 안전성에 관한 데이터 수집을 위한 수업 관찰 및 인터뷰가 포함되어야 한다(UNFPA, 2014).

최근 섹슈얼리티 교육 검토 및 평가 도구(UNESCO, 2011b)와 IPPF(국제가족계획연맹)의 안과 밖(IPPF, 2015a)과 같은 다른 맥락에 적용할 수 있는 다양한 모니터링 및 평가 도구가 개발되어 섹슈얼리티 교육 범위, 내용, 전달방법에 대한 평가들을 제공한다.

2. 섹슈얼리티 교육에 대한 체계적인 측정을 위해 국가 교육 모니터링 시스템 중 하나 또는 그 이상의 지표를 활용한다. : 섹슈얼리티 교육에 대한 체계적인 모니터링은 1~2가지 핵심적인 섹슈얼리티 교육 문제를 포함하여 정기적으로 교육 관련 통계를 구축하는 국가 통계 시스템을 이용할 수 있다. 교육관리정보시스템(EMIS)내에 있는 국가는 아래 지표를 사용하기 바란다. 이 지표는 라이프스킬 기반 HIV 및 섹슈얼리티 교육의 질, 포괄성, 적용 범위에 대한 조사를 위해 UNESCO와 관계부처 교육 업무팀이 개발하였다(UNESCO, 2013a).

지표 조사는 교육관리정보시스템(EMIS) 학교 통계 또는 학교 설문조사를 통해 이루어질 수 있다. 설문조사는 수업내용 전반에 대해 더욱 자세하게 분석할 수 있게 하며 전국적인 학교 표본 조사로 이루어질 수 있다. 후자의 경우, 지표는 학교 기반 섹슈얼리티 교육에 필수적이고, 바람직한 기준이 어느 정도 포함되어 있는지를 측정한다. 필수적인 주제는 HIV 예방에 가장 직접적인 영향을 미치는 것이며, 바람직한 주제는 HIV 예방에 간접적인 영향을 미치는 하지만 전반적인 섹슈얼리티 프로그램의 일부로서 중요하다. 관련하여 전반적인 내용은 부록 VIII. 필수적이고, 바람직한 범주로 제안된 것을 참조한다.

표 7. 교육관리정보시스템(EMIS) 국가의, 라이프스킬 기반 HIV 및 섹슈얼리티 교육의 질, 포괄성, 적용 범위 조사를 위한 지표

학교 학생들은 전년도에 포괄적인 라이프스킬 기반 HIV 및 섹슈얼리티 교육을 받았나요? 예 / 아니오 만약 있다면 라이프 스킬 기반 HIV 및 섹슈얼리티 프로그램에서 다루어진 주제는 무엇이었나요?		
일반적인 라이프 스킬(예: 의사결정/소통/거절 기술)교육	예	아니오
성 및 재생산 건강/섹슈얼리티 교육 (예: 인간의 성장과 발달, 가족 생활, 생식 건강, 성적 학대, 성병 감염)	예	아니오
HIV 감염 및 예방 교육	예	아니오

Source: UNESCO. 2013a. Measuring the education sector response to HIV and AIDS: Guidelines for the construction and use of core indicators. Paris, UNESCO.

3. 프로그램 결과 및 영향에 대한 평가를 한다:

결과 평가는 태도, 행동, 기술의 변화, 목표에 도달한 것으로 파악된 청소년의 비율, 기타 단기 지표와 같이 위험 및 보호 요소에 대한 평가를 한다. 일부 지표에 대한 내용은 특정한 형태의 연구를 통해 수집될 수 있다. 예를 들어, 대상자에 대한 인터뷰, CSE 참가 청소년에 대한 평가를 위해 프로그램 모니터링 결과를 분석할 수 있다. 수혜자 그룹의 구성원이 다른 프로그램 수혜자와의 대화 인터뷰를 하는 동료평가방법은 수혜자의 이야기와 관점에 대한 통찰력을 얻을 수 있는 기회를 제공한다(IPPF, 2013). 청소년의 비판 능력은 직접적인 관찰과 인터뷰를 통해 평가할 수 있으며, 지식, 태도, 관행의 변화는 '자존감 척도', '정확한 콘돔 사용에 대한 자기효능감', '청소년 유대감에 대한 헤밍웨이 척도', '부모-청소년 소통 정도', '성적 권력 관계 척도'와 같은 검증된 척도와 설문조사를 통해 평가할 수 있다(UNFPA, 2014).

영향 평가는 특정 프로그램 결과 변화를 관찰한다. 지표에는 예를 들어, HIV 및 AIDS, 의도하지 않은 임신과 성매개감염병 비율의 감소, 성평등 또는 특정 환경에서의 CSE 프로그램 성과목표와 같은 프로그램의 궁극적인 목표가 포함된다. 영향 평가는 인과관계를 볼 수 있는 무작위비교연구와 같은 연구방법으로 평가한다. 그러나 청소년 임신 또는 HIV 발병과 같은 건강 지표에 따라 CSE 영향을 모니터링 하는 것은 어려울 수 있다. 서비스 접근성과 같은 다른 요인들이 관찰된 변화에 중요한 역할을 할 수 있음을 기억하는 것이 중요하다(UNESCO, 2014a).

7.5 CSE 프로그램 확대

유익미한 영향을 위해서는 높은 양질의 섹슈얼리티 교육이 이루어져야 하며, 국가 교육 체제로 제도화되어야 한다. 특히, CSE 교육을 교육대학 과정으로 하면 그 나라는 포괄적인 CSE 교육 주제를 다룰 줄 알고, 효과적으로 전달할 수 있는 인력을 지속적으로 확대하는 효과를 보게 된다. CSE의 미래 성장에 대한 투자는 지속 가능하고, 충실한 실행을 하도록 돕는다. 또한 이러한 투자는 CSE가 교사연수 과정에 체계적으로 통합되어 있는 경우, 즉각적으로 실행할 필요가 있을 수도 있는 미래의 교사직무연수 비용을 완하시킨다. CSE 제도는 사회 변화의 중요한 공헌이자 청소년 복지와 발달 뿐 아니라 인구 대비 공동 건강 지표에 궁극적인 도움이 될 사회 및 젠더 규범에도 영향을 미친다. 학교 차원의 협력 메커니즘과 국가 차원의 협력적 접근법을 통해 교육과 건강서비스를 제도적으로 연계하는 것도 CSE 확대에 포함된다.

박스 4. 유네스코 섹슈얼리티 교육 보급을 위한 10가지 주요 원칙

1. 기존 체계 내에서 보급할 수 있는 개입 접근 방법을 선택한다.
2. 서로 다른 주체들의 역할과 교육을 보급하고자 하는 목표를 명확히 하고, 지역의 주체적인 역할을 보장한다.
3. 요구에 대한 이해와 기존 정부 체계 및 정책에 적용한다.
4. 프로그램 보급 전 시범운영 프로그램 효과에 대한 자료를 수집하고 배포한다.
5. 개입의 변화가 프로그램 효과에 미치는 영향을 문서화하고 평가한다.
6. 리더십의 역할을 인식한다.
7. 지속 가능한 계획을 위한 교육보급 자원의 가용성을 확인하고, 모금을 위한 계획을 세운다.
8. 장기적(기부자 기부 사이클이 아닌) 계획을 하고, 변화와 걸림돌을 예측한다.
9. 시간이 지남에 따라 과정을 확대시키는 ‘자원팀’의 변화 요구를 예상한다.
10. 정치적인 환경 변화에 맞추어 확장 전략을 조정하고, ‘정책의 창’이 열릴 때 활용한다.

프로그램 보급을 위해서는 섹슈얼리티 교육의 도입 및 시행을 위한 유리한 조건과 행동이 필요하다. 유네스코(2010)에 따르면 성공의 지렛대는 다음과 같다.

- 유리한 정책적 맥락 안에서 반영된 HIV 및 섹슈얼리티 교육 공약
- 교육과 건강부처, 정부와 시민사회조직 간의 파트너십(그리고 이를 위한 공식 메커니즘)
- 청소년의 관점을 대변하고, 공헌하는 조직 및 단체
- 커리큘럼 검토를 위한 협력 과정, 상당한 반대에도 불구하고 CSE 필요성을 알고자 하는 시민사회단체
- 의사결정권자들 사이의 ‘협력자’라는 인식과 적극적인 참여
- 의사결정자의 감수성과 관련하여 (유엔 파트너 및 국제적인 비영리조직으로부터) 받을 수 있는 적절한 전문적 지원
- 교사의 참여 학습방법 사용 촉진과 국제 네트워크 회의 참여
- 동성애 혐오 교재 철회와 같은 CSE에 대한 특정 장벽의 제거

많은 국가에서 섹슈얼리티 교육 관련 국가 정책 및 전략이 시행되고 있지만 제한적이고, 편파적으로 실행되어왔다. 그럼에도 불구하고 소규모, 저소득 및 중간소득국가에서 정부 주도의 노력이 큰 규모(국가의 모든 또는 대부분의 지역 포괄)로 지속적으로 진행되고 있다.

이들 국가의 성공에 결정적이었던 것은 정부의 강력한 지도력, 정부와 경험 많은 비영리조직 및 대학 간의 파트너십, 적절한 자원, 궁극적으로 청소년의 삶에 영향을 미치는 정책과 계획을 행동으로 변환하는 긴 과정에 대한 이해관계자들간의 약속과 공유이다.

많은 확장 프로그램들이 단점이 있고, 성과 유지의 어려움을 겪고 있지만 책무, 전문성, 노력, 자원이 합쳐져 세계 모든 지역으로 섹슈얼리티 교육 보급이 가능하다는 긍정적 전망이 있다.



A photograph of three people from the waist down, standing on a gravel surface against a plain wall. The person on the left wears a plaid shirt and dark pants, holding a green book. The person in the center wears a light-colored sweater and blue jeans, holding a white book. The person on the right wears a striped sweater and dark jeans, holding a dark book. The image has a dark, moody filter.

8

참고자료

8 - 참고자료

- Adeyemi, B. A. 2008. Effects of cooperative learning and problem-solving strategies on junior secondary school students' achievement in social studies. *Journal of Research in Educational Psychology*, Vol. 6, No. 3, pp. 691-708.
- Advocates for Youth, Answer, GLSEN, the Human Rights Campaign, Planned Parenthood Federation of America and the Sexuality Information and Education Council of the U.S. 2015. A Call to Action: LGBTQ youth need inclusive sex education. <http://www.advocatesforyouth.org/storage/advfy/documents/a%20call%20to%20action%20lgbtq%20youth%20need%20inclusive%20sex%20education%20final.pdf> (Accessed 30 April 2017).
- Ahmad, F. and Aziz, J. 2009. Students' perceptions of the teachers' teaching of literature communicating and understanding through the eyes of the audience. *European Journal of Social Sciences*, Vol. 7, No. 3, pp. 17-39.
- Amaugo, L.G., Papadopoulos, C., Ochieng, B. and Ali, N. 2014. The effectiveness of HIV/AIDS school-based sexual health education programmes in Nigeria: A systematic review. *Health Education Research*, Vol. 29, No. 4, pp. 633-648. <https://pdfs.semanticscholar.org/a82e/36dbd9ab9171656d6fa6d9cce134726c124a.pdf> (Accessed 5 May 2017).
- Arends, R. I. 1997. *Classroom Instruction and Management*. Boston, U.S., McGraw Hill.
- Ayot, H. O. and Patel, M. M. 1992. *Instructional Methods*. Nairobi, Educational Research and Publications Ltd.
- Baltag, V., and Sawyer, S.M. 2017. Quality healthcare for adolescents. In: Cherry A., Baltag V., Dillon M. (eds). *International Handbook on Adolescent Health and Development: The public health response*. New York, Springer International Publishing.
- Barth, J., Bermetz, L., Heim, E., Trelle, S. and Tonia, T. 2012. The current prevalence of child sexual abuse worldwide: A systematic review and meta-analysis. *International Journal of Public Health*. Vol 58, No 3, pp 469-83. DOI: 10.1007/s00038-012-0426-1.
- Bekker, LG., Johnson, L., Wallace, M. and Hosek, S. 2015. Building our youth for the future. *Journal of the International AIDS Society*, 18 (2 Suppl 1): 20076. DOI: 10.7448/IAS.18.2.20027. <http://www.jiasociety.org/index.php/jias/article/view/20027/html> (Accessed 24 August 2017).
- Birungi, H., Mugisha, J. F. and Nyombi, J. K. 2007. Sexuality of young people perinatally infected with HIV: A neglected element in HIV/AIDS programming in Uganda. *Exchange on HIV/AIDS, Sexuality and Gender*, No. 3, pp. 7-9.
- Blum, R.W., Mmari, Kristin Nelson. 2005. *Risk and Protective Factors Affecting Adolescent Reproductive Health in Developing Countries*. Geneva, WHO/ Baltimore, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.
- Bridges, A. J., Wosnitzer, R., Scharrer, E., Sun, C. and Libermann, R. 2010. Aggression and sexual behavior in best-selling pornography videos: A content analysis update. *Violence Against Women*, Vol. 16, No. 10, pp. 1065-1085.
- Brown, J. and L'Engle, L. 2009. X-rated: Sexual attitudes and behaviours associated with US early adolescents exposure to sexually explicit media. *Sage Journals*. <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0093650208326465> (Accessed 30 May 2017).
- Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzGA), UNFPA and WHO. 2015. *Sexuality Education Policy Brief No. 1*. Cologne, Germany, BzGA. http://eeca.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GAKC_Policy_Brief_No_1_rz.pdf (Accessed 30 April 2017).
- Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzGA), UNFPA and WHO. 2016. *Sexuality Education Policy Brief No. 2*. Cologne, Germany, BzGA. http://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Sexuality_education_Policy_brief_No_2.pdf (Accessed 30 April 2017).
- Cash, S.J. and A. Bridge, J.A. Epidemiology of Youth Suicide and Suicidal Behavior. *Current Opinion in Pediatrics*. 21(5):613-619, October 2009 - Volume 21 - Issue 5 - p 613-619. DOI: 10.1097/MOP.0b013e32833063e1 (Accessed 5 May 2017).
- Cathy, J. 2011. *Theory of Change Review: A report commissioned by Comic Relief*.
- Chandra-Mouli, V., Lane, C. and Wong, S. 2015. What does work in adolescent sexual and reproductive health: A review of evidence on interventions commonly accepted as best practices. *Global Health: Science and Practice*, Vol. 3, pp. 333-340.
- Chandra-Mouli, V. and Vipul Patel, S. 2017. Mapping the knowledge and understanding of menarche, menstrual hygiene and menstrual health among adolescent girls in low and middle-income countries. *Reproductive Health*, Vol. 1, No. 14, pp. 14-30.
- Child Rights International Network. 2016. *Rights, Remedies and Representation: Global report on access to justice for children*. London, Child Rights International Network. https://www.crin.org/sites/default/files/crin_a2j_global_report_final_1.pdf (Accessed 30 April 2017).
- Constantine, N. A., Jerman, P., Berglas, N. F., Angulo-Olaiz, F.,

- Chou, C. P. and Rohrbach, L. A. 2015b. Short-term effects of a rights-based sexuality education curriculum for high-school students: a cluster-randomized trial. *BioMed Central Public Health*, 15, p. 293. Retrieved from <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1186/s12889-015-1625-5>
- Council of Europe. 2014. Sexual Orientation and Gender Identity: Questions and answers. Brussels, Council of Europe. <https://edoc.coe.int/en/lgbt/7031-sexual-orientation-and-gender-identity-sogi-questions-and-answers.html> (Accessed 4 May 2017).
- Dicenso, A., Guyatt, G., Willan, A. and Griffith, L. 2002. Interventions to reduce unintended pregnancies among adolescents: Systematic review of randomised controlled trials. *British Medical Journal*, Vol. 324, No. 7351, pp. 1426-1426.
- D ring, N. 2014. Consensual sexting among adolescents: Risk prevention through abstinence education or safer sexting? *Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace*, Vol. 8, No. 1. <https://cyberpsychology.eu/article/view/4303/3352> (Accessed 30 May 2017).
- D ring, N., Daneback, K., Shaughnessy, K., Grov, C. and Byers, E. S. 2015. Online sexual activity experiences among college students: A four-country comparison. *Archives of Sexual Behavior*. https://www.researchgate.net/publication/286638680_Online_Sexual_Activity_Experiences_Among_College_Students_A_Four-Country_Comparison
- Duflo, E., Dupas, P., Kremer, M. and Sinei, S. 2006. Education and HIV/AIDS Prevention: Evidence from a randomized evaluation in Western Kenya. Boston, Department of Economics and Poverty Action Lab.
- Dupas, P. 2006. Relative Risks and the Market for Sex: Teenagers, sugar daddies and HIV in Kenya. Hanover, Dartmouth College.
- Durlak, J.A., Weissberg, R.P., Dymnicki, A.B., Taylor, R.D., and Schellinger, K. B. 2011. The Impact of Enhancing students' Social and Emotional Learning: A meta-analysis of school-based universal interventions. *Child Development*, Volume 82, Issue 1, pp. 405-432. DOI: 10.1111/j.1467-8624.2010.01564.x. <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-8624.2010.01564.x/abstract>
- Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP). 2013. Report of the Sixth Asian and Pacific Population Conference. Bangkok, ESCAP. [http://www.unescapdd.org/files/documents/Report of the Sixth APPC.pdf](http://www.unescapdd.org/files/documents/Report%20of%20the%20Sixth%20APPC.pdf)
- Elder, S. K. 2014. Labour Market Transition of Young Women and Men in Sub-Saharan Africa. Work 4 Youth Publication Series No. 9. Geneva, Youth Employment Programme, Employment Policy Department.
- European Union Agency for Fundamental Rights. 2014. Violence against Women, an EU-wide Survey: Main results report. <http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report> (Accessed 4 May 2017).
- Fisher, J. and McTaggart J. 2008. Review of Sex and Relationships Education in Schools. Geneva, UNAIDS. [http://www.cornwallhealthyschools.org/documents/SRE final jim knoght review recommedations.pdf](http://www.cornwallhealthyschools.org/documents/SRE%20final%20jim%20knoght%20review%20recommedations.pdf) (Accessed 30 May 2017).
- Fonner, V. A., Armstrong, K. S., Kennedy, C. E., O'Reilly, K. R. and Sweat, M. D. 2014. School based sex education and HIV prevention in low- and middle-income countries: A systematic review and meta-analysis. *PLoS One*, 9(3), e89692. <http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0089692>. doi:10.1371/journal.pone.0089692
- Gardner, F., Montgomery, P. and Knerr, W. 2015. Transporting evidence-based parenting programs for child problem behavior (Age 3-10) between countries: Systematic review and meta-analysis. *Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology*. 1-14. <http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15374416.2015.1015134>
- Garofalo, R., Wolf, R., Wissow, L., Woods, E. and Goodman, E. 1999. Sexual orientation and risk of suicide attempts among a representative sample of youth. *Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine*, Vol. 153, No. 5.
- Giroux, H. A. 1994. Toward a pedagogy of critical thinking. In *Re-Thinking Reason: New Perspectives in Critical Thinking*. Kerry S. Walters (ed.). Albany, SUNY Press.
- Gordon, P. 2008. Review of Sex, Relationships and HIV education in Schools. Paris, UNESCO.
- Gordon, P. 2010. Sexuality Education and the Prevention of Violence. Council of Europe. www.coe.int/t/dg3/children/1in5/source/publicationsexualviolence/ (Accessed 4 May 2017).
- Goulds, S. 2015. *Because I Am a Girl*. Toronto, Plan. (Accessed 4 May 2017).
- The Guttmacher Institute. 2014. Intended and unintended pregnancies worldwide in 2012 and recent trends. *Studies in Family Planning*, Vol. 45, No. 3. https://www.guttmacher.org/sites/default/files/article_files/j.1728-4465.2014.00393.x.pdf (Accessed 4 May 2017).
- The Guttmacher Institute. 2015a. Adolescent Pregnancy and Its Outcomes Across Countries Factsheet. New York, The Guttmacher Institute. <https://www.guttmacher.org/fact-sheet/adolescent-pregnancy-and-its-outcomes-across-countries> (Accessed 4 May 2017).
- Guttmacher Institute. 2015b. Adolescent Women's Need for and Use of Sexual and Reproductive Health Services in Developing Countries. New York, The Guttmacher Institute. <https://www.guttmacher.org/fact-sheet/adolescent-womens-need-and-use-sexual-and-reproductive-health> (Accessed 4 May 2017).

- Haberland, N. 2015. The case for addressing gender and power in sexuality and HIV education: A comprehensive review of evaluation studies. *International Perspectives on Sexual and Reproductive Health*, Vol. 41, No. 1, pp. 31-42. <https://www.guttmacher.org/journals/ipsrh/2015/03/case-addressing-gender-and-power-sexuality-and-hiv-education-comprehensive> (Accessed 30 April 2017).
- Haberland, N., Rogow, D. 2015. Sexuality education: Emerging trends in evidence and practice. *Journal of Adolescent Health*, Vol. 56, No. 1, pp. 15-21.
- Hadley, A., Ingham, R. and Chandra-Mouli, V. 2016. Teenage pregnancy strategy for England. *The Lancet*, Volume 388, No. 10044. DOI: [http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)30619-5](http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(16)30619-5). [http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(16\)30619-5/fulltext?rss%3Dyes](http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)30619-5/fulltext?rss%3Dyes). (Accessed 4 May 2017).
- Hall, W., Patton, G., Stockings, E., Weier, M., Lynskey, M., Morley, K. and Degenhardt, L. 2016. Why young people's substance use matters for global health. *The Lancet Psychiatry*, Vol. 3, No. 3, pp. 265-279.
- Hillier, L., Jones, T., Monagle, M., Overton, N., Gahan, L., Blackman, J. and Mitchell, A. 2010. Writing Themselves in 3 (WTi3). The third national study on the sexual health and wellbeing of same sex attracted and gender questioning young people. Melbourne, Australian Research Centre in Sex, Health and Society and La Trobe University.
- Hughes, K., Bellis, M., Jones, L., Wood, S., Bates, G., Eckley, L., McCoy, E., Mikton, C., Shakespeare, T. and Officer, A. 2012. Prevalence and risk of violence against adults with disabilities: A systematic review and meta-analysis of observational studies. *The Lancet*, Vol. 379, No. 9826, pp. 1621-1629.
- International Planned Parenthood (IPPF). 2013. Explore; Toolkit for involving young people as researchers in sexual and reproductive health programmes. Rapid PEER review handbook. London, IPPF. https://www.rutgersinternational/sites/rutgersorg/files/pdf/AW_Explore-PEER%20Handbook.pdf (Accessed 25 April 2017).
- International Planned Parenthood Federation (IPPF). 2015. Teaching about Consent and Healthy Boundaries: A guide for educators. London, IPPF. https://www.ifpa.ie/sites/default/files/documents/Reports/teaching_about_consent_healthy_boundaries_a_guide_for_educators.pdf (Accessed 4 May 2017).
- International Planned Parenthood Federation (IPPF). 2016. Everyone's Right to Know: Delivering comprehensive sexuality education for all young people. London, IPPF. http://www.ippf.org/sites/default/files/2016-05/ippf_cse_report_eng_web.pdf (Accessed 25 April 2017).
- International Planned Parenthood Federation (IPPF). 2017 (unpublished). Toolkit Deliver+Enable: Scaling-up comprehensive sexuality education (CSE). London, IPPF.
- International Planned Parenthood Federation (IPPF) and Coram Children's Legal Centre. 2014. Inception Report: Qualitative research on legal barriers to young people's access to sexual and reproductive health services. London, IPPF. <http://www.ippf.org/resource/inception-report-qualitative-research-legal-barriers-young-peoples-access-sexual-and> (Accessed 4 May 2017).
- ILO, OHCHR, UNAIDS Secretariat, UNDP, UNESCO, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNODC, UN Women, WFP and WHO. 2015. Joint UN statement on Ending violence and discrimination against lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex people. New York, United Nations. http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/Joint_LGBTI_Statement_ENG.PDF (Accessed 24 August 2017).
- Jemmott, J. B., Jemmott, L. S., Fong, G. T. and Morales, K. H. 2010. Effectiveness of an HIV/STD risk-reduction intervention for adolescents when implemented by community-based organizations: A cluster-randomized controlled trial. *American Journal of Public Health*, 100(4), 720-726. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2836337/> <http://doi.org/10.2105/AJPH.2008.140657>
- Jennings, L., Parra-Medina, D., Hilfinger-Messias, D. and McLoughlin, K. 2006. Toward a critical social theory of youth empowerment. *Journal of Community Practice*, Vol. 14, No. 1-2, pp. 31-55.
- Kennedy, A.C. and Bennett, L. 2006. Urban adolescent mothers exposed to community, family and partner violence: Is cumulative violence exposure a barrier to school performance and participation? *Journal of Interpersonal Violence*, 6, pp. 750-773.
- Killermann, S. 2015. The Genderbread Person v3. [Blog] It's Pronounced Metrosexual. <http://itspronouncedmetrosexual.com/2015/03/the-genderbread-person-v3/#sthash.F0QoolEk.dpbs> (Accessed 5 February 2017).
- Kirby, D. 2007. Emerging Answers 2007: Research findings on programs to reduce teen pregnancy and sexually transmitted diseases. Washington, DC, The National Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy. https://thenationalcampaign.org/sites/default/files/resource-primary-download/EA2007_full_0.pdf
- Kirby, D. 2009. Recommendations for Effective Sexuality Education Programmes. Unpublished review prepared for UNESCO. Paris, UNESCO.
- Kirby, D. 2011. Sex Education: Access and impact on sexual behaviour of young people. United Nations Expert Group Meeting on Adolescents, Youth and Development. New York, Population Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations Secretariat.
- Kirby, D., Korpi, M., Barth, R. P. and Cagampang, H. H. 1997. The impact of the postponing sexual involvement curriculum among youths in California. *Family Planning Perspectives*, Vol. 29, No. 3, pp. 100-108.

- Kirby, D., Laris, B. and Roller, L. 2005. Impact of Sex and Sex Education Programs on Sexual Behaviors of Youth in Developing and Developed Countries. Washington DC, Family Health International (FHI).
- Kirby, D., and Lepore, G. 2007. Sexual Risk and Protective Factors: Factors affecting teen sexual behavior, pregnancy, childbearing and sexually transmitted disease: Which are important? Which can you change? Washington DC, National Campaign to Prevent Teen Pregnancy.
- Kirby, D., Obasi, A. and Laris, B. 2006. The effectiveness of sex education and hiv education interventions in schools in developing countries. Preventing HIV/AIDS in Young People: A systematic review of the evidence from developing countries in D. Ross, B. Dick and J. Ferguson (eds.) Geneva, WHO, pp. 103-150.
- Kirby, D., Roller, L. and Wilson, M. M. 2007. Tool to Assess the Characteristics of Effective Sex and STD/HIV Education Programmes. Washington, DC, Healthy Teen Network.
- Kivela, J., Ketting, E. and Baltussen, R. 2013. Cost analysis of school-based sexuality education programs in six countries. Cost Effectiveness and Resource Allocation, 11(1), 1-7. doi:10.1186/1478-7547-11-17
- Kontula, O. 2010. The evolution of sex education and students' sexual knowledge in Finland in the 2000s. Sex Education, Vol. 10, No. 4, pp. 373-386.
- Krug, E. G., Dahlberg, L. L., Mercy, J. A., Zwi, A. B. and Lozano, R. 2002. World Report on Violence and Health. Geneva, WHO. http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/introduction.pdf
- Lansdown, G. 2001. Promoting Children's Participation in Democratic Decision Making. Florence, UNICEF. <https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/insight6.pdf> (Accessed 5 February 2017).
- Leijten, P., Melendez-Torres, G. J., Knerr, W., and Gardner, F. 2016. Transported versus homegrown parenting interventions for reducing disruptive child behavior: A multilevel metaregression study. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. 55(7), 610-617. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jaac.2016.05.003>.
- Loaiza, E. and Liang, M. 2013. Adolescent Pregnancy: A review of the evidence. New York, UNFPA. https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/ADOLESCENT%20PREGNANCY_UNFPA.pdf (Accessed 25 April 2017).
- Lopez, L. M., Bernholc, A., Chen, M. and Tolley, E. 2016. School-based interventions for improving contraceptive use in adolescents. The Cochrane Library. doi:10.1002/14651858.CD012249
- Madise, N., Zulu, E. and Ciera, J. 2007. Is poverty a driver for risky sexual behaviour? Evidence from national surveys of adolescents in four African countries. African Journal of Reproductive Health, Vol. 11, No. 3, p. 83. <https://www.guttmacher.org/sites/default/files/pdfs/pubs/journals/reprints/AJRH.11.3.83.pdf> (Accessed 5 February 2017).
- McKee, A. 2014. Methodological issues in defining aggression for content analyses of sexually explicit material. Archives of Sexual Behavior, Vol. 44, No. 1, pp. 81-87.
- Meyer, E. 2010. Gender and Sexual Diversity in Schools. Dordrecht, Netherlands, Springer Science+Business Media.
- Michielsen, K., Chersich, M. F., Luchters, S., De Koker, P., Van Rossem, R. and Temmerman, M. 2010. Effectiveness of HIV prevention for youth in sub-Saharan Africa: Systematic review and meta-analysis of randomized and nonrandomized trials. AIDS, 24(8), pp. 1193-1202.
- Nixon, C. 2014. Current perspectives: The impact of cyberbullying on adolescent health. Adolescent Health, Medicine and Therapeutics, Vol. 5, pp. 143-158.
- O'Connor, C., Small, S. A. and Cooney, S. M., 4. 2007. Program fidelity and adaptation: Meeting local needs without compromising program effectiveness. Madison, WI, University of Wisconsin-Madison/Extension. Retrieved from http://fyi.uwex.edu/whatworkswisconsin/files/2014/04/whatworks_04.pdf
- Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). 2003. CRC General Comment 4: Adolescent health and development in the context of the Convention on the Rights of the Child (CRC). New York, UN. <http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/Health/GC4.pdf> (Accessed 30 April 2017).
- Office of the Special Advisor on Gender Issues and Advancement of Women. 2001. Gender Mainstreaming: Strategy for promoting gender equality. New York, Office of the Special Advisor on Gender Issues and Advancement of Women. <http://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/factsheet1.pdf> (Accessed 30 April 2017).
- Ofsted 2013. Ofsted Annual Report 2012/13: Schools report. London, Ofsted.
- Okonofua, F. 2007. New research findings on adolescent reproductive health in Africa [Nouveaux r sultats de recherche sur la sant de reproduction en Afrique]. African Journal of Reproductive Health, Vol. 11, No. 3, p. 7.
- Oosterhof, P., Muller, C. and Shephard, K. 2017. Sex education in the digital era. IDS Bulletin, Vol. 48, No. 1. <http://bulletin.ids.ac.uk/idsbo/issue/view/223> (Accessed 30 May 2017).
- Oringanje, C., Meremikwu, M. M., Eko, H., Esu, E., Meremikwu, A. and Ehiri, J. E. 2009. Interventions for preventing unintended pregnancies among adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews, N.PAG-N.PAG. doi:10.1002/14651858.CD005215.pub2
- Otieno, A. 2006. Gender and Sexuality in the Kenyan Education System: Is history repeating itself? An exploratory study of information on sexuality within Nakuru town. MA. Southern and Eastern African Regional Centre for Women's Law at the University of Zimbabwe.

- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2017. Early Learning Matters. Paris, OECD. <https://www.oecd.org/edu/school/Early-Learning-Matters-Project-Brochure.pdf>. (Accessed 30 April 2017).
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). 2016. Living Free and Equal. What States are doing to tackle violence and discrimination against lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex people. New York and Geneva, United Nations.
- Pan American Health Organization (PAHO) and WHO. 2000. Promotion of Sexual Health. Recommendations for Action. Washington D.C., PAHO.
- Peter and Valkenburg. 2007. Online communication and adolescent well-being: Testing the stimulation versus the displacement hypothesis. *Journal of Computer-mediated communication*. Vol. 12, 4, pp. 1169-1182.
- Plan International. 2016. Counting the Invisible: Using data to transform the lives of girls and women by 2030. Woking, Plan International. http://www.ungei.org/resources/files/2140_biaag_2016_english_finalv2_low_res.pdf (Accessed 30 April 2017).
- Plan International. 2017. Teenage Pregnancy. Woking, Plan International. <https://plan-international.org/sexual-health/teenage-pregnancy> (Accessed May 2017).
- Pound P., Denford S., Shucksmith J., Tanton C., Johnson A.M., Owen J., Hutten R., Mohan L., Bonell C., Abraham C. and Campbell R. 2017. What is best practice in sex and relationship education? A synthesis of evidence, including stakeholders' views. *British Medical Journal Open*. 2017 Jul 2; 7(5): e014791. doi: 10.1136/bmjopen-2016-014791. <http://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/7/5/e014791.full.pdf> (Accessed 21 July 2017).
- Pound, P., Langford, R., and Campbell, R. 2016. What do young people think about their school-based sex and relationship education? A qualitative synthesis of young people's views and experiences. *British Medical Journal Open*, 6(9). doi:10.1136/bmjopen-2016-011329
- Religious Institute. 2002. Open letter to religious leaders about sex education. <http://religiousinstitute.org/wp-content/uploads/2009/06/Open-Letter-Sex-Education.pdf> (Accessed 30 April 2017).
- Rohleder, P. and Swartz, L. 2012. Disability, sexuality and sexual health. *Understanding Global Sexualities: New Frontiers (Sexuality, culture and health series)*. 138-152. DOI: 10.4324/9780203111291
- Rohrbach, L. A., Berglas, N. F., Jerman, P., Angulo-Olaiz, F., Chou, C. P. and Constantine, N. A. 2015. A Rights-Based Sexuality Education Curriculum for Adolescents: 1-Year Outcomes From a Cluster-Randomized Trial. *Journal of Adolescent Health*, 57(4), 399-406. Retrieved from <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/cochrane/central/articles/910/CN-01131910/frame.html> doi:10.1016/j.jadohealth.2015.07.004
- Ross, D., Dick, B. and Ferguson, J. 2006. Preventing HIV/AIDS in Young People: A systematic review of the evidence from developing countries. Geneva, WHO.
- Save the Children. 2015. What do children want in times of emergency and crisis? They want an education. London, Save the Children. https://www.savethechildren.org.uk/sites/default/files/images/What_Do_Children_Want1.pdf (Accessed 30 April 2017)
- Secor-Turner, M., Schmitz, K. and Benson, K. 2016. Adolescent experience of menstruation in rural Kenya. *Nursing Research*, Vol. 65, No. 4, pp. 301-305.
- Sedgh, G., Ashford, L. S. and Hussain, R. 2016. Unmet Need for Contraception in Developing Countries: Examining women's reasons for not using a method. New York, Guttmacher Institute. <https://www.guttmacher.org/report/unmet-need-for-contraception-in-developing-countries> (Accessed 30 April 2017).
- Shepherd, J., Kavanagh, J., Picot, J., Cooper, K., Harden, A., Barnett-Page, E., ... Price, A. 2010. The effectiveness and cost effectiveness of behavioural interventions for the prevention of sexually transmitted infections in young people aged 13-19: A systematic review and economic evaluation. *Health Technology Assessment*, 14(7), 1-230.
- Stead, M., Stradling, R., MacNeil, M., MacKintosh, A. and Minty, S. 2007. Implementation evaluation of the Blueprint multi-component drug prevention programme: Fidelity of school component delivery. *Drug and Alcohol Review*, Vol. 26, No. 6, pp. 653-664.
- Stephenson, J., Strange, V., Forrest, S., Oakley, A., Copas, A., Allen, E., Babiker, A., Black, S., Ali, M., Monteiro, H. and Johnson, A. 2004. Pupil-led sex education in England (RIPPLE study): cluster-randomised intervention trial. *The Lancet*, Vol. 364, No. 9431, pp. 338-346.
- Stirling, M., Rees, H., Kasedde, S. and Hankins, C. 2008. Addressing the vulnerability of young women and girls to stop the HIV epidemic in Southern Africa. Geneva, UNAIDS.
- Straight Talk Foundation. 2008. Annual Report. Kampala, Straight Talk Foundation. <https://www.scribd.com/document/17357627/Straight-Talk-Foundation-Annual-Report-2008> (Accessed 30 May 2017).
- Thomas, F. and Aggleton, P. 2016. School-based sex and relationships education: Current knowledge and emerging themes. In: Sundaram, V. and Sauntson, H. (eds) *Global Perspectives and Key Debates in Sex and Relationships Education: Addressing Issues of Gender, Sexuality, Plurality and Power*. Basingstoke, Palgrave Macmillan.
- Tolli, M. V. 2012. Effectiveness of peer education interventions for HIV prevention, adolescent pregnancy prevention and sexual health promotion for young people: A systematic review of European studies. *Health Education Research*. 27(5), 904-913. doi:10.1093/her/cys055

- Trenholm, C., Devaney, B., Fortson, K., Quay, L., Wheeler, J. and Clark, M. 2007. Impacts of Four Title V, Section 510 Abstinence Education Programs: Final Report. Trenton, NJ, Mathematica Policy Research Inc.
- Uganda Bureau of Statistics (UBOS) and Macro International Inc. 2007. Uganda Demographic and Health Survey 2006. Calverton, Md., UBOS and Macro International Inc. <http://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/FR194/FR194.pdf> (Accessed 30 May 2017).
- Underhill, K., Montgomery, P. and Operario, D. 2007. Sexual abstinence only programmes to prevent HIV infection in high income countries: Systematic review. *British Medical Journal*, Vol. 335, No. 7613, pp. 248-248. <http://bmj.com/cgi/content/full/335/7613/248> (Accessed 13 August 2017).
- United Nations. 1989. Convention on the Rights of the Child. New York, UN. <http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx> (Accessed 30 May 2017).
- United Nations. 1995. Platform for Action of the United Nations Fourth World Conference on Women. New York, UN. <http://www.un.org/esa/gopher-data/conf/fwcw/off/a--20.en> (Accessed 30 May 2017).
- United Nations. 1999. Overall Review and Appraisal of the Implementation of the Programme of Action of the International Conference on Population and Development. New York, UN. http://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/A_S-21_AC.1_L.pdf (Accessed 30 May 2017).
- United Nations. 2001. Declaration of Commitment on HIV/AIDS. New York, UN. http://www.unaids.org/sites/default/files/sub_landing/files/aidsdeclaration_en_0.pdf (Accessed 30 May 2017).
- United Nations. 2007. Convention of the Rights of Persons with Disabilities. New York, UN. <https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/general-assembly/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-ares61106.html> (Accessed 30 May 2017).
- United Nations. 2010. Report of the United Nations Special Rapporteur on the Right to Education. http://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/UNSR_Sexual_Education_2010.pdf (Accessed 30 May 2017).
- United Nations. 2014. Programme of Action adopted at the International Conference on Population and Development Cairo, 5-13 September 1994. New York, UNFPA. <http://www.unfpa.org/publications/international-conference-population-and-development-programme-action> (Accessed 30 May 2017).
- UNAIDS. 2006. Scaling up Access to HIV Prevention, Treatment, Care and Support: The next steps. Geneva, UNAIDS. http://data.unaids.org/publications/irc-pub07/jc1267-univaccess-thenextsteps_en.pdf (Accessed 30 May 2017).
- UNAIDS. 2008. 2008 Report on the Global AIDS Epidemic. Geneva, UNAIDS. http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/jc1510_2008globalreport_en_0.pdf (Accessed 30 May 2017).
- UNAIDS. 2012 Factsheet on Young people, Adolescents and HIV. Geneva, UNAIDS. http://files.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/factsheet/2012/20120417_FS_adolescentsyoungpeoplehiv_en.pdf (Accessed 30 May 2017).
- UNAIDS 2014. The Gap Report. Geneva, UNAIDS. http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_Gap_report_en.pdf (Accessed 30 May 2017).
- UNAIDS. 2016. HIV Prevention among Adolescent Girls and Young Women: Putting HIV prevention among adolescent girls and young and including boys & men women on the Fast-Track and engaging men and boys. Geneva, UNAIDS. http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_HIV_prevention_among_adolescent_girls_and_young_women.pdf
- UNAIDS. 2017. Ending AIDS. Progress towards the 90-90-90 Targets. Global AIDS Update. Geneva, UNAIDS. http://www.unaids.org/en/resources/documents/2017/20170720_Global_AIDS_update_2017
- UNAIDS and WHO. 2007. 2007 AIDS Epidemic Update. Geneva, UNAIDS. http://data.unaids.org/pub/epislides/2007/2007_epiupdate_en.pdf (Accessed 30 May 2017).
- UNDP. 2015. Report of the Regional Dialogue on LGBTI Human Rights and Health in Asia-Pacific. Bangkok, UNDP. http://www.asiapacific.undp.org/content/dam/rbap/docs/Research%20and%20Publications/hiv_aids/rbap-hhd-2015-report-regional-dialogue-lgbti-rights-health.pdf (Accessed 30 May 2017).
- UNDP (in press). Leave no one Behind: Advancing social, economic, cultural and political inclusion of LGBTI people in Asia and the Pacific.
- UNESCO. 1996. Learning: The treasure within. Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-first Century. Paris, UNESCO. <http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590eo.pdf> (Accessed 30 May 2017).
- UNESCO. 2000a. Dakar Framework for Action, Education for All. Meeting our collective commitments. Paris, UNESCO. <http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147e.pdf> (Accessed 30 May 2017).
- UNESCO. 2000b. General Comment No. 14. Substantive issues arising in the implementation of the international covenant on economic, social and cultural rights. Geneva, UNESCO. http://data.unaids.org/publications/external-documents/ecosoc_cesccr-gc14_en.pdf (Accessed 30 May 2017).

- UNESCO. 2008. School-centred HIV and AIDS Care and Support in Southern Africa: Technical consultation report, 22-24 May 2008, Gaborone, Botswana. Paris, UNESCO. <http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001578/157860e.pdf> (Accessed 30 May 2017).
- UNESCO. 2009. International Technical Guidance on Sexuality Education: An Evidence-informed approach for schools, teachers and health educators. Paris, UNESCO. <http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/183281e.pdf> (Accessed 3 May 2017).
- UNESCO. 2010. Levers of Success: Case studies of national sexuality education programmes. Paris, UNESCO. <http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001884/188495e.pdf> (Accessed 30 April 2017).
- UNESCO. 2011a. Cost and Cost-effectiveness Analysis of School-based Sexuality Education Programmes in Six Countries. Paris, UNESCO. <http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002116/211604e.pdf>
- UNESCO. 2011b. Sexuality Education Review and Assessment Tool. Paris, UNESCO. <http://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/documents/sexuality-education-review-and-assessment-tool-serat-0> (Accessed 4 May 2015).
- UNESCO. 2012. Review of Policies and Strategies to Implement and Scale Up Sexuality Education in Asia and the Pacific. Bangkok, UNESCO Bangkok. <http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002150/215091e.pdf>
- UNESCO. 2013a. Measuring the Education Sector Response to HIV and AIDS: Guidelines for the construction and use of core indicators. Paris, UNESCO. <http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002230/223028e.pdf> (Accessed 30 May 2017).
- UNESCO. 2013b. Ministerial Commitment on Comprehensive Sexuality Education and Sexual and Reproductive Health Services for Adolescents and Young People in Eastern and Southern African (ESA). Paris, UNESCO. <http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/HIV-AIDS/pdf/ESACommitmentFINALAffirmedon7thDecember.pdf> (Accessed 30 May 2017).
- UNESCO. 2014a. Comprehensive Sexuality Education: The challenges and opportunities of scaling-up. Paris, UNESCO. <http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002277/227781e.pdf> (Accessed 5 May 2017).
- UNESCO. 2014b. Good Policy and Practice in Health Education: Puberty education and menstrual hygiene management. Paris, UNESCO. <http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002267/226792e.pdf> (Accessed 3 May 2017).
- UNESCO. 2015a. Emerging Evidence, Lessons and Practice in Global Comprehensive Sexuality Education: A global review. Paris, UNESCO. http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/CSE_Global_Review_2015.pdf (Accessed 4 May 2017).
- UNESCO. 2015b. From Insult to Inclusion: Asia-Pacific report on school bullying, violence and discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity. Paris, UNESCO. <http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235414e.pdf> (Accessed 5 May 2017).
- UNESCO. 2016a. 2016 Global Education Monitoring Report. Education for people and planet: Creating sustainable futures for all. Paris, UNESCO. <http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745e.pdf> (Accessed 5 May 2017).
- UNESCO. 2016b. Out in the Open: Education Sector Responses to Violence based on Sexual Orientation and Gender Identity/Expression. Paris, UNESCO. <http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002447/244756e.pdf>
- UNESCO. 2016c. Review of the Evidence on Sexuality Education. Report to inform the update of the UNESCO International Technical Guidance on Sexuality Education; prepared by Paul Montgomery and Wendy Knerr, University of Oxford Centre for Evidence-Based Intervention. Paris, UNESCO.
- UNESCO. 2017a. Early and Unintended Pregnancy: Recommendations for the education sector. Paris, UNESCO. <http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002484/248418e.pdf> (Accessed 30 May 2017).
- UNESCO. 2017b. Good Policy and Practice in Health Education. Booklet 10. Education sector responses to the use of alcohol, tobacco and drugs. Paris, UNESCO. <http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002475/247509e.pdf> (Accessed 30 May 2017).
- UNESCO. 2017c. Review of Curricula and Curricular Frameworks. Report to inform the update of the UNESCO International Technical Guidance on Sexuality Education: prepared by Advocates for Youth. Paris, UNESCO.
- UNESCO. 2017d. School Violence and Bullying: Global status report. Paris, UNESCO. <http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002469/246970e.pdf> (Accessed 5 May 2017).
- UNESCO and The Global Network of People Living with HIV (GNP+). 2012. Positive Learning: Meeting the needs of young people living with HIV (YPLHIV) in the education sector. Paris/Netherlands, UNESCO/GNP+ <http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002164/216485e.pdf> (Accessed 5 May 2017).
- UNESCO and UNAIDS. 2008. EDUCAIDS Framework for Action. Paris/Geneva, UNESCO/UNAIDS. <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001473/147360e.pdf> (Accessed 30 April 2017).
- UNFPA. 2010. Comprehensive Sexuality Education: Advancing human rights, gender, equality and improved sexual and reproductive health. Bogota, UNFPA. <https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Comprehensive%20Sexuality%20Education%20Advancing%20Human%20Rights%20Gender%20Equality%20and%20Improved%20SRH-1.pdf> (Accessed 3 May 2017).

- UNFPA. 2013. Adolescent Pregnancy: A review of the evidence. New York, UNFPA. https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/ADOLESCENT%20PREGNANCY_UNFPA.pdf (Accessed 5 May 2017).
- UNFPA. 2014. Operational Guidance for Comprehensive Sexuality Education: A focus on human rights and gender. New York, UNFPA. <http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA%20Operational%20Guidance%20for%20CSE%20-Final%20WEB%20Version.pdf> (Accessed 5 May 2017).
- UNFPA. 2015. The Evaluation of Comprehensive Sexuality Programmes: A Focus on the gender and empowerment outcomes. New York, UNFPA. <https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPAEvaluationWEB4.pdf> (Accessed 5 May 2017).
- UNFPA, UNESCO and WHO. 2015. Sexual and Reproductive Health of Young People in Asia and the Pacific: A review of issues, policies and programmes. Bangkok, UNFPA. <http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002435/243566E.pdf> (Accessed 30 April 2017).
- UNICEF. 2002. The State of the World's Children 2003. New York, UNICEF. <https://www.unicef.org/sowc03/contents/pdf/SOWC03-eng.pdf> (Accessed 30 May 2017).
- UNICEF. 2014a. Ending Child Marriage: Progress and prospects. New York, UNICEF. https://www.unicef.org/media/files/Child_Marriage_Report_7_17_LR..pdf (Accessed 5 May 2017).
- UNICEF. 2014b. Hidden in Plain Sight: A statistical analysis of violence against children. New York, UNICEF. http://files.unicef.org/publications/files/Hidden_in_plain_sight_statistical_analysis_EN_3_Sept_2014.pdf (Accessed 5 May 2017).
- USAID. 2009. Factsheet on Youth Reproductive Health Policy: Poverty and youth reproductive health. Washington, DC, USAID. http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadr402.pdf (Accessed 5 May 2017).
- USAID. 2013. Getting to Zero. A discussion paper on ending extreme poverty. Washington, USAID. <https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1870/USAID-Extreme-Poverty-Discussion-Paper.pdf> (Accessed 3 May 2017).
- Villa-Torres, L., and Svanemyr, J. 2015. Ensuring Youth's Right to Participation and Promotion of Youth Leadership in the Development of Sexual and Reproductive Health Policies and Programs. *Journal of Adolescent Health*, 56(1), S51-S57. doi:10.1016/j.jadohealth.2014.07.022
- Weeks, J. 2011. *The Languages of Sexuality*. Oxon, Routledge.
- WHO. 2001. Regional Strategy on Sexual and Reproductive Health. Copenhagen, WHO, Regional Office for Europe. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/69529/e74558.pdf (Accessed 31 May 2017).
- WHO. 2002. Defining Sexual Health: Report of a technical consultation on sexual health. Geneva, WHO. http://www.who.int/reproductivehealth/topics/gender_rights/defining_sexual_health.pdf (Accessed 31 May 2017).
- WHO. 2003. Skills for Health. Skills-based health education including life skills: An important component of a child-friendly/health-promoting school. Geneva, WHO. http://www.who.int/school_youth_health/media/en/sch_skills4health_03.pdf (Accessed 31 May 2017).
- WHO. 2004. Adolescent Pregnancy: Issues in adolescent health and development. Geneva, WHO. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42903/1/9241591455_eng.pdf (Accessed 5 May 2017).
- WHO. 2005. Sexually Transmitted Infections among Adolescents. The need for adequate health services. Geneva, WHO. http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/9241562889/en/ (Accessed 5 May 2017).
- WHO. 2006a. Defining Sexual Health: Report of a technical consultation on sexual health, 28-31 January 2002. Geneva, WHO. http://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en/ (Accessed 5 May 2017).
- WHO. 2006b. Pregnant Adolescents: Delivering on global promises of hope. Geneva, WHO. http://www.youthnet.org.hk/adh/2_AD_sexual_reproductiveH/Adolescent_Pregnancy/WHO%20-%20Pregnant%20Adolescents.pdf (Accessed 30 May 2017).
- WHO. 2007a. Unsafe Abortion: Global and regional estimates of the incidence of unsafe abortion and associated mortality in 2003, 5th edn. Geneva, WHO. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43798/1/9789241596121_eng.pdf (Accessed 5 May 2017).
- WHO 2007b. Adolescent Pregnancy - Unmet needs and undone deeds: A review of the literature and programmes. Geneva, WHO. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43702/1/9789241595650_eng.pdf (Accessed 5 May 2017).
- WHO. 2008. Pregnant Adolescents: Delivering on Global Promises. Geneva, WHO. http://www.youthnet.org.hk/adh/2_AD_sexual_reproductiveH/Adolescent_Pregnancy/WHO%20-%20Pregnant%20Adolescents.pdf (Accessed 30 May 2017).
- WHO. 2010. The ASSIST-linked Brief Intervention for Hazardous and Harmful Substance Use: Manual for use in primary care. Manual 1. Geneva, WHO. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44320/1/9789241599382_eng.pdf (Accessed 30 May 2017).
- WHO. 2011. WHO Guidelines on Preventing Early Pregnancy and Poor Reproductive Outcomes Among Adolescents in Developing Countries. Geneva, WHO. http://www.who.int/immunization/hpv/target/preventing_early_pregnancy_and_poor_reproductive_outcomes_who_2006.pdf (Accessed 5 May 2017).

- WHO. 2014a. Adolescent Pregnancy Factsheet. Geneva, WHO. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112320/1/WHO_RHR_14.08_eng.pdf (Accessed 30 May 2017).
- WHO. 2014b. World Health Statistics 2014. Geneva, WHO. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112738/1/9789240692671_eng.pdf?ua=1 (Accessed 30 May 2017).
- WHO. 2015. Every Woman, Every Child, Every Adolescent: Achievements and prospects. The final report of the independent Expert Review Group on Information and Accountability for Women's and Children's health. Geneva, WHO.
- WHO. 2016a. Global Health Estimates 2015: Deaths by cause, age, sex, by country and by region, 2000-2015. Geneva, WHO. http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/en/
- WHO. 2016b. Violence against Women: Intimate Partner and Sexual Violence Against Women Factsheet. Geneva, WHO. <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/> (Accessed 5 May 2017).
- WHO. 2016c. Youth Violence factsheet. Geneva, WHO. <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs356/en/> (Accessed 5 May 2017).
- WHO. 2017a. Female Genital Mutilation Factsheet. Geneva, WHO. <http://who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en/> (Accessed 30 May 2017).
- WHO. 2017b. Global Accelerated Action for the Health of Adolescents (AA-HA!): Guidance to support country implementation - summary. Geneva, WHO. <http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255418/1/WHO-FWC-MCA-17.05-eng.pdf?ua=1> (Accessed 30 May 2017).
- WHO and UNAIDS. 2009. Operational Guidance for Scaling Up Male Circumcision Services for HIV Prevention. Geneva: WHO. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44021/1/9789241597463_eng.pdf (Accessed 5 May 2017).
- WHO and UNICEF. 2008. More Positive Living: Strengthening the health sector response to young people living with HIV. Geneva, WHO. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43957/1/9789241597098_eng.pdf (Accessed 5 May 2017).
- WHO and UNFPA. 2006. Married Adolescents: No place of safety. Geneva, WHO. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43369/1/9241593776_eng.pdf (Accessed 30 April 2017).
- WHO, UNFPA and UNICEF. 1999. Programming for Adolescent Health and Development. Geneva, WHO. [http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42149/1/WHO_TRS_886_\(p1-p144\).pdf](http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42149/1/WHO_TRS_886_(p1-p144).pdf) (Accessed 5 May 2017).
- WHO Regional Office for Europe and Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). 2010. Standards for Sexuality Education in Europe: A framework for policy makers, educational and health authorities and specialists. Cologne, BZgA. http://www.oif.ac.at/fileadmin/OEIF/andere_Publikationen/WHO_BZgA_Standards.pdf (Accessed 5 May 2017).
- Wight, D. 2011. The effectiveness of school-based sex education: What do rigorous evaluations in Britain tell us? *Education and Health*, 29(4), 72-78.
- Women's Refugee Commission, Save the Children, UNHCR, UNFPA. 2012. Adolescent Sexual and Reproductive Health Programs in Humanitarian Settings: An In-depth Look at Family Planning Services. New York, UNFPA. https://www.unfpa.org/sites/default/files/resourcepdf/AAASRH_good_practice_documentation_English_FINAL.pdf (Accessed 30 April 2017).
- Woog V., Singh, S.S, Browne, A. and Philbin, J. 2015. Adolescent Women's Need for and Use of Sexual and Reproductive Health Services in Developing Countries. New York, Guttmacher Institute. <http://www.guttmacher.org/pubs/Adolescent-SRHS-Need-Developing-Countries.pdf>. (Accessed 30 May 2017).

9

용어설명

9 - 용어설명

이 지침서에서 사용한 용어와 개념은 유네스코와 유엔기관이 만든 문서에서 사용된 정의 뿐 아니라 널리 이용되고 있는 정의를 포함한다.

이 지침서에서 사용한 일반적 용어 및 개념에 대한 정의는 다음과 같다.

청소년(Adolescent) : UN이 정한 10-19세의 사람.

양성애자(Bisexual) : 한 젠더 이상의 사람에 매력을 느끼는 사람.

괴롭힘(Bullying) : 신체적 접촉, 언어적 공격 또는 심리적 조종을 통해 고의적으로 부상 또는 불편함을 주는 행동. 이러한 괴롭힘에는 불균형한 권력관계가 수반된다.

아동(Child) : UN이 정한 18세 미만의 사람.

강제(Coercion) : 강제 또는 위협으로 어떤 것을 하도록 누군가를 설득하는 행위 또는 관행.

커리큘럼(Curriculum) : 커리큘럼은 다른 연령대의 학생들이 무엇을 배우고, 무엇을 할 수 있는지, 왜, 어떻게, 얼마나 잘해야 하는지 등의 문제를 다룬다.

사이버 괴롭힘(Cyberbullying) : 일반적으로 전자통신으로 협박이나 위협적인 메시지를 보냄으로써 사람을 괴롭히는 것.

차별(Discrimination) : 인종, 성별, 종교, 국적, 민족, 성적지향, 장애, 연령, 언어, 사회적 출신 또는 기타 신분에 근거하여 불공정한 대우 또는 임의적인 구별을 하는 것.

형평(Equity) : 동등한 대우 또는 차등 대우를 포함한 공정하고 치우치지 않는 대우를 함으로써 권리, 이익, 의무, 기회의 불균형을 시정하는 것.

게이(Gay) : 주로 같은 성별의 사람에게 매력을 느끼거나 관계를 맺는 사람. 일반적으로 남성에게 사용되며 여성에게도 사용하기도 함.

젠더(Gender) : 남성성과 여성성, 여성과 남성, 여자어린이와 남자어린이의 관계, 아울러 여성들 사이에서의 관계, 남성들 사이에서의 여성들의 관계와 관련된 사회적 특성과 기회를 의미한다. 이러한 특성, 기회, 관계는 사회적으로 구성되며 학습된다.

젠더 규범 또는 역할(Gender norms or roles) : 남녀 간, 남자아이와 여자아이 간의 성별 특성, 기회, 관계 또는 성별 정체성은 사회마다 다르며 시간이 지나면서 바뀔 수 있으며, 젠더와 관련하여 무엇을 어떻게 할 것인지에 대해 문화적으로 기대되고 허용되거나 가치 있는 행동으로 간주되는 것을 둘러싼 사회화 과정을 통해 학습된다. 전통, 문화, 종교 또는 미신에 근거한 경직되고 차별적인 젠더 개념은 불평등과 유해한 관행으로 이끌 수 있다.

젠더 표현(Gender expression) : 자신의 이름, 옷, 어떻게 걷고, 말하고, 소통하는지 등 성별에 따른 사회적 역할 및 일반적인 행동과 같이, 자신의 젠더를 세상에 표현하는 방식을 말한다.

성별 정체성(Gender identity) : 한 사람이 젠더에 대해 개인적으로, 깊은 내면에서 느끼는 경험으로, 이것은 출생과 함께 부여된 생물학적인 성(sex)과 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있다. 이것은 한 개인이 자유로운 선택을 통해 신체적 외모나 기능(의료, 수술 또는 다른 수단에 의해)을 바꾸는 것을 포함한 신체에 대한 개인적 감각이 포함된다.

젠더 불일치(Gender non-conformity/conforming) : 남성성 또는 여성성에 대한 이분법적인 젠더 정의를 따르지 않고, 젠더 표현(gender expression)이 표준적인 젠더 규범과 다른 사람. 어떤 경우에는, 이들의 젠더 표현으로 인해 젠더 불일치로 사회가 개인을 인식할 수도 있다. 젠더 표현과 젠더 불일치는 남성성과 여성성에 대한 개인적 사회적 인식과 분명한 관련이 있다.

젠더 불일치(Gender variance) : 출생시 부여된 생물학적 성(sex)에 대한 기대와 일치하지 않는 젠더 표현(gender expression).

젠더 기반 폭력(Gender-based violence) : 성 차별, 성 역할 기대 그리고/또는 젠더 고정관념에 근거한, 또는 신체적, 성적 또는 심리적 피해 또는 고통을 초래하거나 초래할 수 있는 차별화된 권력을 기반으로 한 폭력.

희롱(Harrassment) : 타인에게 모욕감이나 굴욕감을 줄 것으로 합리적으로 예상 또는 인식될 수 있는 부적절하고 불쾌한 모든 행동. 희롱은 다른 사람을 성가시게 하고, 경고를 하고, 학대하고, 비하하고, 겁을 주고, 하찮게 만들고, 굴욕감을 주고, 또는 위협적이거나 모욕적인 환경을 조성하는 경향이 있는 언어, 몸짓, 행동이다.

이성애 규범(Heteronormativity) : 이성애(heterosexuality)가 정상적 또는 기본적인 성적 지향이라는 믿음.

동성애 혐오(Homophobia) : 자신의 실제 또는 인식된 성적 지향에 근거하여 동성애 및 동성애자에 대한 두려움, 불안, 불관용 또는 증오.

동성애 혐오 폭력(Homophobic violence) : 실제 또는 인식된 성적 지향에 근거한 괴롭힘의 젠더화된 형태.

동성애자(Homosexual) : 신체적, 정서적 그리고/또는 성적으로 동일한 성(sex)의 사람에게 끌리는 사람.

포괄적 교육(Inclusive education) : 모든 학습자에게 다가가기 위해 교육시스템 역량을 강화하는 과정.

정보에 따른 동의(Informed consent) : 연구 또는 개입에 참여하기 위해 자발적인 동의를 얻은 과정.

인터섹스(Intersex) : 간성. 남성 또는 여성의 몸에 대한 전형적인 이분법적 개념에 적합하지 않은 성(sex)적 특성(성기, 생식선 및 염색체 패턴 포함)을 갖고 태어난 사람. ‘인터섹스’는 광범위한 자연적인 신체 변화를 설명하기 위해 사용되는 포괄적인 용어이다. 어떤 경우에도, 인터섹스 형질이 출생 시 보일 수도 있지만 사춘기까지는 분명하지 않다. 일부 염색체 인터섹스 변이는 신체적으로 분명하지 않을 수도 있다. 인터섹스인 것은 생물학적인 성의 특성과 관련이 있으며 성적 지향 또는 성 정체성과는 구별된다. 인터섹스인 사람은 바로 게이, 레즈비언 또는 양성애자가 될 수 있으며, 여성, 남성, 둘 다 또는 둘 다 아닐 수도 있다.

레즈비언(Lesbian) : 주로 다른 여성과의 신체적, 정서적 또는 성적 매력, 그리고 친밀한 관계 형성 능력을 경험한 여성.

페다고지(Pedagogy) : 개별적으로 다양한 학습 방법, 다양한 아이들의 학습 참여를 돕고, 보다 효과적으로 학습하도록 돕는 다양한 방법론에 대한 인식을 포함하여 교육 콘텐츠가 전달되는 방식.

재생산 건강(Reproductive health) : 단지 생식기 질환이나 병약함이 없는 상태가 아닌, 생식 체계와 관련한 모든 문제에 있어서 충분한 신체적, 정신적, 사회적 복지의 상태를 말한다. 재생산 건강은 삶의 모든 단계에서의 생식 과정, 기능, 체계를 다루며, 사람들이 만족하고 안전한 성생활을 하고, 언제, 어떻게, 얼마나 자주 임신, 출산, 육아를 할 것인지 자유롭게 결정할 수 있음을 함의한다.

재생산권(Reproductive rights) : 재생산권은 국제법, 국제 인권 문서, 기타 합의 문서에서 합의한 인권을 포괄하고, 모든 커플 및 개인이 자유롭게 책임감 있게 자녀의 수, 간격, 시기를 결정할 수 있는 기본적인 권리이며 그렇게 할 수 있는 관련 정보, 교육, 수단을 제공하며, 성취 가능한 가장 최고 수준의 성 재생산 건강에 대한 권리이다. 또한 인권 문서에 표현된 바와 같이, 차별, 강압, 폭력으로부터 자유로운 결정에 관한 권리를 포함한다(부록 I 참조).

학교 관련 젠더 기반 폭력 : 젠더 규범과 고정관념의 결과 발생하고 불평등한 권력의 역동성에 의해 강화되는 것으로서, 학교 내외에서 발생하는 성적 위협 또는 행동, 신체적 또는 심리적 폭력.

성(sex) : 남성 또는 여성 인구 구성원으로 범주화하는데 사용되는 생물학적, 생리학적인 특성(유전적, 내분비학적, 해부학적)(인터섹스에 대한 정의 참조).

성 건강(Sexual health) : 섹슈얼리티와 관련된 신체적, 정서적, 정신적, 사회적 웰빙의 상태를 말하며, 단지 질병, 기능장애 또는 병약하지 않은 상태를 의미하는 것은 아님. 성 건강은 긍정적이고 존중받는 섹슈얼리티와 성적 관계 뿐 아니라 강압적, 차별적인 폭력으로부터 자유롭고 안전한 성적 경험을 할 수 있는 가능성을 필요로 한다. 성 건강을 획득하고 유지하기 위해서는 모든 사람이 자신의 성적 권리에 대한 존중, 보호, 충족을 해야 한다.

성적 지향(Sexual orientation) : 다른 성(이성애) 또는 같은 성(동성애) 또는 하나 이상의 성(양성애 또는 pansexual 범애자)에게 깊은 정서적, 애정, 성적 매력을 느끼고, 친밀하고 성적인 관계를 맺는 것에 대한 사람마다의 수용력.

낙인(Stigma) : 한 개인 또는 집단을 부정적으로 보게 하는 개인 또는 사회가 갖고 있는 의견 또는 판단. 차별은 이와 같은 낙인에서 발생한다.

트랜스젠더(Transgender) : 자신의 성(성 정체성)에 대한 내적 감각이 태어날 때의 성(sex)과 다른 사람. 트랜스젠더 사람은 이성애자, 동성애자, 또는 양성애자일 수 있다. 트랜스젠더 사람들은 자신을 남성 또는 여성, 교차적 성(alternate gender), 혼합적 성, 또는 무성(no gender)으로서 파악할 수 있다.

트랜스섹슈얼(Transsexual) : ‘트랜스섹슈얼’이라는 용어는, 자신의 신체가 자신의 성 정체성과 더 잘 어울리도록 의료적 절차(수술 및 호르몬 치료를 포함할 수 있음)를 경험하고 또는 경험하고자하는 트랜스젠더 사람들을 묘사하기 위해 때때로 사용된다.

트랜스포비아(Transphobia) : 트랜스젠더 사람들에 대한 공포, 불편함, 불관용 또는 증오.

트랜스포비아 폭력(Transphobia violence) : 실제 또는 인식된 성 정체성을 기반으로 하는 젠더화된 형태의 폭력.

폭력(Violence) : 신체적, 성적, 또는 심리적 피해를 초래하거나 그 결과로 나타날 수 있는 명시적 또는 상징적인 행위.

청소년(Young person) : UN이 정한 10세-24세 사이의 사람.

청소년(Youth) : UN이 정한 15세-24세 사이의 사람. 유엔은 이 연령대를 통계 목적으로 사용하지만, 국가 및 지역별 청소년에 대한 정의를 존중한다.





10

부록

10 - 부록

부록 I. 포괄적 성교육(CSE) 관련 국제협약, 도구, 표준

포괄적 섹슈얼리티 교육 관련 국제협약, 도구, 표준은 아래와 같다.

세상을 변화시키다 : 지속가능한발전목표(SDGs) 2015를 포함한 지속가능한 발전(A/RES/70) 정치 선언을 위한 2030 아젠다

19. 우리는 세계인권선언과 아울러 인권 및 국제법 관련 다른 국제 기구의 중요성을 재확인한다. 우리는 유엔 헌장에 따라, 인종, 피부색, 성별, 언어, 종교, 정치적 성향 또는 의견, 국가 또는 사회적 출신, 재산, 출생, 장애 또는 기타 지위에 대한 어떠한 종류의 차별 없이, 모두의 인권과 기본적 자유를 존중, 보호, 증진할 모든 국가의 책임을 강조한다.

20. 성 평등과 여성과 여자어린이에 대한 권한의 부여는 모든 목표와 대상을 포괄한 발전에 결정적인 기여를 할 것이다. 만약 인류의 절반이 충분한 인권과 기회의 충족을 지속적으로 거부당한다면, 인간의 잠재력과 지속가능한 개발의 성취는 불가능할 것이다. 여성과 여자어린이들은 양질의 교육, 경제적 자원, 정체적 참여 뿐 아니라, 모든 수준에서의 고용, 리더십, 의사결정에 남성 및 남자아이들과 동등한 기회를 갖고 동등하게 접근할 수 있어야 한다. 우리는 성별 격차를 없애고 세계적, 지역적, 국가적 수준에서 여성의 권한 강화 및 성 평등 관련한 기관에 대한 지원 강화를 위한 유의미한 투자 증가를 위해 노력할 것이다. 남성과 남자어린이의 참여에 의한 것을 포함하여 여성과 여자어린이에 대한 모든 형태의 차별과 폭력이 제거될 것이다. 이러한 아젠다 실행을 위해서는 체계적인 성 주류화가 중요하다.

25. 우리는 유아, 초등, 중등, 고등, 기술, 직업교육 등 모든 수준에서의 포괄적이고 형평성있는 양질의 교육을 제공할 것을 약속한다. 모든 사람들은 성, 연령, 인종, 또는 민족에 관계없이 그리고 장애인, 이민자, 이주민, 아동·청소년, 특히 취약한 상황에 있는 사람들은, 기회 활용 및 온전한 사회 참여를 위해 필요한 지식 및 기술 습득에 도움이 되는 평생학습기회를 가질 수 있어야 한다. 우리는 아동·청소년들에게 자신의 권리와 책임의 충분한 실현을 위한 양육환경을 제공하여, 안전한 학교와 결속력 있는 지역사회와 가족을 통한 것을 포함한, 인구배당효과(Demographic Dividend)(번역자주 : 전체 인구에서 생산가능인구 비율이 증가하면서 경제성장률이 높아지는 현상)를 거둘 수 있도록 지원할 것이다.

26. 우리는 모든 사람들의 육체적, 정신적 건강과 복지 증진과 평균 수명 연장을 위해, 보편적인 건강 보험 혜택 및 양질의 건강관리 서비스를 달성해야 한다. 그 누구도 뒤쳐져서는 안 된다. 우리는 2030년 전에, 모든 예방 가능한 사망을 종식함으로써 현재까지 이룩한 신생아, 아동 및 모성 사망률의 감소를 가속화할 것을 약속한다. 우리는 가족계획, 정보, 교육을 포함하여, 성 및 재생산 건강 관리 서비스에 대한 보편적인 접근 보장을 약속한다.

지속가능개발목표(SDGs)

SDG3 : 건강한 삶의 보장과 모든 연령대의 복지 증진

3.3. 2030년까지, 에이즈, 결핵, 말라리아 및 방치된 열대성 질병의 유행을 종식시키고, 간염, 수인성 질병 및 기타 전염병을 방지한다.

3.7. 2030년까지, 가족계획, 정보 및 교육, 생식건강과 국가 전략 및 프로그램의 통합을 포함하여, 성 및 재생산 건강 관리 서비스에 대한 보편적 접근성을 보장한다.

SDG4 : 포괄적이고 형평성있는 양질의 교육 보장과 모두를 위한 평생학습 기회 증진

4.1. 2030년까지, 모든 여자아이와 남자아이들이 자유롭고, 형평성있는 양질의 초등, 중등 교육으로 효과적인 학습 성과를 이룰 수 있도록 한다.

4.7. 2030년까지, 모든 학습자가, 특히 지속가능한 발달과 지속가능한 라이프스타일, 인권, 성 평등, 평화와 비폭력 문화의 증진, 세계 시민의식, 문화다양성 및 지속가능개발에 대한 문화적 기여에 대한 인식을 포함하여, 지속가능한 발달 증진을 위해 필요한 지식과 기술을 습득할 수 있도록 한다.

SDG5 : 성평등 달성과 모든 여성과 여자어린이에게 권한 부여

5.1. 모든 여성과 여자어린이에 대한 모든 형태의 차별을 종식한다.

5.2. 인신매매와 성적착취 및 다른 형태의 착취를 포함하여, 공공 및 민간 부문의 모든 여성과 여자아이들에 대한 모든 형태의 폭력을 제거한다.

5.3. 아동, 조기강제결혼 및 여성할례와 같은 모든 유해한 관행을 제거한다.

5.4. 세계인구개발회의의 결의문과 베이징 행동강령, 이들 회의 결과 문서와 검토 회의에서 동의한 바와 같이, 성 및 재생산 건강 및 권리에 대한 보편적 접근을 보장한다.

SDG10 : 국가 간 불평등 감소

10.3. 동등한 기회 보장과 차별적인 법률, 정책 및 관행을 제거하고 관련하여 적절한 입법, 정책, 행동을 증진 등을 함으로써 결과의 불평등을 감소한다.

SDG16 : 지속가능한 개발을 위해 평화롭고 포용적인 사회를 촉진하고, 모두를 위한 정의에의 접근성을 제공하며, 모든 수준에서 효과적이고, 책임있고, 포괄적인 제도를 구축한다.

16.1. 모든 형태의 폭력과 관련된 모든 곳에서의 사망률을 현저하게 줄인다.

16.2. 아동에 대한 학대, 착취, 인신매매, 모든 형태의 폭력과 고문을 종식한다.

16.b. 지속가능한 발전을 위한 비차별적인 법과 정책을 증진하고 강화한다.

교육 2030 인천 선언, 지속가능한 발전 목표4 실행을 위한 행동 기본틀, 2015 포괄적이고 형평성있는 양질의 교육과 평생학습 지향, 세계교육포럼

포괄적 섹슈얼리티 교육은 지속가능한개발교육(ESD)과 글로벌시민교육(GCED)과 관련하여 제시된다. 교육 2030 아젠더 모니터를 위한 주제별 지표, SDG 목표 4.7:28에 대한 지표(p. 79) : “생활 기술 기반 HIV와 섹슈얼리티 교육을 하는 학교 비율”

63. 지표 전략 : ESD와 GCED를 홍보하고 이들을 시스템 전반에 걸친 개입과 교사훈련, 커리큘럼 개혁, 교육적 지원을 통해, 형식(formal), 비형식(non-formal), 무형식(informal) 교육으로 주류화하는 정책과 프로그램을 개발한다. 여기에는 ESD에 대한 글로벌 행동 프로그램의 시행과, 국가의 경험과 역량을 토대로 하여 인권, 성평등, 건강, 포괄적 섹슈얼리티 교육, 기후변화, 지속가능한 생계, 책임있고 참여하는 시민과 같은 주제를 다루는 것이 포함된다.

HIV 및 에이즈에 대한 정치 선언 : 2030년, 2016년까지 HIV 퇴치와 에이즈 확산 종식 가속화를 위한 일괄 승인(A/RES/70/266)

41. 전 세계적으로 여성과 여자아이들이 전염병 영향을 가장 크게 받으며, 불균형한 돌봄 부담을 지고 있으며, 성 평등 및 여성과 여자아이들에 대한 권한 부여를 향한 진전은 납득할 수 없을 정도로 느리다는 것을 염두에 둘 것, 그리고 여성과 여자아이들이 HIV로부터 자신을 보호하는 능력은 여러가지 요소들로 인해 위협받고 있다. 신체적 요인, 여성과 남성, 남자아이들과 여자아이들 사이의 불평등한 권력관계를 포함한 성 불평등, 불평등한 법적, 경제적, 사회적 지위, 성 및 재생산 건강을 포함한 건강관리서비스에 대한 접근성의 부족, 인신매매, 성폭력, 착취 및 해로운 관행을 포함한 공공 및 민간 영역에서의 모든 형태의 차별에 의해 여성과 소녀들은 HIV로부터 더 큰 위협을 받고 있음을 주목한다.

61.(c). 성 불평등과 젠더에 기반한 학대와 폭력을 없애고, 여성과 청소년, 여자어린이들에게 건강관리 서비스, 그 중에서도 주로 성 및 재생산 건강 서비스를 제공을 통해 HIV 감염 위험으로부터 자신을 보호하는 능력을 높이고, 포괄적인 정보와 교육에의 충분한 접근으로, 여성 자신의 성 및 재생산 건강을 포함하여 섹슈얼리티와 관련한 문제를 스스로 통제하고, 강요, 차별, 폭력이 없이 자유롭게 책임 있게 결정할 권리를 행사할 수 있도록 하며, HIV 감염으로부터 자신을 보호할 수 있는 능력을 높이기 위해, 여성의 권한 부여를 위한 환경을 조성 및 여성의 경제적 자립 강화를 위해 필요한 모든 조치를 취할 것을 약속한다. 그리고 이러한 맥락에서 성 평등 달성을 위한 남성 및 남자어린이의 역할의 중요성을 다시 강조한다.

62.(c). 과학적으로 정확한 연령에 맞는 포괄적이고 문화적 맥락에 따른 교육 확대 노력을 가속화 하여, 성 및 재생산 건강, HIV 예방, 성평등, 여성의 권한부여, 인권, 신체적, 심리적, 사춘기 발달, 남성과 여성의 권력관계에 대한 정보를, 학교 안팎 사춘기 남녀 청소년들의 발달 능력에 맞추어 제공함으로써, 자존감 구축, 정보에 기초한 의사결정과 의사소통, 위험 감소 능력을 구축할 수 있도록 하며, HIV감염으로부터 자신을 보호할 수 있도록 청소년, 부모, 법적 보호자, 돌봄 제공자, 교사, 의료서비스제공자와의 충분한 파트너십으로 서로 존중하는 관계를 형성할 수 있도록 돕는다.

* Endorsed by the UNESCO General Conference (37C/Resolution 12) and acknowledged by the UN General Assembly (A/RES/69/211) as follow up to the UN Decade of ESD.

인권 문서, 규약, 표준

1. 세계 인권 선언(1948)
2. 여성에 대한 모든 형태의 차별 철폐 협약(CEDAW 1979)
3. 아동 권리 협약(1989/90)
4. 경제적, 사회적, 문화적 권리에 관한 국제 규약(1966/76)
5. 장애인 권리 협약(2006)

인권이사회 : 여성에 대한 폭력 근절 노력 가속화 : 남성과 남자어린이가 모든 여성과 여자어린이에 대한 폭력 예방과 대응에 동참하도록 유도. A/HRC/35/L.15 2017

(g) 모든 연령층의 남성과 여성에 대한 정형화된 사회문화적 행동 패턴을 바꾸고, 성 평등과 인권을 토대로 하여, 편견을 없애고 존중하는 관계 형성을 위한 의사결정, 소통, 위험 감소 기술의 촉진과 증진을 위해, 모든 사춘기 및 청소년들의 발달 단계에 맞게, 부모와 법적보호자로부터의 적절한 방향 및 안내와, 관련 이해관계자의 적극적인 참여로, 포괄적 섹슈얼리티 교육을 포함한 교육프로그램과 교육 자료, 형식/비형식교육 교사 연수 프로그램을 충분하고 정확한 정보를 토대로 하여 개발하고 실행한다.

인권이사회 : 여성에 대한 폭력 근절 노력 가속화 : 원주민 여성, 여자어린이를 포함한 여성과 여자어린이에 대한 폭력 예방과 대응 A/HRC/32/Rev.1, 2016

7(c) 포괄적인 섹슈얼리티 교육, 훈련, 합리적이고 적절한 공공사회 서비스 뿐 아니라, 재정적 자원과 관찮은 일자리, 토지 및 기타 재산을 소유하고 접근 및 통제할 수 있는 충분하고 동등한 권리와 여성과 여자어린이의 상속권 보장을 포함하여, 여성들에게 충분하고 동등한 양질의 교육 접근성을 보장하는 사회경제적 정책을 채택하고 이행함으로써, 여성에게 권한을 부여하는 조치, 이 중에서도 여성들의 경제적 자율성을 강화하고 사회에서, 의사결정과정에서의 충분하고 동등한 참여를 보장하는 조치를 취한다.

경제적, 사회적, 문화적 권리 위원회, 성 및 재생산 건강권에 대한 일반적 논평 제22호(경제적, 사회적, 문화적 권리에 대한 국제 규약 제12조) 2016

II.5. 성 및 재생산 건강에 대한 권리에는 자유와 (공식적인) 자격이 수반된다. 자유에는 신체 및 성, 재생산 건강과 관련된 문제에 대한 폭력, 강요, 차별 없는 자유롭고 책임있는 의사결정과 선택을 할 권리가 포함된다. 자격에는 규약 제12조에 따라 모든 사람들이 성 및 재생산 건강에 대한 권리를 충분히 누릴 수 있도록 전체적인 범위에서의 의료시설, 필수품, 서비스 및 정보에 대해 방해받지 않고 접근할 권리가 포함된다.

II.6. 성 건강과 재생산 건강은 구별되지만 서로 밀접한 관련이 있다. WHO가 정의한 바에 따르면, 성 건강은 '섹슈얼리티와 관련한 신체적, 정서적, 정신적, 사회적 복지 상태'이다. ICPD 행동계획에서 설명한 바에 따르면 재생산 건강은 생식 능력과 정보를 토대로 한 자유롭고 책임있는 결정을 내릴 자유와 관련된다. 또한 개인이 자신의 생식 행동에 대해 정보를 토대로 자유롭고 책임있는 의사결정을 할 수 있도록 돕는, 다양한 생식 건강 정보, 필수품, 시설, 서비스에 대한 접근권을 포함한다.

9. 성 및 재생산 건강에 대한 권리의 실현은 정부 또한 규약의 다른 조항에 따른 의무 이행을 필요로 한다. 예를 들어, 교육권(제13, 14 조)과 남성과 여성간의 비차별과 평등에 대한 권리(제2조(2), 3조)와 결합한 성 및 생식 건강에 대한 권리는, 포괄적이고 비차별적이며 증거에 기반하고, 과학적으로 정확한 섹슈얼리티와 생식에 대한 교육 권리를 수반한다.

28. 법과 실행 모두에서, 여성의 권리와 성 평등의 실현은 성 및 재생산 건강 영역에서의 차별적인 법, 정책, 관행의 철폐 또는 개혁을 필요로 한다. 포괄적인 성 및 재생산 건강 서비스, 필수품, 교육 및 정보에 대한 여성의 접근성을 방해하는 모든 장벽의 제거가 필요하다. 임신부 사망과 질병의 비율을 낮추기 위해서는 농촌 및 외진 지역에서의 안전 보장과 낙태 방지를 포함하여 응급 산모 관리와 숙련된 출산 종사자가 필요하다. 의도하지 않은 임신과 안전하지 않은 임신중단 예방을 위해서는, 제한적인 임신중단 법의 자유화, 청소년을 포함하여 여성과 여자아이들의 건강 관리 제공자 훈련을 포함한 안전한 임신중단 서비스와 양질의 임신중단 후 관리에 대한 접근성 보장, 여성의 성 및 재생산 건강에 대한 자기결정권 존중을 포함하여, 모든 개인에게 합리적이고 안전하며 효과적인 피임과 포괄적인 섹슈얼리티 교육을 보장하는 국가의 법 및 정책적 조치가 필요하다.

2016 청소년기 아동 권리의 이행에 관한 아동권리위원회 의 일반적 논평 제20호(CRC/C/GC/20)

33. 레즈비언, 게이, 양성애, 트랜스젠더, 인터섹스 청소년은 일반적으로 가족 및 사회적 지원의 부족 또는 성 및 재생산 건강 서비스와 정보의 부족과 더불어, 학대, 폭력, 낙인, 차별, 괴롭힘, 교육훈련으로부터 배제를 포함한 박해에 직면한다. 극단적인 경우에는 성폭력, 강간, 심지어 죽음의 상황에까지 직면한다. 이러한 경험은 낮은 자존감, 높은 우울증, 자살, 노숙자 비율로 이어져 왔다.

59. 위원회는 청소년의 포괄적인 젠더 및 섹슈얼리티에 대한 정보, 필수품, 서비스에 대한 불평등한 접근이 차별에 해당한다는 점을 강조하면서, 정부에게 청소년을 위한 포괄적인 젠더 및 섹슈얼리티에 민감한 성 및 재생산 건강 정책을 적용할 것을 촉구한다. 그러한 서비스 접근성이 부족한 여자 청소년은 임신 출산 시 사망 또는 심각한 고통 또는 평생에 걸친 피해를 입을 위험이 가장 큰 집단이다. 가족계획, 피임, 응급 피임, 예방, 성매개감염병 감염 진료 및 치료, 상담, 임신 전 관리, 산모 건강 서비스 및 월경 위생을 포함한, 온라인과 직접적인 성 및 재생산 건강 서비스, 정보, 교육에 대한, 자유롭게, 비밀스럽고, 청소년 인지적이고, 비차별적인 접근이 모든 청소년에게 가능해야 한다.

60. 제 3자의 동의 또는 허가 요건과 같은, 성 및 재생산 건강과 권리와 관련한 필수품, 정보, 상담에 대한 장벽이 없어야 한다. 또한 장애가 있거나 레즈비언, 게이, 양성애, 트랜스젠더, 인터섹스 여자 청소년과 여자아이들이 이와 같은 서비스를 이용하는 가운데 경험하는 낙인과 두려움의 장벽을 극복하기 위한 특별한 노력이 필요하다. 위원회는 정부가 인공임신중단을 비범죄화하여 여자아이들이 안전한 임신중단과 임신중단 후 서비스에 접근할 수 있도록 보장하고, 임신 청소년에 대한 최대 이익 보장과, 임신중단 관련 결정에서 항상 임신 청소년의 관점을 경청하고 존중하는 관점을 담은 입법안을 검토할 것을 촉구한다.

61. 과학적 증거, 인권 기준에 맞고, 청소년과 함께 개발하는 것을 토대로 한, 연령에 적합하고, 포괄적이며, 폭넓은 성 및 재생산 건강 교육은 학교 필수 교과과정의 일부여야 하며, 학교 밖 청소년에게도 전달되어야 한다. 조기 임신 및 성병 예방 뿐 아니라 성 평등, 성적 다양성, 성 및 생식 건강에 대한 권리, 책임 있는 가족계획 및 성적 행동, 폭력예방에 대한 주의를 기울여야 한다. 정보는 모든 청소년, 특히 장애 청소년의 접근성을 위해 대안적인 형태의 정보도 가능해야 한다.

인권위원회 : 성적 지향 및 성 정체성을 토대로 한 폭력과 차별로부터 보호 A/HRC/32/L.2/Rev.1(2016)

1. 모든 사람은 존엄성과 권리에 있어 자유롭고 평등하며, 누구나 인종, 피부색, 성별, 언어, 종교, 정치적 또는 기타 의견, 국가 또는 사회적 출신, 재산, 출생 또는 기타 지위 등 종류에 상관없이 모든 사람이 세계 인권 선언에 명시된 모든 권리와 자유를 누릴 권리가 있음을 재확인한다.

2. 성적 지향 또는 성 정체성을 이유로 개인을 상대로 한 전 세계 모든 지역에서의 폭력과 차별 행동을 강력하게 비난한다.

인권위원회 : 인권, 성적 지향, 성 정체성(성 정체성 이후) A/HRC/27/Rev.1(2014)

성적 지향과 성 정체성을 이유로 개인을 상대로 한 전 세계 모든 지역에서의 폭력과 차별 행위에 대한 심각한 우려를 표명하고, 성적 지향과 성 정체성을 근거로 한 폭력과 차별 근절을 위한 국제적, 지역적, 국가적 차원에서의 긍정적인 진전을 환영한다.

CEDAW 일반 권고안 제24호 : 1999년 여성 차별 철폐위원회 제20차 회의에서 채택된 협약 제12조(여성 및 건강) (문서번호 A/54/38/Rev.1,1)

18. 특히 정부는 개인의 사생활과 비밀에 대한 권리를 존중할 수 있도록 적절히 훈련받은 인력과 특별히 고안된 프로그램으로, 여성과 남성 청소년에 대한 성 및 생식 건강 교육 권리를 보장해야 한다.

23. 가족계획과 관련된 모든 정보와 상담을 포함한 청소년 건강 교육에 특별한 주의를 기울여야 한다.>(*이 중에서도 청소년을 위한 건강 교육은 성 평등, 폭력, 성매개 감염병 예방, 재생산 및 성 건강에 대한 권리에 대한 내용을 추가로 다루어야 한다.)

31.(b). 성 및 재생산 건강 영역, 특히 HIV/AIDS를 포함한 성매개 감염병 예방과 치료를 위한 청소년 대상의 자원과 프로그램 배분과, 여성의 건강서비스, 교육, 정보 접근에 대한 모든 장벽의 제거를 보장한다.

장애인 권리 협약(2006)

제5조 평등과 차별금지 : 1. 정부는 모든 사람이 법 앞에서 법 아래에서 평등하며 어떤 차별도 없이 동등한 보호와 동등한 법의 혜택을 받을 자격이 있음을 인정한다. 2. 정부는 장애를 근거로 한 모든 차별을 금지하고, 장애인을 위해 모든 차별에 대한 평등하고 효과적인 법적 보호를 보장한다.

제24조, 교육 : 정부는 장애인의 교육권을 인정한다. 1. 차별 없는 평등한 기회를 바탕으로 한 권리 실현을 위해 정부는 모든 수준에서의 포괄적인 교육 체계와 직접적인 평생학습을 보장해야 한다 : (a) 인간의 존엄과 자아존중감에 대한 인간 잠재력과 감수성의 충분한 개발과, 인권, 기본적 자유, 인간 다양성에 대한 존중 강화

1995년 제 4차 세계여성회의의 베이징 선언 및 행동강령과 검토 회의 결과 문서

여성, 여자어린이, HIV와 AIDS 결의안 60/2 여성 지위 위원회 E/CN.6/2016/22 2016

9. 성 불평등과 젠더 기반 학대 및 폭력을 제거할 것, 특히 건강관리 및 서비스 제공, 이 중에서도, 성 및 재생산건강 관리, 포괄적 정보 및 교육에의 충분한 접근을 통해, 이 중에서도 특히 성 및 재생산 건강관리 뿐 아니라 포괄적인 정보와 교육에의 접근성을 포함한 건강관리 서비스 제공을 통해, 여성 및 여자청소년들이 HIV 감염으로부터 스스로를 보호할 수 있는 능력을 높이고, 여성들이 성 및 재생산 건강을 포함한 섹슈얼리티 관련 문제에 대해 강요, 차별, 폭력 없이 통제할 수 있는 권리와 자유롭고 책임 있게 결정할 수 있는 권리를 보장할 것, 여성의 권한 부여를 위한 환경 조성 및 경제적 독립의 강화에 필요한 조치를 취할 것, 이 같은 맥락에서, 성 평등 달성에서의 남성과 남자어린이의 역할의 중요성을 강조할 것을 정부에 촉구한다.

11. 과학적으로 정확하고 연령에 적합한 포괄적인 교육을 문화적 맥락에 따라 확대하기 위한 노력을 가속화할 것을 정부에 촉구한다. 이러한 노력은 남녀 청소년에게, 학교 안팎에서, 그들의 발달단계에 따라, 청소년들이 HIV 감염으로부터 자신을 보호할 수 있도록, 자존감, 정보에 기초한 의사결정, 소통, 위험 감소 기술을 형성하고, 청소년, 부모, 법적보호자, 돌봄제공자, 교사, 보건 의료제공자와의 충분한 파트너십으로 존중하는 관계를 개발할 수 있도록, 성 및 재생산 건강, HIV 예방, 성 평등과 여성의 권한 부여, 인권, 신체적, 심리적, 사춘기 발달과 남녀 간의 권력관계에 대한 정보를 제공한다.

여성과 여자아이들을 위한 새천년 개발 목표 이행에서의 도전과 성과, 2014년 여성 지위 위원회에서 합의된 결론

(o) 인구 및 개발에 관한 국제회의에서의 행동 계획과 베이징 행동강령 및 그들의 검토 회의 결과 문서에 따라, 인권은 강압, 차별, 폭력으로부터 자유로운 성 및 재생산 건강을 포함하여, 섹슈얼리티와 관련된 문제에 대해 자유롭고 책임 있게 통제하고 결정할 권리를 포괄한다는 인식으로, 정책 및 법률 체계의 개발 및 집행과 보편적으로 접근 가능하고 이용 가능한 양질의 포괄적인 성 및 재생산 건강관리 서비스, 필수품, 정보와 교육, 이 중에서도 특히 안전하고 효과적인 현대적 피임 방법, 응급 피임, 청소년 임신 예방 프로그램, 숙련된 출산 종사자와 산과적 누관 및 다른 임신출산 합병증을 줄이는 응급한 조기 출산 관리와 같은 모성건강관리, 국가법에 의해 서비스가 허용되는 곳에서의 안전한 인공임신중단, 생식기 감염, 성병, HIV 생식기 암 예방과 치료를 포함한 정보와 교육을 할 수 있도록 건강 시스템을 강화함으로써, 모든 여성의 인권, 성 및 재생산 건강, 재생산권에 대한 증진과 보호를 보장한다.

(x) 모든 연령대의 남성과 여성의 사회문화적 행동 패턴을 수정하고, 편견을 제거하고, 정보에 기초한 의사결정, 소통, 위험 감소 기술을 증진하고 존중하는 관계 구축을 위해서는, 충분하고 정확한 정보와, 섹슈얼리티에 대한 포괄적 성과와, 성 평등 및 인권, 형식, 비형식 교육을 위한 교사교육훈련프로그램에 기반하여, 청소년의 발달 단계에 맞고, 부모 및 법적 보호자가 제공하는 적절한 방향 및 안내에 따라, 아동, 청소년, 청년, 지역사회의 참여, 여성, 청소년, 관련 비영리조직과의 협력하는 방법으로, 모든 청소년과 청년을 위한 교육 프로그램과 교육 자료를 개발하고 실행한다.

세계인구개발회의(ICPD) 결의문(PoA), 추가 이행을 위한 주요 행동 및 검토회의 결과 문서

결의문 2014/1, 세계인구개발회의의 결의문(PoA) 이행 상태 평가, 인구개발위원회, 2014

11. 보건 시스템 강화, 양질의 통합적이고 포괄적인 성 및 재생산 건강 서비스에 대한 형평하고 보편적인 접근성, 그리고 청소년 및 청년들에게 성 및 재생산 건강에 대한 충분하고 정확한 정보 및 교육 접근성을 보장함으로써, 예방 가능한 모성 질병 및 사망률을 낮춘다. 성 및 재생산 건강과 재생산권을 포함하여, 끈질기게 지속되고 있는 차별적 법과 불공정하고 차별적인 법의 적용에 대해 다룸으로써, 인간의 섹슈얼리티에 대한 증거에 기반한 포괄적 교육과, 인권, 특히 여성과 여자아이들의 인권의 증진, 존중, 보호, 이행을 포함하여, 결의문(PoA) 이행에서 부족한 부분에 특별한 주의를 기울일 것을 정부, 국제사회, 기타 모든 이해관계자들에게 촉구한다.

결의문 2012/1 청소년과 청년. 인구개발위원회, (2012)

26. 정부에 촉구한다, 청소년의 전폭적인 참여, 국제사회의 지원으로, 청소년들의 재생산 건강 서비스, 정보와 교육을 한다. 청소년들의 사생활과 비밀을 충분히 존중함으로써 차별 없이 충족시키고, 청소년들이 자신의 섹슈얼리티에 대해 긍정적이고 책임 있게 대처할 수 있도록, 증거에 기반하여 인간의 섹슈얼리티, 성 및 재생산 건강, 인권, 성 평등에 대한 포괄적인 교육을 제공할 것을 촉구한다.

세계인구개발회의(ICPD)+5 (1999)

63. (i) 어떠한 경우에도 가족계획방법으로 인공임신중단을 증진해서는 안된다. 모든 정부와 관련 정부간 기구와 비영리조직은 여성의 건강에 대한 자신의 책무를 강화하고, 안전하지 않은 임신중단이 건강에 미치는 영향을 주요한 공공 건강 문제로 다루고, 확대 개선된 가족계획 서비스를 통해 인공임신중단 의지를 감소할 것을 촉구한다. 원치 않는 임신 예방을 언제나 최우선 과제로 삼아야 하며, 낙태의 필요성을 없애기 위한 모든 시도가 이루어져야 한다. 원치 않는 임신을 한 여성은 신뢰할 수 있는 정보와 따뜻한 상담에 쉽게 접근할 준비가 되어야 있어야 한다. 건강 체계 내에서의 인공임신중단과 관련된 모든 조치 또는 변화는 국내 입법 절차에 따라 국가 또는 지역 수준에서만 결정될 수 있다. 임신중단이 법에 위배되지 않는 상황에서의 임신중단은 안전해야 한다. 모든 경우에서, 여성은 임신중단로 인한 합병증 관리를 위한 양질의 서비스에 접근할 수 있어야 한다. 임신중단 후 상담, 교육, 가족계획 서비스는 신속히 제공되어야 하며, 이는 반복적인 임신중단을 피하는데 도움이 될 것이다.

(ii) 정부는 여성이 임신중단을 피하도록 적절한 조치를 하고, 어떤 경우에도 이러한 조치가 가족계획방법으로서 홍보되어서는 안되며, 임신중단에 의지해 온 여성에게 어떠한 경우라도 인도적인 치료와 상담을 제공해야 한다.

(iii) 위의 내용을 인식하고 이행하는데 있어서, 그리고 임신중단이 법에 위배되지 않는 상황에서는, 건강 시스템이 의료서비스 제공자의 훈련과 장비를 갖추도록 해야 하며, 그러한 임신중단이 안전하고 접근 가능하다는 것을 확인할 수 있는 다른 조치를 취해야 한다. 여성의 건강을 지키기 위한 추가적인 조치를 취해야 한다.

지역 자료

동 아프리카와 남 아프리카(ESA) 청소년을 위한 포괄적인 섹슈얼리티, 성 및 재생산 건강 서비스에 대한 관료의 책무, (2013)

3.0. 위의 고려사항을 바탕으로, 우리 교육 및 건강 관료들은, ESA 지역에서 양질의 포괄적인 섹슈얼리티 교육과 청소년 친화적인 성 및 재생산 건강 서비스를 보장하기 위해 대담한 행동으로 이끌 것이다.

3.1. 특히 우리는 모든 청소년들에게 포괄적인 섹슈얼리티 교육과, HIV에 대한 우리 국가의 대응을 강화하고 새로운 HIV/성매개 감염병 감염, 조기 및 원치 않는 임신을 줄이고, 특히 HIV 감염자를 위한 돌봄과 지원을 강화하는, 청소년 친화적인 성과 재생산 서비스 제공을 위한 공동 의제를 위해 함께 협력하는 데 전념할 것이다. 기존 지역 경제 공동체인 EAC, SADC, ECSA를 통해 부문간 조정 메커니즘을 수립할 것이다. 이러한 메커니즘이 이미 존재하는 곳에서는 이를 더욱 강화하고 지원하게 될 것이다.

3.5. 대부분의 청소년들이 사춘기에 도달하기 전, 성적으로 활발해지기 전에, 그리고 HIV 전염 또는 원치 않는 임신 위험이 증가하기 전인, 초등교육 기간에 연령에 맞는 CSE를 시작하고 확장한다. 합의된 국제 표준을 사용하여, CSE가 연령, 성별, 문화적으로 적절한지, 권리에 기반해 있는지, 그리고 성년기 준비로서 지식, 기술, 가치에 대한 주요 요소가 포함되어 있는지, 섹슈얼리티, 관계, 성 평등, 성 및 재생산 건강, 시민의식에 대한 의사결정 내용이 포함되어 있는지를 확인한다. 가능하다면, 학교 내 CSE 프로그램을 교육과정 안에서 시험을 볼 수 있게 한다.

3.6. CSE와 성 및 재생산 건강 프로그램 기획과 제공에는 지역사회, 가족, 특히, 청소년, 청년, 시민사회와 신앙 조직을 포함한 기타 지역사회 조직의 충분한 참여가 포함되도록 해야 한다. 동시에 청소년들에게는 안전한 공간, 지역사회에서 변화에 대해 그들 자신이 옹호자 및 대리인이 되고, 자신의 필요를 충족시키는 우수 혁신 사례를 추천할 권리가 보장되어야 한다.

3.7. 연령에 맞는 접근, 그리고 콘돔, 피임, HPV 백신, HIV 상담 및 검사(HCT), HIV/성매개 감염병 치료 및 관리, 가족계획, 안전한 인공 임신중단(합법적인 곳에서), 인공임신중단 후 관리, 안전한 출산, 모자수직감염(PMTCT), 기타 학교 안팎에서의 청소년에 대한 다른 서비스를 포함한, 가장 양질의 성 및 재생산 건강 서비스 제공 및 필수품을 포착하기 위해서는, 사회문화적 배경을 고려한 청소년 친화적인 HIV 및 성 및 재생산 건강 서비스를 통합하고 확장한다.

3.9. 남녀 아이들과 남녀 청소년을 위한 입법 및 기타 서비스에 대한 충분하고 평등한 접근성 보장과 함께, 성 및 다른 형태의 폭력, 학대, 착취를 학교 안팎과 지역사회 맥락에서 다루기 위한 조치를 포함하여, 교육과 건강 서비스 내에서의 성 평등과 권리를 강화한다.

중남미 지역 인구개발회의 제 1차 회의, 캐리비안 권리 기반 지속가능한 개발에 평등을 인구 역학적으로 완전 통합 : 2014년 이후 카이로 행동 계획의 핵심(인구개발에 관한 몬테비데오 합의), UNECLAC(2013)

11. 연령 발달 단계에 맞추어 인간관계의 정서적 측면과, 참여적, 문화상호적, 성인지적인 것에서부터 인권감수성까지, 청소년들의 섹슈얼리티와 관련하여 정보에 근거한 결정을 인식하는 포괄적인 섹슈얼리티 교육 프로그램에 대한 효과적 실행을 유아기부터 할 수 있도록 보장한다.

12. 성별, 인권, 세대 및 문화적 관점에서 청소년 친화적인 성 건강, 생식 건강 서비스를 포함한, 사춘기 및 청소년을 위한 포괄적, 시의적절, 양질의 성 건강 및 재생산 건강 프로그램을 실행한다. 이는 안전하고 효과적인 현대적 피임법에 대한 접근성을 보장하고, 청소년으로 하여금 자신의 성적 권리와 재생산 권리를 행사할 수 있도록 하며, 책임감을 갖고 즐겁고 건강한 섹스 생활을 할 수 있고, 조기 및 원치 않는 임신과, HIV 및 다른 성매개 감염병(STIs) 감염을 예방하고, 성 및 재생산 생활, 자신의 성적 지향의 행사와 관련하여 정보에 입각한 책임있는 결정을 할 수 있도록 한다.

14. 정서적 발달과 섹슈얼리티에 대한 포괄적인 교육을 통해 청소년 임신 예방과 안전하지 않은 인공임신중단을 제거하고, 처방전 및 남녀 콘돔 없는 비상 구강 피임법을 포함한 양질의 정보와 상담, 기술과 서비스를 위한 시의적절하고 비밀스러운 접근에 최우선 순위를 둔다.

2014년 이후 아프리카 인구개발에 관한 Addis Ababa 선언 (2013)

40. 학교 안팎에서, 부모, 지역사회, 전통적, 종교적 오피니언 리더들, 청소년 자신들과 함께, 성 및 재생산 건강 서비스와 관련된 포괄적 섹슈얼리티 교육 프로그램을 채택하고 시행한다.

제6차 아시아태평양양인구회(APPC) ICPD 검토(2013)

59. 청소년들로 하여금 책임감 있고 정보에 기초한 의사결정을 하고, 자신의 섹슈얼리티의 모든 측면을 통제하고, 원치 않는 임신, 안전하지 않은 인공임신중단, HIV와 성매개 감염병으로부터 자신을 보호할 권리를 행사하고, 관계에서의 관용, 상호 존중, 비폭력의 가치를 증진하고, 부모로서, 교사로서, 동료 교육자로서의 역할과 책임을 인식하면서 그렇게 하도록 지원하고 자신의 삶을 계획하기 위해서는, 발달 능력과 연령에 맞는 증거 기반의 포괄적인 섹슈얼리티 교육과 라이프 스킬이 필수적이다.

113. 모든 수준에서의 여자아이들을 위한 무상 교육의 제공, 성 및 재생산 건강 정보 서비스와 조기 및 강제 결혼을 근절하기 위한 노력을 우선순위로 한다.

146. 발달 능력과 연령에 맞고, 부모의 역할과 책임을 인식하면서, 섹슈얼리티, 성 평등, 인권, 관계와 성 및 재생산 건강에 대한 정확한 정보를 제공하는, 포괄적인 섹슈얼리티 교육 프로그램 기획, 충분한 자원 확보와 실행.

부록 II. CSE 자문 그룹 참가자 명단 2016-2017

Name	Organization
Qadeer BAIG	Rutgers WPF (former)
Doortje BRAEKEN	International Planned Parenthood Federation (IPPF) (former)
Shanti CONLY	United States Agency for International Development (USAID) (former)
Esther CORONA	World Association of Sexology
Helen CAHILL	University of Melbourne
Pia ENGSTRAND	Swedish International Development Cooperation Agency (Sida)
Nyaradzayi GUMBONZVANDA Nicole	Rozaria Memorial Trust; African Union Goodwill Ambassador on Ending Child
HABERLAND	Marriage Population Council
Wenli LIU	Beijing Normal University
Anna-Kay MAGNUS-WATSON Peter	Ministry of Education, Jamaica
MLADENHOV	Y-Peer
Sanet STEENKAMP	Ministry of Education, Namibia
Remmy SHAWA	Sonke Gender Justice (former)
Aminata TRAOR SECK	Ministry of Education, Senegal
Alice WELBOURN	Salamander Trust
Christine WINKELMANN	Die Bundeszentrale f r gesundheitliche Aufkl rung (BZgA)

UN Partners:

UNAIDS	Aurelie ANDRIAMIALISON, Kreena GOVENDER, Hege WAGAN
UNDP	Caitlin BOYCE, Natalia LINOU, Suki BEAVERS Ilya ZHUKOV, Maria BAKAROUDIS, Elizabeth BENOMAR
UNFPA	Susan KASEDEDE, Abdelkader BACHA, Vivian LOPEZ, Myungsoo CHO, Sudha
UNICEF	Balakrishnan
UN Women	Nazneen DAMJI, Elena KUDRAVTSEVA
WHO	Venkatraman CHANDRA-MOULI
UNESCO	Chris CASTLE, Joanna HERAT, Jenelle BABB, Karin NILSSON, Christophe CORNUT, Yong Feng LIU, Xavier HOSPITAL, Patricia MACHAWIRA, Mary Guinn DELANEY, Tigran YEPOYAN, Hongyan LI, Alice SAILI

부록 III. 유네스코 이해관계자 및 자문 그룹 회의 참가자 명단

Consultation on updating International technical guidance on sexuality education (ITGSE)

25-27 October 2016

UNESCO International Institute for Educational Planning, Paris, France

Maria-Antonieta Alcalde

International Planned Parenthood Federation/Western Hemisphere Region (IPPF/ WHR)
United States of America

Aurelie Andriamialison

Joint United Nations Programme on HIV and AIDS (UNAIDS)
Switzerland

Ben Aliwa

Save the Children
Republic of South Africa

Jenelle Babb

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
France

Qadeer Baig

Rutgers WPF
Pakistan

Maria Bakaroudis

United Nations Population Fund (UNFPA)
East and Southern Africa

Diane Bernard

University of Oxford
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Margaret Bolaji

Population and Reproductive Health Initiative
Nigeria

Elisa Bonilla-Ruis

Secretaria de Education
Mexico

Doortje Braeken

International Planned Parenthood Federation (IPPF) United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Helen Cahill

University of Melbourne
Australia

Chris Castle

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
France

Nicole Cheetham

Advocates for Youth
United States of America

Christophe Cornu

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
France

Esther Corona

World Association for Sexual Health (WAS)
Mexico

Nazneen Damji

The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women)
United States of America

Mary Guinn Delaney

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
Chile

Stephanie Dolata

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
International Institute for Educational Planning France

Pia Engstrand

Swedish International Development Cooperation (SIDA)
Sweden

Eleonor Faur

Universidad Nacional, San Martin
Argentina

Iehente Foote

Global Youth Coalition
Canada

Hayley Gleeson

International Planned Parenthood Federation (IPPF) United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Nyaradzayi Gumbonzvanda

Rozaria Memorial Trust (former World YWCA) Zimbabwe

Nicole Haberland

Population Council
United States of America

Joanna Herat

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
France

Xavier Hospital

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
Senegal

Alan Jarandilla Nu ez

The PACT, Youth Coalition
Bolivia (Plurinational State of)

Temir Kalbaev

Kyrgyz Indigo
Kyrgyzstan

Jane Kato-Wallace

Promundo
Cabo Verde

Jean Kemitare

Raising Voices
Uganda

Sarah Keogh

Guttmacher Institute
United States of America

Evert Kettering

Independent Consultant
The Netherlands

Thanomklang Kornkaew

Ministry of Education
Thailand

Hongyan Li

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
China

Wenli Liu

Beijing Normal University
China

Patricia Machawira

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
Eastern Southern Africa

Anna-Kay Magnus Watson

Ministry of Education
Jamaica

Vincent Maher

Irish Aid
Ireland

Manak Matiyani

YP Foundation
India

Kristien Michielsens

International Centre for Reproductive Health (ICRH), University of Ghent
Belgium

Beth Miller-Pittman

Education Development Center (EDC)
United States of America

Peter Mladenov

Y-Peer
Bulgaria

Paul Montgomery

University of Oxford
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Venkatraman Mouli-Chandra

World Health Organization (WHO)
Switzerland

Rita Muyambo

World Young Women's Christian Association (World YWCA)
Switzerland

Alan Jarandilla Nu ez

The PACT, Youth Coalition
Bolivia (Plurinational State of)

Hans Olsson

Swedish Association for Sexuality Education (RFSU)
Sweden

Alice Saili

United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization (UNESCO)
Zimbabwe

Josephine Sauvarin

United Nations Population Fund (UNFPA)
Asia Pacific

Remmy Shawa

Sonke Gender Justice
Zambia

Saipan Sripongpankul

Ministry of Education
Thailand

Marina Todesco

United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization (UNESCO)
France

Aminata Traor Seck

Ministry of National Education
Senegal

Alice Welbourn

Salamander Trust
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Christine Winkelmann

Bundeszentrale f r gesundheitliche Aufkl rung (BZGA)
Germany

Susan Wood

International Women's Health Coalition (IWHC) United States
of America

Tigran Yepoyan

United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization (UNESCO)
Russian Federation

Justine Sass

United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization (UNESCO)
France

Jihad Zahir

Y-Peer
Morocco

Ilya Zhukov

United Nations Population Fund (UNFPA)
United States of America

부록 IV. 평가연구 및 평가방법의 선정 기준

2016 성과 검토(옥스퍼드대학 Evidence-Based Intervention센터의 폴 몽고메리와 웬디 크너에 의해 수행)

요소	연구내용
인구	5-18세 아동청소년(체계적 검토 분석에서는 24세까지 포함)
개입	주로 성적 행동, 지식, 태도에 미치는 영향에 초점을 둔(주로 약물 또는 음주와 같은 위험한 행동을 줄이는 목적과는 반대의), 학교, 그룹, 커리큘럼 기반 성병, HIV, 섹슈얼리티, 재생산 건강 또는 관계 교육 개입(라이프 스킬 또는 '가족생활' 프로그램 또는 비슷한 다른 이름으로 사용할 수 있음)
비교개입	다음과 같은 비교 그룹을 통한 연구가 포함됨. 개입없음; 통제집단: 형식과 시간은 같지만 비섹슈얼리티 관련 행동을 목표로 한 교육 개입 동일한 프로그램을 개정된 것과 개정되지 않은 것으로 비교 일반적인 치료 또는 서비스
성과	초등: 행동적/생물학적/건강(예: 성매개 감염병, HIV, 임신, 성적 활동 시작 연령, 콘돔 이용, 기타 피임약, 절제, 성 파트너 비율) 중등: 성적 건강, 성적 위험 행동, 젠더, 자기확신, 자기인식, 사회적 기술에 대한 지식과 태도, 기타 관련된 비생물학적 성과
연구설계	변화 또는 지식/태도/자신감에 영향을 주도록 설계된 프로그램의 효과를 평가하는 통제된 개입만을 포함함. (위에 나열한 성과 측정 참조). 여기에는 무작위 및 준 무작위 통제실험이 포함된다. 우리는 무작위통제실험을, 동전 뒤집기 또는 참가자 바꾸기와 같은, 일정한 편견을 유발할 가능성이 거의 없는 할당 방법을 사용하여 연구자의 무작위 추출을 한 것으로 정의한다. 또한 모든 실험은 동시적인 비교집단을 포함해야 한다.

2008 성과 검토(섹슈얼리티 교육에 대한 국제 기술 지침. 학교, 교사, 건강 교육자를 위한 증거 - 정보 접근 제1권, 섹슈얼리티 교육에 대한 이론적 근거, 유네스코, 2009)

각 연구가 섹스, 관계, HIV/STI 교육 프로그램에 대한 검토에 포함되기 위한 충족 기준은 다음과 같다.

1. 평가된 프로그램은 (a) 커리큘럼 기반, 그룹 기반 성매개 감염병, HIV, 섹스 또는 관계 교육 프로그램이어야 한다.(자발적인 토론, 일대일 상호작용만 하거나 광범위한 학교, 지역사회, 또는 매체 인식 활동만 포함하는 개입과는 대조적으로), 그리고 커리큘럼은 임신과 성병에 대한 보호 방법으로 금욕 이상의 것을 장려하는 것이어야 한다. (b) 주로 성적 행동에 초점을 둔다.(약물, 음주, 폭력, 또는 성적 행동과 같은 다양한 위험 행동을 다루는 것과는 대조적인), 그리고 (c) 미국 외 24세, 미국 내 18세까지의 청소년에게 초점을 둔다. (d) 세계 어디에서나 실행될 수 있어야 한다.
2. 연구방법은 (a) 잘 어울리는 중재와 비교집단, 예비테스트와 사후 테스트 데이터 수집 모두를 포함한 합리적으로 강력한 실험적 또는 준 실험적 설계를 포함해야 한다. (b) 표본 크기는 적어도 100이어야 했다. (c) 다음과 같은 하나 이상의 프로그램 영향을 측정해야 한다.: 성 적 행동, 섹스의 시작, 섹스 회수, 섹스 파트너 수, 콘돔 사용, 피임약 사용, 더 일반적으로는, 성적 위험(예:보호되지 않은 섹스의 빈도), 성병발생비율, 임신 및 출생률에 대한 복합적 측정 (d) 빨리, 최소 3개월 동안 변화 행동에 대한 영향 측정(예: 섹스 빈도, 섹스 파트너 수, 콘돔 사용 회수, 피임 회수, 또는 성적 위험 감소 회수) 또는 덜 빨리, 최소 6개월 동안 변화 행동 또는 결과에 대한 영향 측정(예: 섹스 시작 시기, 임신 또는 성별비율)

3. 1990년 또는 그 이후에 완료되거나 출판된 연구여야 했다. 가능한 포괄하기 위해, 피어리뷰저널(학술저널)에 발표된 연구는 범주에 포함하지 않았다.

검토 방법 :

가능한 전 세계의 많은 학생들에 대한 정보를 파악하기 위해, 몇 가지 과제를 수행하였으며, 그들 중 몇 가지는 2-3년 동안 지속적으로 진행되었다.

1. 기준을 충족하는 연구를 위해 다양한 컴퓨터 데이터베이스를 검토했다.(예 : PubMed, Psychinfo, Popline, Sociological Abstracts, Psychological Abstracts, Bireme, Dissertation Abstracts, ERIC, CHID, Biologic Abstract).

2. Education Training and Research Associates가 완료한 이전 검색 결과를 검토하고 위에 명시한 기준을 충족하는 연구를 확인했다.

3. 다른 사람들이 완료한 이전 리뷰에 요약되어 있는 연구를 검토했다.

4. 이 분야의 연구를 수행한 32명의 연구자에게 연락하여 이전에 발견한 연구 내용을 검토하고 새로운 연구를 제안 및 제공하도록 요청했다.

5. 전문가 검토회의, 살펴본 초록은 저자와 이야기하고 가능할 때마다 연구물을 받았다.

6. 관련 연구물이 있는 12개의 저널을 모두 살펴보았다. 이러한 포괄적인 방법으로 조합으로 위의 기준을 충족하는 109개의 연구물을 검토하여 85개의 프로그램을 평가했다.(일부 프로그램은 여러 개의 논문이 있음)

검토 팀은 성적 행동에 영향을 미치는 아래와 같은 섹슈얼리티 교육 프로그램 수를 확인했다.

	개발도상국 (N=29)	미국 (N=47)	기타 개발도상국 (N=11)	합계 (N=87)	
섹스시작					
시작 지연	6	15	2	23	37%
유의미한 영향 없음	16	17	7	40	63%
시작 촉진	0	0	0	0	0%
섹스 빈도					
빈도수 감소	4	6	0	10	31%
유의미한 영향 없음	5	15	1	21	66%
빈도수 증가	0	0	1	1	3%
섹스 파트너 수					
파트너 수 감소	5	11	0	16	44%
유의미한 영향 없음	8	12	0	20	56%
파트너 수 증가	0	0	0	0	0%
콘돔 사용					
콘돔 사용 증가	7	14	2	23	44%
유의미한 영향 없음	14	17	4	35	60%
콘돔 사용 감소	0	0	0	0	0%
피임법 사용					
피임법 사용 증가	1	4	1	6	40%
유의미한 영향 없음	3	4	1	8	53%
피임법 사용 감소	0	1	0	1	7%
성적 위험 감소					
위험 감소 감소	1	15	0	16	53%
유의미한 영향 없음	3	9	1	13	43%
위험 감소 증가	1	0	0	1	3%

부록 V. 2016 성과 검토에 인용된 연구 목록 일부⁵

(Those marked with * were included in the analysis of systematic reviews and high-quality evaluations.)

* Agbemenu, K. and Schlenk, E. A. 2011. An Integrative Review of Comprehensive Sex Education for Adolescent Girls in Kenya. *Journal of Nursing Scholarship*, 43(1), pp. 54-63. doi:10.1111/j. 15475069.2010.01382.x

Akpabio, I. I., Asuzu, M. C., Fajemilehin, B. R. and Ofi, A. B. 2009. Effects of School Health Nursing Education Interventions on HIV/AIDS-Related Attitudes of Students in Akwa Ibom State, Nigeria. *Journal of Adolescent Health*, 44(2), pp. 118-123.

* Amaugo, L. G., Papadopoulos, C., Ochieng, B. M. N. and Ali, N. 2014. The effectiveness of HIV/AIDS school-based sexual health education programmes in Nigeria: a systematic review. *Health Education Research*, 29(4), 633-648. doi:10.1093/her/cyu002

Borawski, E. A., Tufts, K. A., Trapl, E. S., Hayman, L. L., Yoder, L. D. and Lovegreen, L. D. 2015. Effectiveness of health education teachers and school nurses teaching sexually transmitted infections/human immunodeficiency virus prevention knowledge and skills in high school. *The Journal of School Health*, 85(3), pp. 189-196.

Browne, E. 2015. Comprehensive Sexuality Education (GSDRC Helpdesk Research Report 1226) Birmingham, UK: GSDRC, University of Birmingham.

Carroll, C., Patterson, M., Wood, S., Booth, A., Rick, J. and Balain, S. 2007. A conceptual framework for implementation fidelity. *Implementation Science*, 2(1), 40. doi:10.1186/1748-5908-pp. 2-40

Castro, F. G., Barrera, M., Jr. and Martinez, C. R., Jr. 2004. The cultural adaptation of prevention interventions: resolving tensions between fidelity and fit. *Prevention Science*, 5(1), pp. 41-45.

Chandra-Mouli, V., Svanemyr, J., Amin, A., Fogstad, H., Say, L., Girard, F., and Temmerman, M. 2015. Twenty Years After International Conference on Population and Development: Where Are We With Adolescent Sexual and Reproductive Health and Rights? *Journal of Adolescent Health*, 56(1), S1-6. doi:10.1016/j.jadohealth.2014.09.015

Chau, K., Traor Seck, A., Chandra-Mouli, V., and Svanemyr, J. 2016. Scaling up sexuality education in Senegal: integrating family life education into the national curriculum. *Sex Education*, 16(5), pp. 503-519. doi:10.1080/14681811.2015.1123148

Constantine, N. A., Jerman, P., Berglas, N. F., Angulo-Olaiz, F., Chou, C. P. and Rohrbach, L. A. 2015b. Short-term effects of a rights-based sexuality education curriculum for high-school students: a cluster-randomized trial. *BioMed Central Public*

Health, 15, p. 293. Retrieved from <http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clcentral/articles/662/CN-01109662/frame.html> doi:10.1186/s12889-015-1625-5

Denno, D. M., Chandra-Mouli, V. and Osman, M. (2012). Reaching Youth With Out-of-Facility HIV and Reproductive Health Services: A Systematic Review. *Journal of Adolescent Health*, 51(2), 106121. doi:10.1016/j.jadohealth.2012.01.004

Denno, D. M., Hoopes, A. J. and Chandra-Mouli, V. 2015. Effective strategies to provide adolescent sexual and reproductive health services and to increase demand and community support. *Journal of Adolescent Health*, 56(1 Suppl), S22-41. doi:10.1016/j.jadohealth.2014.09.012

Durlak, J. 2013. The importance of quality implementation for research, practice and policy. Washington, D.C. Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation (ASPE). Retrieved from <https://aspe.hhs.gov/basic-report/importance-quality-implementationresearch-practice-and-policy>.

Edwards, S. 2015. 10 things you didn't know about the world's population. New York, UNFPA. Retrieved from <http://www.unfpa.org/news/10-things-you-didn%E2%80%99t-know-aboutworld%E2%80%99s-population>

* Farb, A. 2013. The federal evaluation of the enhanced healthteacher teenage pregnancy prevention program. *Journal of Adolescent Health*, 52(2 suppl. 1), S59-s60. Retrieved from <http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clcentral/articles/680/CN-01028680/frame.html> doi:10.1016/j.jadohealth.2012.10.139

* Fonner, V. A., Armstrong, K. S., Kennedy, C. E., O'Reilly, K. R., and Sweat, M. D. 2014. School based sex education and HIV prevention in low- and middle-income countries: a systematic review and meta-analysis. *PLoS One*, 9(3), e89692. doi:10.1371/journal.pone.0089692

Fraser, M. 2009. *Intervention Research: Developing Social Programs*. New York, Oxford University Press.

Gardner, F., Montgomery, P. and Knerr, W. 2015. Transporting Evidence-Based Parenting Programs for Child Problem Behavior (Age 3-10) Between Countries: Systematic Review and MetaAnalysis. *Journal of Clinical Child Adolescent Psychology*, 1-14. doi:10.1080/15374416.2015.1015134

Goesling, B., Colman, S., Scott, M., and Cook, E. 2014. Impacts of an Enhanced Family Health and Sexuality Module of the HealthTeacher Middle School Curriculum. Princeton, NJ: Mathematica Policy Research. Retrieved from <http://www.hhs.gov/ash/oah/oahinitiatives/assets/healthteacher-impact.pdf>.

* Goesling, B., Colman, S., Trenholm, C., Terzian, M., and Moore, K. 2014. Programs to reduce teen pregnancy, sexually transmitted infections, and associated sexual risk behaviors: A systematic review. *Journal of Adolescent Health*, 54(5), 499-507.

⁵ For a full list of the studies referenced as part of the 2008 review, please see the original Guidance (UNESCO, 2009).

- Goldacre, B. 2013. Building evidence into education: UK Department for Education. Retrieved from <http://media.education.gov.uk/assets/files/pdf/b/ben%20goldacre%20paper.pdf>
- * Guse, K., Levine, D., Martins, S., Lira, A., Gaarde, J., Westmorland, W., and Gilliam, M. (2012). Interventions Using New Digital Media to Improve Adolescent Sexual Health: A Systematic Review. *Journal of Adolescent Health*, 51(6), pp. 535-543. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jadohealth.2012.03.014>
- * Haberland, N. A. 2015. The case for addressing gender and power in sexuality and HIV education: a comprehensive review of evaluation studies. *International Perspectives on Sexual and Reproductive Health*, 41(1), pp. 31-42. doi:10.1363/4103115
- Haberland, N. and Rogow, D. 2015. Sexuality Education: Emerging Trends in Evidence and Practice. *Journal of Adolescent Health*, 56(1), S15-21. doi:10.1016/j.jadohealth.2014.08.013
- Harden, A., Brunton, G., Fletcher, A., Oakley, A., Burchett, H. and Backhans, M. 2006. Young people, pregnancy and social exclusion: A systematic synthesis of research evidence to identify effective, appropriate and promising approaches for prevention and support. London, EPPI-Centre, Social Science Research Unit, Institute of Education, University of London. Retrieved from <http://eprints.ioe.ac.uk/5927/1/Harden2006Youngpeople.pdf>
- Herat, J., Hospital, X., Kalha, U., Alama, A., and Nicollin, L. 2014. Missing the Target: Using Standardised Assessment Tools to Identify Gaps and Strengths in Sexuality Education Programmes in West and Central Africa. Paper presented at the 20th International AIDS Conference, Melbourne.
- * Hindin, M. J., Kalamar, A. M., Thompson, T.-A. and Upadhyay, U. D. 2016. Interventions to Prevent Unintended and Repeat Pregnancy Among Young People in Low- and Middle-Income Countries: A Systematic Review of the Published and Gray Literature. *Journal of Adolescent Health*, 59, S8-S15. doi:10.1016/j.jadohealth.2016.04.021
- Hopewell, S., McDonald, S., Clarke, M. and Egger, M. 2007. Grey literature in meta-analyses of randomized trials of health care interventions. *Cochrane Database Systematic Review*, 2(2).
- Howard, M. N., Davis, J. A. and Mitchell, M. E. 2011. Improving Low-Income Teen Health Behaviors with Internet-Linked Clinic Interventions. *Sexuality Research and Social Policy*, 8(1), pp. 50-57. doi:10.1007/s13178-011-0037-2
- Hunt, F., Castagnaro, K. and Castrejón, E. 2014. Evaluation of the Implementation of the Ministerial Declaration: From Commitment to Action – Advances in Latin America and the Caribbean. New York, International Planned Parenthood Federation (IPPF)/Western Hemisphere Region Inc. Retrieved from <https://www.ippfwhr.org/sites/default/files/Ministerial-DeclarationEvaluation-2012.PDF>.
- Igras, S. M., Macieira, M., Murphy, E. and Lundgren, R. 2014. Investing in very young adolescents' sexual and reproductive health. *Global Public Health*, 9(5), pp. 555-569. doi:10.1080/17441692.2014.908230
- International Planned Parenthood Federation (IPPF). 2016. Sustainable Development Goals and human rights: An introduction for SRHR advocates. London, IPPF. Retrieved from <http://www.ippfen.org/resources/sustainable-development-goals-and-human-rights>.
- * Kennedy, C. E., Fonner, V. A., O'Reilly, K. R. and Sweat, M. D. 2014. A systematic review of income generation interventions, including microfinance and vocational skills training, for HIV prevention. *AIDS – Psychological and Socio-Medical Aspects of AIDS/HIV*, 26(6), 659673.
- Kesterton, A. J. and Cabral de Mello, M. 2010. Generating demand and community support for sexual and reproductive health services for young people: A review of the Literature and Programs. *Reproductive Health*, 7, p. 25. doi:10.1186/1742-4755-7-25
- Kirby, D., Laris, B. and Rolleri, L. 2006. The impact of Sex and HIV Education Programs in Schools and Communities on Sexual Behaviors Among Young Adults. Research Triangle Park, NC, Family Health International. Retrieved from <http://www.sidastudi.org/resources/inmagicimg/dd1054.pdf>.
- Kivela, J., Haldre, K., Part, K., Ketting, E., Baltussen, R. 2014. Impact and cost-effectiveness analysis of the national school-based sexuality education programme in Estonia. *Sex Education*, ol. 14, Iss.1, 2014 <http://www.tandfonline.com/action/showCitFormats?doi=10.1080%2F14681811.2013.813386>
- Lau, A. S. 2006. Making the Case for Selective and Directed Cultural Adaptations of Evidence-Based Treatments: Examples From Parent Training. *Clinical Psychology: Science and Practice*, 13(4), pp. 295-310. doi:10.1111/j.1468-2850.2006.00042.x
- Leijten, P., Melendez-Torres, G. J., Knerr, W. and Gardner, F. 2016. Transported Versus Homegrown Parenting Interventions for Reducing Disruptive Child Behavior: A Multilevel MetaRegression Study. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 55(7), pp. 610-617. doi:<http://dx.doi.org/10.1016/j.jaac.2016.05.003>
- Liberati, A., Altman, D. G., Tetzlaff, J., Mulrow, C., Gøtzsche, P. C., Ioannidis, J. P. A. Clarke C., Devereaux P.J., Kleijnen J. and Moher, D. 2009. The PRISMA Statement for Reporting Systematic Reviews and Meta-Analyses of Studies That Evaluate Health Care Interventions: Explanation and Elaboration. *PLoS Med*, 6(7), e1000100. doi:10.1371/journal.pmed.1000100
- * Lopez, L. M., Bernholc, A., Chen, M. and Tolley, E. 2016. School-based interventions for improving contraceptive use in adolescents. *The Cochrane Library*. doi:10.1002/14651858.CD012249

- Lutz, B., and Small, R. 2014. Cash Transfers and HIV Prevention. New York, UNDP. Retrieved from <http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/discussion-paper--cashtransfers-and-hiv-prevention/>.
- * Maness, S. B. and Bui, E. R. 2013. A Systematic Review of Pregnancy Prevention Programs for Minority Youth in the U.S.: A Critical Analysis and Recommendations for Improvement. *Journal of Health Disparities Research and Practice*, 6(2), pp. 91-106.
- * Manlove, J., Fish, H. and Moore, K. A. 2015. Programs to improve adolescent sexual and reproductive health in the US: A review of the evidence. *Adolescent Health, Medicine and Therapeutics*, 6, pp. 47-79.
- * Mason-Jones, A. J., Crisp, C., Momberg, M., Koech, J., De Koker, P. and Mathews, C. 2012. A systematic review of the role of school-based healthcare in adolescent sexual, reproductive, and mental health. *Systematic Reviews*, 1 (1) (no pagination)(49).
- * Mathews, C., Aaro, L. E., Grimsrud, A., Flisher, A. J., Kaaya, S., Onya, H., Klepp, K. I. 2012. Effects of the SATZ teacher-led school HIV prevention programmes on adolescent sexual behavior: Cluster randomised controlled trials in three sub-Saharan African sites. *International Health*, 4(2), 111-122. Retrieved from <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1016/j.inhe.2012.02.001>
- * Michielsen, K., Chersich, M. F., Luchters, S., De Koker, P., Van Rossem, R. and Temmerman, M. 2010. Effectiveness of HIV prevention for youth in sub-Saharan Africa: Systematic review and meta-analysis of randomized and nonrandomized trials. *AIDS*, 24(8), pp. 1193-1202.
- Mkumbo, K. A. K. and Ingham, R. 2010. What Tanzanian parents want (and do not want) covered in school-based sex and relationships education. *Sex Education*, 10(1), pp. 67-78. doi:10.1080/14681810903491396
- * Napierala Mavedzenge, S. M., Doyle, A. M., and Ross, D. A. 2011. HIV Prevention in Young People in Sub-Saharan Africa: A Systematic Review. *Journal of Adolescent Health*, 49(6), pp. 568-586. doi:<http://dx.doi.org/10.1016/j.jadohealth.2011.02.007>
- O'Connor, C., Small, S. A. and Cooney, S. M., 4. 2007. Program fidelity and adaptation: Meeting local needs without compromising program effectiveness. Madison, WI, University of Wisconsin-Madison/Extension. Retrieved from http://fyi.uwex.edu/whatworkswisconsin/files/2014/04/whatworks_04.pdf
- * Oringanje, C., Meremikwu, M. M., Eko, H., Esu, E., Meremikwu, A. and Ehiri, J. E. 2009. Interventions for preventing unintended pregnancies among adolescents. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, N.PAG-N.PAG. doi:10.1002/14651858.CD005215.pub2
- * Picot, J., Shepherd, J., Kavanagh, J., Cooper, K., Harden, A., Barnett-Page, E., ... Frampton, G. K. 2012. Behavioural interventions for the prevention of sexually transmitted infections in young people aged 13-19 years: a systematic review. *Health Education Research*, 27(3), 495-512.
- Pound, P., Langford, R. and Campbell, R. 2016. What do young people think about their school-based sex and relationship education? A qualitative synthesis of young people's views and experiences. *British Medical Journal Open*, 6(9). doi:10.1136/bmjopen-2016-011329
- Pulerwitz, J., Gortmaker, S. L. and DeJong, W. 2000. Measuring Sexual Relationship Power in HIV/STD Research. *Sex Roles*, 42(7), pp. 637-660. doi:10.1023/a:1007051506972
- Rogow, D., Haberland, N., Del Valle, A., Lee, N., Osakue, G., Sa, Z. and Skaer, M. 2013. Integrating gender and rights into sexuality education: field reports on using It's All One. *Reproductive Health Matters*, 21(41), pp. 154-166. doi:10.1016/s0968-8080(13)41699-3
- Rohrbach, L. A., Berglas, N. F., Jerman, P., Angulo-Olaiz, F., Chou, C. P. and Constantine, N. A. 2015. A Rights-Based Sexuality Education Curriculum for Adolescents: 1-Year Outcomes From a Cluster-Randomized Trial. *Journal of Adolescent Health*, 57(4), 399-406. Retrieved from <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1016/j.jadohealth.2015.07.004>
- Scott, S. and McNeish, D. 2013. School leadership evidence review: using research evidence to support school improvement. Bristol, UK, National Centre for Social Research for CUBec and Dept for Education. Retrieved from <http://www.bristol.ac.uk/medialibrary/sites/cubec/migrated/documents/evidencereview3.pdf>.
- * Shepherd, J., Kavanagh, J., Picot, J., Cooper, K., Harden, A., Barnett-Page, E., ... Price, A. 2010. The effectiveness and cost-effectiveness of behavioural interventions for the prevention of sexually transmitted infections in young people aged 13-19: A systematic review and economic evaluation. *Health Technology Assessment*, 14(7), 1-230.
- Stanton, B., Wang, B., Deveaux, L., Lunn, S., Rolle, G., Li, X., ... Gomez, P. 2015. Assessing the effects of a complementary parent intervention and prior exposure to a preadolescent program of HIV risk reduction for mid-adolescents. *American journal of public health*, 105(3), 575-583. Retrieved from <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1016/j.jadohealth.2015.07.004>
- Stephenson, J. M., Strange, V., Forrest, S., Oakley, A., Copas, A., Allen, E., ... Johnson, A. M. 2004. Pupil-led sex education in England (RIPPLE study): cluster-randomised intervention trial. *The Lancet*, 364(9431), pp. 338-346. doi:10.1016/S0140-6736(04)16722-6

- * Sutton, M. Y., Lasswell, S. M., Lanier, Y. and Miller, K. S. 2014. Impact of Parent-Child Communication Interventions on Sex Behaviors and Cognitive Outcomes for Black/African American and Hispanic/Latino Youth: A Systematic Review, 1988–2012. *Journal of Adolescent Health*, 54(4), 369–384. doi:10.1016/j.jadohealth.2013.11.004
- Svanemyr, J., Amin, A., Robles, O. J., and Greene, M. E. 2015. Creating an enabling environment for adolescent sexual and reproductive health: a framework and promising approaches. *Journal of Adolescent Health*, 56(1 Suppl), S7–14. doi:10.1016/j.jadohealth.2014.09.011
- * Tolji, M. V. 2012. Effectiveness of peer education interventions for HIV prevention, adolescent pregnancy prevention and sexual health promotion for young people: a systematic review of European studies. *Health Education Research*, 27(5), 904–913. doi:10.1093/her/cys055
- UNESCO. 2009. International Technical Guidance on Sexuality Education: An evidence-informed approach for schools, teachers and health educators. Paris, UNESCO. Retrieved from http://data.unaids.org/pub/ExternalDocument/2009/20091210_international_guidance_sex_uality_education_vol_1_en.pdf.
- UNESCO. 2010. Levers of Success: Case Studies of National Sexuality Education Programmes. Paris, UNESCO. Retrieved from <http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001884/188495e.pdf>.
- UNESCO. 2011. School-based sexuality education programmes: A Cost and Cost-Effectiveness Analysis in Six Countries. Paris, UNESCO. Retrieved from <http://www.unesco.org/new/en/hiv-and-aids/our-priorities-in-hiv/sexualityeducation/costing-study/>.
- UNESCO. 2015. Emerging Evidence, Lessons and Practice in Comprehensive Sexuality Education 2015. A Global Review. Paris: UNESCO.
- UNESCO. 2016. Education for people and planet: Creating sustainable futures for all (Global Education Monitoring Report 2016). Paris: UNESCO. Retrieved from <http://gem-report2016.unesco.org/en/home/>.
- UNESCO and UNFPA. 2012. Sexuality Education: A ten-country review of school curricula in East and Southern Africa. Paris, UNESCO and UNFPA. Retrieved from <http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002211/221121E.pdf>.
- UNESCO and UN Women. 2016. Global guidance on addressing school-related gender-based violence. Paris: UNESCO.
- UNFPA-ESA. How effective is comprehensive sexuality education in preventing HIV? Sunninghill. South Africa, UNFPA Eastern and Southern Africa Regional Office.
- UNFPA. 2014. UNFPA Operational Guidance for Comprehensive Sexuality Education: A Focus on Human Rights and Gender. New York, UNFPA. Retrieved from <http://www.unfpa.org/publications/unfpa-operational-guidance-comprehensive-sexualityeducation>
- UNFPA. 2016. Upsurge in sexuality education seen in countries with high HIV rates [Press release]. Retrieved from <http://www.unfpa.org/news/upsurge-sexuality-education-seen-countriesthigh-hiv-rates>
- UNICEF. 2012. Global Evaluation of Life Skills Education Programmes. Final Report. New York, UNICEF.
- UNICEF. 2014. Hidden in Plain Sight: A statistical analysis of violence against children. New York, UNICEF. Retrieved from https://www.unicef.org/publications/index_74865.html.
- USAID. 2012. Making comprehensive sexuality education available at national scale: A case study about tailoring international guidance for Kenya. Washington, DC, USAID. Retrieved from https://www.iywg.org/sites/iywg/files/lessons_learned_sexuality_education_kenya.pdf.
- Underhill, K., Montgomery, P. and Operario, D. 2007. Sexual abstinence only programmes to prevent HIV infection in high income countries: Systematic review. *British Medical Journal*, Vol. 335, No. 7613, pp. 248–248. <http://bmj.com/cgi/content/full/335/7613/248> (Accessed 13 August 2017).
- Villa-Torres, L., and Svanemyr, J. 2015. Ensuring Youth's Right to Participation and Promotion of Youth Leadership in the Development of Sexual and Reproductive Health Policies and Programs. *Journal of Adolescent Health*, 56(1), S51–S57. doi:10.1016/j.jadohealth.2014.07.022
- Visser, M. J. 2005. Life skills training as HIV/AIDS preventive strategy in secondary schools: evaluation of a large-scale implementation process. *SAHARA J: Journal of Social Aspects of HIV/AIDS*, 2(1), 203–216. doi:10.1080/17290376.2005.9724843
- Wang, B., Stanton, B., Deveaux, L., Li, X., Koci, V., and Lunn, S. 2014. The impact of parent involvement in an effective adolescent risk reduction intervention on sexual risk communication and adolescent outcomes. *AIDS Education and Prevention*, 26(6), 500–520.
- WHO. Pakistan Country Synthesis Report: Successful Large-Scale Sustained Adolescent Sexual and Reproductive Health Programmes. Geneva, WHO. (unpublished)
- WHO Regional Office for Europe and BZgA. 2010. Standards for Sexuality Education in Europe. A framework for policy makers, educational and health authorities and specialists. Cologne, BZgA.
- Wight, D. 2011. The effectiveness of school-based sex education: What do rigorous evaluations in Britain tell us? *Education and Health*, 29(4), 72–78.
- Wight, D., and Fullerton, D. 2013. A review of interventions with parents to promote the sexual health of their children. *Journal of Adolescent Health*, 52(1), 4–27. doi:10.1016/j.jadohealth.2012.04.014

부록 VI. 2017년 학습 목표 및, 주요 개념, 주제 업데이트를 위해 진행된 인터뷰 참가자 정보

A total of 16 interviews were conducted to inform findings and recommendations from the ITGSE update process, with a primary focus on CSE content in order to inform the key concepts, topics, and learning objectives section. Learners and teachers were identified as important key stakeholders, as well as additional expert stakeholders.

Eight primary and secondary school learners ages 10-18 were interviewed from Burkina Faso, Kenya, Ghana, the United States and Guatemala. A total of five teachers, including four primary school teachers and one secondary school teacher were interviewed from Algeria, Burkina Faso, Ghana, and India. In addition, three experts from Bangladesh, Algeria and Malawi, with expertise in curriculum development, gender, life skills, and education, took part.

Key informants were contacted by email or phone either directly or through local organizations and contacts. Once informants had agreed to participate, informed consent protocols were followed. In the case of minors, parental consent forms were also developed and translated for parents of learners under the age of 18. Once informed- and parental- consent had been obtained, arrangements were made for calls. Question guides for each category of respondent were developed consisting of a set of pre-determined questions that were used to guide interviews in English, French and Spanish. All the interviews took place by Skype or telephone, except two where the informants completed the questionnaire in writing, scanned, and returned by email. The Skype and telephone interviews ranged in duration from one to one and half hours. Responses were documented and findings were summarized and incorporated into the desk review that informed updates to the Guidance.

Students, primary and secondary

First name	Age	Country
Soubeiga	10	Burkina Faso
Nacro	10	Burkina Faso
Emmanuel	12	Kenya
Vacaecelia	12	Kenya
Sandra	14	Ghana
Caleb	16	United States
Madelyn	18	United States
Ana	18	Guatemala

Teachers

name	School level	Country
Angela Bessah Sagoe	Primary school teacher	Ghana
Sam Talato Sandine Nacro	Primary school teacher	Burkina Faso
Sylvie Kansono	Primary school teacher	Kenya
Sakshi Rajeshirke	Primary school teacher	India
Mohamed Beldjenna	Headmaster and secondary school teacher	Algeria

Other stakeholders

name	Title	Country
Joyce Carol Kasambara	Senior Curriculum Development Specialist	Malawi
Dr. Kamel Bereksi	Pr sident de l'association Sant Sidi El Houari SDH	Algeria
Dr. Rob Ubaidur	Senior Associate and Bangladesh Country Director, Population Council (including oversight of Bangladeshi Association for Life Skills, Income, and Knowledge for Adolescents Project)	Bangladesh

부록 VII. 2017년 학습 목표 및, 주요 개념, 주제 업데이트에 사용된 참고문헌 및 참고자료⁶

References included in desk review

Avni, A. and Chandra-Mouli, V. 2014. Empowering adolescent girls: developing egalitarian gender norms and relations to end violence. *Reproductive Health*, 11: 75. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4216358/>

Bonilla, E. 2016. National Experience of Developing and Delivering Sexuality Education, Mexico. Presentation at the Consultation on updating International Technical Guidance on Sexuality Education (ITGSE), Paris, October 2016. (Unpublished).

Das M., et al. 2012. Engaging Coaches and Athletes in Fostering Gender Equity: Findings from the Parivartan Program in Mumbai, India. New Delhi, ICRW and Futures Without Violence. <https://www.icrw.org/wp-content/uploads/2016/10/Parivartan-Engaging-Coaches-and-Athletes-in-Fostering-Gender-Equity.pdf>

Dupas, P. 2011. Do teenagers respond to HIV risk information? Evidence from a field experiment in Kenya. *American Economic Journal: Applied Economics*, 3(1), 1-34. http://web.stanford.edu/~pdupas/HIV_teenagers.pdf

Future of Sex Education Initiative. 2012. National Sexuality Education Standards: Core Content and Skills, K-12. <http://www.futureofsexed.org/nationalstandards.html>

Future of Sex Education Initiative. 2012. National Teacher Preparation Standards for Sexuality Education Standards. <http://www.futureofsexed.org/documents/teacher-standards.pdf>

Haberland, N. 2010. What happens when programs emphasize gender? A review of the evaluation research. Presentation at Global Technical Consultation on Comprehensive Sexuality Education, 30 November to 2 December, Bogota, Colombia.

Haberland, N. 2015. The case for addressing gender and power in sexuality and HIV education: a comprehensive review of evaluation studies. *International Perspectives Sexual and Reproductive Health*, 41(1), 31-42.

Herat, J., Hospital, X., Kalha, U., Alama, A. and Nicollin, L. 2014. Missing the Target: Using Standardised Assessment Tools to Identify Gaps and Strengths in Sexuality Education Programmes in West and Central Africa. Paper for 20th International AIDS Conference, Melbourne, Australia, 20-25 July, 2014.

International Planned Parenthood Federation. 2010. Framework for Comprehensive Sexuality Education. London,

IPPF. http://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_framework_for_comprehensive_sexuality_education.pdf

Kirby, D., Laris, B., and Roller, L. 2006. The impact of Sex and HIV Education Programs in Schools and Communities on Sexual Behaviors Among Young Adults. New York, Family Health International (FHI). https://www.iywg.org/sites/iywg/files/youth_research_wp_2.pdf

Ministerio de Educaci n Nacional Republica de Colombia 2016. Modulo 2, El Proyecto Pedag gico y sus hilos conductores. http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/articulos-172208_recurso_1.pdf

Ministerio de Educaci n Nacional, Republica de Colombia, et al. 2016. Ambientes Escolares Libres de Discriminaci n. Bogota, Ministerio de Educaci n Nacional. https://unicef.org.co/sites/default/files/informes/Ambientes%20escolares%20Libres%20de%20Discriminacion%20May%202016_0.pdf

Ministry of Drinking Water and Sanitation of the Government of India. 2015. Menstrual Hygiene Management National Guidelines. http://www.mdws.gov.in/sites/default/files/Menstrual%20Hygiene%20Management%20-%20Guidelines_0.pdf

Montgomery, P. and Knerr, W. 2016. Updating the United Nations International Technical Guidance on Sexuality Education: Vol. 2. Evidence and recommendations. Presentation at the Consultation on updating International Technical Guidance on Sexuality Education (ITGSE), Paris, October 2016. (Unpublished).

UNESCO. 2009. International Technical Guidance on Sexuality Education: An Evidence-informed approach for schools, teachers and health educators. Paris, UNESCO. <http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/183281e.pdf>

UNESCO. 2012. Good policy and practice in HIV and Health Education. Booklet 7: Gender equality, HIV, and education. Paris, UNESCO. <http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002187/218793e.pdf>

UNESCO. 2014a. Good policy and practice in health education. Booklet 9: Puberty education and menstrual hygiene management. Paris, UNESCO. <http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002267/226792e.pdf>

UNESCO. 2014b. Comprehensive Sexuality Education: The Challenges and Opportunities of Scaling-Up. Paris, UNESCO. <http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002277/227781e.pdf>

UNESCO. 2015. Emerging Evidence, Lessons and Practice in Comprehensive Sexuality Education: A Global Review. Paris, UNESCO. <http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002431/243106e.pdf>

UNESCO. 2016. Out in the Open: Education Sector Responses to Violence based on Sexual Orientation and Gender Identity/Expression. Paris, UNESCO. <http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002447/244756e.pdf>

⁶ For a full list of the references used in the development of the original Guidance, please see UNESCO, 2009.

UNESCO. 2016. Review of the evidence on sexuality education. Report to inform the update of the UNESCO International Technical Guidance on Sexuality Education. Prepared by Paul Montgomery and Wendy Knerr, University of Oxford Centre for Evidence-Based Intervention. Paris, UNESCO.

UNESCO. 2016. Meeting Notes of the consultation on updating International Technical Guidance on Sexuality Education (ITGSE). Paris, October 2016. (Unpublished).

UNESCO. 2016. Survey Findings: Updating the International Technical Guidance on Sexuality Education. Presentation at the Consultation on updating International Technical Guidance on Sexuality Education (ITGSE). Paris, October 2016. (Unpublished).

UNESCO-IBE and UNESCO Office Yaoundé. 2014. Guide pédagogique pour le développement des compétences en éducation la santé reproductive, au VIH et au SIDA l'usage des formateurs-trices et des enseignants-es 2014. Switzerland, UNESCO-IBE. <http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002294/229421f.pdf>

UNESCO and UN Women. 2016. Global Guidance on Addressing School-Related Gender-Based Violence. Paris/ UNESCO, UNESCO/UN Women. <http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002466/246651E.pdf>

United Nations. 2016. Ending the torment: tackling bullying from the schoolyard to cyberspace. New York, Office of the Special Representative of the Secretary-General on Violence against Children. <http://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/2016/End%20bullying/bullyingreport.pdf>

WHO Regional Office for Europe and BZgA. 2010. Standards for Sexuality Education in Europe. A framework for policy makers, educational and health authorities and specialists. Cologne, WHO. http://www.oif.ac.at/fileadmin/OEIF/andere_Publikationen/WHO_BZgA_Standards.pdf

Regional and National Frameworks/Guidelines and Curricula

Beaumont and Maguire. 2013. Policies for Sexuality Education in the European Union. Brussels: Policy Department C - Citizens' Rights and Constitutional Affairs European Parliament. [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/462515/IPOL-FEMM_NT\(2013\)462515_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/462515/IPOL-FEMM_NT(2013)462515_EN.pdf)

The Caribbean Community Secretariat (CARICOM) and UNICEF. 2010. The Health and Family Life Education Regional Curriculum Framework Ages 5 Years to 12 Years Version 2.1. Bridgetown, UNICEF. <http://www.open.uwi.edu/hflecarribbean/curricula>

Colectivo de Autores 2011. Orientaciones Metodológicas Educación Preescolar, Primaria y Especial. Ministerio de Educación. <http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Havana/pdf/Libro%20Educacion%20de%20la%20sexualidad%201.pdf>

Colectivo de Autores 2011. Orientaciones Metodológicas Educación Secundaria Básica, Preuniversitaria Técnico y Profesional y de Adultos. <http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Havana/pdf/Libro%20Educacion%20de%20la%20sexualidad%202.pdf>

Ministerio de Educación Presidencia de la Nación y Consejo Federal de Educación. 2010. Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral. http://www.me.gov.ar/me_prog/esi/doc/lineamientos.pdf

Ministerio de Educación, El Salvador. 2014. Actualización Curricular de la Educación Integral de la Sexualidad en el Sistema Educativo de El Salvador, con Enfoques de Género y Derechos Humanos (Educación parvularia, primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, y educación media). San Salvador, Ministerio de Educación. <https://www.mined.gob.sv/index.php/noticias/item/7212-educacion-integral-de-la-sexualidad>

Ministerio de Educación, Perú. 2016. Currículo Nacional de la Educación Básica. <http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-2016-2.pdf>

Ministerio de Educación Nacional, República de Colombia 2016. El Proyecto Pedagógico y sus Hilos Conductores. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional. http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/articulos-172208_recurso_1.pdf

Ministerio de Educación Nacional, República de Colombia, et al. 2016. Ambientes Escolares Libres de Discriminación. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional. https://unicef.org.co/sites/default/files/informes/Ambientes%20escolares%20Libres%20de%20Discriminacion%20May%202016_0.pdf

Ministerio de Educación, República de Panamá 2016. Guía de Educación de la Sexualidad para Docentes de Educación Primaria (1º a 6º grado). http://www.prensa.com/sociedad/Conozca-guias-sexualidad-Meduca_0_4525047519.html

Ministerio de Educación, República de Panamá 2016. Guía de Educación Integral de la Sexualidad para Docentes de Educación Premedia y personal técnico de los Gabinetes Psicopedagógicos. http://www.prensa.com/sociedad/EIS-PREMEDIA_LPRFIL20160709_0004.pdf

Ministerio de Educación, República de Panamá 2016. Guía de Educación Integral de la Sexualidad para Docentes de Educación Media y Personal Técnico de los Gabinetes Psicopedagógicos (10mo a 12mo grado). http://www.prensa.com/sociedad/guia-EIS-MEDIA-_meduca-panama_LPRFIL20160709_0003.pdf

Ministry of Drinking Water and Sanitation of the Government of India. 2015. Menstrual Hygiene Management National Guidelines. http://www.mdws.gov.in/sites/default/files/Menstrual%20Hygiene%20Management%20-%20Guidelines_0.pdf

- Ministry of Education, Republic of Trinidad and Tobago. 2009. Secondary School Curriculum. Forms 1-3 Health and Family Life Education. http://www.ibe.unesco.org/curricula/trinidadtobago/tr_ls_lf_2009_eng.pdf
- Ministry of Education and Vocational Training of the United Republic of Tanzania. 2010. National life skills education framework in Tanzania. http://hivhealthclearinghouse.unesco.org/sites/default/files/resources/Tanzania_National_Life_Skills_Education_Framework_Final_Draft.pdf
- Pacific Islands Forum Secretariat. 2009. Pacific Education Development Framework. <http://www.forumsec.org/resources/uploads/attachments/documents/Pacific%20Education%20Development%20Framework%202009-2015.pdf>
- UNESCO-IBE and UNESCO Office Yaoundé. 2014. Guide pédagogique pour le développement des compétences en éducation la santé reproductive, au VIH et au SIDA l'usage des formateurs-trices et des enseignants-es 2014. Switzerland, UNESCO-IBE. <http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002294/229421f.pdf>
- WHO Regional Office for Europe and BZgA. 2010. Standards for Sexuality Education in Europe. A framework for policy makers, educational and health authorities and specialists. Cologne, WHO. http://www.oief.ac.at/fileadmin/OEIF/andere_Publikationen/WHO_BZgA_Standards.pdf
- Reviews, consultations, and studies**
- Agbemenu, K. and Schlenk, E. 2011. An Integrative Review of Comprehensive Sex Education for Adolescent Girls in Kenya. *Journal of Nursing Scholarship*, 43 (1), pp. 54-63. <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1547-5069.2010.01382.x/abstract>
- Acharya, D.R., Van Teijlingen, E.R., and Simkhada, P. 2009. Opportunities and challenges in school-based sex and sexual health education in Nepal. *Kathmandu University Medical Journal*, 7(28), pp. 445-453. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20502093>
- Alcantara, E. (2012). Alcantara, E. 2012. Educación sexual en la escuela como base para la equidad social y de género. UNFPA. <http://countryoffice.unfpa.org/dominicanrepublic/drive/EstadoedlaeducsexualyVBGenlasescuelas310812.pdf>
- Amaugo, L.G., Papadopoulos, C., Ochieng, B. and Ali, N. 2014. The effectiveness of HIV/AIDS school-based sexual health education programmes in Nigeria: a systematic review. *Health Education Research*, 29, 4: pp. 633-648. <http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14681811.2015.1123148?needAccess=true>
- Andrade, H., Brito de Mello, M., Sousa, M., Makuch, M., Bertoni, and N., Fandes. 2009. Changes in sexual behavior following a sex education program in Brazilian public schools. *Cad. Sa de P blica*, Rio de Janeiro, 25(5), pp:1168-1176. http://hivhealthclearinghouse.unesco.org/sites/default/files/resources/santiago_andrade_2009_changes_in_sexual_behavior_in_brazil_public_schools.pdf
- Chau, K., Traor Seck, A., Chandra-Mouli, V. and Svanemyr, J. 2016. Scaling up sexuality education in Senegal: integrating family life education into the national curriculum. *Sex Education: Sexuality, Society and Learning*, 15 (2), pp. 204-216. <http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14681811.2015.1123148>
- Cheney, K. et al. Oosterhoff, P., et al. 2017. Feeling 'Blue': Pornography and Sex Education in Eastern Africa. *IDS Bulletin*, Volume 48, Number 1. UK: Institute of Development Studies.
- Chhabra, R., Springer, C., Rapkin, B., and Merchant. (2008). Differences among male/female adolescents participating in a school-based teenage education program (step) focusing on HIV prevention in India. *Ethnicity and Disease*, 18 (Spring 2008), pp. 123-127. <http://www.ishib.org/ED/journal/18-2s2/ethn-18-02s2-123.pdf>
- Clarke, D. 2010. Sexuality education in Asia: Are we delivering? An assessment from a rights-based perspective. Bangkok, Plan. http://hivhealthclearinghouse.unesco.org/sites/default/files/resources/bangkok_sexualityeducationasia.pdf
- DeMaria, L., Galrraga, O., Campero, L. and Walker, D. 2009. Educación sobre sexualidad y prevención del VIH: Un diagnóstico para América Latina y el Caribe. *Revista Rev Panam Salud Publica*, 26(6), pp. 485-493.
- Government of Southern Australia. 2011. Cyber Safety: Keeping Children Safe in a Connected World. <http://old.decd.sa.gov.au/docs/documents/1/CyberSafetyKeepingChildre.pdf>
- Haberland, N. and Rogow, D. 2015. Emerging trends in evidence and practice. *Journal of Adolescent Health*, 56, pp. S15eS21. <http://www.jahonline.org/article/S1054-139X%2814%2900345-0/pdf>
- Huaynoca, S., Chandra-Mouli, V., Yaqub Jr, N., and Denno, D. 2014. Scaling up comprehensive sexuality education in Nigeria: from national policy to nationwide application. *Sex Education, Sexuality, Society and Learning*, 14(2), pp. 191-209. <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14681811.2013.856292>
- Ismail, S., Shajahan A., Sathyanarayana Rao, T.S., and Wylie, K. 2015. Adolescent sex education in India: Current perspectives. *Indian Journal of Psychiatry*, 57(4), pp. 333-337. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4711229/>

- Ministerio de Educaci n Nacional, Republica de Colombia et al. 2014. Evaluaci n del Programa de Educaci n para la Sexualidad y Construcci n de Ciudadan a – PESCC. https://fys.uniandes.edu.co/site/index.php/component/docman/doc_download/7-informe-evaluacion-programa-de-educacion.../
- Munsi, K. and Guha, D. 2014. Status of Life Skill Education in Teacher Education Curriculum of SAARC Countries. A Comparative Evaluation. *Journal of Educaiton and Social Policy*, 1(1), pp. 93-99. http://jespnet.com/journals/Vol_1_No_1_June_2014/13.pdf
- Rocha, A.C., Leal, C., and Duarte, C. 2016. School-based sexuality education in Portugal: strengths and weaknesses. *Sex Education: Sexuality, Society and Learning*, 16(2), pp. 172-183. <http://dx.doi.org/10.1080/14681811.2015.1087839>
- Schutte, L. et al. 2014. Long Live Love. The implementation of a school-based sex-education program in the Netherlands. *Health Education Research*, 29 (4), pp. 583-597. <https://doi.org/10.1093/her/cyu021>
- UNAIDS. 2016. HIV Prevention among adolescent girls and young women. Geneva: UNAIDS. http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_HIV_prevention_among_adolescent_girls_and_young_women.pdf
- UNESCO. 2012. Good policy and practice in HIV and Health Education. Booklet 7: Gender equality, HIV, and education. Paris, UNESCO. <http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002187/218793e.pdf>
- UNESCO. 2012. Review of Policies and Strategies to Implement and Scale Up/Sexuality Education in Asia and the Pacific. Bangkok, UNESCO. <http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002150/215091e.pdf>
- UNESCO. 2014. Developing an education sector response to early and unintended pregnancy. Paris, UNESCO. <http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230510e.pdf>
- UNESCO. 2015. Emerging evidence and lessons and practice in comprehensive sexuality education review. <http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002431/243106e.pdf>
- UNESCO and UN Women. 2016. Global guidance on addressing School-related gender-based violence. Paris, UNESCO <http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002466/246651E.pdf>
- UNESCO and Radboud University Nijmegen Medical Center. 2011. Cost and Cost effectiveness analysis. School-based sexuality education programs in six countries. Paris, UNESCO. <http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002116/211604e.pdf>
- UNESCO and UNFPA. 2012. A ten-country review of school curricula in East and Southern Africa. Johannesburg, UNESCO. <http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002211/221121E.pdf>
- UNESCO, UNFPA, PEPFAR, USAID, Health Communication Capacity Collaborative. 2015. Comprehensive Sexuality Education in Teacher Training in Eastern and Southern Africa. Johannesburg, UNESCO. http://hivhealthclearinghouse.unesco.org/sites/default/files/resources/cse_in_teacher_training_in_esa.pdf
- UNFPA. 2010. Comprehensive Sexuality Education: Advancing Human Rights, Gender Equality and Improved Sexual and Reproductive Health. A Report on an International Consultation to Review Current Evidence and Experience. Bogot , Columbia. <http://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Comprehensive%20Sexuality%20Education%20Advancing%20Human%20Rights%20Gender%20Equality%20and%20Improved%20SRH-1.pdf>
- UNICEF. 2009. Strengthening Health and Family Life Education in the Region. The Implementation, Monitoring, and Evaluation of HFLE in Four CARICOM Countries. Bridgetown, UNICEF. https://www.unicef.org/easterncaribbean/Final_HFLE.pdf
- UNICEF. 2012. Global Evaluation of Life Skills Education Programmes. New York, UNICEF. https://www.unicef.org/evaluation/files/USA-2012-011-1-1_GLSEE.pdf
- UNICEF. 2013. Menstrual Hygiene Management in Schools in Two Countries of Francophone West Africa: Burkina Faso and Niger Case Studies. https://www.unicef.org/wash/schools/files/MHM_study_report_Burkina_Faso_and_Niger_English_Final.pdf
- UNICEF. 2013. The Status of HIV Prevention, Sexuality and Reproductive Health: Fiji, Kiribati, Solomon Islands and Vanuatu. Suva, UNICEF. https://www.unicef.org/pacificislands/SRH_education_review_report_-_final.pdf
- UNICEF and the Ministry of Education. 2011. An Assessment of the Life-Skills Based Curriculum Project in Lao PDR. Bangkok, UNICEF and Ministry of Education. https://www.unicef.org/eapro/Assessment_of_the_lifeskills.pdf
- UNICEF and Ministry of Education. 2016. Review of Comprehensive Sexuality Education in Thailand. Bangkok, UNICEF. http://hivhealthclearinghouse.unesco.org/sites/default/files/resources/comprehensivesexualityeducationthailand_en.pdf
- Wood, S. and Rogow, D. 2015. Can Sexuality Education Advance Gender Equality and Strengthen Education Overall? Learning from Nigeria's Family Life and HIV Education Program. New York, International Women's Health Coalition. https://iwhc.org/wp-content/uploads/2015/12/Nigeria_FLHE_FINAL-nospreads.pdf
- Wood, L. and Roller, L. 2014. Designing an effective sexuality education curriculum for schools: lessons gleaned from the Southern African literature. *Sex Education: Sexuality, Society and Learning*, 14 (5), pp. 525-542. <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14681811.2014.918540>

부록 VIII. 라이프스킬 기반 HIV 및 섹슈얼리티 교육을 위해 제안된 지표

모든 학교에서의 라이프스킬 기반 HIV와 섹슈얼리티 교육 상황을 평가를 위해, UNESCO와 HIV 및 건강교육에 관한 UNAIDS 기간 과제팀(IATT)이 권고하는 것은, 교육부에서 ‘라이프스킬 기반 HIV 및 섹슈얼리티 교육을 학기 시작 전에 제공하는 학교 비율’을 측정하는 것이다.

이 지표는 정규 커리큘럼 내(독립형 시험 과목 또는 다른 교육과정 과목과의 통합형으로)에 포함되어 있는 라이프스킬 기반 HIV 및 섹슈얼리티 교육 프로그램, 그리고/또는 과외활동의 일부(UNESCO, 2013a)의 일부로서, ‘필수’ 및 ‘희망’ 구성요소 한 세트를 제시한다. 이러한 필수적이고 바람직한 구성요소는 다음과 같다.

주제 / 콘텐츠

일반적인 라이프스킬	
필수 주제	- 의사결정/자기주장 - 의사소통/협상/거절 - 인권 강화
희망 주제	- 수용, 인내, 공감, 비차별 - 기타 일반적인 라이프스킬
성 및 재생산 건강(SRH) / 섹슈얼리티 교육(SE)	
필수 주제	- 인간의 성장과 발달 - 성적 해부학 및 생리학 - 가족생활, 결혼, 대인관계 - 사회, 문화, 섹슈얼리티 : 섹슈얼리티 관련 가치, 태도, 사회적 규범, 매체 - 재생산 - 성 평등과 성 역할 - 성적 학대/원치 않는 또는 강제적인 섹스 저항 - 콘돔 - 성적 행동(성 행위, 쾌락, 감정) - 성매개 감염병 감염 및 예방
희망 주제	- 임신과 출산 - 콘돔 이외의 피임법 - 젠더 기반 폭력과 해로운 관행 / 폭력의 거부 - 성적 다양성 - 성과 재생산건강 서비스 출처/서비스 찾기 - 기타 성과 재생산 건강/섹슈얼리티 교육 관련 내용
HIV 및 AIDS 관련 특정 내용	
필수 주제	- HIV 감염 - HIV 예방 : 콘돔 사용을 포함한 더 안전한 성 행위 - HIV 치료
희망 주제	- HIV 관련 낙인 및 차별 - 상담, 검사 서비스의 출처/ 상담, 치료, 돌봄, 지원 서비스 찾기 - 기타 HIV 및 AIDS 관련 특정 내용

출처 ; UNESCO. 2013a. Measuring the education sector response to HIV and AIDS: Guidelines for the construction and use of core indicators. Paris, UNESCO.

2018 개정판

International technical guidance on sexuality education

국제 성교육 가이드

An evidence-informed approach

The UN International technical guidance on sexuality education was first published in 2009 as an evidence-informed approach for schools, teachers and health educators. Recognizing the dynamic shifts in the field of sexuality education that have occurred since then, an expanded group of UN co-publishing partners has reviewed and updated the content to respond appropriately to the contemporary needs of young learners, and to provide support for education systems and practitioners seeking to address those needs.

The International technical guidance on sexuality education (revised edition) provides sound technical advice on the characteristics of effective comprehensive sexuality education (CSE) programmes; a recommended set of topics and learning objectives that should be covered in comprehensive sexuality education; and, recommendations for planning, delivering and monitoring effective CSE programmes.

This revised edition of the Guidance reaffirms the position of sexuality education within a framework of human rights and gender equality, and promotes structured learning about sex and relationships in a manner that is positive, affirming, and centred on the best interests of the young person. It is based on a review of the latest evidence and lessons-learned from implementing CSE programmes across the globe. The revised Guidance reflects the contribution of sexuality education to the realization of multiple Sustainable Development Goals, notably Goal 3 on good health and well-being for all, Goal 4 on quality education for all, and Goal 5 to achieve gender equality.

